

Bunga Rampai

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN LANSIA

Melalui Pendekatan Kebidanan

Titin Apriyani • Maria Florentina Nining Kosad
Elwitri Silvia • Subang Aini Nasution

Editor: Sri Musfiroh



BUNGA RAMPAI

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN LANSIA MELALUI PENDEKATAN KEBIDANAN

Penulis:

Bdn. Titin Apriyani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.
Bd. Elwitri Silvia, S.ST., M.Keb.
Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Editor:

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.



Bunga Rampai Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Lansia Melalui Pendekatan Kebidanan

Penulis:

Bdn. Titin Apriyani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.
Bd. Elwitri Silvia, S.ST., M.Keb.
Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

Editor:

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-31-2

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku bunga rampai berjudul "Bunga Rampai Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Lansia melalui Pendekatan Kebidanan" ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan praktik kebidanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan perempuan pada masa lanjut usia. Perempuan lansia merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan kesehatan yang beragam dan kompleks karena dipengaruhi oleh proses penuaan, menopause, penyakit kronis, perubahan psikologis, serta perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap perempuan lansia perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek emosional, sosial, spiritual, kemandirian, dan kualitas hidup.

Buku ini memuat beberapa chapter yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Chapter pertama membahas konsep dasar perempuan lansia dalam perspektif kebidanan sebagai landasan awal untuk memahami karakteristik dan kebutuhan perempuan pada masa lanjut usia. Chapter kedua menguraikan perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan, termasuk dampaknya terhadap kualitas hidup, upaya adaptasi, serta peran keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Chapter ketiga membahas masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia, seperti osteoporosis, hipertensi, diabetes melitus, gangguan nutrisi, gangguan tidur, inkontinensia urine, gangguan sensorik, risiko jatuh, serta masalah psikologis dan sosial. Selanjutnya, chapter keempat menekankan pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam mendampingi perempuan lansia, baik melalui dukungan emosional, pemenuhan kebutuhan fisik, kegiatan sosial, pencegahan masalah kesehatan, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, maupun penguatan lingkungan yang ramah lansia.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pendekatan kebidanan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan lansia. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan perempuan sepanjang daur kehidupan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi, melakukan deteksi dini, mendampingi proses adaptasi, memberdayakan keluarga, serta memperkuat peran komunitas. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, dosen, praktisi kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kesehatan perempuan lansia. Terima kasih disampaikan kepada seluruh penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung perempuan lansia agar menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, mandiri, bermartabat, dan bermakna.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PEREMPUAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF

KEBIDANAN	1
------------------------	----------

Bdn. Titin Apriyani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.....	1
---	---

A. Pendahuluan.....	1
---------------------	---

B. Konsep Dasar Lansia	2
------------------------------	---

C. Simpulan.....	7
------------------	---

D. Referensi.....	8
-------------------	---

CHAPTER 2 PERUBAHAN FISIK, PSIKOLOGIS, DAN SOSIAL PADA LANSIA

PEREMPUAN	9
------------------------	----------

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.....	9
---	---

A. Pendahuluan/Prolog	9
-----------------------------	---

B. Konsep Dasar Lansia Perempuan dan Proses Penuaan	13
---	----

C. Perubahan Fisik pada Lansia Perempuan.....	19
---	----

D. Masalah Kesehatan yang Sering Dialami Lansia Perempuan.....	26
--	----

E. Perubahan Psikologis pada Lansia Perempuan	32
---	----

F. Perubahan Sosial pada Lansia Perempuan	38
---	----

G. Dampak Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial terhadap Kualitas Hidup....	44
---	----

H. Upaya Adaptasi Lansia Perempuan terhadap Perubahan	51
---	----

I. Peran Keluarga, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat	57
---	----

J. Simpulan.....	64
------------------	----

K. Referensi.....	65
-------------------	----

L. Glosarium	66
--------------------	----

CHAPTER 3 MASALAH KESEHATAN YANG SERING DIALAMI PEREMPUAN

LANSIA	69
---------------------	-----------

Bd. Elwitri Silvia, S.ST., M.Keb.....	69
---------------------------------------	----

A. Pendahuluan/Prolog	69
-----------------------------	----

B. Konsep Dasar Perempuan Lansia dan Kerentanan Kesehatan	73
---	----

C. Pengaruh Proses Penuaan dan Menopause terhadap Kesehatan Perempuan Lansia.....	79
---	----

D. Osteoporosis, Nyeri Sendi, dan Risiko Fraktur	85
E. Hipertensi, Penyakit Jantung, dan Gangguan Sirkulasi	91
F. Diabetes Melitus dan Penyakit Degeneratif Lainnya.....	97
G. Gangguan Nutrisi, Malnutrisi, Anemia, dan Perubahan Berat Badan	104
H. Gangguan Tidur, Kelelahan, dan Penurunan Energi.....	111
I. Inkontinensia Urine dan Gangguan Urogenital Pascamenopause	118
J. Gangguan Sensorik, Mobilitas, dan Risiko Jatuh.....	124
K. Gangguan Psikologis dan Sosial pada Perempuan Lansia.....	131
L. Simpulan.....	137
M. Referensi.....	138
N. Glosarium	141

CHAPTER 4 PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM MENDUKUNG

PEREMPUAN LANSIA.....143

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.....	143
A. Pendahuluan/Prolog	143
B. Konsep Dasar Perempuan Lansia dalam Keluarga dan Komunitas	148
C. Kebutuhan Perempuan Lansia yang Perlu Didukung Keluarga dan Komunitas.....	153
D. Peran Keluarga dalam Memberikan Dukungan Emosional	160
E. Peran Keluarga dalam Mendukung Kesehatan Fisik Perempuan Lansia	165
F. Peran Komunitas dalam Mendukung Kesehatan Perempuan Lansia.....	171
G. Peran Komunitas dalam Pencegahan Masalah Kesehatan Lansia.....	176
H. Kolaborasi Keluarga, Komunitas, dan Tenaga Kesehatan	183
I. Hambatan dan Strategi Penguatan Dukungan bagi Perempuan Lansia	189
J. Simpulan.....	196
K. Referensi.....	197
L. Glosarium	199

PROFIL PENULIS203

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PEREMPUAN LANSIA DALAM PERSPEKTIF KEBIDANAN

Bdn. Titin Apriyani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan

Peningkatan angka harapan hidup secara global membawa dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah populasi lanjut usia. Menurut data dari World Health Organization (WHO), pada tahun 2050 jumlah lansia diproyeksikan mencapai lebih dari 2 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat bahwa jumlah lansia telah mencapai 10,48% dari total penduduk. Pertambahan populasi lansia ini diiringi dengan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan hiperkolesterolemia, yang menjadi tantangan utama dalam bidang kesehatan masyarakat. Secara fisiologis, perempuan lansia memiliki risiko lebih tinggi terhadap PTM, terutama akibat penurunan hormon estrogen setelah menopause. Kondisi ini berpengaruh pada metabolisme lipid, sensitivitas insulin, serta regulasi tekanan darah. PTM sering bersifat asimtomatik atau tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga disebut sebagai “silent killer”. Banyak lansia yang tidak menyadari kondisi kesehatannya sampai terjadi komplikasi serius. Oleh karena itu, edukasi kesehatan dan pemeriksaan rutin menjadi langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut (Khoiriyah et al., 2023; Nuraisyah et al., 2021; Widiyati et al., 2024)

Idealnya, lansia mendapatkan akses terhadap edukasi kesehatan yang komprehensif dan pemeriksaan rutin dengan pendekatan yang holistik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realita, yang ditandai dengan minimnya edukasi, kurangnya pemantauan kesehatan rutin, serta rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan terstruktur (Passe et al., 2023; Margaretha et al., 2023). Program berbasis komunitas yang melibatkan lansia secara aktif, seperti pendampingan oleh kader atau tenaga kesehatan, juga terbukti mampu membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap pemeriksaan rutin (Khoiriyah et al., 2023; Nuraisyah et al., 2021)

B. Konsep Dasar Lansia

1. Definisi lansia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis (Mustika dkk., 2022). Proses menua yang terjadi secara terus menerus seiring bertambahnya usia seseorang dan mengalami berbagai perubahan yang berdampak pada fungsi dan keterampilan tubuhnya, merupakan proses alami yang terjadi pada individu karena telah mencapai akhir siklus hidupnya. Ketika seseorang mencapai usia 60 tahun atau lebih, mereka dianggap lanjut usia. Lansia yang dapat menjaga diri sendiri, terhindar dari penyakit, meningkatkan kapasitas fungsional, sembuh dari penyakit, dan menjalani rehabilitasi dianggap sehat. Kegiatan ini termasuk mandi, berpakaian, menjalankan bisnis sehari-hari, makan, minum, dan mengompol. Jika lansia ingin hidup lebih lama, kemampuan mereka untuk melakukan tugas sehari-hari yang penting harus dipertahankan (Widiastuti dkk., 2021).

2. Karakteristik lansia

- a. Usia Ketika seseorang mencapai usia 60 tahun atau lebih, mereka dianggap lanjut usia.
- b. Jenis kelamin perempuan mendominasi populasi tua. Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki harapan hidup yang lebih tinggi.
- c. Menurut Badan Pusat Statistik SUPAS 2015, mayoritas penduduk menikah (60%) dan bercerai atau meninggal (37%). Secara spesifik, 82,84% lansia laki-laki menikah dan 56,04% lansia perempuan bercerai atau janda. Ini karena pria yang lebih tua lebih mungkin untuk menikah lagi dan wanita yang lebih tua lebih mungkin meninggal karena perceraian karena wanita memiliki harapan hidup yang lebih lama.
- d. Teks mengacu pada penuaan aktif dan kualitas hidup Penuaan dengan cara yang sehat secara fisik, sosial, dan psikologis memungkinkan lansia untuk mempertahankan kesejahteraan mereka sepanjang hidup mereka dan terus berkontribusi pada upaya masyarakat untuk meningkatkan standar hidup. Menurut informasi dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2016, mayoritas pendapatan lansia berasal dari pekerjaan atau perusahaan (46,7%), pensiun (8,5%), dan tabungan (3,8%), kerabat, atau jaminan sosial.

- e. Menurut penelitian Darmojo, sebagian besar pekerja yang lebih tua adalah pegawai terlatih, dan relatif sedikit yang profesional. Diharapkan bahwa sekolah akan meningkat seiring berjalannya waktu.
- f. Status kesehatan Salah satu metrik yang digunakan untuk menilai kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Kesehatan penduduk akan lebih baik bila angka kesakitan lebih rendah.

3. Ciri-ciri lansia

Ciri-ciri dari lansia diantaranya adalah terjadinya penurunan produktifitas atau terjadinya penurunan fungsi fisik, sosial dan psikologis, sebagaimana dijelaskan oleh Hurlock (Pasmawati, 2017), terdapat beberapa ciri orang lansia yaitu :

- a. Masa tua adalah masa kemunduran; kemunduran ini dapat disebabkan oleh masalah fisik dan psikologis. Pembalikan dapat mempengaruhi pikiran orang lanjut usia. Dalam kasus orang lanjut usia, motivasi sangat penting. Jika orang lanjut usia memiliki motivasi yang rendah, penurunannya akan terjadi lebih cepat; sebaliknya, jika mereka memiliki motivasi yang tinggi, penurunan mereka akan memakan waktu lebih lama.
- b. Lansia dianggap sebagai kelompok minoritas karena sikap sosial yang kurang baik terhadap mereka dan stereotip negatif tentang mereka. Sudut pandang klise mencakup hal-hal seperti, "Orang tua lebih suka mempertahankan sudut pandang mereka daripada mendengarkan sudut pandang orang lain."
- c. Lansia membutuhkan pergeseran peran karena mulai mengalami kemunduran di segala bidang. Peran lansia harus berubah berdasarkan preferensi mereka sendiri, bukan orang lain atau tekanan eksternal.
- d. Lansia memiliki kecenderungan untuk mengembangkan konsep diri yang negatif karena penuaan dan perawatan yang tidak memadai. Lansia menunjukkan lebih banyak perilaku negatif. Orang tua lebih sulit menyesuaikan diri sebagai akibat dari perlakuan kejam ini.

4. Klasifikasi lansia

Menurut Muhith & Siyoto (2016), terdapat beberapa versi klasifikasi, yaitu sebagai berikut :

Menurut World Health Organization (WHO)

- a. Usia pertengahan (*middle age*), antara usia 45-59 tahun
- b. Lansia (*elderly*), antara usia 60-74 tahun
- c. Lansia tua (*old*), antara usia 75-90 tahun
- d. Usia sangat tua (*very old*), usia diatas 90 tahun

Menurut Depkes RI

- a. Pertengahan umur lansia (virilitasi) yaitu masa persiapan lansia yang menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa, antara usia 45-54 tahun
- b. Lansia dini (prasegium) yaitu kelompok yang mulai memasuki lansia, antara 55-64 tahun
- c. Lansia (segium) usia 65 tahun ke atas
- d. Lansia dengan resiko tinggi yaitu kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok lansia yang hidup sendiri, terpencil, tinggal di panti, menderita penyakit berat, atau cacat.

5. Masalah kesehatan lansia

Berdasarkan buku lansia Kusumo (2020), semakin bertambahnya usia, tubuh menjadi semakin rentan mengalami gangguan kesehatan dikarenakan menurunnya fungsi-fungsi organ. Masalah kesehatan yang sering muncul pada lansia meliputi:

- a. Ketika seseorang menderita hipertensi (tekanan darah tinggi), tekanan darah sistolik atau diastoliknyanya masing-masing lebih besar dari 140 mmHg atau 90 mmHg.
- b. Diabetes yang juga dikenal sebagai diabetes melitus (DM) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah lebih dari 200 mg/dl yang disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas, yang merupakan organ penghasil insulin.
- c. Penyakit sendi, sering dikenal sebagai radang sendi, adalah penyakit autoimun kronis yang merusak sendi dan mengganggu mobilitas.
- d. Stroke adalah suatu kondisi yang berkembang ketika arteri darah tersumbat atau rusak, mengganggu aliran nutrisi dan oksigen ke otak.
- e. Penyakit Paru-paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah penyakit paru kronik (menahun) yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas, semakin lama semakin memburuk dan tidak sepenuhnya dapat kembali normal.
- f. Depresi merupakan perasaan tertekan dan sedih yang terus menetap selama kurun waktu lebih dari 2 minggu.

6. Perubahan mental pada lansia

Penyesuaian diri adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental lansia. Perubahan ini merupakan hasil modifikasi keadaan sebelumnya, seperti turunnya lapangan kerja dan pendapatan namun masih dalam kondisi fisik yang

baik. Lansia mengalami perubahan mental sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh proses penuaan. Lansia sering mengalami perubahan mental seperti perubahan kepribadian, perubahan ingatan, dan perubahan kecerdasan karena hal-hal seperti perkembangan global, bertambah usia, pertimbangan geografis, jenis kelamin, kepribadian, tekanan sosial, dukungan sosial, dan pekerjaan. (Ramli & Fadhillah, 2020).

7. Perubahan pada lansia

Berdasarkan buku lansia Kusumo (2020), ada beberapa perubahan yang terjadi pada lansia, meliputi:

- a. Gangguan pendengaran, yang dibuktikan dengan suara yang terdengar kacau dan kata-kata yang sulit untuk dipahami.
- b. Penurunan ketajaman visual.
- c. Seiring bertambahnya usia, kulit mereka menjadi kendur, kering, keriput, dan dehidrasi, menjadikannya kurus dan berjerawat.
- d. Penurunan keseimbangan dan kekuatan tubuh. Orang lanjut usia memiliki kepadatan tulang yang lebih sedikit, lebih rentan terhadap gesekan sendi, dan jaringan otot yang menua.
- e. Modifikasi pada fungsi kardiovaskular dan pernapasan.

8. Konsep Status Kesehatan Lansia

Status kesehatan lansia adalah keadaan kesehatan lansia baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Empat faktor kesehatan yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi, semuanya berinteraksi untuk menentukan tingkat kesehatan seseorang membentuk status kesehatannya. Selain bebas dari penyakit dan kecacatan, sehat juga berarti aktif secara ekonomi dan sosial. Penurunan status kesehatannya yang dapat menghambat produktifitas kerja yang akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan lansia itu sendiri. (Aswati, Supinganto, & Istianah, 2022)

Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara bebas dan sehat menentukan status fungsional atau kondisi kesehatannya. Tiga bagian mendasar dari gagasan ini adalah fungsi biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk mendukung perilaku dan fungsi yang sehat. Keadaan mental yang meliputi perhatian, persepsi, pemikiran, pengetahuan, dan ingatan, merupakan salah satu komponen psikologis. Keadaan lingkungan, penyakit, faktor perilaku, termasuk latihan fisik, stres, dan interaksi sosial, serta faktor sosiodemografi, termasuk usia, posisi pekerjaan, pencapaian pendidikan,

dan status lajang, semuanya terkait langsung dengan kesehatan mental. Salah satu hal yang diketahui mempengaruhi kesehatan mental adalah aktivitas fisik.

Menurut beberapa penelitian, lansia yang kesulitan bergerak atau tidak aktif akan mengalami disparitas mental, yang akan berdampak signifikan pada berapa lama mereka hidup. Lansia perlu menyesuaikan diri sebagai akibat dari perubahan yang disebabkan oleh penuaan. Kesehatan fisik dan mental lansia dapat terganggu jika mereka terlalu lama menyesuaikan diri.

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia

a. Faktor sosial

Perubahan psikososial terjadi pada lansia, termasuk rasa takut akan kematian, penyakit kronis, dan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Kesepian yang disebabkan oleh pengucilan sosial atau isolasi keuangan yang disebabkan oleh pemecatan atau pensiun dapat berdampak negatif pada kesehatan orang lanjut usia. Kemungkinan orang lanjut usia menjadi cacat atau mati muda dapat meningkat sebagai akibatnya. Seiring dengan kematian yang lebih tinggi, penyakit, dan depresi, dukungan sosial yang tidak memadai juga berkorelasi kuat dengan kesehatan dan kesejahteraan secara umum.

Kemungkinan kematian dalam tiga tahun ke depan adalah 1,5 kali lebih tinggi untuk orang lanjut usia yang tidak menerima dukungan sosial yang cukup daripada mereka yang menerimanya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sosial yang tinggi, serta perasaan yang kuat tentang orang yang dicintai dan dihormati. Lansia dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi mengalami rasa membutuhkan dan perhatian dari orang lain, yang dapat mendorong mereka untuk menjalani hidup sehat.

b. Faktor ekonomi

Kesehatan lansia sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Lansia dengan penghasilan sendiri biasanya menolak bantuan dari orang lain, tetapi lansia tanpa penghasilan bergantung pada keturunan atau saudara kandungnya. Orang lanjut usia yang tidak menghasilkan cukup uang memiliki risiko lebih tinggi untuk sakit dan terluka.

Banyak lansia hidup sendiri dan kekurangan sumber daya untuk menutupi pengeluaran dasar mereka. Ini dapat membujuk mereka untuk berinvestasi dalam makanan sehat, perumahan yang bagus, dan perawatan kesehatan. Lansia yang tidak memiliki aset, sedikit atau tidak memiliki tabungan, tidak memiliki uang pensiun, tidak dapat membayar jaminan, atau

berasal dari pendapatan rendah atau rumah tangga kecil sangat rentan.

c. Faktor lingkungan

Lansia yang tinggal di lokasi pedesaan, di mana layanan dukungan sedikit dan pola penyakit mungkin berbeda berdasarkan faktor lingkungan, harus mendapat perawatan khusus. Lansia semakin terisolasi di daerah pedesaan dengan sedikit atau tanpa akses ke perawatan kesehatan karena urbanisasi dan migrasi untuk bekerja. Akses terhadap ketersediaan transportasi umum baik di perkotaan maupun di pedesaan harus dimiliki oleh masyarakat dari segala usia untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ini sangat penting bagi orang lanjut usia yang memiliki masalah mobilitas. Karena bahaya lingkungan, manula lebih rentan terhadap kelemahan dan kerusakan yang serius. Kategori kecelakaan yang paling sering terjadi adalah tabrakan dengan kendaraan yang bergerak, terbakar, dan jatuh. Lebih dari siapa pun, mereka yang berada dalam kelompok usia yang paling rentan, mereka yang menderita penyakit kronis, dan mereka yang sistem kekebalannya lemah membutuhkan akses ke air bersih, udara segar, dan makanan bergizi. (Malhotra, 2019).

C. Simpulan

Semakin tingginya umur harapan hidup mengakibatkan peningkatan jumlah lanjut usia (lansia) di dunia (WHO, 2020). Lansia di Indonesia pada tahun 2022 yaitu sejumlah 29 juta orang penduduk dengan umur harapan hidup mencapai 71,85 tahun (BPS, 2023). UU Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan lansia yaitu orang yang berusia di atas 60 tahun. Komunitas lansia sangat rentan mengalami berbagai hambatan fungsi di banyak sistem organ (Melsæter et al., 2022). Hal ini akan menjadi masalah kesehatan bagi individu maupun masyarakat di Indonesia.

Penuaan pada sistem reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah menopause, dan penuaan menopause bertahap di mana menopause memberikan efek pada tubuh yang menua. Setelah seorang wanita mencapai usia 45-50 tahun, hanya beberapa folikel yang tersisa yang dapat dirangsang oleh Follicle Stimulating Hormone (FSH). Secara progresif, semakin sedikit estrogen yang diproduksi dan konsentrasi FSH dan Luteinizing Hormone (LH) meningkat. Konsentrasi estrogen yang menurun tidak lagi bertindak sebagai mekanisme umpan balik untuk mencegah peningkatan hormonhormon ini. Perubahan ini terjadi sebelum adanya perubahan panjang siklus menstruasi dan merupakan prediktor yang baik

D. Referensi

- Margaretha, P. M. S. E., Rachmawati, N. C., Fijriyah, S., & Annarahayu, L. (2023). Peningkatan kualitas kesehatan lansia dengan deteksi dini penyakit tidak menular. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.37287/psnpkm.v4i2.4643>
- Munir, R., Rasyidin, F., Amalia, D., Lestari, E. P., & Budi, C. S. (2024). Edukasi mengenai hipertensi pada lansia. 4(01), 8–13.
- Nuraisyah, F., Purnama, J. S., Nuryanti, Y., Agustin, R. D., Desriani, R., & Putri, M. U. (2021). Edukasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular pada Lansia untuk Meningkatkan Kualitas Hidup. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 364–368. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1845>
- Passe, R., Janwar, M., & Wahyuningsih. (2023). Peningkatan Kualitas Hidup Wanita Perimenopause Melalui pendampingan Program Sehat Fisik dan Jiwa (SEHATI) Posyandu Lansia Puskesmas Antang Perumnas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2848–2855.
- Purwati, A. E., Asmarani, S. U., Dewi, S. W. R., & Hidayat, N. (2023). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia melalui Pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa Darah dan Edukasi Menggunakan Media Informasi. *Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 164– 169. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v3i3.242>.
- Razalina, M., & Sari, D. L. (2022, Desember). Manfaat Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan. *Jurnal (BDI) BEKASI DEVELOPMENT INNOVATION JOURNAL*, 48-60.
- Riyanto, dkk. (2023, November 10). Mekanisme Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sami Asih Desa Sekartejo, Pituruh, Purworejo. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 10, 579- 585. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10164136>
- Ruhlessin, M. F. (2023, Oktober 12). Kompas.go.id. Retrieved from <https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/11/103000821/sepanjang-2023-14-tpadi-indonesia-alami-kebakaran>
- Sasoko, D. M. (2022). Teknik Analisis SWOT Dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22 (1), 8-19. Retrieved from <https://ejournaljayabaya.id/Perspektif/article/view/64>

CHAPTER 2

PERUBAHAN FISIK, PSIKOLOGIS, DAN SOSIAL PADA LANSIA PEREMPUAN

Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Memahami perubahan pada lansia perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, keluarga, maupun pelayanan sosial. Masa lanjut usia merupakan tahap kehidupan yang ditandai oleh berbagai perubahan alami akibat proses penuaan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada tubuh, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, spiritual, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Pada lansia perempuan, proses penuaan memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruhi oleh perubahan hormonal, riwayat reproduksi, pengalaman hidup, peran dalam keluarga, serta kondisi sosial budaya yang membentuk kehidupan perempuan sejak usia muda hingga lanjut usia.

Lansia perempuan sering kali menghadapi perubahan yang lebih kompleks dibandingkan kelompok usia lainnya. Secara fisik, mereka dapat mengalami penurunan fungsi organ tubuh, berkurangnya kekuatan otot, menurunnya kepadatan tulang, perubahan kulit, gangguan penglihatan dan pendengaran, serta meningkatnya risiko penyakit kronis. Secara psikologis, lansia perempuan dapat mengalami perubahan emosi, penurunan rasa percaya diri, kecemasan, kesepian, kehilangan peran, atau bahkan depresi. Secara sosial, mereka dapat mengalami perubahan hubungan dengan pasangan, anak, cucu, keluarga besar, tetangga, maupun masyarakat. Seluruh perubahan tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi kemampuan lansia perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pentingnya memahami perubahan pada lansia perempuan juga berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Dengan bertambahnya usia harapan hidup, semakin banyak perempuan yang memasuki masa lanjut usia dan membutuhkan perhatian khusus. Lansia perempuan sering memiliki harapan hidup yang lebih panjang, tetapi usia yang lebih panjang tidak selalu berarti kualitas hidup yang lebih baik. Sebagian lansia perempuan dapat hidup mandiri, aktif, dan produktif, tetapi sebagian lainnya mengalami ketergantungan akibat penyakit

kronis, keterbatasan fisik, gangguan psikologis, atau kurangnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perubahan fisik, psikologis, dan sosial sangat diperlukan agar kebutuhan lansia perempuan dapat dikenali dan dipenuhi secara tepat.

Proses penuaan pada perempuan merupakan proses alami yang terjadi secara bertahap. Penuaan menyebabkan tubuh mengalami penurunan kemampuan dalam mempertahankan fungsi optimal. Sel-sel tubuh mengalami perubahan, metabolisme melambat, sistem imun menurun, dan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stres fisik maupun psikologis juga berkurang. Pada lansia perempuan, perubahan ini sering kali lebih terasa setelah melewati masa menopause. Menopause menyebabkan penurunan hormon estrogen yang berpengaruh terhadap banyak sistem tubuh, seperti tulang, kulit, pembuluh darah, sistem urogenital, suasana hati, serta fungsi seksual. Oleh karena itu, menopause menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan lansia perempuan.

Menopause dan masa pascamenopause dapat membawa berbagai konsekuensi bagi kehidupan lansia perempuan. Penurunan estrogen dapat meningkatkan risiko osteoporosis, kekeringan vagina, gangguan tidur, perubahan suasana hati, serta perubahan komposisi tubuh. Beberapa perempuan juga mengalami penurunan rasa percaya diri karena adanya perubahan bentuk tubuh, keriput, rambut memutih, atau berkurangnya kemampuan fisik. Perubahan ini dapat memengaruhi cara lansia perempuan memandang dirinya sendiri. Jika tidak didukung dengan pemahaman dan penerimaan yang baik, lansia perempuan dapat merasa kehilangan daya tarik, kehilangan peran, atau merasa tidak lagi produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan fisik sering kali berdampak pada kondisi psikologis dan sosial.

Penyakit kronis juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kehidupan lansia perempuan. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, osteoporosis, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan inkontinensia urine cenderung meningkat. Penyakit kronis dapat membatasi aktivitas harian, mengurangi kemandirian, menimbulkan rasa nyeri, meningkatkan ketergantungan pada keluarga, serta menurunkan kualitas hidup. Bagi lansia perempuan yang sebelumnya terbiasa aktif mengurus rumah tangga, keluarga, pekerjaan, atau kegiatan sosial, keterbatasan akibat penyakit dapat menimbulkan perasaan sedih, tidak berguna, atau menjadi beban bagi orang lain.

Selain perubahan fisik dan kesehatan, perubahan peran dalam keluarga juga sangat memengaruhi kehidupan lansia perempuan. Pada usia produktif, banyak perempuan memiliki peran sebagai ibu, istri, pengasuh anak, pekerja, pengelola

rumah tangga, atau anggota masyarakat yang aktif. Ketika memasuki masa lanjut usia, peran tersebut dapat berubah. Anak-anak mulai hidup mandiri, pasangan mungkin telah meninggal, aktivitas rumah tangga berkurang, dan kemampuan fisik tidak lagi sekuat sebelumnya. Perubahan ini dapat menimbulkan rasa kehilangan, terutama jika lansia perempuan merasa tidak lagi dibutuhkan oleh keluarga. Sebaliknya, jika keluarga tetap melibatkan lansia dalam kegiatan rumah tangga sesuai kemampuan, memberikan penghargaan, dan mendengarkan pendapatnya, lansia perempuan dapat tetap merasa bermakna.

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan lansia perempuan. Lansia yang tinggal di lingkungan suportif cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena mereka masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi, berbagi cerita, mengikuti kegiatan keagamaan, menghadiri kegiatan masyarakat, atau berkumpul dengan teman sebaya. Sebaliknya, lansia perempuan yang hidup sendiri, jarang dikunjungi keluarga, kehilangan pasangan, atau mengalami keterbatasan mobilitas berisiko mengalami kesepian dan isolasi sosial. Kesepian pada lansia tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena dapat memengaruhi kesehatan mental, menurunkan motivasi hidup, memperburuk penyakit, dan mengurangi kemampuan lansia untuk merawat diri.

Dalam memahami lansia perempuan, diperlukan pendekatan yang holistik. Pendekatan holistik berarti melihat lansia perempuan sebagai manusia utuh, bukan hanya sebagai individu yang mengalami penurunan fungsi tubuh. Kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan fisik, tetapi juga oleh keadaan emosi, hubungan keluarga, dukungan sosial, kondisi ekonomi, spiritualitas, lingkungan tempat tinggal, dan rasa bermakna dalam hidup. Seorang lansia perempuan yang memiliki penyakit kronis tetapi mendapat dukungan keluarga, memiliki kegiatan sosial, dan mampu menerima proses penuaan dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, lansia yang secara fisik relatif sehat tetapi merasa kesepian, tidak dihargai, dan kehilangan tujuan hidup dapat mengalami penurunan kesejahteraan psikologis.

Pendekatan holistik juga penting dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian yang tidak hanya berfokus pada keluhan fisik, tetapi juga menggali kondisi psikologis dan sosial lansia perempuan. Misalnya, ketika seorang lansia perempuan mengeluh sulit tidur, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seperti nyeri, kecemasan, kesepian, efek obat, perubahan hormon, atau kebiasaan tidur yang kurang baik. Ketika lansia sering jatuh, penyebabnya tidak hanya dilihat dari kelemahan otot, tetapi juga dari kondisi rumah, penglihatan, penggunaan obat, alas kaki, dan

dukungan keluarga. Dengan cara pandang holistik, intervensi yang diberikan akan lebih tepat dan sesuai kebutuhan nyata lansia.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup lansia perempuan. Dukungan keluarga dapat berupa pendampingan dalam aktivitas sehari-hari, bantuan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, pengawasan pengobatan, motivasi untuk bergerak aktif, pendampingan kontrol kesehatan, serta dukungan emosional. Namun, dukungan keluarga perlu diberikan dengan tetap menghargai kemandirian lansia. Lansia perempuan sebaiknya tidak diperlakukan seolah-olah tidak mampu melakukan apa pun. Selama masih memungkinkan, lansia perlu tetap diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai kemampuannya, mengambil keputusan sederhana, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Hal ini penting untuk menjaga harga diri dan rasa bermakna pada lansia.

Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia perempuan. Lingkungan yang ramah lansia adalah lingkungan yang aman, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berpartisipasi. Kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, posyandu lansia, kelompok senam lansia, dan komunitas perempuan dapat menjadi sarana penting untuk menjaga keterhubungan sosial lansia. Lansia perempuan yang tetap aktif secara sosial biasanya memiliki semangat hidup yang lebih baik, merasa lebih dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman. Oleh karena itu, perhatian terhadap lansia perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan.

Pembahasan mengenai perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan lansia perempuan secara menyeluruh. Dengan memahami perubahan fisik, pembaca dapat mengenali masalah kesehatan yang sering terjadi dan pentingnya pencegahan penurunan fungsi tubuh. Dengan memahami perubahan psikologis, pembaca dapat lebih peka terhadap perasaan lansia, seperti kecemasan, kesepian, kehilangan, atau perubahan konsep diri. Dengan memahami perubahan sosial, pembaca dapat melihat pentingnya dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan dalam mempertahankan kualitas hidup lansia. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat memberikan dukungan yang lebih tepat.

Lansia perempuan perlu dipandang sebagai individu yang tetap memiliki martabat, pengalaman, nilai, dan potensi. Proses penuaan memang membawa berbagai perubahan, tetapi bukan berarti lansia kehilangan makna hidup. Dengan dukungan yang tepat, lansia perempuan tetap dapat menjalani kehidupan yang

sehat, aman, mandiri sesuai kemampuan, dan bermakna. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami kondisi lansia perempuan secara lebih manusiawi, holistik, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

B. Konsep Dasar Lansia Perempuan dan Proses Penuaan

Lansia perempuan merupakan kelompok usia lanjut yang mengalami proses penuaan secara bertahap, alami, dan menyeluruh. Istilah lansia umumnya merujuk pada seseorang yang telah memasuki usia lanjut, yaitu tahap kehidupan ketika terjadi penurunan fungsi tubuh, perubahan psikologis, serta perubahan peran sosial. Dalam berbagai konsep kesehatan, lanjut usia sering dikaitkan dengan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Namun, penuaan tidak hanya dapat dipahami berdasarkan angka usia semata, karena setiap individu mengalami proses penuaan dengan kecepatan dan kondisi yang berbeda. Ada lansia perempuan yang tetap aktif, mandiri, dan produktif pada usia lanjut, tetapi ada pula yang mengalami keterbatasan fisik, penyakit kronis, atau ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pengertian lansia perlu dipahami secara luas, yaitu tidak hanya berdasarkan umur kronologis, tetapi juga berdasarkan kondisi biologis, psikologis, sosial, dan fungsional.

Berdasarkan tahapan usia, lansia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, seperti usia lanjut awal, usia lanjut madya, dan usia lanjut tua. Pembagian ini membantu tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat memahami bahwa kebutuhan lansia tidak selalu sama pada setiap kelompok usia. Lansia perempuan yang baru memasuki masa lanjut usia mungkin masih memiliki kemampuan fisik yang cukup baik, masih aktif dalam kegiatan keluarga atau masyarakat, dan masih mampu mengambil keputusan secara mandiri. Sementara itu, lansia perempuan pada usia yang lebih tua mungkin mulai mengalami penurunan mobilitas, gangguan daya ingat, penurunan penglihatan atau pendengaran, serta peningkatan kebutuhan bantuan dari orang lain. Dengan memahami tahapan usia lanjut, pelayanan kesehatan dan dukungan keluarga dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.

Karakteristik umum lansia perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara fisik, lansia perempuan biasanya mengalami penurunan kekuatan otot, perubahan postur tubuh, berkurangnya kepadatan tulang, kulit menjadi lebih kering dan keriput, rambut memutih, serta penurunan fungsi pancaindra. Secara biologis, perubahan hormonal setelah menopause berpengaruh besar terhadap kesehatan perempuan lanjut usia. Penurunan hormon estrogen dapat berdampak pada tulang, sistem kardiovaskular, sistem urogenital, kulit, dan suasana hati. Hal

ini membuat lansia perempuan lebih rentan mengalami osteoporosis, kekeringan pada area genital, gangguan tidur, perubahan emosi, serta peningkatan risiko penyakit degeneratif. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa lansia perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang khas dan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan lansia laki-laki.

Secara psikologis, lansia perempuan dapat mengalami perubahan dalam cara memandang diri, menerima proses penuaan, dan menghadapi perubahan peran. Sebagian lansia perempuan mampu menerima penuaan sebagai bagian dari kehidupan dan tetap memiliki semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, sebagian lainnya dapat merasa cemas, sedih, kesepian, kehilangan rasa percaya diri, atau merasa tidak lagi memiliki peran penting dalam keluarga. Perubahan fisik seperti keriput, rambut memutih, penurunan kekuatan tubuh, atau munculnya penyakit kronis dapat memengaruhi konsep diri lansia perempuan. Selain itu, pengalaman kehilangan pasangan, anak yang telah hidup mandiri, pensiun dari pekerjaan, atau berkurangnya aktivitas sosial juga dapat memengaruhi kondisi emosional mereka. Oleh karena itu, memahami lansia perempuan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek fisik dan psikologis secara bersamaan.

Secara sosial, lansia perempuan memiliki karakteristik yang erat kaitannya dengan peran dalam keluarga dan masyarakat. Banyak perempuan sepanjang hidupnya menjalankan peran sebagai ibu, istri, pengasuh, pengelola rumah tangga, pekerja, dan anggota masyarakat. Ketika memasuki masa lanjut usia, sebagian peran tersebut mengalami perubahan. Anak-anak mungkin sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, pasangan mungkin telah meninggal, atau aktivitas sosial mulai berkurang akibat keterbatasan fisik. Perubahan ini dapat menimbulkan rasa kehilangan, terutama jika lansia perempuan merasa tidak lagi dibutuhkan. Namun, dalam banyak budaya, lansia perempuan juga sering dipandang sebagai sumber pengalaman, nasihat, dan nilai keluarga. Mereka dapat memiliki peran penting sebagai pengasuh cucu, penjaga tradisi keluarga, serta figur yang dihormati dalam lingkungan sosial.

Proses penuaan merupakan perubahan alami yang terjadi sepanjang siklus kehidupan manusia. Penuaan bukanlah penyakit, melainkan proses biologis yang berlangsung secara bertahap sejak dewasa hingga usia lanjut. Pada proses ini, tubuh mengalami penurunan kemampuan dalam memperbaiki sel, mempertahankan keseimbangan fungsi organ, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sistem tubuh yang sebelumnya bekerja optimal mulai mengalami penurunan, seperti sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, saraf, endokrin, reproduksi, dan imun. Penurunan fungsi

tersebut dapat menyebabkan lansia lebih rentan terhadap penyakit, cedera, kelelahan, dan keterbatasan aktivitas. Meskipun demikian, proses penuaan tidak selalu berjalan sama pada setiap orang karena dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, dan dukungan sosial.

Pada perempuan, proses penuaan memiliki kekhasan karena sangat dipengaruhi oleh perubahan hormonal, khususnya menopause. Menopause merupakan masa ketika siklus menstruasi berhenti secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dan produksi hormon estrogen. Setelah menopause, perempuan memasuki fase pascamenopause yang membawa berbagai perubahan fisik dan psikologis. Penurunan estrogen dapat menyebabkan tulang lebih rapuh, kulit kehilangan elastisitas, terjadi perubahan distribusi lemak tubuh, serta muncul keluhan urogenital seperti kekeringan vagina atau inkontinensia urine. Selain itu, beberapa perempuan mengalami perubahan suasana hati, mudah lelah, gangguan tidur, atau penurunan gairah seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penuaan pada perempuan sangat berkaitan dengan perjalanan reproduksi dan hormonal sepanjang hidupnya.

Perbedaan proses penuaan antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari aspek biologis, hormonal, sosial, dan psikologis. Secara biologis, perempuan mengalami menopause, sedangkan laki-laki tidak mengalami penghentian fungsi reproduksi secara mendadak seperti perempuan. Perubahan hormonal pada laki-laki biasanya terjadi lebih bertahap, sedangkan pada perempuan penurunan estrogen setelah menopause dapat memberikan dampak yang cukup nyata pada tubuh. Dari aspek kesehatan, perempuan lebih rentan mengalami osteoporosis karena penurunan estrogen berpengaruh terhadap kepadatan tulang. Perempuan lanjut usia juga lebih sering mengalami masalah urogenital, seperti inkontinensia urine, prolaps organ panggul, atau kekeringan vagina. Sementara itu, laki-laki lanjut usia lebih banyak dikaitkan dengan perubahan prostat, penurunan testosteron bertahap, dan risiko penyakit tertentu yang berbeda.

Dari aspek sosial, perempuan sering memiliki pengalaman penuaan yang berbeda karena peran gender yang melekat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Lansia perempuan mungkin memiliki riwayat panjang sebagai pengasuh keluarga, sehingga ketika memasuki usia lanjut mereka tetap diharapkan menjalankan peran merawat cucu atau membantu pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, jika mereka mengalami keterbatasan fisik dan tidak lagi mampu menjalankan peran tersebut, mereka dapat merasa kehilangan fungsi atau harga diri. Perempuan juga lebih mungkin hidup lebih lama dibandingkan laki-laki, sehingga sebagian lansia perempuan mengalami masa janda pada usia lanjut. Kehilangan pasangan dapat menimbulkan perubahan emosional, sosial, dan ekonomi yang

besar. Hal ini berbeda dengan sebagian laki-laki lansia yang mungkin lebih sering mengalami ketergantungan dalam aspek perawatan diri karena selama hidupnya tidak terbiasa mengelola kebutuhan rumah tangga secara mandiri.

Faktor genetik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses penuaan pada perempuan. Riwayat keluarga dapat memengaruhi kerentanan terhadap penyakit tertentu, seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoporosis, penyakit jantung, atau gangguan kognitif. Jika seorang perempuan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit degeneratif, maka risiko mengalami kondisi serupa pada usia lanjut dapat meningkat. Namun, faktor genetik bukan satu-satunya penentu. Gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu memperlambat penurunan fungsi tubuh serta mengurangi risiko komplikasi. Oleh karena itu, meskipun faktor genetik tidak dapat diubah, dampaknya dapat dikendalikan melalui perilaku hidup sehat dan pemantauan kesehatan yang baik.

Faktor hormonal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penuaan perempuan. Estrogen berperan dalam menjaga kesehatan tulang, elastisitas kulit, fungsi pembuluh darah, keseimbangan jaringan urogenital, dan sebagian aspek suasana hati. Ketika kadar estrogen menurun setelah menopause, berbagai perubahan dapat muncul. Risiko osteoporosis meningkat karena kepadatan tulang menurun. Kulit menjadi lebih kering dan kurang elastis. Risiko gangguan jantung dan pembuluh darah juga dapat meningkat karena perlindungan hormonal terhadap sistem kardiovaskular berkurang. Selain itu, perubahan hormonal dapat memengaruhi pola tidur, energi, dan kondisi emosional. Pemahaman tentang faktor hormonal penting agar lansia perempuan dan keluarga tidak menganggap seluruh keluhan sebagai hal yang harus diterima tanpa upaya pencegahan atau penanganan.

Gaya hidup juga sangat menentukan kualitas penuaan pada perempuan. Perempuan yang sejak usia muda memiliki pola makan seimbang, aktif bergerak, cukup istirahat, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol berlebihan, dan mampu mengelola stres cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik saat lanjut usia. Sebaliknya, gaya hidup kurang aktif, konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, kurang asupan kalsium dan vitamin D, serta kebiasaan merokok dapat mempercepat munculnya penyakit degeneratif. Aktivitas fisik yang teratur, seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan ringan, atau aktivitas rumah tangga yang aman, dapat membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, kesehatan tulang, dan fungsi jantung. Dengan demikian, gaya hidup sehat menjadi salah satu upaya penting dalam memperlambat dampak negatif proses penuaan.

Penyakit kronis merupakan faktor lain yang sangat memengaruhi kehidupan lansia perempuan. Banyak lansia perempuan mengalami lebih dari satu masalah kesehatan kronis, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, osteoporosis, gangguan ginjal, atau gangguan penglihatan. Penyakit kronis dapat membatasi aktivitas, menurunkan kemandirian, menimbulkan rasa nyeri, serta meningkatkan kebutuhan terhadap obat dan pelayanan kesehatan. Bila tidak terkontrol, penyakit kronis dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, lansia perempuan membutuhkan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap pengobatan, serta dukungan keluarga dalam menjalani pola hidup sehat dan kontrol rutin.

Nutrisi juga berperan penting dalam proses penuaan pada perempuan. Kebutuhan gizi lansia perempuan dapat berubah seiring penurunan metabolisme, perubahan nafsu makan, masalah gigi dan mulut, gangguan pencernaan, atau penyakit kronis tertentu. Asupan protein yang cukup diperlukan untuk menjaga massa otot dan mencegah kelemahan. Kalsium dan vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang. Serat dan cairan membantu mencegah konstipasi. Zat besi, vitamin B kompleks, dan berbagai mikronutrien lainnya diperlukan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kekurangan gizi dapat menyebabkan lemah, mudah sakit, penurunan berat badan, gangguan penyembuhan, dan meningkatnya risiko jatuh. Sebaliknya, kelebihan asupan tertentu juga dapat memperburuk penyakit kronis, seperti diabetes atau hipertensi. Oleh karena itu, pola makan lansia perempuan perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan makan masing-masing.

Aktivitas fisik menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan lansia perempuan. Penuaan sering disertai penurunan massa otot dan kekuatan tubuh. Jika lansia perempuan kurang bergerak, penurunan tersebut dapat terjadi lebih cepat dan menyebabkan ketergantungan. Aktivitas fisik yang aman dan teratur dapat membantu mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, kesehatan jantung, dan suasana hati. Aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi risiko jatuh, mengontrol berat badan, meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi rasa kesepian jika dilakukan bersama kelompok. Namun, aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi lansia. Lansia dengan penyakit tertentu memerlukan arahan tenaga kesehatan agar aktivitas yang dilakukan aman dan tidak memperburuk kondisi.

Dukungan sosial juga sangat memengaruhi proses penuaan pada lansia perempuan. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, teman, tetangga, komunitas, kelompok keagamaan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Lansia perempuan yang memiliki dukungan sosial baik biasanya lebih mampu

menghadapi perubahan hidup, lebih termotivasi menjaga kesehatan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dukungan sosial dapat berupa bantuan praktis, seperti menemani kontrol kesehatan, membantu aktivitas rumah tangga, atau mengingatkan minum obat. Dukungan juga dapat berupa perhatian emosional, seperti mendengarkan keluhan, menemani berbicara, atau melibatkan lansia dalam kegiatan keluarga. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan kesepian, depresi, penurunan motivasi, dan meningkatnya risiko penelantaran.

Lansia perempuan perlu dipahami dalam konteks keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan lansia. Dalam keluarga, lansia perempuan dapat berperan sebagai ibu, nenek, penasihat, pengasuh cucu, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Hubungan keluarga yang hangat dan saling menghargai dapat membantu lansia merasa bermakna. Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber stres jika terdapat konflik, kurang perhatian, atau beban perawatan yang tidak seimbang. Keluarga perlu memahami bahwa lansia perempuan tetap membutuhkan penghargaan, kemandirian, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Bantuan yang diberikan sebaiknya tidak membuat lansia merasa tidak berdaya, tetapi mendukung mereka agar tetap mampu melakukan aktivitas sesuai kemampuan.

Dalam konteks masyarakat, lansia perempuan merupakan bagian dari kelompok yang perlu diberi ruang untuk tetap aktif dan terlibat. Masyarakat yang ramah lansia akan memberikan kesempatan bagi lansia perempuan untuk mengikuti kegiatan sosial, keagamaan, edukasi kesehatan, atau kegiatan komunitas. Keterlibatan sosial dapat membantu lansia mempertahankan rasa percaya diri, mengurangi kesepian, dan memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, masyarakat yang memandang lansia sebagai kelompok tidak produktif dapat menyebabkan lansia merasa tersisih. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat perlu dibangun agar lebih inklusif, aman, dan menghargai kontribusi lansia perempuan.

Budaya juga memengaruhi cara lansia perempuan dipandang dan diperlakukan. Dalam beberapa budaya, lansia perempuan dihormati sebagai sumber kebijaksanaan dan penjaga nilai keluarga. Namun, dalam budaya atau lingkungan tertentu, perempuan lanjut usia dapat mengalami diskriminasi karena dianggap lemah, tidak produktif, atau bergantung pada orang lain. Pandangan budaya terhadap penuaan, kecantikan, peran perempuan, dan kemandirian dapat memengaruhi harga diri lansia perempuan. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap lansia perempuan harus sensitif terhadap budaya. Tenaga kesehatan dan keluarga perlu memahami nilai-nilai yang dianut lansia, termasuk keyakinan, kebiasaan, dan cara mereka memaknai masa tua.

Dalam pelayanan kesehatan, lansia perempuan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pelayanan tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pencegahan, promosi kesehatan, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, fungsi kognitif, kemampuan aktivitas sehari-hari, status nutrisi, risiko jatuh, serta dukungan keluarga. Lansia perempuan juga perlu diberikan edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit kronis, kesehatan tulang, kesehatan urogenital, aktivitas fisik, serta pentingnya menjaga hubungan sosial. Pelayanan yang baik harus menghargai pilihan, martabat, dan kebutuhan lansia perempuan.

konsep dasar lansia perempuan dan proses penuaan mencakup pemahaman tentang pengertian lansia berdasarkan tahapan usia, karakteristik umum lansia perempuan, proses penuaan sebagai perubahan alami, perbedaan penuaan antara perempuan dan laki-laki, serta berbagai faktor yang memengaruhi penuaan. Penuaan pada perempuan dipengaruhi oleh genetik, hormonal, gaya hidup, penyakit kronis, nutrisi, aktivitas fisik, dan dukungan sosial. Selain itu, lansia perempuan tidak dapat dipahami secara terpisah dari keluarga, masyarakat, budaya, dan pelayanan kesehatan. Pemahaman yang menyeluruh akan membantu keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat memberikan dukungan yang lebih tepat agar lansia perempuan dapat menjalani masa tua dengan sehat, aman, bermartabat, dan bermakna.

C. Perubahan Fisik pada Lansia Perempuan

Perubahan fisik pada lansia perempuan merupakan bagian alami dari proses penuaan yang terjadi secara bertahap dan memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang perlahan seiring bertambahnya usia, perubahan hormonal, gaya hidup, riwayat kesehatan, serta kondisi lingkungan. Pada lansia perempuan, perubahan fisik sering kali memiliki karakteristik khusus karena dipengaruhi oleh masa menopause dan pascamenopause. Penurunan hormon estrogen setelah menopause berperan besar terhadap kesehatan tulang, kulit, sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, serta fungsi urogenital. Oleh karena itu, memahami perubahan fisik pada lansia perempuan sangat penting agar keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang tepat dalam mempertahankan kemandirian, kenyamanan, dan kualitas hidup lansia.

Salah satu perubahan fisik yang paling menonjol pada lansia perempuan adalah perubahan pada sistem muskuloskeletal, yaitu sistem yang terdiri atas otot, tulang, sendi, ligamen, dan struktur pendukung gerak tubuh. Seiring

bertambahnya usia, massa otot cenderung menurun. Kondisi ini sering disebut sebagai sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot yang menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah, mudah lelah, dan kurang stabil saat bergerak. Pada lansia perempuan, penurunan massa otot dapat menyebabkan aktivitas harian seperti berjalan jauh, naik turun tangga, mengangkat barang, berdiri lama, atau melakukan pekerjaan rumah tangga menjadi lebih berat. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai, penurunan kekuatan otot dapat berkembang menjadi keterbatasan mobilitas dan ketergantungan terhadap orang lain.

Selain penurunan massa otot, lansia perempuan juga sering mengalami nyeri sendi. Nyeri sendi dapat disebabkan oleh proses degeneratif pada sendi, seperti osteoarthritis, yaitu kondisi ketika bantalan sendi mengalami penurunan kualitas sehingga tulang dan jaringan sekitar sendi lebih mudah mengalami gesekan dan peradangan. Keluhan ini sering muncul pada lutut, pinggul, tulang belakang, jari-jari tangan, dan pergelangan. Nyeri sendi dapat membuat lansia enggan bergerak karena takut nyeri bertambah. Padahal, kurang bergerak dapat memperburuk kekakuan sendi dan mempercepat penurunan kekuatan otot. Oleh karena itu, lansia perempuan perlu didukung untuk tetap melakukan gerakan ringan yang aman, seperti peregangan, senam lansia, jalan kaki ringan, atau latihan rentang gerak sesuai kemampuan.

Osteoporosis juga menjadi masalah penting pada lansia perempuan. Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Lansia perempuan memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi karena penurunan hormon estrogen setelah menopause mempercepat berkurangnya massa tulang. Osteoporosis sering disebut sebagai penyakit yang berlangsung diam-diam karena pada tahap awal tidak selalu menimbulkan gejala. Lansia mungkin baru menyadari adanya masalah setelah mengalami nyeri punggung, postur tubuh membungkuk, tinggi badan berkurang, atau patah tulang akibat jatuh ringan. Patah tulang pada lansia, terutama patah tulang panggul, dapat berdampak serius karena dapat menurunkan kemandirian, memperpanjang masa perawatan, dan meningkatkan risiko komplikasi.

Perubahan pada sistem muskuloskeletal juga meningkatkan risiko jatuh. Jatuh pada lansia perempuan dapat terjadi karena kombinasi berbagai faktor, seperti kelemahan otot, gangguan keseimbangan, nyeri sendi, osteoporosis, gangguan penglihatan, penggunaan obat tertentu, lantai licin, pencahayaan kurang, atau alas kaki yang tidak sesuai. Risiko jatuh perlu mendapat perhatian serius karena akibatnya dapat berupa luka, patah tulang, trauma kepala, rasa takut bergerak, hingga penurunan aktivitas. Setelah mengalami jatuh, sebagian lansia menjadi takut berjalan atau beraktivitas sendiri, sehingga kemandirian mereka

semakin menurun. Oleh karena itu, pencegahan jatuh perlu dilakukan dengan menjaga kekuatan otot, memperbaiki lingkungan rumah, menggunakan alat bantu bila diperlukan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Perubahan fisik berikutnya terjadi pada sistem kardiovaskular. Pada proses penuaan, pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Jantung juga dapat mengalami perubahan kemampuan dalam memompa darah, terutama ketika tubuh membutuhkan tenaga lebih besar, misalnya saat berjalan cepat atau naik tangga. Pada lansia perempuan, risiko penyakit kardiovaskular meningkat setelah menopause karena menurunnya kadar estrogen yang sebelumnya memiliki efek perlindungan terhadap pembuluh darah. Akibatnya, lansia perempuan lebih rentan mengalami hipertensi, penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, dan gangguan sirkulasi. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan seperti cepat lelah, berdebar, sesak saat aktivitas, pusing, atau bengkak pada tungkai.

Hipertensi merupakan salah satu masalah kardiovaskular yang sering ditemukan pada lansia perempuan. Tekanan darah dapat meningkat karena pembuluh darah menjadi kaku, fungsi ginjal berubah, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, stres, kelebihan berat badan, atau adanya penyakit penyerta. Hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, lansia perempuan perlu melakukan pemantauan tekanan darah secara teratur. Pengendalian hipertensi tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga membutuhkan perubahan gaya hidup, seperti mengurangi konsumsi garam, menjaga berat badan, aktif bergerak, cukup istirahat, dan mengelola stres.

Gangguan sirkulasi juga dapat terjadi pada lansia perempuan. Sirkulasi yang kurang baik dapat menyebabkan kaki terasa dingin, kesemutan, mudah bengkak, luka sulit sembuh, atau rasa berat pada tungkai. Pada lansia dengan diabetes melitus atau penyakit pembuluh darah, gangguan sirkulasi dapat menjadi lebih berat. Kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan lansia berjalan dan meningkatkan risiko luka pada kaki. Perawatan kaki, penggunaan alas kaki yang nyaman, pemeriksaan kaki secara rutin, serta aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga aliran darah dan mencegah komplikasi.

Pada sistem pernapasan, lansia perempuan juga mengalami perubahan yang dapat memengaruhi daya tahan dan aktivitas sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, elastisitas paru-paru dan dinding dada menurun. Otot pernapasan juga dapat melemah, sehingga kemampuan paru-paru untuk mengembang dan mengempis menjadi tidak seoptimal saat usia muda. Akibatnya, kapasitas paru menurun dan

pertukaran oksigen dapat menjadi kurang efisien, terutama saat melakukan aktivitas fisik. Lansia perempuan mungkin menjadi lebih mudah lelah, cepat terengah-engah, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah aktivitas. Perubahan ini dapat lebih berat pada lansia yang memiliki riwayat merokok, penyakit paru kronis, obesitas, atau kurang aktivitas fisik.

Penurunan fungsi pernapasan juga dapat membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Batuk yang kurang efektif, penurunan refleks tubuh, serta daya tahan yang menurun dapat menyebabkan lendir lebih sulit dikeluarkan. Bila lansia mengalami flu, batuk, atau infeksi paru, proses pemulihannya dapat berlangsung lebih lama. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pernapasan menjadi penting. Lansia perempuan dianjurkan untuk tetap melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan, menjaga ventilasi rumah, menghindari asap rokok dan polusi, memenuhi kebutuhan cairan, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami sesak, batuk berkepanjangan, demam, atau penurunan kondisi umum.

Sistem pencernaan juga mengalami perubahan pada masa lanjut usia. Salah satu keluhan yang sering dialami lansia perempuan adalah konstipasi atau sulit buang air besar. Konstipasi dapat terjadi karena pergerakan usus melambat, kurang konsumsi serat, kurang minum, kurang aktivitas fisik, efek samping obat, atau kebiasaan menunda buang air besar. Konstipasi tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan perut kembung, nyeri perut, penurunan nafsu makan, dan muntah berlebihan. Pada lansia, muntah terlalu kuat dapat berisiko menimbulkan keluhan lain, terutama bila terdapat penyakit jantung atau wasir. Pencegahan konstipasi dapat dilakukan dengan konsumsi makanan berserat, cukup cairan, aktivitas ringan, dan membiasakan pola buang air besar yang teratur.

Penurunan nafsu makan juga sering ditemukan pada lansia perempuan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penurunan fungsi pengecap dan penciuman, masalah gigi dan mulut, gangguan menelan, efek obat, kesepian, depresi, penyakit kronis, atau perubahan metabolisme. Ketika nafsu makan menurun, lansia berisiko mengalami kekurangan gizi, penurunan berat badan, kelemahan otot, penurunan daya tahan tubuh, dan penyembuhan yang lebih lambat saat sakit. Lansia perempuan membutuhkan pola makan yang seimbang, tidak hanya cukup kalori, tetapi juga cukup protein, vitamin, mineral, serat, dan cairan. Makanan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemampuan mengunyah, selera, serta kebiasaan makan lansia.

Gangguan penyerapan zat gizi juga dapat terjadi pada usia lanjut. Perubahan produksi enzim pencernaan, perubahan asam lambung, penggunaan obat jangka

panjang, serta penyakit tertentu dapat memengaruhi kemampuan tubuh menyerap zat gizi. Akibatnya, meskipun lansia makan, tubuh belum tentu mendapatkan zat gizi secara optimal. Kekurangan zat gizi tertentu dapat menyebabkan anemia, kelemahan, gangguan daya tahan tubuh, gangguan tulang, atau penurunan fungsi saraf. Oleh karena itu, pemantauan status gizi lansia perempuan penting dilakukan, terutama jika terdapat penurunan berat badan tanpa sebab jelas, lemah berkepanjangan, pucat, mudah sakit, atau nafsu makan menurun.

Perubahan kulit, rambut, dan kuku merupakan perubahan fisik yang mudah terlihat pada lansia perempuan. Kulit lansia cenderung menjadi lebih tipis, kering, keriput, dan kurang elastis. Hal ini terjadi karena produksi kolagen dan elastin menurun, kadar air dalam kulit berkurang, serta kelenjar minyak menghasilkan lebih sedikit minyak alami. Kulit yang kering dan tipis lebih mudah mengalami gatal, luka, memar, atau iritasi. Pada lansia yang kurang bergerak atau lebih banyak berbaring, risiko luka tekan juga meningkat. Perawatan kulit menjadi penting dengan menjaga kebersihan, menggunakan pelembap, memenuhi kebutuhan cairan, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, dan memperhatikan area tubuh yang mudah tertekan.

Rambut lansia perempuan juga mengalami perubahan, seperti memutih, menipis, lebih mudah rontok, atau pertumbuhan yang lebih lambat. Perubahan ini dipengaruhi oleh penuaan folikel rambut, faktor hormonal, nutrisi, penyakit, dan penggunaan obat tertentu. Bagi sebagian lansia perempuan, perubahan rambut dan kulit dapat memengaruhi kepercayaan diri karena penampilan sering berkaitan dengan konsep diri. Oleh karena itu, perubahan fisik ini perlu dipahami sebagai bagian alami dari penuaan, namun tetap dapat dirawat agar lansia merasa nyaman dan percaya diri. Perawatan diri sederhana, seperti menjaga kebersihan rambut, berpakaian rapi, dan merawat kulit, dapat membantu lansia mempertahankan harga diri.

Kuku juga mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Kuku dapat menjadi lebih tebal, rapuh, kering, mudah pecah, atau tumbuh lebih lambat. Pada lansia dengan gangguan sirkulasi atau diabetes, perawatan kuku perlu dilakukan dengan hati-hati karena luka kecil dapat sulit sembuh dan berisiko infeksi. Kuku kaki yang terlalu panjang atau menebal juga dapat mengganggu cara berjalan dan meningkatkan risiko jatuh. Oleh sebab itu, perawatan kuku yang aman, penggunaan alas kaki yang sesuai, dan pemeriksaan kaki secara rutin penting dilakukan, terutama pada lansia dengan penyakit kronis.

Perubahan sistem sensorik juga sangat memengaruhi kehidupan lansia perempuan. Penglihatan biasanya mengalami penurunan akibat perubahan pada

lensa mata, retina, atau saraf penglihatan. Lansia dapat mengalami kesulitan melihat dekat, penglihatan kabur, sensitif terhadap cahaya, sulit melihat pada malam hari, atau mengalami penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula. Gangguan penglihatan dapat menghambat aktivitas membaca, memasak, berjalan, mengenali wajah, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, gangguan penglihatan juga meningkatkan risiko jatuh. Pemeriksaan mata berkala, pencahayaan rumah yang cukup, penggunaan kacamata sesuai kebutuhan, dan penataan rumah yang aman sangat penting bagi lansia perempuan.

Pendengaran juga dapat menurun pada usia lanjut. Lansia perempuan mungkin mengalami kesulitan mendengar suara pelan, sulit memahami percakapan di tempat ramai, sering meminta orang lain mengulang perkataan, atau salah menangkap informasi. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan lansia merasa malu, kesal, atau memilih menarik diri dari interaksi sosial. Jika tidak ditangani, penurunan pendengaran dapat meningkatkan risiko kesepian dan gangguan komunikasi dalam keluarga. Keluarga perlu berbicara dengan jelas, tidak berteriak, menghadap ke arah lansia saat berbicara, serta memastikan lansia memahami pesan yang disampaikan. Pemeriksaan pendengaran juga diperlukan apabila gangguan sudah menghambat aktivitas.

Selain penglihatan dan pendengaran, penciuman dan pengecapan juga dapat menurun. Penurunan penciuman dapat membuat lansia sulit mencium bau makanan, asap, gas, atau bau yang menandakan bahaya. Penurunan pengecapan dapat membuat makanan terasa hambar sehingga nafsu makan menurun. Lansia mungkin menambahkan terlalu banyak garam atau gula agar makanan terasa lebih kuat, padahal hal ini dapat memperburuk hipertensi atau diabetes. Oleh karena itu, keluarga perlu membantu menyediakan makanan yang tetap menarik, bergizi, dan aman tanpa berlebihan menggunakan garam atau gula. Penurunan penciuman juga membuat keamanan rumah perlu diperhatikan, misalnya memastikan kompor dimatikan dan ventilasi baik.

Perubahan pada sistem reproduksi dan urogenital merupakan aspek penting pada lansia perempuan. Setelah menopause, penurunan estrogen menyebabkan jaringan vagina dan saluran kemih menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis. Kekeringan vagina dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal, nyeri saat berhubungan seksual, atau mudah iritasi. Perubahan ini dapat memengaruhi fungsi seksual dan hubungan intim. Lansia perempuan mungkin merasa malu membicarakan keluhan ini, padahal masalah tersebut umum terjadi dan dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat. Tenaga kesehatan perlu menciptakan

suasana komunikasi yang aman agar lansia berani menyampaikan keluhan reproduksi dan seksual tanpa merasa dihakimi.

Inkontinensia urine juga sering dialami lansia perempuan. Inkontinensia urine adalah kondisi keluarnya urine tanpa dapat dikontrol sepenuhnya. Hal ini dapat terjadi karena melemahnya otot dasar panggul, perubahan jaringan urogenital, riwayat persalinan, obesitas, infeksi saluran kemih, penyakit kronis, atau gangguan saraf. Inkontinensia dapat menyebabkan rasa malu, tidak nyaman, gangguan tidur, iritasi kulit, dan penurunan kepercayaan diri. Lansia perempuan yang mengalami inkontinensia mungkin mengurangi kegiatan sosial karena takut mengompol atau berbau urine. Padahal, kondisi ini dapat dibantu dengan latihan otot dasar panggul, pengaturan cairan, menjaga kebersihan, penggunaan alat bantu yang sesuai, serta pemeriksaan kesehatan bila terdapat keluhan infeksi atau gangguan lain.

Perubahan fungsi seksual pada lansia perempuan juga perlu dipahami secara manusiawi. Penuaan tidak berarti lansia kehilangan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan emosional, dan kehidupan seksual. Namun, perubahan fisik seperti kekeringan vagina, nyeri, penyakit kronis, kelelahan, perubahan citra tubuh, atau kehilangan pasangan dapat memengaruhi kehidupan seksual. Sebagian lansia perempuan mungkin mengalami penurunan gairah seksual, sementara sebagian lainnya masih memiliki kebutuhan intim tetapi merasa malu membicarakannya. Tenaga kesehatan dan keluarga perlu menghargai aspek ini sebagai bagian dari kesehatan dan kualitas hidup. Pendekatan yang sensitif, sopan, dan tidak menghakimi sangat penting agar lansia perempuan mendapatkan informasi dan dukungan yang sesuai.

perubahan fisik pada lansia perempuan mencakup berbagai sistem tubuh, mulai dari sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, kulit, rambut, kuku, sistem sensorik, hingga sistem reproduksi dan urogenital. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses penuaan, tetapi dampaknya dapat berbeda pada setiap individu. Sebagian perubahan dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas, penurunan kemandirian, risiko jatuh, gangguan nutrisi, masalah komunikasi, gangguan kenyamanan, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, lansia perempuan membutuhkan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan, dukungan keluarga, gaya hidup sehat, lingkungan yang aman, serta pelayanan kesehatan yang holistik. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, perubahan fisik akibat penuaan dapat dikelola sehingga lansia perempuan tetap dapat menjalani kehidupan secara lebih sehat, nyaman, mandiri, dan bermartabat.

D. Masalah Kesehatan yang Sering Dialami Lansia Perempuan

Lansia perempuan merupakan kelompok usia yang rentan mengalami berbagai masalah kesehatan akibat proses penuaan, perubahan hormonal pascamenopause, riwayat reproduksi, gaya hidup, serta adanya penyakit kronis yang berkembang secara bertahap. Masalah kesehatan pada lansia perempuan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memengaruhi kemandirian, psikologis, hubungan sosial, dan kualitas hidup. Berbagai gangguan seperti osteoporosis, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan tidur, nyeri kronis, inkontinensia urine, malnutrisi, anemia, gangguan keseimbangan, dan risiko jatuh perlu dipahami secara menyeluruh agar dapat dilakukan pencegahan, deteksi dini, serta penanganan yang tepat.

Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami lansia perempuan adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi berkurangnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Lansia perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki karena setelah menopause terjadi penurunan hormon estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Penurunan estrogen mempercepat proses pengeroposan tulang, terutama pada tulang belakang, panggul, pergelangan tangan, dan tulang paha. Kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak lansia perempuan baru menyadari adanya masalah setelah mengalami nyeri punggung, postur tubuh membungkuk, tinggi badan berkurang, atau patah tulang akibat benturan ringan.

Osteoporosis sangat berkaitan dengan peningkatan risiko fraktur atau patah tulang. Pada lansia perempuan, fraktur dapat terjadi hanya karena jatuh ringan, terpeleset, atau gerakan sederhana yang memberikan tekanan pada tulang yang rapuh. Patah tulang panggul merupakan salah satu komplikasi serius karena dapat menyebabkan lansia sulit berjalan, membutuhkan perawatan lama, mengalami ketergantungan, bahkan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Selain itu, fraktur tulang belakang dapat menyebabkan nyeri kronis, perubahan postur, dan gangguan pernapasan akibat bentuk tubuh yang membungkuk. Oleh karena itu, pencegahan osteoporosis menjadi sangat penting melalui asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, aktivitas fisik sesuai kemampuan, paparan sinar matahari yang aman, pencegahan jatuh, serta pemeriksaan kesehatan tulang bila diperlukan.

Masalah kesehatan lain yang sering dialami lansia perempuan adalah penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit pembuluh darah. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ dan perubahan metabolisme tubuh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi banyak

ditemukan pada lansia karena pembuluh darah menjadi lebih kaku, elastisitas pembuluh menurun, serta kemampuan tubuh mengatur tekanan darah tidak seoptimal saat usia muda. Hipertensi sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Karena itu, pemeriksaan tekanan darah secara berkala sangat penting bagi lansia perempuan.

Diabetes melitus juga menjadi masalah kesehatan yang cukup sering terjadi pada lansia perempuan. Kondisi ini terjadi ketika kadar gula darah meningkat akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Pada lansia, diabetes dapat dipengaruhi oleh faktor usia, riwayat keluarga, pola makan tinggi gula dan kalori, kurang aktivitas fisik, obesitas, serta perubahan metabolisme tubuh. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti gangguan penglihatan, gangguan ginjal, luka yang sulit sembuh, kesemutan, gangguan saraf, serta peningkatan risiko infeksi. Pada lansia perempuan, diabetes juga dapat memperburuk gangguan urogenital, seperti infeksi saluran kemih atau keluhan berkemih. Oleh sebab itu, pengendalian gula darah, pola makan seimbang, aktivitas fisik, kepatuhan obat, dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi.

Penyakit jantung juga perlu mendapat perhatian serius pada lansia perempuan. Setelah menopause, risiko penyakit jantung meningkat karena penurunan estrogen dapat memengaruhi metabolisme lemak, elastisitas pembuluh darah, dan kesehatan sistem kardiovaskular. Lansia perempuan dapat mengalami keluhan seperti cepat lelah, sesak saat beraktivitas, nyeri dada, jantung berdebar, pusing, atau bengkak pada tungkai. Namun, gejala penyakit jantung pada perempuan kadang tidak khas, sehingga sering terlambat dikenali. Penyakit jantung dapat membatasi aktivitas harian dan meningkatkan ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, gaya hidup sehat, pengendalian tekanan darah, pengaturan kadar gula dan kolesterol, serta pemeriksaan kesehatan berkala menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan jantung lansia perempuan.

Gangguan tidur merupakan masalah yang sering dialami lansia perempuan dan dapat memengaruhi kesehatan secara luas. Seiring bertambahnya usia, pola tidur cenderung berubah. Lansia sering lebih mudah terbangun pada malam hari, sulit memulai tidur, bangun terlalu pagi, atau merasa tidur tidak nyenyak. Pada perempuan, gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh perubahan hormonal pascamenopause, sering buang air kecil pada malam hari, nyeri sendi, kecemasan, kesepian, efek obat, atau penyakit kronis. Tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan kelelahan, mudah marah, penurunan konsentrasi, gangguan daya

ingat, penurunan daya tahan tubuh, dan peningkatan risiko jatuh akibat mengantuk atau lemah pada siang hari.

Kelelahan pada lansia perempuan dapat muncul sebagai akibat dari gangguan tidur, anemia, penyakit kronis, kurang aktivitas fisik, malnutrisi, gangguan emosi, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Kelelahan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa pada lansia, terutama jika berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lansia yang sering merasa lelah dapat menjadi kurang bergerak, kehilangan minat melakukan kegiatan, lebih banyak berbaring, dan akhirnya mengalami penurunan massa otot serta kemandirian. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab kelelahan secara menyeluruh, apakah berasal dari masalah fisik, psikologis, pola tidur, nutrisi, atau penyakit tertentu.

Nyeri kronis juga banyak dialami oleh lansia perempuan. Nyeri kronis dapat berasal dari osteoarthritis, osteoporosis, nyeri punggung, gangguan saraf, penyakit degeneratif sendi, atau cedera lama. Nyeri yang berlangsung lama dapat menyebabkan lansia membatasi gerakan, menghindari aktivitas, sulit tidur, mudah lelah, dan mengalami perubahan suasana hati. Pada lansia perempuan, nyeri kronis dapat mengurangi kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga, berjalan, beribadah, mengikuti kegiatan sosial, dan merawat diri. Jika tidak ditangani, nyeri kronis dapat menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Penanganan nyeri pada lansia perlu dilakukan secara hati-hati, mencakup pengkajian lokasi, intensitas, durasi, faktor pencetus, dampak terhadap aktivitas, serta terapi yang aman sesuai kondisi kesehatan lansia.

Keterbatasan mobilitas sering muncul sebagai akibat dari nyeri kronis, kelemahan otot, gangguan sendi, penyakit saraf, gangguan keseimbangan, atau rasa takut jatuh. Lansia perempuan yang mengalami keterbatasan mobilitas dapat mengalami kesulitan berjalan, berdiri lama, naik tangga, mandi, berpakaian, memasak, atau melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Keterbatasan mobilitas dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat lansia merasa menjadi beban keluarga. Selain itu, kurang bergerak dapat memperburuk kondisi fisik karena menyebabkan otot semakin lemah, sendi semakin kaku, sirkulasi darah menurun, dan risiko luka tekan meningkat. Oleh karena itu, lansia perlu didorong untuk tetap aktif sesuai kemampuan dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Inkontinensia urine merupakan masalah kesehatan urogenital yang cukup sering dialami lansia perempuan. Inkontinensia urine adalah keluarnya urine secara tidak sengaja atau sulit dikontrol. Kondisi ini dapat terjadi karena melemahnya otot dasar panggul, perubahan jaringan saluran kemih akibat penurunan estrogen, riwayat persalinan, obesitas, infeksi saluran kemih, gangguan saraf, atau penyakit

kronis tertentu. Inkontinensia urine sering menimbulkan rasa malu, tidak percaya diri, takut bepergian, gangguan tidur, iritasi kulit, dan risiko infeksi. Banyak lansia perempuan enggan membicarakan masalah ini karena merasa malu, padahal keluhan tersebut dapat dikaji dan dibantu melalui latihan otot dasar panggul, pengaturan cairan, menjaga kebersihan, penggunaan pelindung yang tepat, serta pemeriksaan kesehatan bila ada tanda infeksi.

Gangguan kesehatan urogenital pascamenopause juga dapat mencakup kekeringan vagina, rasa gatal, nyeri saat berhubungan seksual, infeksi saluran kemih berulang, atau rasa tidak nyaman pada area genital. Penurunan estrogen menyebabkan jaringan vagina dan saluran kemih menjadi lebih tipis, kering, dan mudah iritasi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan seksual, hubungan dengan pasangan, dan harga diri lansia perempuan. Tenaga kesehatan dan keluarga perlu memiliki sikap yang sensitif dan tidak menghakimi karena masalah urogenital sering dianggap tabu untuk dibicarakan. Lansia perempuan perlu diberi ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan agar dapat memperoleh bantuan yang sesuai.

Masalah nutrisi juga sering terjadi pada lansia perempuan. Malnutrisi dapat berupa kekurangan gizi, kelebihan berat badan, atau ketidakseimbangan asupan zat gizi. Pada lansia, nafsu makan dapat menurun akibat perubahan pengecap dan penciuman, masalah gigi, kesulitan mengunyah, kesulitan menelan, gangguan pencernaan, kesepian, depresi, penyakit kronis, atau efek obat. Jika asupan makanan tidak mencukupi, lansia dapat mengalami penurunan berat badan, kelemahan, penurunan massa otot, mudah sakit, dan penyembuhan luka yang lambat. Sebaliknya, pola makan tinggi gula, garam, dan lemak dapat memperburuk hipertensi, diabetes melitus, obesitas, dan penyakit jantung. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi pada lansia perempuan perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemampuan makan, dan kebutuhan tubuh.

Anemia juga dapat dialami lansia perempuan, meskipun mereka sudah tidak mengalami menstruasi. Anemia pada lansia dapat disebabkan oleh kurang asupan zat besi, vitamin B12, asam folat, penyakit kronis, gangguan penyerapan zat gizi, perdarahan saluran cerna, atau gangguan ginjal. Gejala anemia dapat berupa lemah, pucat, mudah lelah, pusing, berdebar, sesak saat aktivitas, dan penurunan konsentrasi. Pada lansia, anemia dapat memperburuk kelemahan fisik, meningkatkan risiko jatuh, dan menurunkan kemampuan beraktivitas. Oleh karena itu, jika lansia perempuan tampak sangat lemah atau cepat lelah, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap status nutrisi, riwayat penyakit, dan kemungkinan anemia.

Perubahan berat badan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan dapat menunjukkan adanya masalah serius, seperti malnutrisi, depresi, gangguan pencernaan, penyakit kronis, infeksi, atau kanker. Sementara itu, peningkatan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, penyakit jantung, nyeri sendi, dan gangguan mobilitas. Pada lansia perempuan, perubahan komposisi tubuh setelah menopause dapat menyebabkan peningkatan lemak tubuh dan penurunan massa otot, meskipun berat badan tampak tidak banyak berubah. Oleh karena itu, pemantauan berat badan, lingkaran perut, kekuatan otot, dan pola makan menjadi penting dalam menjaga kesehatan lansia.

Gangguan keseimbangan merupakan masalah yang sering dialami lansia perempuan dan sangat berkaitan dengan risiko jatuh. Keseimbangan dapat menurun akibat kelemahan otot, gangguan sendi, penurunan penglihatan, gangguan telinga bagian dalam, tekanan darah yang mudah turun saat berdiri, efek obat, atau gangguan saraf. Lansia yang mengalami gangguan keseimbangan mungkin merasa goyah saat berjalan, takut berdiri dari duduk, sering berpegangan pada dinding, atau pernah hampir jatuh. Gangguan keseimbangan dapat membuat lansia membatasi aktivitas karena takut jatuh. Namun, pembatasan aktivitas yang berlebihan justru dapat menyebabkan otot semakin lemah dan risiko jatuh semakin tinggi.

Risiko jatuh merupakan salah satu masalah penting pada lansia perempuan karena dampaknya dapat sangat serius. Jatuh dapat menyebabkan luka, memar, patah tulang, cedera kepala, ketakutan beraktivitas, dan penurunan kemandirian. Pada lansia perempuan dengan osteoporosis, jatuh ringan pun dapat menyebabkan fraktur. Faktor risiko jatuh dapat berasal dari kondisi tubuh lansia maupun lingkungan. Faktor dari tubuh meliputi kelemahan otot, nyeri sendi, gangguan penglihatan, pusing, penggunaan obat penenang atau obat tekanan darah tertentu, dan gangguan keseimbangan. Faktor lingkungan meliputi lantai licin, pencahayaan kurang, karpet yang mudah tersandung, kamar mandi tanpa pegangan, tangga curam, dan alas kaki yang tidak sesuai. Pencegahan jatuh perlu dilakukan melalui latihan keseimbangan, penggunaan alat bantu, penataan rumah yang aman, serta pemeriksaan obat dan kesehatan secara berkala.

Penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari merupakan dampak lanjutan dari berbagai masalah kesehatan fisik pada lansia perempuan. Aktivitas sehari-hari mencakup mandi, berpakaian, makan, berjalan, menggunakan toilet, berpindah tempat, memasak, membersihkan rumah, mengelola obat, dan berinteraksi dengan lingkungan. Ketika lansia mengalami nyeri, kelemahan, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, atau penyakit kronis,

kemampuan melakukan aktivitas tersebut dapat menurun. Penurunan kemandirian sering menimbulkan dampak psikologis, seperti rasa sedih, malu, tidak berguna, atau takut menjadi beban keluarga. Oleh karena itu, dukungan kepada lansia harus diberikan dengan tetap mempertahankan harga diri dan kemandirian semaksimal mungkin.

Dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan pada lansia perempuan, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik dan berkesinambungan. Masalah kesehatan jarang berdiri sendiri. Osteoporosis dapat meningkatkan risiko jatuh, jatuh dapat menyebabkan fraktur, fraktur dapat menurunkan mobilitas, mobilitas yang menurun dapat menyebabkan ketergantungan dan depresi. Demikian pula, gangguan tidur dapat memperburuk kelelahan, kelelahan dapat menurunkan aktivitas fisik, dan kurang aktivitas fisik dapat memperburuk penyakit kronis. Oleh karena itu, pengkajian dan penanganan lansia perempuan harus melihat hubungan antar masalah secara menyeluruh.

Keluarga memiliki peran penting dalam membantu lansia perempuan menghadapi masalah kesehatan tersebut. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan bergizi, mendampingi pemeriksaan kesehatan, memastikan obat diminum sesuai anjuran, membantu menciptakan lingkungan rumah yang aman, mendukung aktivitas fisik ringan, dan memberikan dukungan emosional. Namun, keluarga juga perlu memahami bahwa bantuan sebaiknya tidak membuat lansia kehilangan kemandirian. Lansia perempuan tetap perlu diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Dukungan yang tepat akan membantu lansia merasa dihargai dan tetap bermakna.

Dari pembahasan diatas, masalah kesehatan yang sering dialami lansia perempuan mencakup osteoporosis dan risiko fraktur, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan tidur, kelelahan, nyeri kronis, keterbatasan mobilitas, inkontinensia urine, gangguan urogenital pascamenopause, malnutrisi, anemia, perubahan berat badan, gangguan keseimbangan, risiko jatuh, serta penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari. Masalah-masalah tersebut dapat memengaruhi kemandirian, kenyamanan, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas hidup lansia perempuan. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini, pencegahan, pengelolaan penyakit kronis, dukungan nutrisi, aktivitas fisik yang aman, lingkungan yang ramah lansia, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan agar lansia perempuan dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, mandiri, dan bermartabat.

E. Perubahan Psikologis pada Lansia Perempuan

Perubahan psikologis pada lansia perempuan merupakan bagian penting dari proses penuaan yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan fisik, sosial, spiritual, dan pengalaman hidup yang telah dilalui. Memasuki masa lanjut usia, seorang perempuan tidak hanya menghadapi penurunan fungsi tubuh, tetapi juga berbagai perubahan dalam cara memandang diri, merasakan emosi, menjalani peran, berhubungan dengan orang lain, dan memaknai kehidupan. Perubahan psikologis ini dapat berlangsung secara perlahan dan berbeda pada setiap individu. Ada lansia perempuan yang mampu menerima masa tua dengan tenang, tetap aktif, dan merasa hidupnya bermakna. Namun, ada pula lansia perempuan yang mengalami kecemasan, kesedihan, kesepian, kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi akibat perubahan yang terjadi dalam kehidupannya.

Salah satu perubahan psikologis yang sering terjadi pada lansia perempuan adalah perubahan konsep diri. Konsep diri merupakan cara seseorang memandang, menilai, dan menerima dirinya sendiri. Pada lansia perempuan, konsep diri dapat berubah karena adanya perubahan fisik seperti kulit keriput, rambut memutih, tubuh menjadi lebih lemah, munculnya penyakit kronis, perubahan bentuk tubuh, serta berkurangnya kemampuan melakukan aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri. Perempuan yang pada masa muda terbiasa aktif, produktif, dan memiliki banyak peran mungkin merasa tidak nyaman ketika kemampuan fisiknya mulai menurun. Perubahan penampilan dan fungsi tubuh dapat menimbulkan perasaan kurang percaya diri, malu, atau merasa tidak lagi menarik.

Penerimaan terhadap proses penuaan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan psikologis lansia perempuan. Penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, tetapi cara seseorang menerima proses tersebut sangat memengaruhi kesejahteraan mentalnya. Lansia perempuan yang mampu menerima perubahan usia biasanya lebih mudah beradaptasi dengan keterbatasan yang muncul. Mereka dapat melihat masa tua sebagai fase kehidupan yang tetap memiliki makna, kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga, memperkuat spiritualitas, berbagi pengalaman, dan menikmati kehidupan dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, lansia yang sulit menerima penuaan dapat merasa marah, kecewa, rendah diri, atau terus membandingkan dirinya dengan masa lalu. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan menghambat proses adaptasi.

Perubahan konsep diri juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan memperlakukan lansia perempuan. Jika keluarga dan masyarakat tetap menghargai pendapat, pengalaman, dan keberadaan lansia, maka lansia akan lebih mudah mempertahankan harga dirinya. Namun, jika lansia sering dianggap tidak

mampu, tidak produktif, merepotkan, atau tidak dilibatkan dalam keputusan keluarga, maka konsep dirinya dapat menurun. Lansia perempuan dapat merasa tidak lagi dibutuhkan atau merasa menjadi beban. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting untuk membantu lansia tetap merasa dihargai. Memberikan kesempatan kepada lansia untuk melakukan aktivitas sesuai kemampuan, mendengarkan pendapatnya, serta melibatkannya dalam kehidupan keluarga dapat memperkuat penerimaan diri dan harga diri lansia.

Perubahan emosi juga sering dialami oleh lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, sebagian lansia menjadi lebih mudah cemas, lebih sensitif, mudah sedih, mudah tersinggung, atau merasa kesepian. Perubahan emosi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perubahan hormonal setelah menopause, penyakit kronis, nyeri yang berkepanjangan, gangguan tidur, keterbatasan aktivitas, kehilangan pasangan, berkurangnya interaksi sosial, serta perubahan peran dalam keluarga. Lansia perempuan yang sebelumnya memiliki banyak aktivitas mungkin merasa kehilangan rutinitas ketika memasuki masa pensiun atau ketika anak-anak sudah mandiri. Ketika aktivitas berkurang dan waktu lebih banyak dihabiskan di rumah, perasaan sepi dan kosong dapat muncul.

Kecemasan pada lansia perempuan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada lansia yang cemas terhadap kondisi kesehatannya, takut jatuh, takut menjadi beban keluarga, takut kehilangan kemandirian, atau takut menghadapi kematian. Ada pula yang cemas karena masalah ekonomi, hubungan keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Kecemasan dapat membuat lansia sulit tidur, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, sering mengeluh, atau menjadi lebih mudah marah. Kecemasan yang tidak ditangani dapat memperburuk kondisi fisik, misalnya meningkatkan tekanan darah, menurunkan nafsu makan, dan mengurangi motivasi untuk beraktivitas. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan tenaga kesehatan untuk mengenali tanda kecemasan pada lansia dan memberikan dukungan yang menenangkan.

Rasa sensitif dan mudah tersinggung juga dapat terjadi pada lansia perempuan. Kondisi ini sering kali bukan semata-mata karena sifat lansia berubah, tetapi dapat merupakan respons terhadap perasaan tidak aman, kurang dihargai, nyeri kronis, kelelahan, atau kesulitan menerima perubahan. Lansia perempuan mungkin merasa tersinggung ketika merasa pendapatnya diabaikan, aktivitasnya dibatasi tanpa penjelasan, atau ketika keluarga berbicara seolah-olah dirinya tidak mampu memahami sesuatu. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang sabar dan penuh penghargaan sangat penting. Keluarga perlu memahami bahwa lansia tetap memiliki kebutuhan untuk dihormati, didengarkan, dan diberi ruang untuk menyampaikan perasaan.

Kesedihan dan rasa kesepian merupakan masalah emosional yang banyak dialami lansia perempuan. Kesepian dapat terjadi meskipun lansia tinggal bersama keluarga, terutama jika tidak ada komunikasi yang hangat, tidak dilibatkan dalam kegiatan keluarga, atau merasa tidak memiliki teman berbicara. Lansia perempuan yang kehilangan pasangan hidup juga berisiko mengalami kesepian yang mendalam karena kehilangan figur yang selama bertahun-tahun menjadi teman, pendamping, dan sumber dukungan emosional. Kesepian dapat membuat lansia kehilangan minat, lebih banyak diam, menarik diri, menangis, atau merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Jika berlangsung lama, kesepian dapat berkembang menjadi depresi.

Risiko depresi pada lansia perempuan perlu mendapat perhatian serius. Depresi pada lansia sering tidak dikenali karena gejalanya dapat tampak seperti keluhan fisik biasa, misalnya lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, nyeri tubuh, atau kurang semangat. Padahal, depresi merupakan gangguan suasana hati yang dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu fungsi sehari-hari. Lansia perempuan memiliki risiko depresi karena berbagai faktor, seperti kehilangan pasangan, hidup sendiri, penyakit kronis, nyeri berkepanjangan, keterbatasan ekonomi, penurunan kemandirian, konflik keluarga, serta kurangnya dukungan sosial. Depresi juga dapat muncul ketika lansia merasa tidak berguna, tidak dihargai, atau kehilangan tujuan hidup.

Depresi pada lansia perempuan dapat ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, mudah menangis, merasa tidak berharga, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, menarik diri dari lingkungan, sulit berkonsentrasi, dan muncul pikiran tentang kematian. Pada beberapa lansia, depresi tidak selalu tampak sebagai kesedihan yang jelas. Mereka mungkin lebih sering mengeluh sakit, tampak mudah marah, atau menolak berinteraksi. Oleh karena itu, keluarga dan tenaga kesehatan perlu peka terhadap perubahan perilaku lansia. Depresi pada lansia tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, karena kondisi ini dapat ditangani melalui dukungan emosional, aktivitas bermakna, konseling, pendekatan spiritual, dan bila diperlukan penanganan medis.

Penurunan daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif juga merupakan perubahan psikologis yang sering dikaitkan dengan proses penuaan. Pada lansia, kemampuan mengingat informasi baru dapat menurun. Lansia mungkin lebih sering lupa meletakkan barang, lupa nama seseorang, membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi, atau sulit berkonsentrasi dalam percakapan panjang. Penurunan ringan dalam daya ingat dapat menjadi bagian dari proses penuaan normal. Namun, apabila gangguan memori semakin berat hingga

mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti lupa jalan pulang, lupa makan, tidak mampu mengelola uang, atau tidak mengenali anggota keluarga, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dapat mengarah pada gangguan kognitif yang lebih serius.

Fungsi kognitif lansia perempuan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kesehatan otak, penyakit kronis, kualitas tidur, nutrisi, aktivitas mental, tingkat pendidikan, interaksi sosial, dan kondisi emosional. Lansia yang mengalami depresi atau kecemasan juga dapat tampak sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Oleh karena itu, ketika lansia mengalami penurunan daya ingat, perlu dilihat secara menyeluruh apakah penyebabnya adalah penuaan normal, kurang tidur, efek obat, depresi, gangguan metabolik, atau masalah neurologis. Stimulasi kognitif sangat penting untuk menjaga fungsi otak, misalnya melalui membaca, berdiskusi, menulis, bermain permainan sederhana, mengikuti kegiatan sosial, menghafal doa atau lagu, dan melakukan aktivitas yang melibatkan pemikiran.

Perasaan kehilangan merupakan pengalaman psikologis yang sering dialami lansia perempuan. Kehilangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan pekerjaan karena pensiun, kehilangan pasangan karena kematian, kehilangan teman sebaya, kehilangan kemandirian, kehilangan peran dalam keluarga, atau kehilangan kemampuan fisik yang dahulu dimiliki. Pensiun dapat menjadi pengalaman yang berat bagi perempuan yang sebelumnya aktif bekerja atau memiliki kegiatan produktif. Setelah pensiun, lansia mungkin merasa kehilangan rutinitas, identitas diri, penghasilan, atau hubungan sosial di tempat kerja. Jika tidak memiliki kegiatan pengganti, masa pensiun dapat menimbulkan rasa kosong dan kurang bermakna.

Kematian pasangan merupakan bentuk kehilangan yang sangat besar bagi lansia perempuan. Kehilangan pasangan tidak hanya berarti kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga kehilangan teman berbicara, pendamping hidup, dukungan emosional, dan bagian penting dari identitas keluarga. Lansia perempuan yang menjadi janda dapat mengalami kesepian, kesedihan mendalam, kecemasan ekonomi, dan perubahan peran dalam keluarga. Proses berduka membutuhkan waktu dan dukungan. Keluarga perlu memberikan perhatian, mendengarkan cerita lansia, mengajak lansia tetap terlibat dalam aktivitas, dan tidak memaksa lansia segera melupakan kehilangan. Dukungan yang sabar dapat membantu lansia melewati masa berduka secara lebih sehat.

Perubahan peran dalam keluarga juga dapat menimbulkan perasaan kehilangan. Ketika anak-anak sudah mandiri, menikah, atau tinggal terpisah, lansia perempuan dapat merasa rumah menjadi sepi dan perannya sebagai ibu berkurang. Pada sebagian keluarga, lansia tetap dilibatkan dalam pengasuhan cucu

atau kegiatan rumah tangga, tetapi pada keluarga lain lansia mungkin merasa tersisih. Perubahan ini dapat menimbulkan perasaan tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk tetap memberi ruang bagi lansia perempuan agar merasa memiliki peran. Peran tersebut tidak harus berat, tetapi dapat berupa memberi nasihat, membantu aktivitas ringan, berpartisipasi dalam kegiatan keluarga, atau menjadi sumber nilai dan pengalaman bagi generasi muda.

Mekanisme koping merupakan cara seseorang menghadapi tekanan, perubahan, atau masalah dalam hidup. Lansia perempuan membutuhkan mekanisme koping yang adaptif agar mampu menghadapi proses penuaan, penyakit, kehilangan, dan perubahan sosial. Koping adaptif dapat berupa menerima perubahan secara bertahap, berbicara dengan orang yang dipercaya, mengikuti kegiatan sosial, berdoa, melakukan aktivitas yang disukai, menjaga rutinitas, berolahraga ringan, dan mencari bantuan ketika mengalami kesulitan. Lansia perempuan yang memiliki koping adaptif biasanya lebih mampu mempertahankan ketenangan, mengelola emosi, dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna meskipun menghadapi keterbatasan.

Sebaliknya, koping maladaptif dapat memperburuk kondisi psikologis lansia. Contohnya adalah menarik diri terus-menerus, menolak bantuan, menyangkal penyakit, mudah marah tanpa mencari solusi, menyalahkan orang lain, atau berhenti melakukan aktivitas yang bermanfaat. Koping maladaptif dapat membuat lansia semakin terisolasi dan sulit menerima dukungan. Tenaga kesehatan dan keluarga perlu membantu lansia mengenali cara menghadapi masalah yang lebih sehat. Misalnya, jika lansia sering merasa sedih karena kesepian, keluarga dapat mengajak lansia mengikuti kegiatan sosial atau menyediakan waktu khusus untuk berbicara. Jika lansia merasa tidak berguna, keluarga dapat memberi kesempatan melakukan aktivitas ringan yang membuat lansia merasa bermakna.

Dukungan spiritual memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, banyak lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, hubungan dengan Tuhan, kematian, serta pengalaman hidup yang telah dilalui. Spiritualitas dapat memberikan ketenangan, harapan, penerimaan, dan kekuatan dalam menghadapi penyakit atau kehilangan. Kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, membaca kitab suci, mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan, serta berbagi pengalaman rohani dapat membantu lansia merasa lebih damai. Dukungan spiritual juga dapat membantu lansia menerima proses penuaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memiliki nilai dan makna.

Dukungan keluarga merupakan faktor pelindung yang sangat penting bagi kesehatan mental lansia perempuan. Keluarga dapat memberikan dukungan

emosional melalui perhatian, kasih sayang, komunikasi yang hangat, dan kesediaan mendengarkan. Dukungan keluarga juga dapat berupa bantuan praktis, seperti mendampingi kontrol kesehatan, membantu minum obat, menyediakan makanan bergizi, menjaga keamanan rumah, dan membantu aktivitas sehari-hari. Namun, dukungan harus diberikan dengan cara yang tetap menghargai kemandirian lansia. Lansia perempuan perlu merasa dibantu, bukan dikendalikan. Mereka perlu merasa dihargai, bukan dianggap lemah. Keseimbangan antara memberi bantuan dan menjaga harga diri sangat penting dalam mendukung kesehatan psikologis lansia.

Lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental lansia perempuan. Lansia yang memiliki hubungan baik dengan tetangga, teman sebaya, komunitas, dan kelompok keagamaan biasanya memiliki rasa keterhubungan yang lebih baik. Kegiatan sosial dapat membantu mengurangi kesepian, meningkatkan rasa bermakna, dan memberi kesempatan lansia untuk berbagi cerita. Lingkungan yang ramah lansia dapat membuat lansia merasa aman, diterima, dan dihargai. Sebaliknya, lingkungan yang tidak peduli, penuh stigma, atau tidak memberi ruang bagi lansia dapat memperburuk kesepian dan penurunan harga diri. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran dalam menciptakan suasana yang mendukung lansia untuk tetap aktif dan terlibat.

Tenaga kesehatan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental lansia perempuan. Dalam pelayanan kesehatan, keluhan psikologis lansia perlu dikaji dengan serius. Lansia yang sering mengeluh lelah, sulit tidur, nyeri, atau kehilangan nafsu makan perlu dikaji tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek emosi dan sosial. Tenaga kesehatan perlu melakukan komunikasi yang sabar, empatik, dan menghargai pengalaman lansia. Lansia perempuan perlu diberi kesempatan untuk menceritakan perasaan, kekhawatiran, dan harapannya. Dengan pendekatan yang manusiawi, lansia akan lebih mudah terbuka dan menerima bantuan.

perubahan psikologis pada lansia perempuan mencakup perubahan konsep diri, penerimaan terhadap proses penuaan, perubahan emosi, risiko depresi, penurunan daya ingat dan fungsi kognitif, perasaan kehilangan, serta mekanisme koping dalam menghadapi perubahan hidup. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik, menopause, penyakit kronis, kehilangan peran, hubungan keluarga, dukungan sosial, dan spiritualitas. Lansia perempuan membutuhkan dukungan yang menyeluruh agar dapat menghadapi masa tua dengan lebih sehat secara mental. Dukungan keluarga, lingkungan, tenaga kesehatan, dan spiritualitas sangat penting untuk membantu lansia perempuan mempertahankan harga diri, mengelola emosi, mencegah kesepian dan depresi, serta menjalani kehidupan lanjut usia secara bermakna dan bermartabat.

F. Perubahan Sosial pada Lansia Perempuan

Perubahan sosial pada lansia perempuan merupakan bagian penting dari proses penuaan yang sering kali memengaruhi kualitas hidup secara mendalam. Ketika seorang perempuan memasuki masa lanjut usia, perubahan yang dialami tidak hanya terjadi pada tubuh dan kondisi psikologis, tetapi juga pada peran, hubungan, kedudukan, aktivitas, serta keterlibatannya dalam keluarga dan masyarakat. Perubahan sosial ini dapat berlangsung secara bertahap, bergantung pada kondisi kesehatan, status perkawinan, keadaan ekonomi, budaya, tempat tinggal, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial tempat lansia berada. Bagi sebagian lansia perempuan, masa lanjut usia dapat menjadi masa yang tenang, penuh penerimaan, dan tetap bermakna karena masih memiliki keluarga yang mendukung serta lingkungan sosial yang baik. Namun, bagi sebagian lainnya, masa lanjut usia dapat diwarnai oleh kesepian, kehilangan peran, keterbatasan aktivitas, ketergantungan, bahkan isolasi sosial.

Salah satu perubahan sosial yang paling nyata pada lansia perempuan adalah perubahan peran dalam keluarga. Pada masa dewasa, banyak perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan keluarga, seperti menjadi ibu, istri, pengasuh anak, pengelola rumah tangga, pendidik informal bagi anak, serta penjaga keharmonisan keluarga. Peran tersebut sering menjadi bagian penting dari identitas diri perempuan. Ketika memasuki usia lanjut, peran-peran tersebut dapat mengalami perubahan. Anak-anak yang dahulu diasuh kini telah dewasa, menikah, bekerja, dan memiliki kehidupan sendiri. Tanggung jawab rumah tangga mungkin mulai berkurang karena kemampuan fisik menurun atau karena tugas-tugas tersebut telah diambil alih oleh anggota keluarga lain. Perubahan ini dapat membuat lansia perempuan merasa kehilangan fungsi, terutama jika sebelumnya ia terbiasa menjadi pusat kegiatan keluarga.

Perubahan peran dalam keluarga dapat menimbulkan dua kemungkinan. Pada satu sisi, lansia perempuan dapat merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul tanggung jawab besar seperti saat usia produktif. Ia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, beribadah, menikmati kebersamaan dengan cucu, atau melakukan kegiatan yang disukai. Namun, pada sisi lain, berkurangnya peran dapat menimbulkan perasaan tidak dibutuhkan, tidak dihargai, atau merasa menjadi beban keluarga. Perasaan ini dapat muncul terutama jika keluarga tidak lagi melibatkan lansia dalam percakapan, keputusan sederhana, atau kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami bahwa meskipun lansia mengalami penurunan kemampuan fisik, mereka tetap membutuhkan peran yang bermakna. Memberikan kesempatan kepada lansia perempuan untuk terlibat

sesuai kemampuan dapat membantu mempertahankan harga diri dan rasa kebermaknaan hidup.

Dalam masyarakat, peran lansia perempuan juga dapat berubah. Sebagian lansia yang dahulu aktif dalam kegiatan sosial, pekerjaan, organisasi, atau kegiatan keagamaan mungkin mulai mengurangi keterlibatan karena keterbatasan fisik, penyakit, transportasi, atau rasa lelah. Bila sebelumnya lansia perempuan dikenal sebagai pribadi yang aktif dan banyak berinteraksi, berkurangnya aktivitas sosial dapat memengaruhi rasa percaya diri dan identitas sosialnya. Namun, banyak pula lansia perempuan yang tetap memiliki peran penting dalam masyarakat, misalnya sebagai tokoh yang dihormati, penasihat keluarga, penggerak kegiatan keagamaan, pendamping cucu, atau sumber pengalaman bagi generasi muda. Dengan dukungan lingkungan yang ramah lansia, perempuan lanjut usia tetap dapat berkontribusi dalam masyarakat sesuai kapasitasnya.

Perubahan hubungan dengan pasangan juga menjadi bagian penting dari perubahan sosial pada lansia perempuan. Bagi lansia yang masih memiliki pasangan, hubungan suami istri dapat mengalami penyesuaian karena adanya perubahan fisik, kesehatan, emosi, dan kebutuhan sehari-hari. Pada masa lanjut usia, hubungan dengan pasangan sering kali lebih banyak berpusat pada kebersamaan, saling menemani, saling merawat, dan memberikan dukungan emosional. Namun, hubungan juga dapat menghadapi tantangan apabila salah satu pasangan mengalami penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, gangguan kognitif, atau ketergantungan tinggi. Dalam kondisi tersebut, lansia perempuan dapat berperan sebagai pihak yang dirawat atau justru sebagai perawat bagi pasangannya. Peran merawat pasangan pada usia lanjut dapat menjadi sumber makna, tetapi juga dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional.

Bagi lansia perempuan yang telah kehilangan pasangan, perubahan sosial dapat terasa lebih berat. Kematian pasangan bukan hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga kehilangan teman hidup, tempat berbagi cerita, pendamping dalam aktivitas harian, dan sumber dukungan emosional. Lansia perempuan yang menjadi janda dapat mengalami kesepian, perubahan status sosial, perubahan ekonomi, serta penyesuaian terhadap kehidupan sehari-hari tanpa pasangan. Jika sebelumnya semua keputusan dan aktivitas dilakukan bersama pasangan, maka setelah pasangan meninggal, lansia perlu belajar menata kembali rutinitas dan peran sosialnya. Dukungan anak, cucu, keluarga besar, tetangga, dan komunitas sangat penting agar lansia tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa kehilangan.

Hubungan lansia perempuan dengan anak-anak juga mengalami perubahan. Pada masa sebelumnya, lansia perempuan mungkin berperan sebagai pengasuh,

pelindung, dan pengambil keputusan bagi anak-anaknya. Namun, ketika anak-anak telah dewasa, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan yang lebih setara atau bahkan berbalik, yaitu anak menjadi pihak yang membantu dan merawat orang tua. Perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh lansia. Sebagian lansia merasa bersyukur karena anak memberikan perhatian, tetapi sebagian lainnya merasa tidak nyaman karena harus bergantung pada anak. Lansia perempuan yang terbiasa mandiri dapat merasa sedih atau malu ketika harus meminta bantuan dalam aktivitas tertentu. Oleh karena itu, anak perlu memberikan bantuan dengan cara yang tetap menghargai kemandirian dan martabat lansia.

Hubungan dengan cucu dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi lansia perempuan. Banyak lansia merasa hidupnya lebih bermakna ketika dapat berinteraksi dengan cucu, bercerita, mengasuh, atau mendampingi mereka. Kehadiran cucu dapat mengurangi rasa sepi dan memberikan semangat baru. Namun, peran sebagai pengasuh cucu juga perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban berlebihan. Ada lansia perempuan yang masih harus mengurus cucu setiap hari meskipun kondisi fisiknya sudah menurun. Jika tidak disesuaikan dengan kemampuan, peran ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, atau memperburuk penyakit kronis. Oleh karena itu, keluarga perlu menyeimbangkan antara memberi kesempatan lansia terlibat dalam pengasuhan cucu dan tetap memperhatikan kesehatan serta batas kemampuan lansia.

Hubungan dengan teman sebaya juga dapat berubah seiring bertambahnya usia. Pada usia lanjut, lingkaran pertemanan dapat mengecil karena teman sebaya meninggal, sakit, pindah tempat tinggal, atau tidak lagi mampu beraktivitas seperti sebelumnya. Berkurangnya teman sebaya dapat menimbulkan rasa kehilangan dan kesepian. Padahal, teman sebaya memiliki peran penting karena lansia dapat berbagi pengalaman yang relatif sama, seperti pengalaman menjadi tua, kehilangan pasangan, menghadapi penyakit, atau menyesuaikan diri dengan perubahan peran. Interaksi dengan teman sebaya dapat memberikan rasa dipahami dan mengurangi beban emosional. Oleh karena itu, kegiatan kelompok lansia, posyandu lansia, senam lansia, kelompok pengajian, arisan, atau kegiatan komunitas dapat menjadi sarana penting untuk mempertahankan hubungan sosial.

Perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi kesejahteraan lansia perempuan. Lingkungan yang peduli, ramah, dan menghargai lansia dapat membuat lansia merasa aman dan diterima. Tetangga yang saling menyapa, membantu saat diperlukan, dan melibatkan lansia dalam kegiatan lingkungan dapat meningkatkan rasa keterhubungan sosial. Sebaliknya, lingkungan yang tidak peduli atau cenderung mengabaikan lansia dapat

memperkuat rasa sepi dan tidak berarti. Lansia perempuan yang tinggal sendiri sangat membutuhkan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar karena tetangga sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui jika terjadi masalah, seperti sakit mendadak, jatuh, atau membutuhkan bantuan.

Risiko isolasi sosial dan kesepian merupakan masalah besar pada lansia perempuan. Isolasi sosial terjadi ketika seseorang memiliki hubungan sosial yang sangat terbatas atau kurang terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Kesepian adalah perasaan subjektif ketika seseorang merasa sendiri, tidak memiliki teman dekat, atau merasa tidak terhubung secara emosional dengan orang lain. Seorang lansia bisa saja tinggal bersama keluarga, tetapi tetap merasa kesepian jika tidak ada komunikasi yang hangat, tidak dilibatkan dalam aktivitas keluarga, atau merasa tidak didengarkan. Sebaliknya, lansia yang tinggal sendiri belum tentu merasa kesepian jika memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, atau komunitas.

Kesepian pada lansia perempuan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kematian pasangan, anak yang tinggal jauh, berkurangnya teman sebaya, keterbatasan fisik, gangguan pendengaran, penyakit kronis, rasa malu karena inkontinensia urine, atau keterbatasan ekonomi. Lansia yang sulit berjalan atau memiliki risiko jatuh mungkin jarang keluar rumah, sehingga kesempatan berinteraksi berkurang. Lansia dengan gangguan pendengaran dapat menghindari percakapan karena takut salah memahami. Lansia yang merasa menjadi beban keluarga dapat menarik diri dan memilih diam. Jika kesepian berlangsung lama, dampaknya dapat serius, seperti menurunnya nafsu makan, gangguan tidur, depresi, penurunan motivasi, memburuknya penyakit, dan penurunan kualitas hidup.

Status ekonomi juga sangat memengaruhi kesejahteraan lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, sebagian lansia tidak lagi bekerja atau memiliki penghasilan tetap. Lansia perempuan yang tidak memiliki pensiun, tabungan, atau dukungan keluarga dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, transportasi, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan pribadi. Kondisi ekonomi yang terbatas dapat membuat lansia menunda berobat, mengurangi makan, atau tidak mampu membeli alat bantu seperti kacamata, tongkat, atau popok dewasa. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut dapat memperburuk kesehatan fisik dan psikologis.

Lansia perempuan juga dapat lebih rentan secara ekonomi karena sepanjang hidupnya sebagian perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan formal, pendidikan, atau jaminan sosial. Banyak perempuan bekerja di sektor informal atau berfokus pada pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan

pendapatan langsung. Ketika memasuki usia lanjut, mereka dapat bergantung pada pasangan, anak, atau keluarga besar. Ketergantungan ekonomi ini dapat memengaruhi posisi tawar lansia dalam keluarga. Lansia perempuan yang bergantung secara ekonomi mungkin merasa tidak enak meminta kebutuhan pribadi atau merasa harus menerima keputusan keluarga meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, dukungan sosial dan kebijakan pelayanan lansia sangat penting untuk melindungi kesejahteraan lansia perempuan.

Budaya memiliki pengaruh besar dalam memandang lansia perempuan. Dalam sebagian budaya, lansia perempuan dihormati sebagai sosok yang bijaksana, berpengalaman, dan menjadi penjaga nilai keluarga. Mereka sering dianggap sebagai sumber nasihat, tokoh keluarga, atau figur yang patut dihormati. Pandangan budaya seperti ini dapat memperkuat harga diri lansia dan membuat mereka tetap memiliki tempat penting dalam keluarga serta masyarakat. Namun, dalam lingkungan lain, lansia perempuan dapat mengalami stigma karena dianggap lemah, tidak produktif, bergantung, atau tidak lagi memiliki peran penting. Pandangan negatif terhadap usia tua dan perempuan dapat menyebabkan diskriminasi, pengabaian, atau penelantaran.

Budaya juga memengaruhi cara lansia perempuan mengekspresikan kebutuhan dan masalahnya. Ada lansia yang terbiasa menahan keluhan karena merasa tidak ingin merepotkan keluarga. Ada pula yang merasa tidak pantas membicarakan masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan urogenital, fungsi seksual, atau kesepian. Dalam beberapa budaya, perempuan lanjut usia diharapkan tetap kuat, sabar, dan menerima keadaan tanpa banyak mengeluh. Sikap ini dapat membuat masalah kesehatan fisik maupun psikologis tidak terungkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dan keluarga perlu memahami latar belakang budaya lansia agar dapat memberikan pendekatan yang sensitif, sopan, dan tidak menghakimi.

Keterlibatan lansia perempuan dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan komunitas sangat penting untuk mempertahankan kesejahteraan sosial dan psikologis. Kegiatan sosial memberikan kesempatan bagi lansia untuk bertemu orang lain, berbagi pengalaman, merasa dihargai, dan tetap aktif. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, kelompok keterampilan, kegiatan PKK, arisan, pengajian, kebaktian, atau kegiatan sukarela dapat membantu lansia tetap memiliki rutinitas dan tujuan. Keterlibatan dalam kegiatan sosial juga dapat meningkatkan rasa percaya diri karena lansia merasa masih mampu berkontribusi.

Kegiatan keagamaan sering memiliki makna yang sangat penting bagi lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual sering meningkat karena lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, kematian, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Mengikuti kegiatan keagamaan dapat memberikan

ketenangan, harapan, dukungan sosial, dan rasa kebersamaan. Selain itu, komunitas keagamaan sering menjadi tempat lansia memperoleh teman, perhatian, dan bantuan ketika mengalami kesulitan. Bagi lansia perempuan yang kehilangan pasangan atau tinggal jauh dari anak, kegiatan keagamaan dapat menjadi sumber dukungan emosional yang sangat berarti.

Keterlibatan dalam komunitas juga membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan emosional. Ketika lansia berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi, mengikuti kegiatan, atau belajar hal baru, otak tetap mendapatkan stimulasi. Aktivitas sosial dapat membantu menjaga daya ingat, konsentrasi, dan semangat hidup. Selain itu, keterlibatan sosial dapat mendorong lansia untuk tetap merawat diri, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan bergerak keluar rumah. Semua hal tersebut berkontribusi pada kesehatan fisik dan psikologis. Dengan demikian, aktivitas sosial bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari upaya menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh.

Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam mempertahankan kualitas hidup lansia perempuan. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, pasangan, anak, cucu, tetangga, teman sebaya, komunitas, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dukungan ini dapat berbentuk dukungan emosional, seperti perhatian, kasih sayang, mendengarkan keluhan, dan memberikan rasa aman. Dukungan juga dapat berbentuk bantuan praktis, seperti mendampingi berobat, membantu pekerjaan rumah, menyediakan makanan, atau membantu transportasi. Selain itu, dukungan informasional juga penting, misalnya memberikan informasi tentang kesehatan, jadwal posyandu lansia, atau cara mengakses pelayanan kesehatan.

Kualitas hidup lansia perempuan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa dihargai, aman, mandiri, dan terhubung dengan orang lain. Dukungan sosial yang baik dapat membantu lansia menghadapi penyakit, kehilangan, keterbatasan fisik, dan perubahan peran. Lansia yang merasa didukung biasanya lebih memiliki motivasi untuk menjaga kesehatan, mengikuti pengobatan, beraktivitas, dan terlibat dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kesepian, depresi, ketergantungan, dan penurunan fungsi tubuh. Oleh karena itu, dukungan sosial perlu dipandang sebagai kebutuhan dasar lansia, bukan sekadar tambahan.

Keluarga memiliki peran utama dalam memberikan dukungan sosial. Namun, dukungan keluarga perlu diberikan dengan cara yang tepat. Lansia perempuan perlu dibantu tanpa kehilangan kemandirian dan martabat. Jika keluarga terlalu membatasi aktivitas lansia karena takut terjadi sesuatu, lansia dapat merasa tidak dipercaya atau tidak berdaya. Sebaliknya, jika keluarga mengabaikan kebutuhan

lansia, lansia dapat merasa tidak dicintai. Dukungan yang ideal adalah dukungan yang seimbang, yaitu membantu ketika diperlukan, tetap memberi ruang kemandirian, mendengarkan pendapat lansia, dan melibatkan lansia dalam kehidupan keluarga. Cara ini dapat membantu lansia merasa tetap menjadi bagian penting dari keluarga.

Masyarakat dan pelayanan kesehatan juga perlu memperkuat dukungan sosial bagi lansia perempuan. Program posyandu lansia, kunjungan rumah, kelompok dukungan, kegiatan edukasi, dan lingkungan ramah lansia dapat membantu menjaga keterlibatan sosial lansia. Tenaga kesehatan perlu memperhatikan aspek sosial ketika melakukan pengkajian, misalnya apakah lansia tinggal sendiri, apakah memiliki teman berbicara, apakah masih mengikuti kegiatan sosial, dan apakah mengalami kesepian. Dengan memahami kondisi sosial lansia, intervensi yang diberikan akan lebih tepat. Misalnya, lansia yang sering kesepian dapat diarahkan untuk mengikuti kegiatan komunitas, sedangkan lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas dapat dibantu melalui kunjungan rumah atau dukungan keluarga.

Dengan demikian, perubahan sosial pada lansia perempuan mencakup perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, perubahan hubungan dengan pasangan, anak, cucu, teman sebaya, serta lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat menimbulkan risiko isolasi sosial dan kesepian, terutama jika lansia mengalami kehilangan pasangan, keterbatasan fisik, rendahnya dukungan keluarga, atau masalah ekonomi. Status ekonomi, budaya, dan pandangan masyarakat terhadap lansia perempuan juga memengaruhi kesejahteraan mereka. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan komunitas sangat penting untuk mempertahankan rasa bermakna, hubungan sosial, dan kualitas hidup. Dukungan sosial dari keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan menjadi kunci agar lansia perempuan dapat menjalani masa tua dengan sehat, aman, dihargai, dan bermartabat.

G. Dampak Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial terhadap Kualitas Hidup

Perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup. Kualitas hidup pada lansia tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya penyakit, tetapi juga dari kemampuan lansia untuk menjalani aktivitas sehari-hari, merasa nyaman dengan dirinya, memiliki hubungan sosial yang baik, merasa dihargai, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta tetap memiliki makna dalam hidup. Pada lansia perempuan, kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi kesehatan fisik, kestabilan emosi, dukungan keluarga, lingkungan sosial,

status ekonomi, spiritualitas, dan kemampuan mempertahankan kemandirian. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada masa lanjut usia perlu dipahami secara menyeluruh agar lansia perempuan tetap dapat menjalani kehidupan yang sehat, bermartabat, dan bermakna.

Perubahan fisik merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup lansia perempuan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi pada berbagai sistem, seperti sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, sensorik, reproduksi, dan urogenital. Penurunan massa otot, nyeri sendi, osteoporosis, gangguan keseimbangan, dan penurunan stamina dapat membatasi kemampuan lansia dalam bergerak. Aktivitas yang dahulu mudah dilakukan, seperti berjalan jauh, naik tangga, membersihkan rumah, memasak, berbelanja, mandi, berpakaian, atau menghadiri kegiatan sosial, dapat menjadi lebih sulit. Ketika kemampuan fisik menurun, lansia perempuan mungkin mulai membutuhkan bantuan dari keluarga atau orang lain. Kondisi ini dapat memengaruhi rasa percaya diri dan perasaan mandiri yang selama ini dimiliki.

Kemandirian merupakan bagian penting dari kualitas hidup lansia perempuan. Banyak lansia perempuan terbiasa menjalankan berbagai peran dalam keluarga, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, mendampingi pasangan, mengasuh cucu, atau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ketika perubahan fisik menyebabkan mereka tidak lagi mampu menjalankan aktivitas seperti sebelumnya, muncul perasaan kehilangan peran dan ketergantungan. Ketergantungan ini dapat membuat sebagian lansia merasa tidak nyaman, malu, atau merasa menjadi beban bagi keluarga. Oleh karena itu, penurunan kemampuan fisik tidak hanya berdampak pada aktivitas tubuh, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan konsep diri lansia perempuan.

Mobilitas yang menurun juga berpengaruh besar terhadap kualitas hidup. Lansia perempuan yang mengalami nyeri sendi, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, atau takut jatuh cenderung membatasi pergerakan. Mereka mungkin lebih banyak duduk atau berbaring, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menghindari kegiatan sosial. Pembatasan aktivitas yang berlebihan dapat memperburuk kondisi fisik karena otot semakin lemah, sendi semakin kaku, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit kronis meningkat. Selain itu, berkurangnya mobilitas dapat mempersempit ruang interaksi sosial lansia. Ketika lansia jarang keluar rumah, kesempatan bertemu teman, tetangga, atau mengikuti kegiatan komunitas semakin sedikit. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesepian dan penurunan kesejahteraan psikologis.

Kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari atau *activity of daily living* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hidup lansia perempuan. Aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, berpindah tempat, menggunakan toilet, dan menjaga kebersihan diri sangat menentukan tingkat kemandirian lansia. Jika lansia masih mampu melakukan aktivitas tersebut secara mandiri, biasanya harga diri dan rasa percaya dirinya lebih terjaga. Sebaliknya, jika lansia membutuhkan bantuan penuh, ia dapat merasa kehilangan kendali atas kehidupannya. Dalam kondisi ini, keluarga perlu memberikan bantuan dengan cara yang tetap menghargai martabat lansia. Bantuan sebaiknya tidak diberikan dengan nada merendahkan atau terburu-buru, melainkan dengan sikap sabar, menghormati pilihan lansia, dan tetap mendorong lansia melakukan bagian yang masih mampu dilakukan.

Perubahan fisik juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman yang berkepanjangan. Nyeri kronis, gangguan tidur, inkontinensia urine, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan kelelahan dapat menurunkan kenyamanan hidup. Lansia perempuan yang mengalami nyeri kronis mungkin menjadi mudah lelah, sulit tidur, mudah marah, dan enggan beraktivitas. Lansia yang mengalami inkontinensia urine dapat merasa malu, takut keluar rumah, atau menghindari pertemuan sosial. Gangguan penglihatan dapat membuat lansia kesulitan membaca, memasak, berjalan, atau mengenali orang. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan lansia sulit mengikuti percakapan sehingga merasa tersisih. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani, kualitas hidup lansia dapat menurun secara perlahan.

Perubahan psikologis juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup lansia perempuan. Masa lanjut usia sering membawa perubahan dalam cara lansia memandang diri, menerima tubuh yang menua, menghadapi penyakit, dan menyesuaikan diri dengan perubahan peran. Lansia perempuan yang mampu menerima proses penuaan biasanya lebih mudah beradaptasi. Mereka dapat melihat masa tua sebagai bagian alami dari kehidupan dan tetap menemukan makna dalam aktivitas sederhana, hubungan keluarga, ibadah, atau kegiatan sosial. Sebaliknya, lansia yang sulit menerima perubahan dapat mengalami rasa rendah diri, kecemasan, kesedihan, atau kemarahan terhadap kondisi yang dialami. Ketika penerimaan diri terganggu, motivasi untuk merawat diri dan menjaga kesehatan juga dapat menurun.

Motivasi merupakan aspek psikologis yang sangat penting dalam mempertahankan kualitas hidup. Lansia perempuan yang memiliki motivasi baik cenderung lebih bersedia menjaga pola makan, mengikuti pengobatan, melakukan aktivitas fisik ringan, menjaga kebersihan diri, mengikuti kegiatan sosial, dan

mencari bantuan ketika sakit. Namun, motivasi dapat menurun jika lansia merasa tidak berguna, tidak dihargai, kesepian, atau merasa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan. Penurunan motivasi dapat membuat lansia menjadi pasif, kurang bergerak, tidak peduli terhadap kesehatan, dan menarik diri dari lingkungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kesehatan fisik maupun mental.

Harga diri lansia perempuan juga dapat berubah akibat proses penuaan. Perubahan penampilan, seperti kulit keriput, rambut memutih, tubuh melemah, berat badan berubah, atau munculnya penyakit kronis, dapat memengaruhi cara lansia menilai dirinya. Selain itu, perubahan peran dalam keluarga dapat membuat lansia merasa tidak lagi dibutuhkan. Jika keluarga tidak melibatkan lansia dalam percakapan atau keputusan sederhana, lansia dapat merasa keberadaannya kurang bermakna. Harga diri yang rendah dapat membuat lansia kehilangan semangat, menarik diri, atau merasa menjadi beban. Sebaliknya, penghargaan dari keluarga dan lingkungan dapat memperkuat harga diri lansia. Ucapan yang menghargai pengalaman lansia, pemberian kesempatan untuk berpendapat, dan pelibatan dalam aktivitas keluarga dapat membantu lansia merasa tetap bernilai.

Kesejahteraan emosional merupakan bagian penting dari kualitas hidup. Lansia perempuan dapat mengalami perubahan emosi seperti mudah cemas, sensitif, sedih, mudah tersinggung, atau merasa kesepian. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh penyakit, nyeri, kurang tidur, kehilangan pasangan, anak yang tinggal jauh, atau berkurangnya aktivitas sosial. Jika emosi negatif berlangsung lama, lansia dapat mengalami depresi. Depresi pada lansia sering kali tidak tampak jelas karena dapat muncul dalam bentuk keluhan fisik, seperti lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, atau nyeri tubuh. Kesejahteraan emosional yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup karena lansia kehilangan minat, tidak bersemangat, dan sulit menikmati aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan mental lansia perlu diperhatikan sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

Penerimaan diri menjadi kunci penting dalam menghadapi masa lanjut usia. Lansia perempuan yang mampu menerima perubahan fisik dan sosial cenderung lebih mampu menyesuaikan diri. Penerimaan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa penuaan adalah bagian dari kehidupan dan tetap berupaya menjaga kesehatan sesuai kemampuan. Lansia yang memiliki penerimaan diri baik dapat lebih mudah menerima bantuan tanpa merasa rendah diri, tetap melakukan aktivitas sesuai kemampuan, dan tidak terus-menerus membandingkan diri dengan masa muda. Penerimaan diri juga dapat diperkuat melalui dukungan spiritual, keluarga, dan lingkungan yang menghargai lansia sebagai individu yang memiliki pengalaman dan martabat.

Perubahan sosial juga memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, hubungan sosial dapat berubah karena anak-anak sudah mandiri, pasangan meninggal, teman sebaya berkurang, atau aktivitas masyarakat menurun. Perubahan ini dapat memengaruhi rasa bermakna dan keterhubungan lansia dengan orang lain. Lansia perempuan yang tetap memiliki hubungan sosial yang baik biasanya merasa lebih bahagia, lebih dihargai, dan lebih termotivasi menjaga kesehatan. Hubungan dengan keluarga, cucu, tetangga, teman sebaya, dan komunitas dapat memberikan rasa aman serta dukungan emosional. Sebaliknya, jika hubungan sosial berkurang, lansia berisiko merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita.

Rasa bermakna sangat penting bagi lansia perempuan. Banyak lansia tetap ingin merasa berguna bagi keluarga dan masyarakat. Mereka mungkin tidak lagi mampu melakukan pekerjaan berat, tetapi masih dapat memberikan nasihat, membantu aktivitas ringan, mendampingi cucu, mengikuti kegiatan keagamaan, atau berbagi pengalaman hidup. Ketika lansia diberi kesempatan untuk tetap berperan, mereka merasa hidupnya masih memiliki tujuan. Rasa bermakna ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Sebaliknya, jika lansia merasa tidak dibutuhkan, tidak didengar, atau hanya dianggap sebagai beban, kualitas hidupnya dapat menurun meskipun kebutuhan fisiknya terpenuhi.

Keterhubungan sosial juga berperan penting dalam mempertahankan kesehatan mental lansia perempuan. Keterhubungan berarti lansia merasa masih menjadi bagian dari keluarga, komunitas, dan lingkungan. Lansia yang terhubung secara sosial memiliki kesempatan untuk berbicara, tertawa, bertukar pengalaman, dan memperoleh dukungan ketika menghadapi masalah. Interaksi sosial dapat membantu menjaga fungsi kognitif, mengurangi stres, dan mencegah kesepian. Sebaliknya, kurangnya keterhubungan dapat menyebabkan isolasi sosial. Isolasi sosial tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Lansia yang terisolasi cenderung kurang aktif, kurang memperhatikan kesehatan, dan lebih berisiko mengalami depresi.

Dukungan sosial menjadi faktor pelindung yang sangat penting dalam kualitas hidup lansia perempuan. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, teman, tetangga, komunitas, tenaga kesehatan, dan kelompok keagamaan. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional, seperti perhatian dan kasih sayang; dukungan praktis, seperti bantuan dalam aktivitas sehari-hari; dukungan informasi, seperti edukasi kesehatan; serta dukungan spiritual, seperti pendampingan ibadah atau kegiatan keagamaan. Lansia yang mendapatkan dukungan sosial yang baik biasanya lebih mampu menghadapi penyakit, kehilangan, dan perubahan hidup. Dukungan sosial juga dapat membantu lansia

mempertahankan kemandirian karena bantuan diberikan sesuai kebutuhan, bukan dengan mengambil alih seluruh kemampuan lansia.

Hubungan antara penyakit kronis, keterbatasan aktivitas, kesepian, dan penurunan kualitas hidup sangat erat. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, nyeri sendi, dan gangguan penglihatan dapat membatasi aktivitas lansia. Ketika aktivitas berkurang, lansia lebih jarang keluar rumah dan lebih sedikit berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini dapat menimbulkan kesepian. Kesepian kemudian dapat menurunkan motivasi lansia untuk merawat diri, mengikuti pengobatan, makan dengan baik, atau berolahraga ringan. Akibatnya, penyakit kronis dapat semakin sulit dikendalikan dan kualitas hidup semakin menurun. Siklus ini perlu diputus melalui dukungan keluarga, pengelolaan penyakit, aktivitas yang aman, dan keterlibatan sosial.

Keterbatasan aktivitas juga dapat menimbulkan rasa takut dan ketergantungan. Lansia yang pernah jatuh mungkin menjadi takut berjalan, sehingga lebih banyak duduk atau berbaring. Lansia yang nyeri sendi mungkin menghindari aktivitas, padahal kurang bergerak dapat memperburuk kekakuan sendi. Lansia yang mengalami inkontinensia urine mungkin enggan mengikuti kegiatan sosial karena takut malu. Setiap masalah fisik dapat berdampak pada kehidupan sosial dan emosional. Oleh karena itu, penanganan masalah fisik harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap psikologis dan sosial lansia. Tujuan perawatan bukan hanya mengurangi gejala, tetapi juga membantu lansia tetap mampu menjalani kehidupan yang bermakna.

Kesepian merupakan salah satu faktor yang sering mempercepat penurunan kualitas hidup. Lansia perempuan yang kesepian dapat mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, kurang semangat, dan kehilangan minat terhadap aktivitas. Kesepian juga dapat memperburuk persepsi terhadap penyakit. Keluhan fisik terasa lebih berat ketika lansia tidak memiliki dukungan emosional. Sebaliknya, lansia yang memiliki teman berbicara dan dukungan keluarga biasanya lebih mampu menerima kondisi kesehatan dan tetap bersemangat menjalani perawatan. Oleh karena itu, pencegahan kesepian harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia perempuan.

Pendekatan holistik sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual lansia perempuan. Pendekatan holistik berarti melihat lansia sebagai manusia utuh dengan kebutuhan yang saling berkaitan. Jika lansia datang dengan keluhan nyeri, tenaga kesehatan tidak hanya menilai lokasi dan intensitas nyeri, tetapi juga dampak nyeri terhadap tidur, suasana hati, aktivitas, hubungan sosial, dan kemandirian. Jika lansia tampak sedih, perlu dikaji apakah ada penyakit fisik, kehilangan pasangan, kesepian, masalah ekonomi, atau kurang

dukungan keluarga. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan dan keluarga memberikan bantuan yang lebih tepat.

Keseimbangan fisik dapat dijaga melalui pemeriksaan kesehatan rutin, pengelolaan penyakit kronis, nutrisi seimbang, aktivitas fisik ringan, istirahat cukup, pencegahan jatuh, dan penggunaan obat sesuai anjuran. Keseimbangan mental dapat dijaga melalui komunikasi yang empatik, dukungan emosional, aktivitas bermakna, stimulasi kognitif, serta perhatian terhadap tanda depresi atau kecemasan. Keseimbangan sosial dapat dijaga dengan melibatkan lansia dalam kegiatan keluarga, masyarakat, komunitas, dan kelompok sebaya. Sementara itu, keseimbangan spiritual dapat diperkuat melalui ibadah, doa, kegiatan keagamaan, refleksi hidup, dan dukungan untuk menemukan makna dalam masa lanjut usia.

Keluarga memiliki peran penting dalam pendekatan holistik. Keluarga perlu memahami bahwa kualitas hidup lansia tidak hanya ditentukan oleh makanan dan obat, tetapi juga oleh rasa dihargai, didengarkan, dan dilibatkan. Lansia perempuan perlu diberi ruang untuk tetap mandiri sesuai kemampuan. Bantuan yang diberikan keluarga sebaiknya bersifat mendukung, bukan menghilangkan peran lansia sepenuhnya. Misalnya, jika lansia masih mampu memilih pakaian, makan sendiri, atau membantu pekerjaan ringan, keluarga sebaiknya tetap memberi kesempatan. Hal ini membantu mempertahankan rasa percaya diri dan harga diri lansia.

Tenaga kesehatan juga perlu berperan dalam mempertahankan kualitas hidup lansia perempuan melalui edukasi, deteksi dini, pengkajian komprehensif, dan koordinasi pelayanan. Pengkajian lansia sebaiknya mencakup kondisi fisik, status mental, fungsi kognitif, kemampuan aktivitas harian, status nutrisi, risiko jatuh, dukungan keluarga, dan kondisi sosial. Dengan pengkajian menyeluruh, intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Tenaga kesehatan juga dapat membantu keluarga memahami cara merawat lansia dengan tetap menjaga martabat dan kemandirian.

Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia perempuan. Lingkungan yang ramah lansia, kegiatan sosial yang terbuka, kelompok senam lansia, posyandu lansia, kegiatan keagamaan, dan dukungan tetangga dapat membantu lansia tetap aktif dan terhubung. Lansia perempuan yang tetap terlibat dalam komunitas biasanya memiliki rasa bermakna yang lebih kuat. Oleh karena itu, kualitas hidup lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama.

Perubahan fisik, psikologis, dan sosial memiliki dampak yang saling berkaitan terhadap kualitas hidup lansia perempuan. Perubahan fisik dapat memengaruhi kemandirian, mobilitas, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan psikologis dapat memengaruhi motivasi, harga diri, kesejahteraan

emosional, dan penerimaan diri. Perubahan sosial dapat memengaruhi rasa bermakna, keterhubungan, dan dukungan sosial. Penyakit kronis, keterbatasan aktivitas, dan kesepian dapat membentuk siklus yang menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual sangat penting agar lansia perempuan dapat menjalani masa tua dengan sehat, aman, mandiri, bermartabat, dan bermakna.

H. Upaya Adaptasi Lansia Perempuan terhadap Perubahan

Upaya adaptasi lansia perempuan terhadap perubahan merupakan proses penting agar lansia mampu menjalani masa lanjut usia dengan lebih sehat, nyaman, mandiri, dan bermartabat. Adaptasi berarti kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, baik perubahan fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Pada lansia perempuan, adaptasi menjadi sangat penting karena proses penuaan membawa berbagai perubahan yang dapat memengaruhi aktivitas harian, perasaan, hubungan sosial, peran dalam keluarga, serta kualitas hidup. Perubahan seperti menurunnya kekuatan tubuh, munculnya penyakit kronis, perubahan penampilan, menopause, kehilangan pasangan, anak yang telah mandiri, serta berkurangnya aktivitas sosial dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Apabila lansia perempuan mampu beradaptasi dengan baik, maka perubahan tersebut tidak selalu menjadi hambatan, melainkan dapat menjadi bagian dari proses kehidupan yang tetap bermakna.

Adaptasi fisik merupakan salah satu bentuk penyesuaian utama yang perlu dilakukan oleh lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan yang sama seperti saat usia muda. Kekuatan otot menurun, tulang menjadi lebih rapuh, sendi lebih mudah nyeri, daya tahan tubuh melemah, dan energi berkurang lebih cepat. Oleh karena itu, lansia perempuan perlu menyesuaikan pola hidupnya agar tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Adaptasi fisik bukan berarti lansia harus berhenti beraktivitas, tetapi menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan tubuh. Lansia tetap perlu bergerak, makan dengan baik, beristirahat cukup, dan memeriksakan kesehatan secara rutin agar fungsi tubuh dapat dipertahankan selama mungkin.

Pola makan sehat menjadi bagian penting dalam adaptasi fisik lansia perempuan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi dapat berubah. Metabolisme tubuh melambat, nafsu makan dapat menurun, kemampuan mengunyah atau menelan mungkin berkurang, dan penyakit kronis tertentu dapat

membatasi jenis makanan yang dikonsumsi. Lansia perempuan perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan cairan yang cukup. Protein penting untuk menjaga massa otot agar lansia tidak mudah lemah. Kalsium dan vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Serat membantu mencegah konstipasi, sedangkan cairan membantu menjaga fungsi tubuh dan mencegah dehidrasi. Pola makan yang sehat juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan, misalnya mengurangi garam pada hipertensi, mengontrol gula pada diabetes, dan mengurangi makanan tinggi lemak pada gangguan jantung atau kolesterol.

Aktivitas fisik ringan juga merupakan bentuk adaptasi penting bagi lansia perempuan. Banyak lansia mengurangi gerak karena takut jatuh, cepat lelah, atau merasa tubuhnya tidak lagi kuat. Namun, kurang bergerak justru dapat mempercepat penurunan massa otot, membuat sendi semakin kaku, menurunkan keseimbangan, dan meningkatkan risiko ketergantungan. Lansia perempuan dianjurkan tetap melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan, seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, latihan pernapasan, berkebun ringan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana. Aktivitas fisik membantu menjaga kekuatan otot, kelenturan sendi, kesehatan jantung, sirkulasi darah, keseimbangan, serta suasana hati. Meskipun demikian, aktivitas harus dilakukan secara aman, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Bila lansia memiliki penyakit jantung, nyeri sendi berat, gangguan keseimbangan, atau riwayat jatuh, maka aktivitas fisik sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan.

Istirahat yang cukup juga menjadi bagian penting dari adaptasi fisik. Lansia perempuan sering mengalami perubahan pola tidur, seperti sulit tidur, sering terbangun pada malam hari, bangun terlalu pagi, atau merasa tidur tidak nyenyak. Kurang tidur dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, emosi tidak stabil, konsentrasi menurun, dan risiko jatuh meningkat. Oleh karena itu, lansia perlu membangun kebiasaan tidur yang baik. Lingkungan tidur sebaiknya dibuat nyaman, tenang, tidak terlalu terang, dan aman. Lansia juga sebaiknya mengurangi konsumsi kafein pada sore atau malam hari, menghindari tidur siang terlalu lama, serta melakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Jika gangguan tidur disebabkan oleh nyeri, sering buang air kecil, kecemasan, atau efek obat, maka penyebab tersebut perlu dikaji dan ditangani secara tepat.

Pemeriksaan kesehatan rutin merupakan upaya adaptasi yang tidak kalah penting. Lansia perempuan perlu melakukan pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, kesehatan tulang, fungsi penglihatan, pendengaran, status

gizi, kesehatan gigi dan mulut, serta kondisi penyakit kronis yang dimiliki. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi komplikasi. Misalnya, hipertensi yang diketahui sejak dini dapat dikendalikan agar tidak menyebabkan stroke atau penyakit jantung. Osteoporosis dapat dipantau untuk mencegah fraktur. Gangguan penglihatan dapat ditangani agar lansia tidak mudah jatuh. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya dilakukan ketika sakit, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan untuk mempertahankan kualitas hidup.

Selain adaptasi fisik, lansia perempuan juga perlu melakukan adaptasi psikologis. Perubahan fisik, kehilangan peran, kematian pasangan, anak yang telah mandiri, dan keterbatasan aktivitas dapat memengaruhi kondisi emosional. Oleh karena itu, penerimaan diri menjadi dasar penting dalam adaptasi psikologis. Penerimaan diri berarti lansia mampu menyadari bahwa penuaan adalah bagian alami dari kehidupan, menerima perubahan yang terjadi, dan tetap menghargai dirinya sebagai pribadi yang bernilai. Penerimaan diri bukan berarti menyerah terhadap keadaan, tetapi memahami batas kemampuan diri dan tetap berusaha menjaga kesehatan serta makna hidup. Lansia perempuan yang mampu menerima proses penuaan biasanya lebih mudah merasa tenang, tidak terlalu membandingkan diri dengan masa muda, dan lebih mampu menikmati kehidupan sesuai tahap usianya.

Penguatan coping juga sangat penting dalam membantu lansia menghadapi perubahan hidup. Coping adalah cara seseorang mengelola tekanan, masalah, dan perubahan. Lansia perempuan yang memiliki coping adaptif dapat menghadapi kesulitan dengan cara yang lebih sehat, misalnya berbicara dengan keluarga, berdoa, mengikuti kegiatan sosial, melakukan aktivitas yang disukai, menjaga rutinitas, atau mencari bantuan tenaga kesehatan ketika mengalami masalah. Sebaliknya, coping yang kurang adaptif, seperti menarik diri, menyalahkan diri sendiri, menolak bantuan, atau membiarkan masalah berlarut-larut, dapat memperburuk kondisi psikologis. Oleh karena itu, keluarga dan tenaga kesehatan perlu membantu lansia menemukan cara menghadapi masalah yang sesuai dengan kepribadian, pengalaman, nilai, dan keyakinannya.

Kegiatan bermakna juga dapat membantu lansia perempuan beradaptasi secara psikologis. Masa lanjut usia sering kali membawa perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Lansia yang sebelumnya aktif bekerja, mengurus rumah, atau memiliki banyak tanggung jawab mungkin merasa kehilangan kesibukan. Oleh karena itu, kegiatan bermakna diperlukan agar lansia tetap merasa berguna dan memiliki tujuan hidup. Kegiatan tersebut tidak harus berat atau rumit. Lansia dapat melakukan aktivitas seperti merawat tanaman, memasak ringan, menjahit,

membaca, menulis, mengaji, mengikuti kegiatan keagamaan, membantu mengasuh cucu sesuai kemampuan, berbagi cerita dengan keluarga, atau mengikuti kegiatan komunitas. Kegiatan bermakna dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kesepian, dan membantu lansia merasa bahwa dirinya tetap memiliki peran.

Dukungan spiritual juga menjadi sumber kekuatan bagi banyak lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, seseorang sering lebih banyak merenungkan perjalanan hidup, makna kehidupan, kematian, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Spiritualitas dapat membantu lansia menerima perubahan, menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memperkuat harapan. Kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, membaca kitab suci, berzikir, meditasi, atau mengikuti kegiatan keagamaan dapat menjadi sumber ketenangan batin. Bagi lansia perempuan, dukungan spiritual juga dapat membantu mengatasi rasa kehilangan, kesepian, dan ketakutan terhadap masa depan. Keluarga perlu mendukung kebutuhan spiritual lansia sesuai keyakinannya, misalnya dengan memfasilitasi ibadah, mengantar ke kegiatan keagamaan, atau menyediakan suasana yang tenang untuk berdoa.

Adaptasi sosial juga sangat penting karena manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain sepanjang hidupnya, termasuk pada masa lanjut usia. Lansia perempuan perlu tetap terlibat dalam keluarga, komunitas, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial sesuai kemampuan. Keterlibatan sosial membantu lansia merasa tetap menjadi bagian dari lingkungan, mengurangi rasa kesepian, dan memperkuat rasa bermakna. Dalam keluarga, lansia dapat dilibatkan dalam percakapan, pengambilan keputusan sederhana, kegiatan bersama, atau peran ringan yang sesuai dengan kemampuan. Lansia perempuan juga dapat tetap berinteraksi dengan cucu, anak, tetangga, teman sebaya, dan kelompok masyarakat. Interaksi yang hangat dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mencegah isolasi sosial.

Keterlibatan dalam komunitas dapat menjadi sarana penting bagi lansia perempuan untuk mempertahankan hubungan sosial. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, kelompok pengajian, kegiatan gereja, arisan, kelompok keterampilan, atau pertemuan warga dapat memberikan kesempatan untuk bertemu orang lain dan berbagi pengalaman. Lansia yang aktif dalam komunitas biasanya memiliki semangat hidup yang lebih baik karena merasa diperhatikan dan dihargai. Namun, keterlibatan sosial harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan lansia. Jika lansia memiliki keterbatasan fisik, keluarga atau masyarakat dapat membantu dengan menyediakan transportasi, mendampingi kegiatan, atau menghadirkan kegiatan sosial yang mudah dijangkau.

Menjaga kemandirian lansia perempuan sesuai kemampuan merupakan bagian penting dalam adaptasi terhadap penuaan. Kemandirian tidak selalu berarti mampu melakukan semua hal sendiri, tetapi kemampuan untuk tetap terlibat dalam aktivitas sesuai kapasitas yang dimiliki. Lansia perempuan perlu diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang masih mampu dilakukan, seperti memilih pakaian, makan sendiri, merapikan tempat tidur, berjalan dengan alat bantu, atau membantu pekerjaan ringan. Jika keluarga mengambil alih semua aktivitas tanpa mempertimbangkan kemampuan lansia, lansia dapat merasa tidak berguna dan kehilangan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika lansia dibiarkan melakukan aktivitas yang terlalu berat tanpa bantuan, risiko cedera juga meningkat. Oleh karena itu, dukungan harus diberikan secara seimbang, yaitu membantu saat diperlukan tetapi tetap memberi ruang bagi lansia untuk mandiri.

Kemandirian juga berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan. Lansia perempuan perlu tetap dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut dirinya, seperti pilihan makanan, pakaian, kegiatan, jadwal pemeriksaan kesehatan, atau pengaturan aktivitas harian. Melibatkan lansia dalam keputusan sederhana dapat menjaga harga diri dan rasa kontrol terhadap hidupnya. Lansia yang merasa masih memiliki kendali atas hidupnya cenderung lebih percaya diri dan lebih termotivasi menjaga kesehatan. Keluarga perlu menghindari sikap memaksakan kehendak tanpa mendengarkan pendapat lansia. Komunikasi yang sabar, empatik, dan menghargai sangat penting dalam membantu lansia beradaptasi tanpa merasa kehilangan martabat.

Mengembangkan kebiasaan hidup sehat merupakan upaya penting untuk mencegah penurunan fungsi tubuh yang lebih cepat. Kebiasaan hidup sehat pada lansia perempuan mencakup pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan diri, menghindari rokok dan alkohol, mengelola stres, minum obat sesuai anjuran, serta rutin memeriksakan kesehatan. Kebiasaan ini perlu dilakukan secara konsisten dan disesuaikan dengan kondisi lansia. Misalnya, lansia dengan hipertensi perlu membatasi garam dan memantau tekanan darah. Lansia dengan diabetes perlu mengatur asupan gula dan memeriksa kadar gula darah. Lansia dengan risiko osteoporosis perlu memperhatikan asupan kalsium, vitamin D, dan latihan beban ringan yang aman.

Kebiasaan hidup sehat juga mencakup menjaga keamanan lingkungan. Lansia perempuan yang mengalami penurunan keseimbangan atau penglihatan perlu tinggal di lingkungan yang aman untuk mencegah jatuh. Rumah sebaiknya memiliki pencahayaan cukup, lantai tidak licin, barang-barang tidak berserakan, kamar mandi dilengkapi pegangan bila memungkinkan, dan alas kaki yang digunakan nyaman serta tidak mudah tergelincir. Pencegahan jatuh sangat penting

karena jatuh dapat menyebabkan fraktur, ketergantungan, dan penurunan kualitas hidup. Dengan lingkungan yang aman, lansia dapat lebih percaya diri untuk bergerak dan beraktivitas.

Mengelola stres juga merupakan bagian dari kebiasaan hidup sehat. Lansia perempuan dapat mengalami stres akibat penyakit, masalah ekonomi, kehilangan pasangan, konflik keluarga, atau rasa kesepian. Stres yang berkepanjangan dapat memperburuk tekanan darah, mengganggu tidur, menurunkan nafsu makan, dan memengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, lansia perlu memiliki cara untuk menenangkan diri, seperti berdoa, berbicara dengan orang yang dipercaya, melakukan aktivitas menyenangkan, mendengarkan musik, berjalan santai, atau mengikuti kegiatan sosial. Keluarga juga perlu menciptakan suasana rumah yang tenang dan mendukung agar lansia tidak merasa tertekan.

Meningkatkan kepercayaan diri lansia perempuan merupakan bagian penting dalam menjalani masa lanjut usia secara bermartabat. Kepercayaan diri lansia dapat menurun akibat perubahan penampilan, penurunan kemampuan fisik, penyakit kronis, atau perubahan peran dalam keluarga. Lansia perempuan mungkin merasa tidak lagi menarik, tidak produktif, atau tidak berguna. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, lansia perlu dibantu melihat bahwa nilai dirinya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik atau usia muda, tetapi juga oleh pengalaman, kebijaksanaan, kasih sayang, dan peran yang masih dapat diberikan kepada keluarga serta masyarakat. Penghargaan dari keluarga sangat berpengaruh dalam membangun rasa percaya diri tersebut.

Keluarga dapat meningkatkan kepercayaan diri lansia dengan cara memberikan pujian yang tulus, meminta pendapatnya, melibatkan dalam kegiatan keluarga, dan memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disukai. Misalnya, lansia yang senang memasak dapat tetap dilibatkan dalam memilih menu atau menyiapkan bahan ringan. Lansia yang senang bercerita dapat diberi ruang untuk berbagi pengalaman kepada cucu. Lansia yang senang beribadah dapat didukung untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Hal-hal sederhana ini dapat membuat lansia merasa dihargai dan tetap memiliki peran. Perasaan dihargai sangat penting agar lansia perempuan dapat menjalani masa tua dengan martabat.

Tenaga kesehatan juga memiliki peran dalam membantu adaptasi lansia perempuan. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi tentang proses penuaan, pola hidup sehat, pencegahan penyakit, penggunaan obat, nutrisi, aktivitas fisik, kesehatan mental, serta pencegahan jatuh. Selain itu, tenaga kesehatan perlu melakukan komunikasi yang empatik dan tidak merendahkan lansia. Lansia perempuan perlu diperlakukan sebagai individu yang memiliki pengalaman hidup dan hak untuk terlibat dalam keputusan terkait kesehatannya.

Pendekatan yang menghargai akan membantu lansia lebih percaya kepada tenaga kesehatan dan lebih bersedia mengikuti anjuran perawatan.

Masyarakat juga dapat mendukung adaptasi lansia perempuan melalui lingkungan yang ramah lansia. Lingkungan ramah lansia adalah lingkungan yang aman, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan memberi kesempatan kepada lansia untuk tetap berpartisipasi. Kegiatan sosial dan komunitas perlu dibuat inklusif agar lansia perempuan tidak merasa tersisih. Dukungan dari tetangga, kader kesehatan, tokoh agama, dan kelompok masyarakat dapat membantu lansia tetap terhubung secara sosial. Lansia yang merasa diterima oleh masyarakat cenderung lebih percaya diri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Maka dari itu, upaya adaptasi lansia perempuan terhadap perubahan mencakup adaptasi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Adaptasi fisik dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik ringan, istirahat cukup, pemeriksaan kesehatan rutin, dan kebiasaan hidup sehat. Adaptasi psikologis dilakukan melalui penerimaan diri, penguatan coping, kegiatan bermakna, dan dukungan spiritual. Adaptasi sosial dilakukan melalui keterlibatan dalam keluarga, komunitas, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial. Kemandirian lansia perlu dijaga sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan agar lansia tetap memiliki rasa percaya diri. Dengan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat, lansia perempuan dapat menjalani masa lanjut usia dengan lebih sehat, aman, bermartabat, dan penuh makna.

I. Peran Keluarga, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat

Peran keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung kesehatan serta kualitas hidup lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang dapat memengaruhi kemandirian, rasa percaya diri, hubungan sosial, serta kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari. Perubahan tersebut tidak dapat dihadapi oleh lansia perempuan seorang diri, terutama apabila disertai penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, kesepian, penurunan fungsi kognitif, atau berkurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, lansia perempuan membutuhkan lingkungan yang mendukung, baik dari keluarga sebagai orang terdekat, tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan profesional, maupun masyarakat sebagai ruang sosial tempat lansia berinteraksi dan mempertahankan kebermaknaan hidupnya.

Keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi lansia perempuan karena keluarga adalah lingkungan terdekat yang paling sering berinteraksi dengan lansia dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga tidak hanya terbatas pada memenuhi

kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional, sosial, spiritual, dan praktis. Dukungan emosional diberikan melalui perhatian, kasih sayang, kesabaran, dan kesediaan mendengarkan keluhan lansia. Lansia perempuan sering kali membutuhkan teman berbicara untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, kekhawatiran, atau rasa tidak nyaman yang dialami. Ketika keluarga mau mendengarkan dengan penuh perhatian, lansia akan merasa dihargai dan tidak merasa sendiri. Hal ini sangat penting karena rasa kesepian dan perasaan tidak dibutuhkan dapat menurunkan semangat hidup serta meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi.

Dukungan sosial dari keluarga dapat diberikan dengan cara melibatkan lansia perempuan dalam kehidupan keluarga. Lansia sebaiknya tetap diajak berbicara, dimintai pendapat, dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga yang sesuai kemampuan, serta diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan anak, cucu, dan keluarga besar. Keterlibatan tersebut dapat membantu lansia merasa bahwa dirinya masih memiliki peran dan keberadaan yang bermakna. Banyak lansia perempuan yang sepanjang hidupnya terbiasa menjadi pusat pengasuhan keluarga. Ketika usia bertambah dan kemampuan fisik menurun, mereka dapat merasa kehilangan peran. Oleh karena itu, keluarga perlu memberi ruang agar lansia tetap dapat berkontribusi, misalnya dengan membantu pekerjaan ringan, memberikan nasihat, mendampingi cucu belajar, atau terlibat dalam kegiatan keagamaan keluarga. Dukungan sosial seperti ini membantu mempertahankan harga diri dan rasa percaya diri lansia.

Dukungan spiritual juga memiliki makna besar bagi lansia perempuan. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual sering meningkat karena lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, rasa syukur, pengalaman masa lalu, kematian, dan hubungan dengan Tuhan. Keluarga dapat mendukung kebutuhan spiritual dengan memfasilitasi lansia untuk beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan, membaca kitab suci, berdoa, atau menjalankan kebiasaan spiritual sesuai keyakinannya. Dukungan spiritual dapat memberikan ketenangan batin, membantu lansia menerima proses penuaan, mengurangi kecemasan, serta memperkuat harapan. Keluarga perlu menghargai keyakinan lansia dan tidak mengabaikan kebutuhan spiritualnya, karena bagi banyak lansia perempuan, spiritualitas menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penyakit, kehilangan pasangan, keterbatasan fisik, dan perubahan hidup.

Dukungan praktis keluarga juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini dapat berupa membantu menyiapkan makanan, mengantar lansia ke fasilitas kesehatan, mengingatkan jadwal minum obat, membantu menjaga kebersihan diri, menyediakan pakaian yang nyaman, memastikan rumah

aman dari risiko jatuh, serta membantu aktivitas yang sulit dilakukan lansia secara mandiri. Namun, dukungan praktis perlu diberikan secara seimbang. Keluarga tidak sebaiknya mengambil alih seluruh aktivitas lansia apabila lansia masih mampu melakukannya sendiri. Bantuan yang terlalu berlebihan dapat membuat lansia merasa tidak berdaya dan kehilangan kemandirian. Sebaliknya, membiarkan lansia melakukan aktivitas berat tanpa bantuan juga dapat meningkatkan risiko cedera. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami batas kemampuan lansia dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, melakukan deteksi dini masalah kesehatan, memantau kondisi, serta mencegah komplikasi pada lansia perempuan. Edukasi kesehatan menjadi salah satu tugas utama tenaga kesehatan karena lansia dan keluarga perlu memahami proses penuaan, perubahan fisik yang umum terjadi, tanda bahaya penyakit, pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, kepatuhan pengobatan, pemeriksaan rutin, serta pencegahan jatuh. Edukasi yang baik membantu lansia dan keluarga mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kesehatan. Edukasi harus diberikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, sabar, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman lansia. Tenaga kesehatan juga perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh lansia dan keluarga.

Deteksi dini masalah kesehatan sangat penting karena banyak penyakit pada lansia berkembang secara perlahan dan sering tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, anemia, malnutrisi, depresi, dan gangguan kognitif dapat muncul secara bertahap. Jika tidak dikenali sejak dini, masalah tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berat dan menurunkan kualitas hidup lansia. Tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian menyeluruh, tidak hanya pada keluhan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, spiritual, fungsi kognitif, kemampuan aktivitas sehari-hari, status nutrisi, risiko jatuh, serta dukungan keluarga. Dengan deteksi dini, tindakan pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Pemantauan kondisi lansia perempuan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Lansia dengan penyakit kronis membutuhkan pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, fungsi jantung, kepatuhan minum obat, efek samping obat, serta perkembangan keluhan yang dialami. Lansia dengan risiko jatuh perlu dipantau kekuatan otot, keseimbangan, penggunaan alat bantu, dan keamanan lingkungan rumah. Lansia yang mengalami perubahan suasana hati atau penurunan daya ingat perlu dipantau kondisi psikologis dan fungsi kognitifnya. Pemantauan yang berkelanjutan membantu tenaga kesehatan

mengetahui apakah kondisi lansia membaik, stabil, atau memburuk. Hasil pemantauan menjadi dasar untuk menentukan tindakan lanjutan, rujukan, atau edukasi tambahan bagi keluarga.

Pencegahan komplikasi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan lansia. Komplikasi dapat muncul apabila penyakit kronis tidak terkontrol, lansia kurang bergerak, nutrisi tidak terpenuhi, lingkungan tidak aman, atau obat tidak diminum sesuai anjuran. Misalnya, hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan luka sulit sembuh, gangguan saraf, dan gangguan ginjal. Osteoporosis yang tidak dicegah dapat meningkatkan risiko patah tulang. Gangguan keseimbangan yang tidak diperhatikan dapat menyebabkan jatuh. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu membantu lansia dan keluarga memahami langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengaturan makan, aktivitas fisik, penggunaan obat, kontrol rutin, serta penataan lingkungan yang aman.

Komunikasi yang sabar, empatik, dan menghargai lansia perempuan sangat penting dalam setiap interaksi. Lansia perempuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi, mengingat instruksi, atau menyampaikan keluhan. Sebagian lansia juga mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, atau penurunan konsentrasi sehingga komunikasi perlu dilakukan dengan lebih perlahan dan jelas. Keluarga dan tenaga kesehatan harus menghindari sikap terburu-buru, membentak, meremehkan, atau berbicara seolah-olah lansia tidak mampu memahami. Sikap seperti itu dapat membuat lansia merasa tersinggung, tidak dihargai, atau enggan menyampaikan keluhan. Sebaliknya, komunikasi yang lembut, sopan, dan penuh penghargaan dapat membangun rasa percaya dan membuat lansia lebih terbuka.

Empati dalam komunikasi berarti berusaha memahami perasaan lansia dari sudut pandangnya. Lansia perempuan yang mengeluh berulang-ulang, mudah cemas, atau tampak sensitif mungkin sedang menghadapi rasa takut, nyeri, kesepian, atau perasaan kehilangan. Keluarga dan tenaga kesehatan perlu melihat perilaku lansia secara lebih dalam, bukan hanya menilai dari ucapan atau sikap yang tampak. Misalnya, lansia yang marah karena tidak ingin dibantu mandi mungkin sebenarnya merasa malu atau takut kehilangan kemandirian. Lansia yang menolak makan mungkin mengalami masalah gigi, gangguan menelan, depresi, atau merasa tidak berselera karena makan sendirian. Dengan komunikasi empatik, kebutuhan lansia dapat dipahami secara lebih tepat.

Dukungan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi menjadi salah satu aspek penting dalam merawat lansia perempuan. Nutrisi yang cukup membantu

mempertahankan kekuatan otot, kesehatan tulang, daya tahan tubuh, fungsi otak, dan proses penyembuhan. Lansia perempuan perlu mendapatkan makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan cairan yang cukup. Keluarga dapat membantu dengan menyediakan makanan yang mudah dikunyah, sesuai selera, bergizi, dan sesuai kondisi penyakit. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi mengenai makanan yang perlu dibatasi, misalnya garam pada hipertensi, gula pada diabetes, atau lemak jenuh pada penyakit jantung. Nutrisi yang baik bukan hanya memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga mendukung energi, mood, dan kemampuan beraktivitas.

Dukungan terhadap aktivitas fisik juga penting. Lansia perempuan perlu tetap bergerak sesuai kemampuan agar kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan kesehatan jantung tetap terjaga. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, latihan napas, atau aktivitas rumah tangga sederhana dapat membantu mencegah penurunan fungsi tubuh yang lebih cepat. Keluarga dapat mendampingi lansia saat berjalan, memastikan alas kaki aman, dan menghindari aktivitas yang terlalu berat. Tenaga kesehatan dapat memberikan arahan mengenai jenis aktivitas yang sesuai dengan kondisi lansia, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit jantung, osteoporosis, nyeri sendi, atau gangguan keseimbangan.

Dukungan dalam pengobatan juga menjadi tanggung jawab bersama. Lansia perempuan sering menggunakan lebih dari satu jenis obat untuk mengontrol penyakit kronis. Hal ini dapat meningkatkan risiko lupa minum obat, salah dosis, atau mengalami efek samping. Keluarga dapat membantu mengatur jadwal obat, menyimpan obat dengan rapi, mendampingi kontrol, dan mengamati keluhan setelah minum obat. Tenaga kesehatan perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang nama obat, manfaat, dosis, waktu minum, efek samping yang perlu diwaspadai, dan pentingnya tidak menghentikan obat tanpa konsultasi. Kepatuhan terhadap pengobatan membantu mencegah komplikasi dan mempertahankan kondisi lansia agar tetap stabil.

Pemeriksaan kesehatan rutin juga perlu didukung oleh keluarga dan masyarakat. Banyak lansia tidak memeriksakan diri karena merasa keluhannya biasa, takut biaya, sulit transportasi, atau tidak ingin merepotkan keluarga. Padahal, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal. Keluarga dapat membantu dengan mengantar lansia ke puskesmas, posyandu lansia, klinik, atau rumah sakit sesuai kebutuhan. Masyarakat juga dapat mendukung melalui kegiatan posyandu lansia, pemeriksaan tekanan darah, penyuluhan kesehatan, senam lansia, dan kunjungan rumah. Pemeriksaan berkala memungkinkan kondisi

lansia dipantau dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih berat.

Perawatan diri lansia perempuan juga perlu diperhatikan. Perawatan diri mencakup kebersihan tubuh, mandi, berpakaian, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan kuku, kebersihan area genital, serta penggunaan alat bantu bila diperlukan. Lansia yang mengalami kelemahan, nyeri sendi, gangguan penglihatan, atau inkontinensia urine mungkin membutuhkan bantuan dalam menjaga kebersihan diri. Bantuan ini harus diberikan dengan penuh penghormatan terhadap privasi dan martabat lansia. Keluarga dan tenaga kesehatan perlu menghindari sikap yang membuat lansia merasa malu. Kebersihan diri yang baik dapat mencegah infeksi, iritasi kulit, bau tidak sedap, luka, serta meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri lansia.

Pencegahan kekerasan, penelantaran, stigma, dan diskriminasi terhadap lansia perempuan merupakan tanggung jawab keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kekerasan terhadap lansia dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, emosional, ekonomi, seksual, maupun penelantaran. Lansia perempuan dapat menjadi kelompok yang rentan karena ketergantungan fisik, keterbatasan ekonomi, gangguan kognitif, atau posisi sosial yang lemah. Kekerasan verbal seperti membentak, menghina, merendahkan, atau menyalahkan lansia dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental. Penelantaran dapat terjadi ketika kebutuhan makan, kebersihan, obat, keamanan, atau perhatian emosional lansia diabaikan. Kondisi ini harus dicegah melalui edukasi keluarga, penguatan kepedulian masyarakat, dan deteksi dini oleh tenaga kesehatan.

Stigma dan diskriminasi terhadap lansia perempuan juga perlu dihindari. Lansia tidak boleh dianggap tidak berguna, tidak produktif, lambat, merepotkan, atau tidak mampu mengambil keputusan. Pandangan seperti ini dapat membuat lansia merasa rendah diri dan tersisih. Lansia perempuan tetap memiliki pengalaman, nilai, kebijaksanaan, dan hak untuk dihormati. Dalam pelayanan kesehatan, lansia harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki martabat, bukan sekadar pasien tua yang pasif. Dalam keluarga, lansia perlu tetap dilibatkan sesuai kemampuan. Dalam masyarakat, lansia perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan komunitas. Menghargai lansia berarti mengakui bahwa masa tua tetap merupakan bagian berharga dari kehidupan manusia.

Kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia perempuan. Tidak ada satu pihak yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan lansia secara sendiri. Keluarga memiliki kedekatan emosional dan mengetahui kebiasaan lansia sehari-hari.

Tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengkajian, edukasi, pencegahan, serta penanganan masalah kesehatan. Masyarakat menyediakan lingkungan sosial yang dapat mendukung partisipasi, keamanan, dan rasa keterhubungan lansia. Ketika ketiga unsur ini bekerja sama, lansia perempuan memiliki peluang lebih besar untuk menjalani masa tua dengan sehat, aman, aktif, dan bermakna.

Kolaborasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Keluarga dapat membawa lansia ke posyandu lansia atau fasilitas kesehatan secara rutin. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan kader masyarakat tentang perawatan lansia, pencegahan jatuh, nutrisi, kesehatan mental, dan tanda bahaya penyakit. Masyarakat dapat menyediakan kegiatan ramah lansia, seperti senam lansia, kelompok keagamaan, kunjungan sosial, atau dukungan bagi lansia yang tinggal sendiri. Kader kesehatan dapat membantu memantau kondisi lansia di lingkungan sekitar dan menghubungkan keluarga dengan fasilitas kesehatan jika ditemukan masalah. Kolaborasi ini membantu menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat bagi lansia perempuan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan lansia perempuan, penting untuk mempertahankan prinsip bahwa lansia adalah subjek yang memiliki hak, bukan objek yang hanya menerima bantuan. Lansia perempuan perlu dilibatkan dalam perencanaan perawatan, diberi kesempatan menyampaikan pilihan, dan dihormati keputusan yang masih mampu diambilnya. Keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada kualitas hidup, kenyamanan, kemandirian, spiritualitas, dan rasa bermakna. Dengan pendekatan seperti ini, lansia perempuan tidak hanya dibantu untuk hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan lebih baik.

Dengan demikian, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung lansia perempuan. Keluarga memberikan dukungan emosional, sosial, spiritual, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga kesehatan berperan dalam edukasi, deteksi dini, pemantauan kondisi, dan pencegahan komplikasi. Masyarakat berperan menciptakan lingkungan sosial yang ramah, aman, dan menghargai lansia. Komunikasi yang sabar, empatik, dan menghormati lansia menjadi dasar dalam semua bentuk dukungan. Melalui kolaborasi yang baik, lansia perempuan dapat mempertahankan kesehatan, kemandirian, harga diri, dan kualitas hidupnya secara optimal dalam masa lanjut usia.

J. Simpulan

Perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan merupakan bagian alami dari proses penuaan yang terjadi secara bertahap dan saling berkaitan. Perubahan fisik dapat terlihat pada penurunan fungsi sistem tubuh, seperti sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, sensorik, reproduksi, dan urogenital. Kondisi seperti osteoporosis, nyeri sendi, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan tidur, inkontinensia urine, malnutrisi, anemia, gangguan keseimbangan, serta risiko jatuh dapat memengaruhi kemandirian, mobilitas, kenyamanan, dan kemampuan lansia perempuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain perubahan fisik, lansia perempuan juga mengalami perubahan psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup. Perubahan psikologis meliputi perubahan konsep diri, penerimaan terhadap proses penuaan, kecemasan, kesepian, risiko depresi, penurunan daya ingat, serta perasaan kehilangan akibat perubahan peran, pensiun, atau kematian pasangan. Sementara itu, perubahan sosial dapat terjadi dalam hubungan dengan pasangan, anak, cucu, teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Apabila tidak didukung dengan baik, perubahan tersebut dapat menimbulkan isolasi sosial, penurunan harga diri, kehilangan rasa bermakna, dan berkurangnya keterlibatan lansia dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, lansia perempuan membutuhkan pendekatan yang holistik, humanis, dan berkesinambungan agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang dialami. Upaya adaptasi dapat dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik ringan, istirahat cukup, pemeriksaan kesehatan rutin, penerimaan diri, penguatan coping, kegiatan bermakna, dukungan spiritual, serta keterlibatan dalam keluarga dan komunitas. Peran keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan emosional, sosial, spiritual, praktis, edukasi kesehatan, deteksi dini masalah kesehatan, pencegahan komplikasi, serta perlindungan dari kekerasan, penelantaran, stigma, dan diskriminasi. Dengan dukungan yang tepat, lansia perempuan dapat menjalani masa lanjut usia secara lebih sehat, mandiri, aman, bermartabat, dan bermakna.

K. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk lanjut usia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bandiyah, S. (2009). *Lanjut usia dan keperawatan gerontik*. Nuha Medika.
- Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper, C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinkova, E., Vandewoude, M., Visser, M., & Zamboni, M. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31.
- Darmojo, R. B., & Martono, H. H. (2015). *Buku ajar geriatri: Ilmu kesehatan usia lanjut* (Edisi 5). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Eliopoulos, C. (2018). *Gerontological nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Halter, J. B., Ouslander, J. G., Studenski, S., High, K. P., Asthana, S., Supiano, M. A., & Ritchie, C. (Eds.). (2017). *Hazzard's geriatric medicine and gerontology* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2019). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. *Osteoporosis International*, 30(1), 3–44.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2016–2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mauk, K. L. (2018). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Meiner, S. E., & Yeager, J. J. (2019). *Gerontologic nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Miller, C. A. (2019). *Nursing for wellness in older adults* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., ... Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: A global initiative. *Age and Ageing*, 51(9), afac205.
- North American Menopause Society. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 29(7),

767–794.

- Nugroho, W. (2008). *Keperawatan gerontik dan geriatrik* (Edisi 3). EGC.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Santini, Z. I., Jose, P. E., Cornwell, E. Y., Koyanagi, A., Nielsen, L., Hinrichsen, C., Meilstrup, C., Madsen, K. R., & Koushede, V. (2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans. *The Lancet Public Health*, 5(1), e62–e70.
- Stanley, M., & Beare, P. G. (2007). *Buku ajar keperawatan gerontik* (Edisi 2). EGC.
- Stephoe, A., Shankar, A., Demakakos, P., & Wardle, J. (2013). Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(15), 5797–5801.
- Tamher, S., & Noorkasiani. (2009). *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. Salemba Medika.
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2020). *Ebersole & Hess' gerontological nursing & healthy aging* (5th ed.). Elsevier.
- Valtorta, N. K., Kanaan, M., Gilbody, S., Ronzi, S., & Hanratty, B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: Systematic review and meta-analysis. *Heart*, 102(13), 1009–1016.
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Global report on ageism*. World Health Organization.

L. Glosarium

- **Lansia Perempuan**

Perempuan yang telah memasuki tahap lanjut usia dan mengalami perubahan fisik, psikologis, sosial, serta spiritual sebagai bagian dari proses penuaan.

- **Penuaan**

Proses alami yang terjadi secara bertahap sepanjang kehidupan dan ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, perubahan emosi, perubahan peran sosial, serta penyesuaian terhadap kondisi hidup yang baru.

- **Menopause**

Masa berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dan produksi hormon estrogen pada perempuan.

- **Pascamenopause**

Masa setelah menopause yang ditandai dengan berbagai perubahan tubuh, seperti peningkatan risiko osteoporosis, kekeringan vagina, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan perubahan fungsi urogenital.

- **Estrogen**

Hormon utama pada perempuan yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, elastisitas kulit, fungsi pembuluh darah, kesehatan organ reproduksi, dan keseimbangan suasana hati.

- **Osteoporosis**

Kondisi menurunnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan meningkatkan risiko fraktur, terutama pada lansia perempuan setelah menopause.

- **Sarkopenia**

Penurunan massa dan kekuatan otot akibat proses penuaan yang dapat menyebabkan kelemahan, keterbatasan mobilitas, mudah lelah, dan peningkatan risiko jatuh.

- **Penyakit Degeneratif**

Penyakit yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ tubuh, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan nyeri sendi.

- **Inkontinensia Urine**

Kondisi keluarnya urine secara tidak sengaja atau sulit dikontrol, yang sering dialami lansia perempuan akibat melemahnya otot dasar panggul dan perubahan sistem urogenital.

- **Kualitas Hidup**

Keadaan kesejahteraan lansia yang mencakup kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial, kemandirian, kenyamanan, spiritualitas, dan rasa bermakna dalam hidup.

- **Kemandirian Lansia**

Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kapasitasnya, seperti makan, mandi, berpakaian, berjalan, mengambil keputusan sederhana, dan berpartisipasi dalam keluarga.

- **Aktivitas Sehari-hari**

Kegiatan dasar yang dilakukan lansia dalam kehidupan harian, seperti merawat diri, makan, berpakaian, menggunakan toilet, bergerak, berkomunikasi, dan melakukan pekerjaan ringan.

- **Dukungan Sosial**

Bantuan emosional, praktis, informasional, dan spiritual yang diberikan oleh keluarga, teman, tetangga, komunitas, tenaga kesehatan, atau masyarakat kepada lansia perempuan.

- **Isolasi Sosial**

Kondisi ketika lansia memiliki keterbatasan hubungan sosial atau kurang terlibat dalam interaksi dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan risiko kesepian dan depresi.

- **Pendekatan Holistik**

Pendekatan pelayanan yang memandang lansia perempuan sebagai manusia utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan.

CHAPTER 3

MASALAH KESEHATAN YANG SERING DIALAMI PEREMPUAN LANSIA

Bd. Elwitri Silvia, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Perempuan lansia merupakan kelompok usia yang membutuhkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan karena pada masa lanjut usia terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Proses penuaan merupakan bagian alami dari kehidupan, tetapi dampaknya dapat berbeda pada setiap individu. Pada perempuan, proses penuaan sering kali memiliki karakteristik khas karena dipengaruhi oleh riwayat reproduksi, menopause, perubahan hormonal, pola hidup, penyakit kronis, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, memahami masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia menjadi sangat penting agar upaya pencegahan, perawatan, dan pendampingan dapat dilakukan secara tepat, manusiawi, dan sesuai kebutuhan.

Pentingnya memahami masalah kesehatan pada perempuan lansia tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya usia, tetapi juga dengan perubahan fungsi tubuh yang berlangsung secara bertahap. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan dalam mempertahankan keseimbangan fungsi organ. Otot menjadi lebih lemah, tulang menjadi lebih rapuh, sendi lebih mudah nyeri, daya tahan tubuh menurun, penglihatan dan pendengaran dapat berkurang, serta metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Perubahan tersebut membuat perempuan lansia lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti osteoporosis, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan tidur, inkontinensia urine, malnutrisi, anemia, gangguan keseimbangan, dan risiko jatuh.

Perempuan lansia juga menjadi kelompok rentan karena adanya perubahan hormonal yang terjadi setelah menopause. Menopause menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen yang sebelumnya berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, elastisitas pembuluh darah, kelembapan jaringan urogenital, kesehatan kulit, serta kestabilan suasana hati. Ketika kadar estrogen menurun, risiko osteoporosis meningkat, keluhan urogenital dapat muncul, perubahan suasana hati lebih mudah terjadi, dan risiko penyakit kardiovaskular dapat

bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan perempuan lansia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan biologis perempuan sepanjang siklus hidupnya.

Selain perubahan hormonal, proses penuaan juga dapat memperberat penyakit kronis yang telah ada sebelumnya. Perempuan lansia yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, atau gangguan ginjal membutuhkan pemantauan kesehatan yang lebih teratur. Penyakit kronis yang tidak terkontrol dapat menurunkan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, meningkatkan ketergantungan pada orang lain, serta memperburuk kualitas hidup. Misalnya, diabetes melitus yang tidak terkontrol dapat menyebabkan luka sulit sembuh, gangguan saraf, gangguan penglihatan, dan penurunan daya tahan tubuh. Hipertensi yang tidak dikendalikan dapat meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Osteoporosis yang tidak dicegah dapat menyebabkan patah tulang akibat jatuh ringan.

Masalah kesehatan pada perempuan lansia dapat berdampak besar terhadap kemandirian. Kemandirian merupakan kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kapasitasnya, seperti makan, mandi, berpakaian, berjalan, menggunakan toilet, mengelola obat, dan berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. Ketika perempuan lansia mengalami nyeri sendi, kelemahan otot, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, atau penyakit kronis, kemampuan tersebut dapat menurun. Penurunan kemandirian sering kali menimbulkan perasaan tidak nyaman, malu, sedih, atau merasa menjadi beban keluarga. Oleh karena itu, masalah kesehatan pada perempuan lansia perlu dikenali sejak dini agar penurunan kemandirian dapat dicegah atau diperlambat.

Dampak masalah kesehatan juga terlihat pada kenyamanan hidup perempuan lansia. Gangguan tidur, nyeri kronis, sesak napas, konstipasi, inkontinensia urine, atau gangguan urogenital pascamenopause dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang berlangsung lama. Lansia yang mengalami nyeri kronis dapat menjadi mudah lelah, sulit tidur, dan enggan bergerak. Lansia yang mengalami inkontinensia urine dapat merasa malu, takut keluar rumah, atau menghindari kegiatan sosial. Lansia yang mengalami gangguan pendengaran dapat sulit mengikuti percakapan dan akhirnya memilih menarik diri. Jika keluhan-keluhan tersebut tidak dipahami dan tidak ditangani dengan baik, kualitas hidup perempuan lansia dapat menurun secara perlahan.

Kualitas hidup perempuan lansia sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan secara menyeluruh. Kualitas hidup tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan untuk merasa nyaman, mandiri, aman, dihargai, memiliki hubungan sosial yang baik, serta tetap merasa hidupnya bermakna.

Seorang perempuan lansia mungkin memiliki penyakit kronis, tetapi tetap dapat memiliki kualitas hidup yang baik apabila penyakitnya terkontrol, keluarga memberikan dukungan, lingkungan aman, dan ia masih dapat melakukan aktivitas sesuai kemampuan. Sebaliknya, lansia yang secara fisik tampak cukup sehat dapat mengalami kualitas hidup yang rendah apabila merasa kesepian, tidak dihargai, mengalami kecemasan, atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai.

Deteksi dini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan perempuan lansia. Banyak masalah kesehatan pada lansia berkembang secara perlahan dan tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Hipertensi sering disebut sebagai kondisi yang dapat muncul tanpa keluhan nyata, tetapi berisiko menimbulkan komplikasi serius. Osteoporosis sering tidak disadari sampai terjadi patah tulang. Diabetes melitus dapat berkembang tanpa gejala khas, tetapi diam-diam merusak pembuluh darah, saraf, mata, dan ginjal. Depresi pada lansia juga sering tidak dikenali karena gejalanya dapat menyerupai keluhan fisik, seperti lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, atau sering mengeluh sakit. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan rutin sangat diperlukan agar masalah dapat ditemukan lebih awal.

Pencegahan masalah kesehatan pada perempuan lansia harus dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan dapat dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik yang aman, istirahat cukup, pengelolaan stres, pemeriksaan kesehatan berkala, kepatuhan terhadap pengobatan, serta penataan lingkungan rumah yang aman. Perempuan lansia perlu mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, seperti cukup protein untuk menjaga massa otot, cukup kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang, cukup serat untuk mencegah konstipasi, serta pembatasan garam, gula, atau lemak bila memiliki hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, atau latihan keseimbangan dapat membantu mempertahankan kekuatan tubuh dan mencegah jatuh.

Penanganan masalah kesehatan perempuan lansia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik. Pendekatan holistik berarti melihat lansia sebagai manusia utuh yang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan. Ketika perempuan lansia mengeluh sulit tidur, penyebabnya tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga perlu dikaji apakah ia mengalami nyeri, kecemasan, kesepian, sering buang air kecil, efek obat, atau gangguan suasana hati. Ketika lansia sering jatuh, penyebabnya tidak hanya dilihat dari kelemahan otot, tetapi juga dari penglihatan, obat yang dikonsumsi, kondisi rumah, alas kaki, dan dukungan keluarga. Dengan pendekatan holistik, penanganan yang diberikan menjadi lebih tepat dan tidak hanya berfokus pada gejala.

Keluarga memiliki peran sangat penting dalam mendukung kesehatan perempuan lansia. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, memantau kondisi kesehatan, mengingatkan minum obat, mendampingi kontrol, menyediakan makanan bergizi, serta memberikan dukungan emosional. Namun, dukungan keluarga perlu diberikan dengan tetap menghargai kemandirian dan martabat lansia. Perempuan lansia sebaiknya tetap diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam kehidupan keluarga. Bantuan yang diberikan secara berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan lansia dapat membuat lansia merasa tidak berguna, sedangkan kurangnya dukungan dapat membuat lansia merasa diabaikan.

Tenaga kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan perempuan lansia. Peran tersebut meliputi edukasi kesehatan, deteksi dini, pemantauan penyakit kronis, pencegahan komplikasi, pemberian intervensi sesuai kebutuhan, serta rujukan apabila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, sabar, dan tidak menghakimi. Perempuan lansia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi atau mengingat anjuran. Oleh karena itu, komunikasi yang empatik dan menghargai sangat diperlukan agar lansia merasa aman, dihormati, dan bersedia mengikuti anjuran kesehatan.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung kesehatan perempuan lansia. Lingkungan masyarakat yang ramah lansia dapat membantu lansia tetap aktif, terhubung, dan merasa dihargai. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, kelompok keagamaan, kegiatan sosial, edukasi kesehatan, dan kunjungan rumah dapat membantu mencegah isolasi sosial serta mendukung pemantauan kesehatan. Masyarakat juga perlu mencegah stigma dan diskriminasi terhadap lansia. Perempuan lansia tidak boleh dianggap tidak produktif, merepotkan, atau tidak memiliki peran. Mereka tetap memiliki pengalaman, nilai, kebijaksanaan, dan potensi yang dapat memberi kontribusi bagi keluarga dan lingkungan.

Tujuan pembahasan bab ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai berbagai masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia, faktor-faktor yang memengaruhinya, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta pentingnya upaya pencegahan dan penanganan. Dengan memahami masalah kesehatan perempuan lansia secara menyeluruh, pembaca diharapkan dapat lebih peka terhadap kebutuhan lansia, baik sebagai tenaga kesehatan, keluarga, caregiver, maupun anggota masyarakat. Pemahaman ini juga diharapkan dapat mendorong pelayanan dan pendampingan yang lebih manusiawi, tidak hanya

berorientasi pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup.

Dengan demikian, masalah kesehatan pada perempuan lansia perlu dipahami sebagai kondisi yang kompleks dan saling berkaitan. Proses penuaan, menopause, penyakit kronis, penurunan fungsi tubuh, perubahan psikologis, serta dukungan sosial merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan perempuan lansia. Deteksi dini, pencegahan, perawatan yang tepat, dukungan keluarga, peran tenaga kesehatan, dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar perempuan lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, mandiri, nyaman, bermartabat, dan bermakna.

B. Konsep Dasar Perempuan Lansia dan Kerentanan Kesehatan

Perempuan lansia merupakan kelompok perempuan yang telah memasuki tahap lanjut usia dan mengalami berbagai perubahan alami akibat proses penuaan. Secara umum, lanjut usia sering dipahami sebagai tahap kehidupan ketika seseorang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Namun, pengertian perempuan lansia tidak hanya dapat dilihat dari angka usia semata. Usia kronologis memang menjadi batas administratif untuk menentukan seseorang masuk dalam kelompok lansia, tetapi kondisi setiap perempuan pada masa lanjut usia dapat sangat berbeda. Ada perempuan lansia yang masih aktif, mandiri, produktif, dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sebaliknya, ada pula perempuan lansia yang mengalami keterbatasan fisik, penyakit kronis, gangguan psikologis, penurunan kognitif, atau ketergantungan pada keluarga. Oleh karena itu, perempuan lansia perlu dipahami secara menyeluruh berdasarkan kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan fungsionalnya.

Berdasarkan tahapan usia lanjut, perempuan lansia dapat berada pada fase lanjut usia awal, lanjut usia madya, atau lanjut usia tua. Pada fase lanjut usia awal, sebagian perempuan masih memiliki kemampuan fisik yang relatif baik, masih mampu mengikuti kegiatan keluarga dan masyarakat, serta masih dapat mengambil keputusan secara mandiri. Pada fase lanjut usia yang lebih tua, kemampuan tubuh biasanya semakin menurun sehingga kebutuhan bantuan dari orang lain dapat meningkat. Perempuan lansia pada usia yang lebih lanjut mungkin mulai mengalami gangguan mobilitas, daya ingat menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang, serta lebih rentan mengalami penyakit kronis. Pembagian tahapan usia ini penting karena kebutuhan kesehatan perempuan lansia tidak selalu sama. Perempuan lansia yang masih aktif membutuhkan pendekatan untuk mempertahankan fungsi tubuh, sedangkan perempuan lansia yang sudah

mengalami keterbatasan membutuhkan dukungan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup.

Karakteristik umum perempuan lansia dapat dilihat dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara fisik, perempuan lansia mengalami penurunan fungsi tubuh akibat proses penuaan. Kekuatan otot dapat menurun, tulang menjadi lebih rapuh, sendi mudah nyeri, kulit menjadi kering dan keriput, rambut memutih atau menipis, serta fungsi penglihatan dan pendengaran berkurang. Perempuan lansia juga lebih rentan mengalami penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, gangguan sendi, dan gangguan keseimbangan. Selain itu, riwayat reproduksi dan perubahan hormonal setelah menopause membuat perempuan lansia memiliki masalah kesehatan khas, seperti kekeringan vagina, inkontinensia urine, gangguan urogenital, dan peningkatan risiko osteoporosis. Kondisi fisik tersebut dapat memengaruhi kemampuan perempuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Secara psikologis, perempuan lansia dapat mengalami perubahan cara memandang diri dan kehidupannya. Perubahan fisik, kehilangan peran, penyakit kronis, kematian pasangan, anak-anak yang telah mandiri, atau berkurangnya aktivitas sosial dapat memengaruhi konsep diri dan suasana hati. Sebagian perempuan lansia dapat menerima proses penuaan dengan baik dan melihat masa lanjut usia sebagai fase kehidupan yang tetap bermakna. Namun, sebagian lainnya dapat mengalami kecemasan, kesedihan, rasa kesepian, mudah tersinggung, kehilangan rasa percaya diri, atau merasa tidak lagi dibutuhkan. Perubahan psikologis ini perlu dipahami dengan empati karena tidak jarang keluhan emosional pada lansia muncul dalam bentuk keluhan fisik, seperti sulit tidur, mudah lelah, nyeri tubuh, atau penurunan nafsu makan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kondisi psikologis perempuan lansia sangat penting dalam pelayanan kesehatan maupun pendampingan keluarga.

Secara sosial, perempuan lansia sering mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Pada masa dewasa, banyak perempuan berperan sebagai ibu, istri, pengasuh anak, pengelola rumah tangga, pekerja, atau anggota masyarakat yang aktif. Ketika memasuki masa lanjut usia, peran tersebut dapat berubah. Anak-anak mungkin telah menikah atau tinggal terpisah, pasangan mungkin telah meninggal, kemampuan fisik mulai menurun, dan aktivitas sosial menjadi lebih terbatas. Perubahan ini dapat menimbulkan rasa kehilangan, terutama jika perempuan lansia merasa tidak lagi dilibatkan dalam kehidupan keluarga. Namun, dalam banyak keluarga dan budaya, perempuan lansia tetap memiliki kedudukan penting sebagai sumber pengalaman, penasihat, pengasuh

cucu, penjaga nilai keluarga, dan figur yang dihormati. Lingkungan sosial yang menghargai lansia akan membantu perempuan lansia mempertahankan rasa bermakna dan harga diri.

Secara spiritual, perempuan lansia umumnya memiliki kebutuhan yang semakin kuat untuk memperoleh ketenangan batin, makna hidup, dan penerimaan terhadap proses kehidupan. Spiritualitas dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penyakit, keterbatasan fisik, kehilangan pasangan, kesepian, maupun kecemasan terhadap kematian. Kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan keagamaan, atau melakukan refleksi diri dapat membantu perempuan lansia merasa lebih damai. Dukungan spiritual juga dapat meningkatkan kemampuan lansia dalam menerima perubahan dan menjalani masa tua dengan lebih tenang. Oleh karena itu, kebutuhan spiritual perempuan lansia perlu dihargai dan difasilitasi sesuai keyakinan masing-masing.

Proses penuaan merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan kesehatan pada perempuan lansia. Penuaan adalah proses alami yang berlangsung sepanjang kehidupan dan ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh dalam mempertahankan fungsi optimal. Sel-sel tubuh mengalami perubahan, sistem metabolisme melambat, daya tahan tubuh menurun, dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki jaringan tidak sebaik saat usia muda. Sistem tubuh seperti sistem otot dan tulang, jantung dan pembuluh darah, pernapasan, pencernaan, saraf, endokrin, reproduksi, dan imun mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Penurunan ini membuat perempuan lansia lebih rentan terhadap penyakit, cedera, kelelahan, gangguan mobilitas, dan penurunan kemandirian.

Pada perempuan, proses penuaan tidak dapat dilepaskan dari menopause. Menopause merupakan masa berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dan produksi hormon estrogen. Setelah menopause, perempuan memasuki masa pascamenopause yang membawa berbagai perubahan pada tubuh. Penurunan estrogen dapat memengaruhi kesehatan tulang, pembuluh darah, kulit, sistem urogenital, suasana hati, dan fungsi seksual. Salah satu dampak paling penting adalah meningkatnya risiko osteoporosis karena estrogen berperan dalam mempertahankan kepadatan tulang. Ketika kadar estrogen menurun, tulang menjadi lebih mudah rapuh sehingga risiko fraktur atau patah tulang meningkat, terutama jika lansia mengalami jatuh. Selain itu, penurunan estrogen juga dapat menyebabkan kulit menjadi lebih kering, jaringan vagina menjadi lebih tipis dan kering, serta risiko gangguan saluran kemih meningkat.

Menopause juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan kardiovaskular perempuan lansia. Sebelum menopause, estrogen memiliki efek perlindungan

terhadap pembuluh darah dan metabolisme lemak. Setelah menopause, perlindungan tersebut berkurang sehingga risiko hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan pembuluh darah dapat meningkat. Perempuan lansia juga dapat mengalami perubahan komposisi tubuh, seperti peningkatan lemak tubuh dan penurunan massa otot. Perubahan ini dapat memperbesar risiko obesitas, diabetes melitus, nyeri sendi, dan keterbatasan aktivitas. Selain berdampak pada fisik, perubahan hormonal juga dapat memengaruhi suasana hati, pola tidur, energi, dan kenyamanan seksual. Oleh karena itu, menopause merupakan salah satu faktor penting dalam memahami kerentanan kesehatan perempuan lansia.

Kerentanan kesehatan perempuan lansia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor genetik. Riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit tertentu, seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoporosis, penyakit jantung, kanker, atau gangguan kognitif. Jika seorang perempuan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit degeneratif, maka risiko mengalami masalah serupa pada masa lanjut usia dapat lebih tinggi. Meskipun faktor genetik tidak dapat diubah, dampaknya dapat dikendalikan melalui gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, pengelolaan stres, serta pengendalian faktor risiko. Dengan kata lain, faktor genetik bukanlah satu-satunya penentu kesehatan lansia, tetapi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam deteksi dini dan pencegahan.

Gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan perempuan lansia. Perempuan yang sejak usia muda terbiasa mengonsumsi makanan bergizi, aktif bergerak, cukup istirahat, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, menjaga berat badan, dan mengelola stres cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik saat memasuki usia lanjut. Sebaliknya, pola hidup kurang sehat seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, kebiasaan merokok, kurang tidur, dan stres berkepanjangan dapat mempercepat munculnya penyakit degeneratif. Pada perempuan lansia, gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, tekanan darah, kadar gula darah, fungsi jantung, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup tetap bermanfaat meskipun dilakukan pada usia lanjut.

Penyakit kronis merupakan faktor lain yang meningkatkan kerentanan kesehatan perempuan lansia. Banyak perempuan lansia hidup dengan satu atau lebih penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoarthritis, osteoporosis, gangguan ginjal, penyakit paru kronis, atau gangguan penglihatan. Penyakit kronis dapat menurunkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, meningkatkan kebutuhan obat, menimbulkan nyeri, memperbesar risiko komplikasi, serta menurunkan kualitas hidup. Bila penyakit kronis tidak

dikontrol dengan baik, perempuan lansia dapat mengalami ketergantungan yang semakin besar terhadap keluarga. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan, kepatuhan pengobatan, pengaturan pola makan, aktivitas fisik yang aman, dan kontrol rutin menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kesehatan perempuan lansia.

Nutrisi juga memegang peranan penting dalam kerentanan kesehatan perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, kebutuhan gizi berubah karena metabolisme tubuh melambat, massa otot menurun, nafsu makan berkurang, dan penyakit kronis dapat memengaruhi pola makan. Perempuan lansia membutuhkan asupan protein untuk menjaga otot, kalsium dan vitamin D untuk menjaga tulang, serat untuk mencegah konstipasi, cairan untuk mencegah dehidrasi, serta vitamin dan mineral untuk mendukung fungsi tubuh. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kelemahan, penurunan berat badan, anemia, mudah sakit, penyembuhan luka yang lambat, dan peningkatan risiko jatuh. Sebaliknya, kelebihan asupan gula, garam, dan lemak dapat memperburuk diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Karena itu, pemenuhan nutrisi harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia.

Aktivitas fisik juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kerentanan kesehatan. Kurang bergerak dapat mempercepat penurunan massa otot, melemahkan tulang, menurunkan keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh. Perempuan lansia yang jarang bergerak juga lebih rentan mengalami obesitas, diabetes, hipertensi, konstipasi, gangguan tidur, dan penurunan suasana hati. Sebaliknya, aktivitas fisik yang aman dan teratur dapat membantu mempertahankan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, keseimbangan, kesehatan jantung, dan fungsi pernapasan. Aktivitas seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan ringan, latihan keseimbangan, atau aktivitas rumah tangga sederhana dapat dilakukan sesuai kemampuan. Namun, aktivitas fisik harus tetap disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan sebaiknya dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan bila lansia memiliki penyakit tertentu.

Dukungan sosial juga sangat memengaruhi kesehatan perempuan lansia. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, pasangan, anak, cucu, tetangga, teman sebaya, komunitas, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Perempuan lansia yang memiliki dukungan sosial baik cenderung lebih termotivasi menjaga kesehatan, lebih patuh terhadap pengobatan, lebih aktif secara sosial, dan lebih mampu menghadapi perubahan hidup. Dukungan sosial dapat berupa perhatian emosional, bantuan praktis, pendampingan berobat, informasi kesehatan, atau dukungan spiritual. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko kesepian, depresi, penurunan motivasi, penelantaran, dan memburuknya

penyakit kronis. Oleh karena itu, dukungan sosial bukan hanya kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari kesehatan lansia.

Dalam memahami masalah kesehatan perempuan lansia, pendekatan holistik sangat diperlukan. Pendekatan holistik berarti memandang perempuan lansia sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai tubuh yang mengalami penyakit. Masalah kesehatan lansia sering kali saling berkaitan antara fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan. Misalnya, seorang perempuan lansia yang mengalami nyeri sendi mungkin menjadi jarang bergerak, kemudian kehilangan kesempatan bersosialisasi, merasa kesepian, dan akhirnya mengalami penurunan motivasi untuk merawat diri. Lansia yang mengalami inkontinensia urine mungkin merasa malu keluar rumah, sehingga menarik diri dari kegiatan sosial. Lansia yang mengalami gangguan pendengaran mungkin sulit berkomunikasi, lalu merasa tersisih dari keluarga. Dengan pendekatan holistik, tenaga kesehatan dan keluarga dapat melihat hubungan antar masalah tersebut secara lebih tepat.

Pendekatan holistik juga membantu dalam menentukan intervensi yang sesuai. Jika perempuan lansia mengalami gangguan tidur, penyebabnya tidak hanya dilihat dari faktor usia, tetapi juga dari nyeri, kecemasan, sering buang air kecil, efek obat, kesepian, atau suasana lingkungan tidur. Jika lansia mengalami penurunan nafsu makan, perlu dikaji apakah penyebabnya adalah gangguan gigi, penurunan pengecap, depresi, penyakit kronis, efek obat, atau makan sendirian tanpa dukungan sosial. Jika lansia sering jatuh, penyebabnya tidak hanya kelemahan otot, tetapi juga penglihatan, obat-obatan, alas kaki, pencahayaan rumah, dan kondisi lantai. Dengan demikian, pendekatan holistik memungkinkan masalah kesehatan perempuan lansia ditangani secara lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada gejala.

Keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu memahami bahwa perempuan lansia tetap memiliki martabat, hak, pengalaman, dan potensi. Kerentanan kesehatan tidak boleh membuat lansia dipandang sebagai individu yang tidak berdaya atau tidak berguna. Sebaliknya, kerentanan tersebut harus menjadi dasar untuk memberikan dukungan yang tepat agar lansia tetap mampu menjalani kehidupan sesuai kemampuan. Perempuan lansia perlu dilibatkan dalam keputusan yang berkaitan dengan dirinya, diberi kesempatan untuk tetap mandiri, dan dihargai dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan sikap yang menghargai, perempuan lansia akan lebih mudah menerima bantuan tanpa merasa kehilangan harga diri.

konsep dasar perempuan lansia dan kerentanan kesehatan mencakup pemahaman tentang pengertian perempuan lansia berdasarkan tahapan usia lanjut, karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, serta proses penuaan

sebagai faktor utama perubahan kesehatan. Menopause memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan perempuan lansia karena perubahan hormonal dapat meningkatkan risiko osteoporosis, gangguan kardiovaskular, masalah urogenital, gangguan tidur, dan perubahan emosi. Kerentanan kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, penyakit kronis, nutrisi, aktivitas fisik, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan holistik sangat penting agar masalah kesehatan perempuan lansia dapat dipahami dan ditangani secara menyeluruh, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, mandiri, bermartabat, dan bermakna.

C. Pengaruh Proses Penuaan dan Menopause terhadap Kesehatan Perempuan Lansia

Proses penuaan dan menopause memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan perempuan lansia. Keduanya merupakan proses alami yang terjadi dalam perjalanan hidup perempuan, tetapi dampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan, mulai dari fungsi tubuh, kondisi hormonal, metabolisme, kesehatan tulang, kulit, pembuluh darah, sistem urogenital, suasana hati, hingga risiko penyakit degeneratif. Pada masa lanjut usia, tubuh perempuan mengalami penurunan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan fungsi organ secara optimal. Perubahan ini berlangsung secara bertahap dan berbeda pada setiap individu, tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, riwayat penyakit, nutrisi, aktivitas fisik, lingkungan, serta dukungan keluarga dan sosial.

Penuaan merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari. Seiring bertambahnya usia, sel-sel tubuh mengalami penurunan kemampuan untuk memperbaiki diri. Jaringan tubuh menjadi lebih rentan terhadap kerusakan, fungsi organ menurun, daya tahan tubuh melemah, dan kemampuan tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun psikologis menjadi berkurang. Pada perempuan lansia, perubahan fungsi tubuh ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti tubuh lebih mudah lelah, kekuatan otot menurun, gerakan menjadi lebih lambat, sendi terasa kaku atau nyeri, kulit menjadi lebih kering, penglihatan dan pendengaran berkurang, serta kemampuan tubuh melawan infeksi menurun. Perubahan tersebut dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kebutuhan perempuan lansia terhadap pemantauan kesehatan yang lebih teratur.

Salah satu perubahan penting akibat penuaan adalah penurunan fungsi sistem muskuloskeletal, yaitu sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan penunjang gerak tubuh. Pada perempuan lansia, massa otot cenderung berkurang sehingga tubuh menjadi lebih lemah dan mudah lelah. Kekuatan otot yang menurun dapat memengaruhi kemampuan berjalan, berdiri lama, naik

tangga, membawa barang, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kepadatan tulang juga menurun, terutama setelah menopause, sehingga risiko osteoporosis dan patah tulang meningkat. Sendi juga dapat mengalami perubahan degeneratif yang menyebabkan nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak. Jika tidak ditangani dengan baik, perubahan ini dapat menurunkan mobilitas dan kemandirian perempuan lansia.

Sistem kardiovaskular juga mengalami perubahan akibat penuaan. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan kurang elastis, sehingga tekanan darah cenderung meningkat. Jantung juga dapat mengalami penurunan kemampuan dalam menyesuaikan kerja saat tubuh melakukan aktivitas berat. Perempuan lansia menjadi lebih rentan mengalami hipertensi, penyakit jantung, gangguan sirkulasi, dan keluhan seperti cepat lelah, berdebar, pusing, atau sesak saat beraktivitas. Perubahan ini semakin penting diperhatikan karena setelah menopause, perlindungan alami hormon estrogen terhadap sistem pembuluh darah berkurang. Akibatnya, risiko penyakit kardiovaskular pada perempuan meningkat seiring bertambahnya usia.

Selain sistem otot, tulang, dan jantung, proses penuaan juga memengaruhi sistem pernapasan. Elastisitas jaringan paru dan dinding dada berkurang, otot pernapasan melemah, serta kapasitas paru mengalami penurunan. Kondisi ini dapat membuat perempuan lansia lebih mudah lelah saat berjalan jauh, menaiki tangga, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan energi lebih besar. Pada beberapa lansia, penurunan fungsi pernapasan juga membuat proses pemulihan dari infeksi saluran pernapasan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, menjaga aktivitas fisik ringan, lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik, serta menghindari asap rokok dan polusi menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pernapasan perempuan lansia.

Sistem pencernaan juga mengalami perubahan pada masa lanjut usia. Pergerakan usus dapat menjadi lebih lambat, produksi cairan pencernaan berubah, nafsu makan menurun, serta kemampuan mengunyah dan menelan dapat terganggu akibat masalah gigi dan mulut. Perempuan lansia sering mengalami keluhan konstipasi, perut kembung, cepat kenyang, atau kurang selera makan. Jika kondisi ini berlangsung lama, asupan zat gizi dapat berkurang dan menyebabkan kelemahan, penurunan berat badan, anemia, serta penurunan daya tahan tubuh. Penuaan juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh menyerap zat gizi tertentu, sehingga pemenuhan nutrisi pada perempuan lansia perlu diperhatikan secara cermat.

Menopause merupakan perubahan besar dalam kehidupan perempuan yang sangat memengaruhi kesehatan pada masa lanjut usia. Menopause terjadi ketika

menstruasi berhenti secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dalam menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Setelah menopause, perempuan memasuki masa pascamenopause, yaitu masa ketika tubuh mulai beradaptasi dengan kadar hormon estrogen yang rendah. Penurunan estrogen inilah yang menjadi salah satu faktor utama munculnya berbagai perubahan kesehatan pada perempuan lansia. Estrogen tidak hanya berperan dalam sistem reproduksi, tetapi juga berpengaruh terhadap tulang, kulit, pembuluh darah, sistem urogenital, metabolisme, dan suasana hati.

Penurunan hormon estrogen setelah menopause berdampak besar terhadap kesehatan tulang. Estrogen membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan dan penguraian jaringan tulang. Ketika kadar estrogen menurun, proses pengurangan massa tulang dapat terjadi lebih cepat daripada pembentukan tulang baru. Akibatnya, kepadatan tulang menurun dan risiko osteoporosis meningkat. Osteoporosis sering tidak disadari karena pada tahap awal tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun, ketika tulang menjadi rapuh, perempuan lansia lebih mudah mengalami patah tulang, terutama pada tulang panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Patah tulang pada lansia dapat berdampak serius karena dapat menyebabkan nyeri, keterbatasan gerak, ketergantungan, dan penurunan kualitas hidup.

Dampak menopause juga tampak pada kulit. Estrogen berperan dalam menjaga kelembapan, elastisitas, dan ketebalan kulit. Setelah menopause, kulit perempuan lansia cenderung menjadi lebih kering, tipis, kurang elastis, dan lebih mudah mengalami keriput. Produksi kolagen menurun sehingga kulit kehilangan kekenyalan. Selain itu, kulit menjadi lebih rentan terhadap iritasi, gatal, luka, dan memar. Perubahan pada kulit tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi rasa percaya diri. Sebagian perempuan lansia merasa kurang nyaman dengan perubahan penampilan, seperti kulit keriput, rambut memutih, atau tubuh yang tidak lagi sekuat dahulu. Oleh karena itu, perubahan kulit perlu dipahami sebagai bagian alami dari proses penuaan, tetapi tetap membutuhkan perawatan agar lansia merasa nyaman dan percaya diri.

Pada pembuluh darah, menopause dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular. Sebelum menopause, estrogen membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan berperan dalam metabolisme lemak tubuh. Setelah menopause, kadar estrogen yang menurun dapat menyebabkan perubahan kadar lemak darah, peningkatan kekakuan pembuluh darah, dan kecenderungan peningkatan tekanan darah. Hal ini membuat perempuan lansia lebih berisiko mengalami hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan sirkulasi. Risiko ini dapat meningkat apabila perempuan lansia memiliki faktor lain seperti

obesitas, diabetes melitus, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, stres, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung.

Sistem urogenital juga sangat dipengaruhi oleh penurunan estrogen. Setelah menopause, jaringan vagina dan saluran kemih menjadi lebih tipis, kering, dan mudah iritasi. Perempuan lansia dapat mengalami kekeringan vagina, rasa tidak nyaman pada area genital, nyeri saat berhubungan seksual, gatal, atau infeksi saluran kemih berulang. Selain itu, otot dasar panggul dapat melemah, terutama pada perempuan yang memiliki riwayat persalinan, sehingga risiko inkontinensia urine meningkat. Inkontinensia urine adalah kondisi keluarnya urine tanpa dapat dikontrol sepenuhnya. Masalah ini sering menimbulkan rasa malu, menurunkan rasa percaya diri, mengganggu tidur, dan membuat lansia membatasi aktivitas sosial. Padahal, keluhan urogenital dapat ditangani apabila dikaji dengan baik dan disampaikan kepada tenaga kesehatan.

Menopause juga dapat memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan emosional perempuan lansia. Perubahan hormonal dapat berkontribusi terhadap gangguan tidur, mudah lelah, perubahan mood, kecemasan, atau mudah tersinggung. Namun, kondisi psikologis perempuan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh hormon. Faktor lain seperti penyakit kronis, nyeri, kesepian, kehilangan pasangan, perubahan peran keluarga, masalah ekonomi, dan berkurangnya aktivitas sosial juga dapat memperberat perubahan suasana hati. Oleh karena itu, ketika perempuan lansia mengalami perubahan emosi, tenaga kesehatan dan keluarga perlu melihatnya secara menyeluruh, bukan hanya menganggapnya sebagai bagian biasa dari usia tua.

Perubahan metabolisme tubuh juga terjadi pada perempuan lansia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme basal menurun, sehingga kebutuhan energi tubuh dapat berkurang. Jika asupan makanan tetap berlebihan sementara aktivitas fisik menurun, perempuan lansia lebih mudah mengalami peningkatan berat badan atau penumpukan lemak tubuh. Setelah menopause, perubahan distribusi lemak juga sering terjadi, terutama peningkatan lemak di area perut. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya. Sebaliknya, sebagian perempuan lansia mengalami penurunan berat badan karena nafsu makan menurun, gangguan gigi dan mulut, penyakit kronis, depresi, atau kesepian. Baik kelebihan maupun kekurangan berat badan sama-sama dapat menurunkan kualitas hidup perempuan lansia.

Perubahan metabolisme juga berkaitan dengan penurunan massa otot. Jika perempuan lansia kurang bergerak dan asupan protein tidak mencukupi, massa otot dapat menurun lebih cepat. Penurunan massa otot menyebabkan tubuh lemah, mudah lelah, keseimbangan menurun, dan risiko jatuh meningkat. Kondisi

ini dapat menciptakan lingkaran masalah: tubuh lemah membuat lansia malas bergerak, kurang bergerak membuat otot semakin lemah, dan kelemahan yang bertambah membuat lansia semakin bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi dan aktivitas fisik ringan sangat penting untuk menjaga metabolisme, kekuatan otot, dan fungsi tubuh perempuan lansia.

Setelah menopause, risiko penyakit degeneratif juga meningkat. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ tubuh, proses penuaan, perubahan metabolisme, dan faktor gaya hidup. Penyakit yang sering dialami perempuan lansia antara lain hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoarthritis, osteoporosis, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, dan gangguan saraf. Penyakit-penyakit ini sering berlangsung lama dan memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan. Jika tidak dikendalikan, penyakit degeneratif dapat menyebabkan komplikasi, keterbatasan aktivitas, ketergantungan, penurunan kemandirian, dan penurunan kualitas hidup.

Peningkatan risiko penyakit degeneratif setelah menopause juga berkaitan dengan perubahan gaya hidup pada masa lanjut usia. Banyak perempuan lansia menjadi kurang aktif karena nyeri sendi, takut jatuh, mudah lelah, atau tidak memiliki teman beraktivitas. Kurang aktivitas fisik dapat memperburuk tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, kekuatan otot, dan kesehatan jantung. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang, kurang asupan serat, kelebihan garam, gula, dan lemak, serta kurang minum dapat memperburuk kondisi kesehatan. Oleh sebab itu, masa pascamenopause memerlukan perhatian khusus terhadap pengaturan gaya hidup agar risiko penyakit degeneratif dapat ditekan.

Pemantauan kesehatan secara rutin pada masa pascamenopause sangat penting untuk menjaga kesehatan perempuan lansia. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sebelum berkembang menjadi komplikasi. Pemeriksaan tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi dan mengontrol hipertensi. Pemeriksaan kadar gula darah penting untuk mencegah dan mengendalikan diabetes melitus. Pemeriksaan kadar kolesterol membantu menilai risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pemeriksaan tulang dapat dipertimbangkan pada perempuan yang berisiko osteoporosis. Pemeriksaan mata, pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, status gizi, serta fungsi urogenital juga penting untuk mempertahankan kualitas hidup.

Pemantauan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika perempuan lansia sudah sakit. Pemeriksaan berkala justru sangat penting sebagai tindakan pencegahan. Banyak penyakit pada lansia berkembang tanpa gejala yang jelas. Hipertensi dapat terjadi tanpa keluhan, diabetes dapat berkembang perlahan, osteoporosis dapat

tidak disadari sampai terjadi patah tulang, dan gangguan penglihatan dapat meningkat secara bertahap. Dengan pemeriksaan rutin, masalah dapat ditemukan lebih awal dan ditangani sebelum menyebabkan dampak yang lebih berat. Hal ini membantu perempuan lansia mempertahankan kemandirian dan mencegah komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup.

Selain pemeriksaan fisik, pemantauan kesehatan pada masa pascamenopause juga perlu mencakup aspek psikologis dan sosial. Perempuan lansia perlu dikaji apakah mengalami kecemasan, kesepian, gangguan tidur, penurunan minat, atau tanda depresi. Mereka juga perlu ditanya mengenai dukungan keluarga, aktivitas sosial, spiritualitas, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, dan rasa aman di rumah. Pendekatan seperti ini penting karena kesehatan perempuan lansia tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan laboratorium atau tekanan darah, tetapi juga oleh perasaan dihargai, hubungan sosial, kemampuan beraktivitas, dan makna hidup.

Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung perempuan lansia menghadapi dampak penuaan dan menopause. Keluarga dapat membantu mengingatkan jadwal pemeriksaan, mendampingi kontrol kesehatan, menyediakan makanan sehat, mendorong aktivitas fisik ringan, memastikan obat diminum sesuai anjuran, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman. Namun, keluarga juga perlu menjaga agar bantuan yang diberikan tidak membuat lansia kehilangan kemandirian. Perempuan lansia tetap perlu diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang masih mampu dilakukan, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam keputusan terkait kesehatannya. Dukungan yang menghargai akan membantu perempuan lansia merasa lebih percaya diri dan bermartabat.

Tenaga kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang perubahan akibat penuaan dan menopause. Edukasi perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perempuan lansia perlu memahami bahwa keluhan seperti nyeri sendi, gangguan tidur, inkontinensia urine, kekeringan vagina, atau perubahan suasana hati bukan hal yang harus selalu ditanggung sendiri tanpa bantuan. Mereka perlu didorong untuk menyampaikan keluhan secara terbuka agar dapat dikaji dan ditangani. Tenaga kesehatan juga perlu menghindari sikap menghakimi, terutama ketika membahas masalah urogenital atau fungsi seksual, karena banyak lansia merasa malu membicarakan hal tersebut.

proses penuaan dan menopause memiliki pengaruh luas terhadap kesehatan perempuan lansia. Penuaan menyebabkan penurunan fungsi tubuh secara bertahap, sedangkan menopause menyebabkan penurunan estrogen yang berdampak pada tulang, kulit, pembuluh darah, sistem urogenital, metabolisme, dan suasana hati. Perubahan metabolisme dan penurunan aktivitas fisik dapat

meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, dan nyeri sendi. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan secara rutin pada masa pascamenopause sangat penting untuk mendeteksi masalah lebih awal, mencegah komplikasi, dan mempertahankan kualitas hidup. Dengan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat, perempuan lansia dapat menghadapi perubahan akibat penuaan dan menopause secara lebih sehat, aman, mandiri, dan bermartabat.

D. Osteoporosis, Nyeri Sendi, dan Risiko Fraktur

Osteoporosis, nyeri sendi, dan risiko fraktur merupakan masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia dan sangat berkaitan dengan proses penuaan serta perubahan hormonal setelah menopause. Pada masa lanjut usia, struktur tulang, otot, sendi, dan jaringan pendukung gerak tubuh mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Kondisi ini menyebabkan perempuan lansia lebih rentan mengalami nyeri, keterbatasan gerak, gangguan keseimbangan, jatuh, dan patah tulang. Masalah ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi kemandirian, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, rasa percaya diri, serta kualitas hidup perempuan lansia secara menyeluruh.

Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan dan kekuatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Pada perempuan lansia, osteoporosis sering terjadi karena proses penuaan menyebabkan kemampuan tubuh dalam membentuk jaringan tulang baru semakin menurun. Tulang merupakan jaringan hidup yang terus mengalami proses pembentukan dan penguraian. Pada usia muda, proses pembentukan tulang berlangsung cukup baik sehingga kepadatan tulang dapat dipertahankan. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah menopause, proses penguraian tulang dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan tulang baru. Akibatnya, massa tulang berkurang secara perlahan dan tulang menjadi lebih mudah mengalami kerusakan.

Osteoporosis pada perempuan lansia sering disebut sebagai masalah kesehatan yang “diam-diam” karena pada tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala yang jelas. Banyak perempuan lansia tidak menyadari bahwa kepadatan tulangnya telah menurun sampai akhirnya mengalami nyeri punggung, postur tubuh membungkuk, tinggi badan berkurang, atau patah tulang akibat jatuh ringan. Kondisi ini menjadi berbahaya karena perempuan lansia dapat merasa tubuhnya masih cukup kuat, padahal tulangnya sudah rapuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang osteoporosis sangat penting agar perempuan lansia, keluarga, dan tenaga kesehatan dapat melakukan pencegahan sejak dini sebelum terjadi fraktur atau patah tulang.

Penurunan hormon estrogen setelah menopause memiliki hubungan yang sangat erat dengan berkurangnya kepadatan tulang. Estrogen berperan dalam menjaga keseimbangan proses pembentukan dan penguraian tulang. Ketika perempuan memasuki menopause, kadar estrogen dalam tubuh menurun secara signifikan. Penurunan estrogen menyebabkan proses penguraian tulang berlangsung lebih cepat, sementara pembentukan tulang baru tidak mampu menggantikan kehilangan tersebut secara optimal. Inilah alasan mengapa perempuan pascamenopause memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada usia yang sama. Dampak penurunan estrogen ini paling sering terlihat pada tulang belakang, tulang panggul, dan pergelangan tangan, yaitu area yang sering mengalami fraktur pada lansia.

Selain penurunan estrogen, terdapat berbagai faktor risiko yang dapat mempercepat terjadinya osteoporosis pada perempuan lansia. Kekurangan kalsium merupakan salah satu faktor utama karena kalsium adalah mineral penting untuk membentuk dan mempertahankan kekuatan tulang. Bila asupan kalsium tidak mencukupi dalam jangka panjang, tubuh dapat mengambil cadangan kalsium dari tulang untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga tulang menjadi lebih rapuh. Perempuan lansia sering mengalami kekurangan kalsium karena pola makan yang kurang seimbang, penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, atau kurangnya konsumsi makanan sumber kalsium seperti susu, ikan bertulang lunak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau tertentu.

Kekurangan vitamin D juga berperan penting dalam meningkatkan risiko osteoporosis. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium yang dikonsumsi tidak dapat diserap secara optimal. Perempuan lansia dapat mengalami kekurangan vitamin D karena kurang terpapar sinar matahari, jarang beraktivitas di luar rumah, menggunakan pakaian yang menutupi hampir seluruh tubuh, atau mengalami gangguan metabolisme vitamin D akibat penyakit tertentu. Paparan sinar matahari pagi secara aman, makanan bergizi, dan pemeriksaan kesehatan dapat membantu menjaga kecukupan vitamin D pada perempuan lansia.

Kurangnya aktivitas fisik juga menjadi faktor risiko penting. Tulang dan otot membutuhkan rangsangan gerak agar tetap kuat. Perempuan lansia yang jarang bergerak, terlalu banyak duduk, atau lebih sering berbaring berisiko mengalami penurunan massa tulang dan otot lebih cepat. Aktivitas fisik ringan yang aman, seperti berjalan kaki, senam lansia, latihan keseimbangan, dan latihan beban ringan sesuai kemampuan, dapat membantu mempertahankan kekuatan tulang dan otot. Sebaliknya, kurang gerak dapat mempercepat kelemahan tubuh, membuat sendi

semakin kaku, meningkatkan risiko jatuh, dan memperburuk penurunan kemandirian.

Riwayat keluarga juga memengaruhi risiko osteoporosis. Perempuan lansia yang memiliki orang tua atau saudara dengan riwayat osteoporosis atau patah tulang akibat trauma ringan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Faktor genetik dapat memengaruhi kepadatan tulang, bentuk tubuh, metabolisme kalsium, serta kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Meskipun faktor genetik tidak dapat diubah, risiko dapat dikurangi melalui gaya hidup sehat, pemenuhan gizi, aktivitas fisik, pemeriksaan tulang, serta pencegahan jatuh. Dengan demikian, riwayat keluarga perlu menjadi perhatian dalam pengkajian kesehatan perempuan lansia.

Tanda dan gejala osteoporosis sering kali tidak disadari. Pada tahap awal, osteoporosis tidak selalu menyebabkan nyeri atau keluhan khusus. Perempuan lansia mungkin tetap merasa sehat, tetapi kepadatan tulangnya telah menurun. Gejala biasanya mulai muncul ketika tulang sudah sangat rapuh atau telah terjadi fraktur. Salah satu tanda yang dapat muncul adalah nyeri punggung, terutama jika terjadi pengeroposan atau keretakan kecil pada tulang belakang. Selain itu, tinggi badan dapat berkurang secara bertahap karena tulang belakang mengalami perubahan bentuk. Postur tubuh juga dapat menjadi membungkuk, yang sering disebut kifosis. Perubahan postur ini tidak hanya memengaruhi penampilan, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko jatuh.

Fraktur akibat osteoporosis dapat terjadi pada tulang belakang, panggul, pergelangan tangan, atau tulang paha. Fraktur tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung kronis, tubuh semakin membungkuk, dan kemampuan bergerak menurun. Fraktur panggul merupakan kondisi serius karena dapat membuat perempuan lansia sulit berjalan, membutuhkan perawatan jangka panjang, dan mengalami ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Fraktur pergelangan tangan sering terjadi ketika lansia berusaha menahan tubuh saat jatuh. Karena tulang sudah rapuh, benturan ringan dapat menyebabkan patah tulang. Oleh karena itu, meskipun jatuh tampak ringan, perempuan lansia dengan risiko osteoporosis perlu diperiksa apabila mengalami nyeri hebat, bengkak, kesulitan bergerak, atau perubahan bentuk anggota tubuh.

Selain osteoporosis, nyeri sendi merupakan keluhan yang sangat sering dialami perempuan lansia. Nyeri sendi dapat disebabkan oleh proses degeneratif pada sendi, terutama osteoarthritis. Osteoarthritis adalah gangguan sendi yang terjadi ketika tulang rawan atau bantalan sendi mengalami kerusakan secara perlahan. Tulang rawan berfungsi sebagai pelindung agar permukaan tulang tidak saling bergesekan saat bergerak. Ketika tulang rawan menipis atau rusak, gerakan

sendi menjadi tidak nyaman dan dapat menimbulkan nyeri, kaku, bengkak, serta keterbatasan gerak. Osteoarthritis sering menyerang sendi lutut, panggul, tulang belakang, tangan, dan jari-jari.

Pada perempuan lansia, osteoarthritis dapat dipengaruhi oleh usia, kelebihan berat badan, riwayat cedera sendi, pekerjaan atau aktivitas yang memberi tekanan berulang pada sendi, kurang aktivitas fisik, dan faktor hormonal. Nyeri sendi dapat memburuk saat lansia berjalan jauh, naik turun tangga, berdiri lama, atau membawa beban. Pada pagi hari, sendi dapat terasa kaku, tetapi biasanya membaik setelah digerakkan perlahan. Namun, jika aktivitas terlalu berat, nyeri dapat kembali meningkat. Kondisi ini dapat membuat perempuan lansia membatasi gerakan karena takut nyeri bertambah. Pembatasan gerak yang berlebihan justru dapat memperburuk kekakuan sendi, melemahkan otot, dan menurunkan kemampuan bergerak.

Nyeri sendi tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada psikologis dan sosial. Perempuan lansia yang mengalami nyeri kronis dapat menjadi mudah lelah, sulit tidur, mudah tersinggung, dan kehilangan minat untuk beraktivitas. Mereka mungkin menghindari kegiatan sosial, tidak lagi menghadiri pengajian, arisan, posyandu lansia, atau pertemuan keluarga karena takut nyeri kambuh atau sulit berjalan. Jika berlangsung lama, nyeri sendi dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan risiko kesepian. Oleh karena itu, nyeri sendi perlu dikelola secara tepat, bukan hanya dengan obat, tetapi juga dengan aktivitas fisik yang sesuai, pengendalian berat badan, latihan rentang gerak, istirahat yang cukup, serta dukungan keluarga.

Risiko fraktur pada perempuan lansia meningkat karena adanya kombinasi antara tulang rapuh dan kejadian jatuh. Tulang yang rapuh akibat osteoporosis lebih mudah patah ketika menerima tekanan atau benturan. Sementara itu, proses penuaan menyebabkan keseimbangan menurun, otot melemah, penglihatan berkurang, refleks melambat, dan kemampuan tubuh menahan jatuh tidak sebaik saat usia muda. Faktor lingkungan juga dapat memperbesar risiko jatuh, seperti lantai licin, pencahayaan kurang, kamar mandi tanpa pegangan, tangga curam, karpet yang mudah tersandung, atau barang-barang yang berserakan. Penggunaan obat tertentu, seperti obat tidur, obat penenang, atau obat tekanan darah yang menyebabkan pusing, juga dapat meningkatkan risiko jatuh.

Jatuh pada perempuan lansia dapat menimbulkan dampak serius. Selain menyebabkan luka, memar, atau cedera kepala, jatuh dapat menyebabkan patah tulang yang berakibat pada penurunan mobilitas dan kemandirian. Setelah mengalami jatuh, banyak lansia menjadi takut bergerak. Rasa takut ini dapat membuat mereka lebih banyak duduk atau berbaring, sehingga otot semakin

lemah dan risiko jatuh berikutnya semakin meningkat. Kondisi ini dapat menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus: takut jatuh membuat lansia kurang bergerak, kurang bergerak membuat tubuh semakin lemah, dan kelemahan meningkatkan risiko jatuh. Oleh karena itu, pencegahan jatuh merupakan bagian penting dalam mencegah fraktur pada perempuan lansia.

Upaya pencegahan osteoporosis, nyeri sendi, dan risiko fraktur perlu dilakukan secara menyeluruh. Nutrisi menjadi dasar utama dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Perempuan lansia perlu memperoleh asupan kalsium, vitamin D, protein, dan zat gizi lain yang mendukung kekuatan tulang dan otot. Kalsium membantu menjaga kepadatan tulang, vitamin D membantu penyerapan kalsium, sedangkan protein membantu mempertahankan massa otot. Makanan bergizi seimbang perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan lansia. Bagi lansia dengan hipertensi, konsumsi garam perlu dibatasi. Bagi lansia dengan diabetes, pengaturan gula dan karbohidrat perlu diperhatikan. Dengan pola makan yang tepat, kesehatan tulang, sendi, dan otot dapat lebih terjaga.

Aktivitas fisik yang aman juga sangat penting. Perempuan lansia perlu tetap bergerak sesuai kemampuan agar otot dan tulang tetap mendapatkan rangsangan. Aktivitas seperti berjalan kaki, senam lansia, latihan peregangan, latihan keseimbangan, dan latihan kekuatan ringan dapat membantu menjaga kepadatan tulang, memperkuat otot, mengurangi kekakuan sendi, dan meningkatkan keseimbangan. Aktivitas fisik harus dilakukan secara bertahap dan tidak berlebihan. Lansia yang memiliki nyeri berat, riwayat jatuh, penyakit jantung, atau gangguan keseimbangan sebaiknya mendapatkan arahan dari tenaga kesehatan agar latihan yang dilakukan aman. Tujuannya bukan memaksa lansia bergerak berat, tetapi membantu tubuh tetap aktif sesuai kemampuan.

Pemeriksaan tulang juga menjadi bagian penting dari pencegahan. Perempuan lansia yang memiliki faktor risiko osteoporosis, seperti riwayat menopause dini, riwayat patah tulang, tubuh sangat kurus, riwayat keluarga osteoporosis, kurang aktivitas fisik, atau penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang, perlu mendapatkan pengkajian risiko osteoporosis. Pemeriksaan kepadatan tulang dapat membantu mengetahui kondisi tulang dan menentukan upaya pencegahan atau penanganan yang sesuai. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin juga penting untuk menilai tekanan darah, kadar gula darah, fungsi penglihatan, penggunaan obat, status gizi, dan risiko jatuh yang dapat memengaruhi keselamatan lansia.

Pencegahan jatuh harus dilakukan baik dari sisi tubuh lansia maupun lingkungan. Dari sisi tubuh, perempuan lansia perlu menjaga kekuatan otot, memperbaiki keseimbangan, menggunakan alat bantu bila diperlukan, memeriksa

penglihatan dan pendengaran, serta menghindari penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Dari sisi lingkungan, rumah perlu ditata agar aman. Lantai sebaiknya tidak licin, pencahayaan cukup, kabel atau barang berserakan disingkirkan, kamar mandi dilengkapi pegangan bila memungkinkan, alas kaki harus nyaman dan tidak mudah tergelincir, serta tangga perlu diberi pegangan. Keluarga berperan penting dalam memastikan lingkungan rumah aman dan mendampingi lansia saat melakukan aktivitas yang berisiko.

Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam pencegahan osteoporosis, nyeri sendi, dan fraktur. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan bergizi, mengingatkan lansia untuk tetap bergerak, mendampingi pemeriksaan kesehatan, membantu menata rumah agar aman, serta memberikan dukungan emosional agar lansia tidak takut beraktivitas. Dukungan perlu diberikan dengan tetap menghargai kemandirian lansia. Perempuan lansia sebaiknya tetap diberi kesempatan melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan. Bila keluarga terlalu melarang lansia bergerak karena takut jatuh, lansia dapat menjadi semakin lemah dan kehilangan percaya diri. Sebaliknya, jika lansia dibiarkan melakukan aktivitas berat tanpa pendampingan, risiko cedera meningkat. Karena itu, keseimbangan antara perlindungan dan kemandirian sangat penting.

Tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam edukasi dan pemantauan. Perempuan lansia dan keluarga perlu diberi informasi mengenai osteoporosis, nyeri sendi, risiko jatuh, tanda bahaya fraktur, pentingnya nutrisi, aktivitas fisik, serta pemeriksaan kesehatan. Edukasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menakutkan. Tenaga kesehatan juga perlu mengkaji keluhan nyeri, kemampuan berjalan, riwayat jatuh, penggunaan obat, status gizi, dan kondisi lingkungan rumah. Dengan pengkajian yang menyeluruh, intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lansia.

Dari pembahasan diatas, osteoporosis, nyeri sendi, dan risiko fraktur merupakan masalah kesehatan yang saling berkaitan dan sering dialami perempuan lansia. Osteoporosis terjadi akibat penurunan kepadatan tulang, yang sangat dipengaruhi oleh penurunan estrogen setelah menopause serta faktor lain seperti kurang kalsium, kurang vitamin D, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Nyeri sendi, terutama akibat osteoarthritis, dapat membatasi gerak dan menurunkan kualitas hidup. Tulang yang rapuh, gangguan keseimbangan, kelemahan otot, dan lingkungan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko jatuh dan fraktur. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui nutrisi yang baik, aktivitas fisik aman, pemeriksaan kesehatan dan tulang, pencegahan jatuh, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Dengan penanganan yang tepat,

perempuan lansia dapat mempertahankan mobilitas, kemandirian, kenyamanan, dan kualitas hidup secara lebih optimal.

E. Hipertensi, Penyakit Jantung, dan Gangguan Sirkulasi

Hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi merupakan masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia dan perlu mendapat perhatian serius. Ketiga masalah ini saling berkaitan karena sama-sama melibatkan sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan aliran darah ke seluruh tubuh. Pada masa lanjut usia, sistem kardiovaskular mengalami berbagai perubahan akibat proses penuaan, seperti pembuluh darah menjadi lebih kaku, elastisitas pembuluh menurun, kemampuan jantung menyesuaikan beban kerja berkurang, serta aliran darah ke jaringan tubuh dapat mengalami hambatan. Pada perempuan lansia, risiko gangguan kardiovaskular juga meningkat setelah menopause karena terjadi penurunan hormon estrogen yang sebelumnya memiliki peran perlindungan terhadap pembuluh darah dan metabolisme lemak.

Hipertensi pada perempuan lansia dapat diartikan sebagai kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal secara menetap. Tekanan darah yang tinggi menunjukkan bahwa jantung harus bekerja lebih kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada awalnya, hipertensi sering tidak menimbulkan keluhan yang jelas sehingga banyak perempuan lansia tidak menyadari bahwa dirinya mengalami tekanan darah tinggi. Kondisi ini membuat hipertensi sering disebut sebagai masalah kesehatan yang diam-diam berbahaya karena dapat berlangsung lama tanpa gejala, tetapi secara perlahan merusak pembuluh darah, jantung, otak, ginjal, dan organ lainnya. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan penurunan kualitas hidup.

Pada perempuan lansia, hipertensi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Proses penuaan menyebabkan pembuluh darah mengalami perubahan struktur. Dinding pembuluh darah menjadi lebih tebal, kaku, dan kurang elastis. Saat pembuluh darah kehilangan kelenturannya, tekanan di dalam pembuluh darah cenderung meningkat. Selain itu, fungsi ginjal yang ikut berubah pada usia lanjut dapat memengaruhi pengaturan cairan dan garam dalam tubuh, sehingga tekanan darah lebih mudah naik. Faktor lain seperti konsumsi garam berlebihan, kurang aktivitas fisik, kelebihan berat badan, stres, kurang tidur, riwayat keluarga, diabetes melitus, dan penggunaan obat tertentu juga dapat memperburuk tekanan darah pada perempuan lansia.

Perubahan pembuluh darah akibat proses penuaan merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya risiko hipertensi dan penyakit jantung. Pada usia

muda, pembuluh darah memiliki elastisitas yang baik sehingga dapat melebar dan menyempit sesuai kebutuhan tubuh. Elastisitas ini membantu menjaga aliran darah tetap lancar dan tekanan darah tetap stabil. Namun, pada masa lanjut usia, pembuluh darah menjadi lebih kaku sehingga tidak dapat menyesuaikan tekanan dengan baik. Kekakuan pembuluh darah membuat jantung harus memompa darah dengan tekanan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membebani jantung dan menyebabkan perubahan pada otot jantung.

Pembuluh darah yang menuju juga lebih rentan mengalami penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain pada dinding pembuluh darah. Penumpukan ini dapat mempersempit saluran pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Bila pembuluh darah yang menuju jantung menyempit, perempuan lansia dapat mengalami penyakit jantung koroner. Bila pembuluh darah yang menuju otak terganggu, risiko stroke meningkat. Bila aliran darah ke tungkai berkurang, dapat muncul keluhan seperti kaki dingin, kesemutan, nyeri saat berjalan, atau luka yang sulit sembuh. Oleh karena itu, perubahan pembuluh darah pada masa lanjut usia tidak boleh dianggap sebagai hal ringan karena dapat berdampak luas terhadap kesehatan dan kemandirian perempuan lansia.

Menopause memiliki pengaruh penting terhadap meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular pada perempuan lansia. Sebelum menopause, hormon estrogen membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, mendukung keseimbangan kadar lemak darah, dan berperan dalam perlindungan terhadap sistem jantung dan pembuluh darah. Setelah menopause, kadar estrogen menurun sehingga perlindungan tersebut berkurang. Penurunan estrogen dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol jahat, penurunan kolesterol baik, peningkatan lemak tubuh terutama di area perut, serta meningkatnya kekakuan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini membuat perempuan lansia lebih rentan mengalami hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi.

Peningkatan risiko kardiovaskular setelah menopause juga dapat diperberat oleh perubahan gaya hidup pada masa lanjut usia. Sebagian perempuan lansia menjadi kurang aktif karena nyeri sendi, mudah lelah, takut jatuh, atau tidak memiliki teman untuk beraktivitas. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berat badan meningkat, kadar gula darah tidak stabil, tekanan darah naik, dan kekuatan jantung menurun. Selain itu, pola makan tinggi garam, gula, lemak jenuh, serta rendah serat dapat memperburuk kesehatan pembuluh darah. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan stroke semakin meningkat.

Penyakit jantung pada perempuan lansia perlu dikenali sejak dini karena gejalanya kadang tidak khas. Sebagian orang mengira penyakit jantung selalu

ditandai dengan nyeri dada hebat, padahal pada perempuan lansia keluhan dapat lebih samar. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain rasa tidak nyaman di dada, dada terasa berat atau tertekan, sesak napas saat aktivitas ringan, cepat lelah, jantung berdebar, pusing, keringat dingin, mual, nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, rahang, atau ulu hati. Pada sebagian perempuan lansia, keluhan utama justru berupa kelelahan yang tidak biasa, sulit bernapas saat berbaring, atau bengkak pada kaki. Karena gejala dapat tidak khas, keluarga dan tenaga kesehatan perlu lebih peka terhadap perubahan kondisi perempuan lansia.

Sesak napas merupakan salah satu tanda yang perlu diperhatikan. Perempuan lansia yang sebelumnya mampu berjalan atau melakukan aktivitas rumah tangga, kemudian menjadi mudah sesak saat aktivitas ringan, perlu mendapatkan pemeriksaan. Sesak dapat disebabkan oleh gangguan jantung, gangguan paru, anemia, atau kondisi lain. Pada penyakit jantung, sesak dapat muncul karena jantung tidak mampu memompa darah secara optimal sehingga terjadi penumpukan cairan di paru atau jaringan tubuh. Sesak juga dapat disertai kelelahan, batuk malam hari, atau bengkak pada tungkai. Gejala seperti ini tidak boleh dianggap sebagai “biasa karena tua”, karena dapat menjadi tanda adanya masalah kardiovaskular yang membutuhkan penanganan.

Nyeri dada juga merupakan keluhan penting yang perlu diwaspadai. Nyeri dada pada penyakit jantung dapat terasa seperti ditekan, ditindih, panas, atau tidak nyaman di dada. Namun, pada perempuan lansia, nyeri dapat terasa tidak terlalu khas dan kadang menyerupai keluhan lambung, seperti nyeri ulu hati atau mual. Karena itu, keluhan nyeri dada, rasa tidak nyaman di dada, atau keluhan yang muncul saat aktivitas dan membaik saat istirahat perlu diperiksa lebih lanjut. Keluarga sebaiknya tidak menunda membawa perempuan lansia ke fasilitas kesehatan apabila keluhan dada disertai sesak, keringat dingin, pusing, lemas berat, atau nyeri menjalar.

Gangguan sirkulasi juga sering dialami perempuan lansia. Sirkulasi adalah proses peredaran darah yang membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh. Jika sirkulasi terganggu, jaringan tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Gangguan sirkulasi dapat ditandai dengan kaki bengkak, kesemutan, kaki terasa dingin, warna kulit berubah, nyeri pada tungkai saat berjalan, atau luka yang sulit sembuh. Pada perempuan lansia dengan diabetes melitus, gangguan sirkulasi sering menjadi lebih berat karena diabetes dapat merusak pembuluh darah kecil dan saraf. Akibatnya, luka kecil pada kaki dapat sulit sembuh dan berisiko menjadi infeksi.

Kaki bengkak pada perempuan lansia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, kurang

bergerak, atau efek obat tertentu. Bengkak pada kaki perlu diperhatikan terutama bila terjadi terus-menerus, disertai sesak napas, cepat lelah, atau penurunan kemampuan beraktivitas. Kaki yang bengkak dapat membuat lansia sulit berjalan, sulit memakai alas kaki, dan merasa tidak nyaman. Selain itu, pembengkakan yang berlangsung lama dapat membuat kulit lebih mudah lecet atau luka. Oleh karena itu, keluhan kaki bengkak perlu dikaji penyebabnya agar penanganannya tepat.

Kesemutan dan kaki dingin juga dapat menjadi tanda gangguan sirkulasi atau gangguan saraf. Perempuan lansia yang sering merasakan kesemutan, kebas, atau rasa seperti ditusuk-tusuk pada kaki perlu diperiksa, terutama jika memiliki riwayat diabetes melitus atau penyakit pembuluh darah. Gangguan ini dapat mengurangi kemampuan merasakan nyeri atau luka. Akibatnya, lansia mungkin tidak menyadari adanya luka kecil pada kaki sampai luka tersebut membesar atau terinfeksi. Perawatan kaki menjadi sangat penting, termasuk memeriksa kaki setiap hari, menjaga kebersihan, menggunakan alas kaki yang nyaman, menghindari berjalan tanpa alas kaki, dan segera memeriksakan luka yang tidak membaik.

Luka sulit sembuh merupakan salah satu masalah serius yang berkaitan dengan gangguan sirkulasi. Aliran darah yang tidak lancar menyebabkan oksigen dan zat gizi tidak cukup sampai ke area luka, sehingga proses penyembuhan menjadi lambat. Pada perempuan lansia dengan diabetes, hipertensi, atau penyakit pembuluh darah, luka kecil dapat berkembang menjadi luka kronis jika tidak dirawat dengan baik. Luka yang sulit sembuh dapat menimbulkan nyeri, infeksi, keterbatasan mobilitas, dan kecemasan. Oleh karena itu, pencegahan luka dan perawatan luka yang tepat sangat penting pada perempuan lansia, terutama yang memiliki penyakit kronis.

Hipertensi dan penyakit jantung dapat memberikan dampak besar terhadap aktivitas sehari-hari perempuan lansia. Ketika tekanan darah tidak terkontrol atau fungsi jantung menurun, perempuan lansia dapat merasa cepat lelah, pusing, sesak, atau tidak kuat melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Aktivitas sederhana seperti memasak, menyapu, berjalan ke kamar mandi, berbelanja, atau mengikuti kegiatan sosial dapat terasa berat. Kondisi ini dapat menurunkan kemandirian dan membuat lansia lebih bergantung pada keluarga. Jika perempuan lansia merasa aktivitasnya semakin terbatas, ia dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa menjadi beban, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

Dampak penyakit jantung dan hipertensi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis. Perempuan lansia yang sering merasakan keluhan jantung atau tekanan darah tinggi dapat menjadi cemas, takut beraktivitas, atau khawatir mengalami serangan mendadak. Rasa takut ini dapat membuat lansia membatasi diri secara berlebihan. Padahal, kurang aktivitas fisik dapat memperburuk kesehatan jantung

dan pembuluh darah. Oleh karena itu, perempuan lansia membutuhkan edukasi tentang aktivitas yang aman, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta pentingnya tetap bergerak sesuai kemampuan. Dukungan keluarga sangat penting agar lansia merasa aman tetapi tetap terdorong untuk aktif.

Pencegahan hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pola makan sehat merupakan langkah utama. Perempuan lansia dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah sesuai kondisi kesehatan, memilih sumber protein yang baik, mengurangi makanan tinggi garam, membatasi makanan tinggi lemak jenuh, serta menghindari konsumsi gula berlebihan. Pengurangan garam sangat penting bagi perempuan lansia dengan hipertensi karena konsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja jantung. Makanan yang terlalu berlemak juga perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak pada pembuluh darah.

Aktivitas fisik yang aman juga penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Aktivitas fisik membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga tekanan darah, mengontrol berat badan, meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki suasana hati, dan menjaga fungsi jantung. Perempuan lansia dapat melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, latihan napas, atau aktivitas rumah tangga ringan sesuai kemampuan. Aktivitas tidak perlu dilakukan secara berat, tetapi sebaiknya dilakukan secara teratur dan aman. Jika perempuan lansia memiliki penyakit jantung, riwayat sesak, nyeri dada, atau gangguan keseimbangan, jenis dan durasi aktivitas perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan.

Pengendalian stres juga berperan dalam pencegahan hipertensi dan penyakit jantung. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah, mengganggu tidur, menurunkan nafsu makan, dan memperburuk kondisi penyakit kronis. Perempuan lansia dapat mengalami stres akibat masalah kesehatan, kehilangan pasangan, konflik keluarga, kesepian, atau masalah ekonomi. Oleh karena itu, dukungan emosional dari keluarga, kegiatan spiritual, aktivitas sosial, relaksasi, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan menjalankan kegiatan yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres. Keluarga perlu menciptakan suasana rumah yang tenang dan tidak penuh tekanan agar lansia merasa nyaman.

Pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat penting, terutama karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala. Perempuan lansia sebaiknya melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala di rumah, posyandu lansia, puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Pemantauan tekanan darah membantu mengetahui apakah tekanan darah terkontrol atau membutuhkan

penanganan lebih lanjut. Selain tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, berat badan, fungsi ginjal, dan kesehatan jantung juga penting, terutama bagi perempuan lansia yang memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan rutin memungkinkan masalah ditemukan lebih awal sebelum terjadi komplikasi.

Kepatuhan minum obat merupakan bagian penting dalam pengendalian hipertensi dan penyakit jantung. Banyak perempuan lansia memerlukan obat jangka panjang untuk menjaga tekanan darah, mengontrol gula darah, mengatur kolesterol, atau membantu kerja jantung. Obat harus diminum sesuai anjuran tenaga kesehatan. Menghentikan obat sendiri karena merasa sudah membaik dapat menyebabkan tekanan darah naik kembali atau kondisi jantung memburuk. Sebaliknya, penggunaan obat tanpa pengawasan juga dapat menimbulkan efek samping atau interaksi obat. Keluarga dapat membantu dengan membuat jadwal minum obat, menyiapkan kotak obat, mengingatkan waktu minum obat, dan mendampingi kontrol kesehatan.

Selain kepatuhan obat, perempuan lansia juga perlu memahami tanda bahaya yang membutuhkan pertolongan segera. Keluhan seperti nyeri dada, sesak napas berat, pingsan, kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, bicara pelo, pusing hebat, bengkak berat, atau luka kaki yang tidak membaik perlu segera diperiksakan. Edukasi tentang tanda bahaya penting diberikan kepada lansia dan keluarga agar tidak terlambat mencari pertolongan. Pada lansia, keterlambatan penanganan dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berat dan memperpanjang masa pemulihan.

Peran keluarga sangat penting dalam mencegah dan mengelola hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi pada perempuan lansia. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan sehat, mengurangi makanan tinggi garam, menemani aktivitas fisik, mendampingi kontrol kesehatan, memantau keluhan, dan memberikan dukungan emosional. Namun, keluarga juga perlu menjaga agar lansia tetap memiliki kemandirian. Bantuan sebaiknya diberikan dengan cara yang menghargai, bukan mengatur secara keras atau membuat lansia merasa tidak mampu. Komunikasi yang sabar dan empatik akan membantu perempuan lansia lebih mudah menerima perubahan gaya hidup dan mengikuti pengobatan.

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam edukasi, deteksi dini, pemantauan, dan pencegahan komplikasi. Tenaga kesehatan perlu menjelaskan kondisi hipertensi dan penyakit jantung dengan bahasa sederhana, memantau tekanan darah dan faktor risiko, mengevaluasi obat yang digunakan, serta memberi arahan tentang aktivitas fisik dan pola makan. Selain itu, tenaga kesehatan perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial perempuan lansia. Lansia yang takut

beraktivitas karena penyakit jantung perlu diberi penjelasan mengenai aktivitas yang aman. Lansia yang sulit patuh obat perlu dicari penyebabnya, apakah karena lupa, efek samping, biaya, atau kurang pemahaman. Dengan pendekatan menyeluruh, pengelolaan penyakit dapat menjadi lebih efektif.

Dengan demikian, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi merupakan masalah kesehatan penting pada perempuan lansia yang dipengaruhi oleh proses penuaan, perubahan pembuluh darah, penurunan estrogen setelah menopause, gaya hidup, penyakit kronis, dan faktor keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti tekanan darah tinggi, cepat lelah, sesak, nyeri dada, kaki bengkak, kesemutan, kaki dingin, dan luka sulit sembuh. Dampaknya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kemandirian, dan memengaruhi kualitas hidup. Pencegahan dan pengelolaan perlu dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik aman, pengendalian stres, pemeriksaan tekanan darah rutin, kepatuhan obat, dukungan keluarga, serta pemantauan oleh tenaga kesehatan. Dengan pengelolaan yang tepat, perempuan lansia dapat mempertahankan kesehatan kardiovaskular, tetap aktif sesuai kemampuan, dan menjalani masa tua dengan lebih aman, nyaman, dan bermartabat.

F. Diabetes Melitus dan Penyakit Degeneratif Lainnya

Diabetes melitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia dan menjadi bagian dari kelompok penyakit degeneratif yang perlu mendapat perhatian serius. Diabetes melitus adalah kondisi ketika kadar gula darah meningkat secara menetap akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau kombinasi keduanya. Insulin merupakan hormon yang membantu gula darah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Ketika insulin tidak bekerja dengan baik, gula tetap berada di dalam darah sehingga kadar gula darah meningkat. Pada perempuan lansia, kondisi ini sering berkembang secara perlahan dan kadang tidak disadari sejak awal karena gejalanya dapat samar atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan biasa.

Pada masa lanjut usia, diabetes melitus tidak hanya menjadi masalah kadar gula darah, tetapi juga dapat memengaruhi hampir seluruh aspek kesehatan. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah, saraf, ginjal, mata, jantung, dan kulit. Akibatnya, perempuan lansia dengan diabetes berisiko mengalami berbagai komplikasi yang dapat menurunkan kemandirian, kenyamanan, mobilitas, dan kualitas hidup. Diabetes juga sering muncul bersama penyakit lain seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan gangguan sirkulasi. Oleh karena itu, diabetes pada perempuan lansia perlu dipahami sebagai kondisi kronis yang

mebutuhkan pengelolaan berkelanjutan, bukan hanya pengobatan sesaat ketika gula darah meningkat.

Risiko diabetes melitus pada perempuan lansia meningkat seiring bertambahnya usia. Proses penuaan menyebabkan perubahan metabolisme tubuh, termasuk penurunan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, tubuh menjadi kurang efektif dalam menggunakan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Selain itu, pada masa lanjut usia, massa otot cenderung menurun, sementara lemak tubuh dapat meningkat, terutama bila aktivitas fisik berkurang. Otot merupakan jaringan penting yang membantu penggunaan gula sebagai energi. Ketika massa otot menurun dan aktivitas fisik berkurang, penggunaan gula oleh tubuh menjadi lebih rendah sehingga risiko peningkatan kadar gula darah semakin besar.

Obesitas atau kelebihan berat badan juga menjadi faktor risiko penting diabetes melitus pada perempuan lansia. Setelah menopause, perubahan hormonal dapat memengaruhi distribusi lemak tubuh, terutama peningkatan lemak di area perut. Lemak perut berkaitan erat dengan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh kurang responsif terhadap insulin. Perempuan lansia dengan obesitas tidak hanya berisiko mengalami diabetes, tetapi juga lebih rentan terhadap hipertensi, penyakit jantung, nyeri sendi, gangguan tidur, dan keterbatasan mobilitas. Oleh karena itu, menjaga berat badan ideal melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik sesuai kemampuan sangat penting untuk menurunkan risiko diabetes dan penyakit degeneratif lainnya.

Riwayat keluarga juga berperan dalam meningkatkan risiko diabetes. Perempuan lansia yang memiliki orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga dekat dengan diabetes memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kondisi yang sama. Faktor genetik dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam memproduksi insulin maupun merespons insulin. Namun, faktor keturunan bukan berarti diabetes pasti terjadi. Gaya hidup sehat, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, serta pemeriksaan gula darah secara berkala dapat membantu mengurangi risiko atau memperlambat munculnya diabetes. Dengan demikian, perempuan lansia yang memiliki riwayat keluarga diabetes perlu lebih waspada dan melakukan pemantauan kesehatan secara rutin.

Pola makan merupakan faktor yang sangat memengaruhi risiko diabetes pada perempuan lansia. Konsumsi makanan tinggi gula, tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, serta rendah serat dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan gangguan pengaturan gula darah. Kebiasaan mengonsumsi minuman manis, makanan ringan manis, nasi dalam porsi berlebihan, makanan olahan, gorengan, serta makanan tinggi lemak dapat memperburuk kontrol gula darah. Pada lansia, pola makan juga dapat terganggu karena penurunan nafsu makan, masalah gigi,

kesulitan mengunyah, kesepian, atau kebiasaan makan yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, pengaturan makan pada perempuan lansia perlu dilakukan secara bijaksana, tidak sekadar melarang makanan tertentu, tetapi membantu lansia memahami pilihan makanan yang lebih sehat, seimbang, dan sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Kurang aktivitas fisik juga menjadi faktor risiko penting. Perempuan lansia sering mengurangi gerak karena mudah lelah, nyeri sendi, takut jatuh, gangguan keseimbangan, atau tidak memiliki teman untuk beraktivitas. Padahal, aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan gula darah sebagai energi dan meningkatkan sensitivitas insulin. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, berkebun ringan, latihan keseimbangan, atau pekerjaan rumah tangga sederhana dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan, memperkuat otot, dan meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas fisik tidak harus berat, tetapi perlu dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi kesehatan perempuan lansia.

Tanda dan gejala diabetes pada lansia dapat berbeda-beda. Beberapa perempuan lansia mengalami keluhan klasik seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lapar, berat badan menurun tanpa sebab jelas, mudah lelah, dan pandangan kabur. Namun, pada lansia, gejala diabetes sering tidak khas. Mereka mungkin hanya mengeluh lemas, mudah mengantuk, luka yang lama sembuh, sering mengalami infeksi, gatal pada kulit, kesemutan, atau penurunan kemampuan beraktivitas. Karena gejalanya samar, diabetes pada perempuan lansia sering terlambat diketahui. Oleh sebab itu, pemeriksaan gula darah secara berkala sangat penting, terutama pada lansia yang memiliki faktor risiko seperti obesitas, riwayat keluarga diabetes, hipertensi, atau pola hidup kurang aktif.

Sering buang air kecil pada perempuan lansia perlu diperhatikan karena dapat berkaitan dengan kadar gula darah yang tinggi. Ketika gula darah meningkat, ginjal berusaha membuang kelebihan gula melalui urine. Proses ini dapat menyebabkan peningkatan frekuensi buang air kecil dan rasa haus yang berlebihan. Pada malam hari, sering buang air kecil dapat mengganggu tidur, menyebabkan kelelahan pada siang hari, dan meningkatkan risiko jatuh karena lansia harus berjalan ke kamar mandi dalam kondisi mengantuk atau pencahayaan kurang. Namun, sering buang air kecil juga dapat disebabkan oleh inkontinensia urine, infeksi saluran kemih, atau gangguan urogenital pascamenopause. Karena itu, keluhan ini perlu dikaji secara menyeluruh.

Kesemutan atau rasa kebas pada kaki dan tangan juga merupakan keluhan yang perlu diwaspadai pada perempuan lansia dengan diabetes. Keluhan ini dapat terjadi karena kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang tinggi dalam jangka

panjang. Gangguan saraf tersebut dapat menyebabkan rasa kesemutan, kebas, nyeri seperti terbakar, atau penurunan kemampuan merasakan nyeri dan suhu. Jika sensasi pada kaki menurun, perempuan lansia mungkin tidak menyadari adanya luka kecil, lecet, atau tekanan dari alas kaki. Luka yang tidak disadari dapat membesar, terinfeksi, dan sulit sembuh, terutama bila sirkulasi darah juga terganggu. Oleh karena itu, perawatan kaki menjadi bagian penting dalam pengelolaan diabetes pada perempuan lansia.

Komplikasi diabetes dapat terjadi pada berbagai organ tubuh. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah gangguan saraf atau neuropati diabetik. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan lansia merasakan rangsangan, menjaga keseimbangan, dan berjalan dengan aman. Neuropati dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, kebas, atau kelemahan pada kaki. Jika kondisi ini tidak ditangani, risiko jatuh dan luka pada kaki dapat meningkat. Perempuan lansia dengan gangguan saraf juga dapat mengalami kesulitan menjalankan aktivitas harian karena rasa tidak nyaman yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, pengendalian gula darah, pemeriksaan kaki, penggunaan alas kaki yang tepat, dan pemantauan keluhan saraf sangat penting dilakukan.

Gangguan ginjal juga dapat menjadi komplikasi diabetes. Ginjal berfungsi menyaring darah dan membuang sisa metabolisme melalui urine. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal sehingga fungsi ginjal menurun secara perlahan. Pada tahap awal, gangguan ginjal mungkin tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun, bila semakin berat, dapat muncul keluhan seperti bengkak pada kaki, mudah lelah, tekanan darah sulit terkontrol, mual, nafsu makan menurun, atau perubahan pola buang air kecil. Karena gangguan ginjal dapat berkembang diam-diam, perempuan lansia dengan diabetes perlu melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Gangguan penglihatan juga sering berkaitan dengan diabetes pada perempuan lansia. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina mata, sehingga penglihatan menjadi kabur atau menurun. Selain itu, diabetes juga dapat meningkatkan risiko katarak dan glaukoma. Gangguan penglihatan pada perempuan lansia dapat berdampak besar terhadap kemandirian karena dapat menghambat aktivitas membaca, memasak, berjalan, mengenali wajah, mengelola obat, dan melakukan perawatan diri. Gangguan penglihatan juga meningkatkan risiko jatuh. Oleh karena itu, pemeriksaan mata secara berkala penting dilakukan, terutama pada lansia dengan diabetes atau keluhan penglihatan.

Luka yang sulit sembuh merupakan komplikasi diabetes yang perlu mendapat perhatian khusus. Kadar gula darah yang tinggi dapat mengganggu proses penyembuhan luka dan menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Selain itu, gangguan sirkulasi dan kerusakan saraf dapat membuat luka pada kaki lebih mudah terjadi dan sulit diketahui. Luka kecil akibat gesekan sandal, kuku yang terlalu panjang, kulit kering pecah-pecah, atau benda tajam dapat berkembang menjadi luka yang serius jika tidak dirawat. Pada perempuan lansia, luka yang sulit sembuh dapat membatasi mobilitas, menimbulkan nyeri, meningkatkan risiko infeksi, dan menyebabkan ketergantungan. Pencegahan luka dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kaki, menggunakan alas kaki yang nyaman, memeriksa kaki secara rutin, dan segera melaporkan luka kepada tenaga kesehatan.

Selain diabetes, perempuan lansia juga rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif lainnya. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ tubuh, proses penuaan, perubahan metabolisme, dan faktor gaya hidup. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang sering ditemukan pada perempuan lansia. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, serta gangguan penglihatan. Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat penting.

Penyakit jantung juga menjadi masalah degeneratif yang sering dialami perempuan lansia, terutama setelah menopause. Penurunan estrogen dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah dan perubahan kadar lemak darah. Penyakit jantung dapat menimbulkan keluhan seperti cepat lelah, sesak, nyeri dada, jantung berdebar, atau bengkak pada kaki. Pada perempuan lansia, gejala penyakit jantung kadang tidak khas sehingga sering terlambat dikenali. Penyakit jantung dapat membatasi aktivitas harian, meningkatkan rasa takut bergerak, dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, perempuan lansia perlu menjaga tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, berat badan, serta tetap melakukan aktivitas fisik yang aman.

Osteoarthritis atau penyakit sendi degeneratif juga sering terjadi pada perempuan lansia. Kondisi ini terjadi ketika bantalan sendi mengalami kerusakan secara perlahan, sehingga sendi terasa nyeri, kaku, bengkak, atau sulit digerakkan. Osteoarthritis sering menyerang lutut, pinggul, jari tangan, dan tulang belakang. Nyeri sendi dapat membuat perempuan lansia mengurangi aktivitas fisik, padahal kurang bergerak dapat memperburuk kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh. Oleh karena itu, penanganan osteoarthritis perlu mencakup pengendalian

nyeri, aktivitas fisik yang sesuai, pengaturan berat badan, latihan rentang gerak, dan dukungan keluarga agar lansia tetap aktif secara aman.

Osteoporosis juga termasuk masalah degeneratif yang sering dialami perempuan lansia. Setelah menopause, kepadatan tulang menurun lebih cepat akibat berkurangnya estrogen. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah, terutama jika lansia mengalami jatuh. Osteoporosis sering tidak disadari sampai terjadi fraktur. Patah tulang pada lansia dapat menyebabkan nyeri, keterbatasan gerak, ketergantungan, dan penurunan kualitas hidup. Karena itu, pemenuhan kalsium dan vitamin D, aktivitas fisik yang sesuai, pemeriksaan tulang, serta pencegahan jatuh menjadi upaya penting dalam menjaga kesehatan tulang perempuan lansia.

Pentingnya pengendalian gula darah tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan diabetes pada perempuan lansia. Pengendalian gula darah bertujuan mencegah gejala diabetes, memperlambat kerusakan organ, dan mengurangi risiko komplikasi. Pengendalian ini dilakukan melalui kombinasi pola makan sehat, aktivitas fisik, penggunaan obat sesuai anjuran, pemantauan gula darah, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Namun, pengendalian gula darah pada lansia perlu dilakukan secara hati-hati dan individual. Kondisi fisik, penyakit penyerta, kemampuan makan, risiko hipoglikemia, kemampuan memahami instruksi, serta dukungan keluarga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perempuan lansia sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan dan tidak mengubah obat atau pola makan ekstrem tanpa pendampingan.

Pemeriksaan kesehatan berkala sangat penting bagi perempuan lansia dengan diabetes maupun penyakit degeneratif lainnya. Pemeriksaan dapat mencakup pengukuran gula darah, tekanan darah, berat badan, pemeriksaan kolesterol, fungsi ginjal, kondisi mata, kesehatan kaki, status gizi, serta evaluasi obat yang digunakan. Pemeriksaan berkala membantu mendeteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi komplikasi yang berat. Misalnya, gangguan penglihatan dapat ditemukan lebih awal, luka kaki dapat ditangani sebelum infeksi meluas, dan tekanan darah tinggi dapat dikendalikan sebelum menyebabkan stroke. Dengan pemantauan rutin, perempuan lansia dapat mempertahankan fungsi tubuh dan kemandirian lebih lama.

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung pengaturan diet perempuan lansia. Mengatur diet pada lansia tidak selalu mudah karena berkaitan dengan kebiasaan makan yang sudah lama terbentuk, selera makan, kondisi gigi, kemampuan mengunyah, penyakit penyerta, dan kondisi emosional. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan yang bergizi, rendah gula berlebihan, rendah garam, rendah lemak jenuh, cukup serat, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan lansia. Namun, keluarga perlu menghindari cara yang terlalu keras atau

menyalahkan lansia. Perubahan pola makan sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan selera dan kenyamanan lansia agar ia tidak merasa tertekan atau kehilangan kenikmatan makan.

Keluarga juga berperan dalam mendukung aktivitas fisik. Perempuan lansia dengan diabetes dan penyakit degeneratif tetap perlu bergerak sesuai kemampuan. Keluarga dapat menemani berjalan pagi, mengajak senam ringan, membantu melakukan peregangan, atau mendorong lansia tetap melakukan aktivitas rumah tangga sederhana. Pendampingan keluarga penting untuk memberikan rasa aman, terutama bila lansia memiliki risiko jatuh atau gangguan keseimbangan. Aktivitas fisik bersama keluarga juga dapat meningkatkan semangat lansia karena ia merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Namun, aktivitas harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan agar tidak menimbulkan kelelahan berlebihan.

Dukungan keluarga dalam pengobatan juga sangat diperlukan. Perempuan lansia sering menggunakan beberapa jenis obat untuk mengontrol diabetes, hipertensi, kolesterol, nyeri sendi, atau penyakit lainnya. Banyaknya obat dapat membuat lansia lupa jadwal, salah dosis, atau bingung membedakan obat. Keluarga dapat membantu dengan membuat jadwal minum obat, menyiapkan kotak obat harian, mengingatkan waktu minum obat, dan memantau keluhan setelah obat diminum. Keluarga juga perlu memahami bahwa obat tidak boleh dihentikan sendiri meskipun kondisi tampak membaik. Jika ada efek samping atau keluhan, keluarga sebaiknya membantu lansia berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Kontrol kesehatan secara rutin juga membutuhkan dukungan keluarga. Perempuan lansia mungkin enggan kontrol karena merasa merepotkan, takut biaya, sulit transportasi, atau merasa tidak ada keluhan. Padahal, banyak penyakit degeneratif dapat memburuk tanpa gejala yang jelas. Keluarga dapat membantu mengatur jadwal kontrol, mengantar ke fasilitas kesehatan, mencatat hasil pemeriksaan, dan menyampaikan keluhan yang mungkin lupa diungkapkan oleh lansia. Keluarga juga dapat membantu memastikan anjuran tenaga kesehatan diterapkan di rumah. Dengan dukungan yang baik, pengelolaan diabetes dan penyakit degeneratif menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Dukungan emosional juga tidak kalah penting. Perempuan lansia dengan diabetes atau penyakit degeneratif dapat merasa bosan, lelah, takut, atau cemas karena harus menjalani pengobatan jangka panjang. Mereka mungkin merasa hidupnya dibatasi oleh aturan makanan, jadwal obat, dan pemeriksaan rutin. Dalam kondisi ini, keluarga perlu memberikan semangat, mendengarkan keluhan, dan menghargai usaha lansia dalam menjaga kesehatan. Dukungan yang hangat dapat

meningkatkan motivasi lansia untuk patuh terhadap pengobatan dan menjalani pola hidup sehat. Sebaliknya, sikap keluarga yang menyalahkan atau memarahi dapat membuat lansia merasa tertekan dan enggan bekerja sama.

diabetes melitus dan penyakit degeneratif lainnya merupakan masalah kesehatan penting pada perempuan lansia. Diabetes terjadi ketika kadar gula darah meningkat akibat gangguan produksi atau kerja insulin, dan risikonya meningkat karena usia, obesitas, riwayat keluarga, pola makan tidak sehat, serta kurang aktivitas fisik. Gejala diabetes pada lansia dapat berupa sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, pandangan kabur, kesemutan, infeksi berulang, atau luka sulit sembuh. Komplikasi diabetes dapat meliputi gangguan saraf, ginjal, penglihatan, dan penyembuhan luka. Selain diabetes, perempuan lansia juga rentan mengalami hipertensi, penyakit jantung, osteoarthritis, osteoporosis, dan penyakit degeneratif lain. Oleh karena itu, pengendalian gula darah, pemeriksaan kesehatan berkala, pola makan sehat, aktivitas fisik aman, kepatuhan pengobatan, serta dukungan keluarga sangat diperlukan agar perempuan lansia dapat mempertahankan kemandirian, kenyamanan, dan kualitas hidup secara optimal.

G. Gangguan Nutrisi, Malnutrisi, Anemia, dan Perubahan Berat Badan

Gangguan nutrisi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia dan memiliki dampak besar terhadap kondisi fisik, psikologis, kemandirian, serta kualitas hidup. Pada masa lanjut usia, kebutuhan tubuh terhadap zat gizi mengalami perubahan akibat proses penuaan, penurunan metabolisme, perubahan komposisi tubuh, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan, serta perubahan kemampuan makan. Perempuan lansia dapat mengalami kekurangan gizi, kelebihan gizi, anemia, penurunan berat badan yang tidak direncanakan, atau obesitas. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan karena status gizi yang tidak seimbang dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh, meningkatkan risiko infeksi, memperburuk penyakit kronis, menurunkan kekuatan otot, dan menghambat kemampuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pada perempuan lansia, kebutuhan gizi tidak selalu sama dengan kebutuhan pada usia dewasa muda. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh cenderung melambat sehingga kebutuhan energi atau kalori dapat menurun. Namun, kebutuhan terhadap zat gizi penting seperti protein, vitamin, mineral, serat, dan cairan tetap harus dipenuhi dengan baik. Protein sangat diperlukan untuk mempertahankan massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, mendukung sistem imun, dan mencegah kelemahan. Kalsium dan vitamin D penting untuk

menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, terutama pada perempuan pascamenopause yang mengalami penurunan hormon estrogen. Serat diperlukan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah konstipasi, sedangkan cairan penting untuk mencegah dehidrasi dan membantu fungsi organ tubuh.

Perubahan kebutuhan gizi pada perempuan lansia juga dipengaruhi oleh adanya penyakit kronis. Perempuan lansia dengan hipertensi perlu membatasi konsumsi garam dan makanan tinggi natrium. Perempuan lansia dengan diabetes melitus perlu mengatur asupan gula dan karbohidrat agar kadar gula darah tetap terkendali. Perempuan lansia dengan penyakit jantung perlu memperhatikan asupan lemak jenuh dan kolesterol. Sementara itu, perempuan lansia dengan gangguan ginjal mungkin membutuhkan pengaturan khusus terhadap protein, cairan, atau mineral tertentu sesuai anjuran tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi pada perempuan lansia harus bersifat individual, disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemampuan makan, aktivitas harian, dan kebutuhan tubuh masing-masing.

Salah satu masalah yang sering muncul pada perempuan lansia adalah penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik fisik, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Secara fisik, proses penuaan dapat menyebabkan penurunan fungsi pengecap dan penciuman, sehingga makanan terasa hambar dan kurang menarik. Lansia mungkin tidak lagi merasakan rasa makanan sekuat dahulu, sehingga selera makan menurun. Kondisi ini dapat diperburuk apabila lansia mengalami masalah gigi dan mulut, seperti gigi tanggal, gigi palsu yang tidak nyaman, sariawan, mulut kering, atau nyeri saat mengunyah. Jika makan menjadi tidak nyaman, lansia cenderung memilih makan sedikit atau menghindari makanan tertentu yang sebenarnya bergizi.

Penyakit kronis juga dapat menyebabkan nafsu makan perempuan lansia menurun. Nyeri kronis, gangguan pencernaan, diabetes melitus, penyakit jantung, infeksi, gangguan ginjal, atau penyakit paru dapat membuat tubuh mudah lelah dan menurunkan keinginan untuk makan. Selain itu, efek samping obat-obatan juga dapat memengaruhi nafsu makan. Beberapa obat dapat menyebabkan mual, mulut kering, rasa pahit, konstipasi, atau gangguan lambung. Bila lansia menggunakan beberapa jenis obat sekaligus, keluhan tersebut dapat semakin terasa. Oleh karena itu, ketika perempuan lansia mengalami penurunan nafsu makan, tenaga kesehatan dan keluarga perlu mengkaji kemungkinan penyebabnya secara menyeluruh, bukan hanya menganggapnya sebagai bagian biasa dari usia tua.

Faktor psikologis dan sosial juga berperan penting dalam penurunan nafsu makan. Perempuan lansia yang merasa kesepian, kehilangan pasangan, tidak memiliki teman makan, mengalami depresi, atau merasa tidak dihargai dapat kehilangan minat terhadap makanan. Makan bukan hanya aktivitas biologis, tetapi juga aktivitas sosial dan emosional. Lansia yang makan sendirian setiap hari dapat merasa kurang bersemangat, sehingga asupan makanan menurun. Sebaliknya, suasana makan yang hangat bersama keluarga, makanan yang disajikan dengan menarik, dan perhatian dari orang terdekat dapat meningkatkan selera makan. Karena itu, dukungan keluarga sangat penting dalam membantu lansia mempertahankan pola makan yang baik.

Jika penurunan asupan makanan berlangsung lama, perempuan lansia berisiko mengalami malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan zat gizi yang cukup atau tidak mendapatkan zat gizi dalam keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan. Malnutrisi dapat berupa kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan vitamin dan mineral, atau kombinasi dari berbagai kekurangan zat gizi. Pada perempuan lansia, malnutrisi sering terjadi secara perlahan dan tidak selalu langsung disadari. Tanda-tandanya dapat berupa berat badan menurun, tubuh tampak lemah, mudah lelah, otot mengecil, kulit kering, luka sulit sembuh, sering sakit, atau kurang bersemangat dalam melakukan aktivitas.

Malnutrisi memiliki dampak besar terhadap daya tahan tubuh. Tubuh yang kekurangan zat gizi tidak mampu mempertahankan sistem imun secara optimal. Akibatnya, perempuan lansia menjadi lebih mudah terkena infeksi, seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, atau infeksi kulit. Jika sudah sakit, proses pemulihan juga dapat berlangsung lebih lama karena tubuh tidak memiliki cadangan energi dan zat pembangun yang cukup untuk memperbaiki jaringan. Selain itu, kekurangan protein dapat menyebabkan penurunan massa otot sehingga lansia menjadi lemah, mudah jatuh, dan semakin sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, malnutrisi tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga dengan keselamatan, kemandirian, dan kualitas hidup lansia.

Malnutrisi juga dapat memperburuk penyakit kronis. Perempuan lansia dengan diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit ginjal membutuhkan pengaturan gizi yang tepat agar penyakitnya tetap terkendali. Jika asupan makanan terlalu sedikit atau tidak seimbang, kadar gula darah dapat menjadi tidak stabil, tekanan darah dapat terganggu, tubuh menjadi lemah, dan risiko komplikasi meningkat. Pada lansia yang memiliki luka, malnutrisi dapat memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko infeksi. Pada lansia dengan osteoporosis, kekurangan kalsium, vitamin D, dan protein dapat memperburuk

kerapuhan tulang. Oleh karena itu, pemantauan status gizi perempuan lansia perlu menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan lansia.

Anemia juga merupakan masalah yang dapat dialami perempuan lansia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal, sehingga kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh menurun. Pada perempuan usia reproduktif, anemia sering dikaitkan dengan menstruasi, tetapi pada perempuan lansia yang sudah tidak menstruasi, anemia tetap dapat terjadi karena berbagai penyebab. Penyebab anemia pada lansia dapat meliputi kurang asupan zat besi, vitamin B12, atau asam folat; gangguan penyerapan zat gizi; penyakit kronis; gangguan ginjal; perdarahan saluran cerna; penggunaan obat tertentu; atau adanya peradangan kronis dalam tubuh.

Gejala anemia pada perempuan lansia dapat berupa lemah, cepat lelah, pucat, pusing, berdebar, sesak saat aktivitas, tangan dan kaki terasa dingin, sulit berkonsentrasi, atau menurunnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Pada lansia, gejala anemia kadang tidak spesifik dan dapat disalahartikan sebagai keluhan biasa akibat usia tua. Padahal, anemia dapat memperburuk kondisi kesehatan secara umum. Perempuan lansia yang mengalami anemia dapat menjadi lebih mudah jatuh karena lemas atau pusing, lebih sulit beraktivitas, dan lebih rentan mengalami penurunan kualitas hidup. Jika anemia terjadi pada lansia dengan penyakit jantung, kondisi jantung dapat semakin terbebani karena tubuh kekurangan oksigen.

Faktor penyebab anemia perlu dikaji dengan baik agar penanganannya tepat. Bila anemia disebabkan oleh kurang asupan zat besi, maka pemenuhan makanan sumber zat besi dan pendamping penyerapan zat besi perlu diperhatikan. Jika anemia disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau asam folat, maka sumber makanan dan kemungkinan gangguan penyerapan perlu dikaji. Bila anemia berkaitan dengan perdarahan saluran cerna, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada perempuan lansia dengan penyakit ginjal, anemia dapat terjadi karena ginjal berperan dalam merangsang pembentukan sel darah merah. Dengan demikian, anemia pada perempuan lansia tidak boleh dianggap sederhana, karena dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius.

Penurunan berat badan yang tidak direncanakan merupakan tanda penting yang harus diperhatikan pada perempuan lansia. Berat badan yang menurun tanpa usaha diet atau tanpa alasan jelas dapat menunjukkan adanya masalah kesehatan. Penyebabnya dapat berupa malnutrisi, depresi, kesepian, gangguan pencernaan, penyakit kronis, infeksi, gangguan menelan, kanker, efek obat, atau masalah ekonomi yang membuat lansia sulit memperoleh makanan bergizi. Penurunan

berat badan pada lansia sering disertai penurunan massa otot, kelemahan, mudah lelah, dan berkurangnya daya tahan tubuh. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan, risiko jatuh, dan penurunan kualitas hidup.

Keluarga perlu waspada apabila perempuan lansia mulai makan lebih sedikit, pakaian tampak longgar, wajah terlihat lebih tirus, tubuh semakin lemah, atau lansia tampak tidak berminat terhadap makanan. Penurunan berat badan yang berlangsung perlahan sering kali tidak disadari karena keluarga terbiasa melihat lansia setiap hari. Oleh karena itu, pemantauan berat badan secara berkala sangat penting. Selain berat badan, perlu juga diperhatikan kekuatan tubuh, kemampuan berjalan, nafsu makan, kondisi mulut, suasana hati, dan aktivitas sehari-hari. Bila penurunan berat badan terjadi tanpa sebab jelas, perempuan lansia perlu dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengkajian lebih lanjut.

Di sisi lain, obesitas juga dapat menjadi masalah pada perempuan lansia. Obesitas adalah kondisi ketika terjadi penumpukan lemak tubuh berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Pada perempuan lansia, obesitas dapat terjadi akibat penurunan metabolisme, kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi kalori, perubahan hormonal setelah menopause, serta peningkatan lemak perut. Obesitas tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Perempuan lansia dengan obesitas lebih rentan mengalami hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan pernapasan, gangguan tidur, nyeri sendi, dan keterbatasan mobilitas.

Obesitas dapat memperberat hipertensi karena tubuh membutuhkan kerja jantung yang lebih besar untuk memompa darah ke jaringan yang lebih luas. Obesitas juga dapat meningkatkan resistensi insulin sehingga risiko diabetes melitus meningkat. Lemak tubuh berlebih, terutama di area perut, berkaitan dengan gangguan metabolisme dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, kelebihan berat badan memberi tekanan tambahan pada sendi lutut, pinggul, dan tulang belakang. Akibatnya, perempuan lansia dengan obesitas sering mengalami nyeri sendi atau osteoarthritis yang membuat mereka semakin sulit bergerak. Kurang bergerak kemudian dapat memperburuk obesitas, sehingga terbentuk lingkaran masalah yang saling memperkuat.

Obesitas juga dapat memengaruhi aspek psikologis dan sosial perempuan lansia. Lansia dengan obesitas mungkin merasa tidak nyaman bergerak, mudah lelah, malu mengikuti kegiatan sosial, atau merasa kurang percaya diri. Jika nyeri sendi dan keterbatasan mobilitas semakin berat, lansia dapat menjadi lebih banyak di rumah dan berisiko mengalami isolasi sosial. Oleh karena itu, pengelolaan obesitas pada perempuan lansia tidak boleh dilakukan dengan diet ekstrem yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Pengaturan berat badan harus dilakukan

secara aman melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik sesuai kemampuan, pengelolaan penyakit kronis, dan pemantauan tenaga kesehatan.

Upaya pemenuhan gizi seimbang pada perempuan lansia harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Prinsip utamanya adalah memberikan makanan yang cukup, bergizi, mudah dikonsumsi, sesuai selera, dan tidak memperburuk penyakit yang sudah ada. Makanan sebaiknya mengandung sumber karbohidrat kompleks, protein berkualitas, sayur dan buah, lemak sehat, serta cukup cairan. Protein dapat diperoleh dari ikan, telur, ayam tanpa lemak, tahu, tempe, kacang-kacangan, atau sumber lain yang sesuai kondisi kesehatan. Sayur dan buah membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat. Cairan perlu diperhatikan karena lansia sering kurang minum akibat rasa haus yang menurun atau takut sering buang air kecil.

Pada perempuan lansia dengan gangguan gigi atau kesulitan mengunyah, makanan dapat disajikan dalam tekstur yang lebih lunak tetapi tetap bergizi. Misalnya, lauk dapat dibuat lebih lembut, sayur dimasak hingga mudah dikunyah, dan makanan disajikan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Pada lansia dengan nafsu makan rendah, penyajian makanan yang menarik, suasana makan yang nyaman, serta makan bersama keluarga dapat membantu meningkatkan asupan. Keluarga juga dapat menanyakan makanan yang disukai lansia, selama tetap memperhatikan batasan kesehatan. Pendekatan yang terlalu memaksa atau menyalahkan lansia karena tidak mau makan dapat membuat lansia semakin tidak nyaman.

Bagi perempuan lansia dengan penyakit kronis, pengaturan gizi perlu lebih terarah. Lansia dengan hipertensi perlu membatasi garam dan makanan olahan tinggi natrium. Lansia dengan diabetes perlu mengatur porsi karbohidrat, menghindari gula berlebihan, dan makan secara teratur agar gula darah lebih stabil. Lansia dengan penyakit jantung perlu membatasi lemak jenuh dan memilih makanan yang lebih sehat untuk pembuluh darah. Lansia dengan osteoporosis perlu memperhatikan kalsium, vitamin D, dan protein. Namun, pengaturan diet harus tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemampuan lansia agar tidak menimbulkan stres atau penolakan. Edukasi gizi perlu diberikan dengan bahasa sederhana dan contoh makanan sehari-hari yang mudah diterapkan.

Aktivitas fisik juga mendukung status gizi yang baik. Gerak tubuh membantu menjaga massa otot, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki metabolisme, mengontrol berat badan, dan menjaga keseimbangan. Perempuan lansia dapat melakukan aktivitas ringan seperti berjalan, senam lansia, peregangan, berkebun ringan, atau aktivitas rumah tangga sederhana. Aktivitas perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik. Pada lansia yang sangat lemah atau

memiliki penyakit tertentu, aktivitas sebaiknya dilakukan dengan pendampingan dan arahan tenaga kesehatan. Dengan aktivitas yang tepat, tubuh dapat memanfaatkan zat gizi dengan lebih baik dan risiko kelemahan dapat berkurang.

Peran keluarga sangat penting dalam menjaga status gizi perempuan lansia. Keluarga dapat membantu menyediakan makanan bergizi, mengingatkan waktu makan, memperhatikan perubahan nafsu makan, memantau berat badan, membantu perawatan gigi dan mulut, serta mendampingi lansia ke fasilitas kesehatan jika muncul tanda masalah gizi. Keluarga juga perlu memperhatikan suasana emosional saat makan. Lansia yang merasa dihargai dan ditemani biasanya lebih bersemangat untuk makan. Sebaliknya, lansia yang makan sendirian, sering dimarahi, atau merasa menjadi beban dapat kehilangan selera makan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi pada lansia tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga dengan perhatian, komunikasi, dan dukungan emosional.

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam melakukan pengkajian status gizi, memberikan edukasi, mendeteksi anemia, menilai perubahan berat badan, serta menyusun anjuran makan sesuai kondisi lansia. Pengkajian dapat mencakup berat badan, tinggi badan atau perkiraan tinggi badan, lingkar lengan, riwayat makan, kondisi gigi, kemampuan menelan, penyakit kronis, obat yang digunakan, serta kondisi psikologis dan sosial. Jika ditemukan penurunan berat badan, anemia, malnutrisi, atau obesitas, tenaga kesehatan perlu membantu menentukan penyebab dan penanganan yang tepat. Rujukan ke ahli gizi atau dokter dapat diperlukan bila masalah gizi cukup berat atau berkaitan dengan penyakit tertentu.

Dengan demikian, gangguan nutrisi, malnutrisi, anemia, dan perubahan berat badan merupakan masalah kesehatan penting pada perempuan lansia. Perubahan kebutuhan gizi, penurunan nafsu makan, gangguan gigi, penyakit kronis, efek obat, kesepian, dan perubahan metabolisme dapat menyebabkan asupan zat gizi menjadi tidak seimbang. Malnutrisi dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperlemah otot, memperlambat penyembuhan, dan meningkatkan risiko jatuh. Anemia dapat menyebabkan lemah, cepat lelah, pusing, dan penurunan kemampuan beraktivitas. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan dapat menjadi tanda masalah kesehatan serius, sedangkan obesitas dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan nyeri sendi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi seimbang, pemantauan berat badan, pemeriksaan kesehatan, aktivitas fisik aman, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat diperlukan agar perempuan lansia dapat mempertahankan kesehatan, kemandirian, dan kualitas hidup secara optimal.

H. Gangguan Tidur, Kelelahan, dan Penurunan Energi

Gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan energi merupakan masalah yang sering dialami perempuan lansia dan dapat memengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam memulihkan tenaga, menjaga keseimbangan emosi, memperbaiki jaringan tubuh, mempertahankan daya tahan tubuh, serta mendukung fungsi kognitif. Pada perempuan lansia, pola tidur sering mengalami perubahan akibat proses penuaan, perubahan hormonal pascamenopause, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan, nyeri, kecemasan, dan perubahan aktivitas sehari-hari. Meskipun gangguan tidur sering dianggap sebagai hal biasa pada usia lanjut, kondisi ini tetap perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap kualitas hidup, keselamatan, dan kemandirian perempuan lansia.

Perubahan pola tidur pada perempuan lansia dapat terjadi secara bertahap. Lansia sering mengalami kesulitan memulai tidur, mudah terbangun pada malam hari, tidur menjadi lebih pendek, bangun terlalu pagi, atau merasa tidur tidak nyenyak meskipun waktu tidur tampak cukup. Tidur malam yang terputus-putus dapat membuat perempuan lansia merasa tidak segar saat bangun pagi. Selain itu, beberapa lansia menjadi lebih sering mengantuk pada siang hari karena kualitas tidur malam yang buruk. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh menurunnya produksi hormon yang mengatur siklus tidur, perubahan jam biologis tubuh, berkurangnya aktivitas fisik, serta meningkatnya keluhan kesehatan yang mengganggu kenyamanan tidur.

Pada perempuan lansia, gangguan tidur juga dapat berkaitan dengan masa pascamenopause. Penurunan hormon estrogen dapat memengaruhi kenyamanan tubuh, suasana hati, dan pola tidur. Sebagian perempuan mengalami keluhan seperti rasa panas, berkeringat pada malam hari, jantung berdebar, atau perubahan emosi yang dapat mengganggu tidur. Walaupun tidak semua perempuan lansia mengalami keluhan menopause yang sama, perubahan hormonal tetap dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidur menjadi kurang berkualitas. Selain itu, perubahan fisik seperti nyeri sendi, sering buang air kecil, atau gangguan pernapasan saat tidur dapat memperberat gangguan tidur pada masa lanjut usia.

Nyeri merupakan salah satu penyebab utama gangguan tidur pada perempuan lansia. Nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri akibat osteoarthritis, osteoporosis, atau penyakit kronis lain dapat membuat lansia sulit menemukan posisi tidur yang nyaman. Rasa nyeri dapat meningkat saat tubuh beristirahat atau ketika lansia mengubah posisi tidur. Akibatnya, lansia sering terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Jika nyeri berlangsung lama, kualitas tidur akan

semakin menurun dan tubuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup. Kondisi ini dapat menimbulkan lingkaran masalah, karena kurang tidur dapat membuat lansia lebih sensitif terhadap nyeri, mudah lelah, dan lebih sulit beraktivitas pada siang hari.

Sering buang air kecil pada malam hari juga menjadi penyebab gangguan tidur yang umum dialami perempuan lansia. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh inkontinensia urine, infeksi saluran kemih, diabetes melitus, konsumsi cairan berlebihan menjelang tidur, penggunaan obat tertentu, atau perubahan fungsi kandung kemih akibat penuaan dan pascamenopause. Ketika lansia harus bangun beberapa kali pada malam hari untuk ke kamar mandi, tidurnya menjadi terputus dan kualitas istirahat menurun. Selain mengganggu tidur, sering bangun malam juga meningkatkan risiko jatuh, terutama jika pencahayaan kurang, lantai licin, atau lansia berjalan dalam keadaan mengantuk.

Kecemasan juga dapat menyebabkan gangguan tidur pada perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, banyak hal dapat menjadi sumber kecemasan, seperti kekhawatiran terhadap penyakit, takut jatuh, takut menjadi beban keluarga, masalah ekonomi, kehilangan pasangan, kesepian, atau ketidakpastian masa depan. Kecemasan membuat pikiran sulit tenang saat malam hari. Lansia mungkin terus memikirkan masalah, merasa gelisah, atau sulit rileks sehingga tidur menjadi tertunda. Jika kecemasan berlangsung lama, tidur yang terganggu dapat memperburuk suasana hati, menurunkan energi, dan membuat lansia semakin sulit menghadapi aktivitas sehari-hari.

Efek obat juga perlu diperhatikan sebagai salah satu penyebab gangguan tidur. Perempuan lansia sering mengonsumsi lebih dari satu jenis obat karena memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, atau gangguan lainnya. Beberapa obat dapat menyebabkan sering buang air kecil, rasa gelisah, mengantuk berlebihan pada siang hari, pusing, atau gangguan lambung yang mengganggu kenyamanan tidur. Sebaliknya, penggunaan obat tidur tanpa pemantauan yang tepat dapat menyebabkan kantuk berlebihan, gangguan keseimbangan, kebingungan, dan peningkatan risiko jatuh. Oleh karena itu, keluhan gangguan tidur pada perempuan lansia perlu dikaji bersama riwayat penggunaan obat secara cermat.

Penyakit kronis juga berperan besar dalam gangguan tidur. Perempuan lansia dengan penyakit jantung dapat mengalami sesak saat berbaring atau mudah terbangun karena rasa tidak nyaman di dada. Lansia dengan diabetes melitus dapat sering buang air kecil pada malam hari atau mengalami kesemutan yang mengganggu tidur. Lansia dengan penyakit paru dapat mengalami batuk atau sesak yang memburuk pada malam hari. Lansia dengan nyeri kronis dapat sering

terbangun karena rasa nyeri. Penyakit kronis yang tidak terkontrol akan membuat tidur semakin tidak berkualitas dan memperburuk kelelahan pada siang hari. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas tidur sering kali tidak cukup hanya dengan mengatur jadwal tidur, tetapi juga membutuhkan pengelolaan penyakit yang mendasarinya.

Kurang tidur dapat memberikan dampak luas terhadap perempuan lansia. Salah satu dampak yang sering muncul adalah perubahan emosi. Lansia yang tidak tidur dengan baik dapat menjadi lebih mudah marah, sensitif, cemas, sedih, atau kurang sabar. Emosi yang tidak stabil dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga mungkin menganggap lansia menjadi lebih rewel atau mudah tersinggung, padahal kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kualitas tidur yang buruk. Oleh sebab itu, ketika terjadi perubahan emosi pada perempuan lansia, gangguan tidur perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penyebab.

Kurang tidur juga dapat menurunkan konsentrasi dan fungsi kognitif. Perempuan lansia yang tidur tidak nyenyak dapat mengalami kesulitan fokus, mudah lupa, lambat memahami informasi, atau bingung saat melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan mengelola obat, memasak, berjalan dengan aman, atau mengikuti instruksi kesehatan. Pada lansia yang sudah mengalami penurunan daya ingat, kurang tidur dapat memperburuk kondisi tersebut. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk membantu otak memproses informasi, menjaga daya ingat, dan mempertahankan kewaspadaan.

Daya tahan tubuh juga dapat menurun apabila perempuan lansia mengalami kurang tidur secara terus-menerus. Tidur membantu tubuh melakukan proses pemulihan dan menjaga sistem imun. Jika tidur terganggu, tubuh menjadi lebih mudah lemah dan lebih rentan terhadap infeksi. Perempuan lansia yang kurang tidur dapat lebih mudah mengalami flu, infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, atau proses penyembuhan yang lebih lambat ketika sakit. Bagi lansia dengan penyakit kronis, kurang tidur dapat memperburuk pengendalian gula darah, tekanan darah, dan kondisi jantung. Dengan demikian, tidur yang baik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kesehatan perempuan lansia.

Gangguan tidur juga meningkatkan risiko jatuh. Lansia yang kurang tidur dapat merasa mengantuk, pusing, lemah, dan kurang fokus pada siang hari. Jika ditambah dengan gangguan penglihatan, kelemahan otot, nyeri sendi, atau penggunaan obat tertentu, risiko jatuh menjadi semakin besar. Pada malam hari, risiko jatuh juga meningkat ketika lansia sering bangun untuk buang air kecil. Dalam kondisi setengah mengantuk, lansia dapat tersandung, terpeleset, atau kehilangan keseimbangan. Jatuh pada perempuan lansia dapat berakibat serius,

terutama jika terdapat osteoporosis, karena dapat menyebabkan patah tulang dan penurunan kemandirian.

Kelelahan kronis merupakan masalah lain yang sering dialami perempuan lansia. Kelelahan kronis berbeda dengan rasa lelah biasa setelah beraktivitas. Kelelahan kronis dapat berlangsung lama, muncul meskipun aktivitas tidak berat, dan tidak sepenuhnya membaik setelah istirahat. Perempuan lansia yang mengalami kelelahan kronis dapat merasa tubuhnya lemah, tidak bertenaga, sulit memulai aktivitas, kehilangan minat, dan lebih banyak duduk atau berbaring. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari, seperti memasak, membersihkan rumah, berjalan, beribadah, mengikuti kegiatan sosial, atau merawat diri.

Kelelahan pada perempuan lansia dapat disebabkan oleh anemia. Anemia membuat tubuh kekurangan hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke jaringan. Ketika oksigen yang sampai ke jaringan tubuh berkurang, lansia akan merasa lemah, cepat lelah, pusing, berdebar, atau sesak saat aktivitas. Anemia pada lansia dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, asam folat, gangguan penyerapan gizi, penyakit kronis, perdarahan saluran cerna, atau gangguan ginjal. Karena gejala anemia sering tampak seperti keluhan umum pada lansia, pemeriksaan kesehatan diperlukan apabila kelelahan berlangsung lama atau disertai pucat, pusing, dan penurunan kemampuan beraktivitas.

Malnutrisi juga berhubungan erat dengan kelelahan dan penurunan energi. Perempuan lansia yang asupan makanannya kurang, kurang protein, kurang vitamin dan mineral, atau mengalami penurunan berat badan tanpa sebab jelas akan lebih mudah merasa lemah. Tubuh membutuhkan zat gizi untuk menghasilkan energi, memperbaiki jaringan, mempertahankan massa otot, dan menjaga daya tahan tubuh. Jika asupan gizi tidak mencukupi, otot menjadi lebih lemah, tubuh mudah sakit, dan energi untuk beraktivitas menurun. Malnutrisi dapat terjadi akibat nafsu makan menurun, gangguan gigi, kesulitan mengunyah, penyakit kronis, efek obat, depresi, atau kesepian. Oleh karena itu, kelelahan pada perempuan lansia perlu dikaji bersama pola makan dan status gizinya.

Penyakit kronis juga menjadi penyebab utama kelelahan. Hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit paru, gangguan ginjal, nyeri kronis, dan gangguan tiroid dapat menyebabkan perempuan lansia merasa tidak bertenaga. Pada penyakit jantung, kelelahan dapat terjadi karena jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Pada diabetes, kelelahan dapat muncul akibat kadar gula darah yang tidak stabil. Pada penyakit paru, tubuh dapat kekurangan oksigen saat beraktivitas. Pada nyeri kronis, energi terkuras karena tubuh terus-

menerus menghadapi rasa sakit. Karena itu, kelelahan yang menetap perlu dilihat sebagai tanda bahwa mungkin ada masalah kesehatan yang belum terkontrol.

Kurang aktivitas fisik juga dapat menyebabkan penurunan energi. Banyak perempuan lansia mengurangi aktivitas karena takut jatuh, nyeri sendi, atau merasa mudah lelah. Namun, semakin jarang bergerak, otot akan semakin lemah dan tubuh semakin tidak bertenaga. Kurang bergerak juga dapat memperburuk sirkulasi darah, keseimbangan, suasana hati, dan kualitas tidur. Aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara teratur justru dapat membantu meningkatkan energi, memperbaiki tidur, mengurangi kekakuan sendi, memperkuat otot, dan meningkatkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, perempuan lansia perlu didorong untuk tetap bergerak sesuai kemampuan, bukan dipaksa beraktivitas berat.

Gangguan psikologis juga dapat berperan dalam kelelahan. Kecemasan, depresi, kesepian, kehilangan pasangan, konflik keluarga, atau rasa tidak bermakna dapat membuat perempuan lansia merasa tidak berenergi. Depresi pada lansia sering tampak sebagai keluhan fisik, seperti lelah berkepanjangan, sulit tidur, nafsu makan menurun, dan tidak berminat melakukan aktivitas. Lansia yang merasa kesepian atau tidak dihargai mungkin kehilangan motivasi untuk merawat diri dan bergerak. Oleh karena itu, ketika perempuan lansia mengeluh lelah terus-menerus, aspek emosional dan sosial juga perlu diperhatikan, bukan hanya kondisi fisiknya.

Upaya memperbaiki kualitas tidur dapat dimulai dengan membangun rutinitas tidur yang baik. Perempuan lansia sebaiknya memiliki jadwal tidur dan bangun yang relatif teratur setiap hari. Rutinitas yang konsisten membantu tubuh mengenali waktu istirahat. Sebelum tidur, lansia dapat melakukan aktivitas yang menenangkan seperti berdoa, membaca ringan, mendengarkan musik lembut, latihan napas, atau relaksasi. Aktivitas yang terlalu merangsang, seperti menonton acara yang menegangkan, memikirkan masalah berat, atau menggunakan gawai terlalu lama, sebaiknya dikurangi menjelang tidur. Tidur siang boleh dilakukan bila diperlukan, tetapi sebaiknya tidak terlalu lama agar tidak mengganggu tidur malam.

Lingkungan tidur yang nyaman juga sangat penting. Kamar tidur sebaiknya tenang, bersih, tidak terlalu terang, memiliki suhu yang nyaman, dan bebas dari gangguan suara berlebihan. Tempat tidur perlu dibuat aman dan mudah dijangkau. Jika lansia sering bangun malam untuk ke kamar mandi, pencahayaan jalur menuju kamar mandi perlu cukup agar risiko jatuh berkurang. Barang-barang yang dapat menyebabkan tersandung sebaiknya disingkirkan. Alas kaki yang digunakan saat bangun malam harus nyaman dan tidak licin. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman, perempuan lansia dapat tidur lebih tenang dan mengurangi risiko cedera.

Pengelolaan nyeri juga berperan penting dalam memperbaiki tidur. Jika perempuan lansia mengalami nyeri sendi atau nyeri punggung, posisi tidur perlu disesuaikan agar lebih nyaman. Penggunaan bantal penyangga, kompres hangat sesuai kebutuhan, aktivitas ringan pada siang hari, dan pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi nyeri. Lansia tidak dianjurkan mengonsumsi obat nyeri secara sembarangan karena dapat menimbulkan efek samping, terutama jika memiliki penyakit lambung, ginjal, atau menggunakan obat lain. Keluhan nyeri yang mengganggu tidur perlu dikonsultasikan agar mendapatkan penanganan yang aman.

Sering buang air kecil pada malam hari juga perlu dikelola. Lansia dapat mengatur konsumsi cairan agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi pada siang hari, tetapi tidak berlebihan menjelang tidur. Minuman yang bersifat merangsang buang air kecil, seperti kafein, sebaiknya dikurangi terutama pada sore dan malam hari. Namun, pengurangan cairan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat menyebabkan dehidrasi. Jika sering buang air kecil disertai nyeri, panas saat berkemih, urine keruh, demam, atau inkontinensia yang memburuk, perempuan lansia perlu diperiksa untuk memastikan apakah terdapat infeksi saluran kemih atau masalah urogenital lain.

Pengendalian kecemasan dan stres juga dapat membantu memperbaiki tidur dan mengurangi kelelahan. Perempuan lansia perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kekhawatiran dan perasaannya. Keluarga dapat membantu dengan mendengarkan, tidak meremehkan keluhan, dan memberi dukungan emosional. Kegiatan spiritual, doa, ibadah, percakapan hangat dengan keluarga, aktivitas sosial, dan kegiatan bermakna dapat membantu menenangkan pikiran. Jika kecemasan atau kesedihan berlangsung lama dan mengganggu tidur, nafsu makan, serta aktivitas, tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kemungkinan gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan.

Kualitas tidur dan energi juga dapat diperbaiki melalui aktivitas fisik ringan pada siang hari. Aktivitas fisik membantu tubuh lebih rileks pada malam hari, memperbaiki sirkulasi darah, menjaga kekuatan otot, dan meningkatkan suasana hati. Perempuan lansia dapat melakukan aktivitas sesuai kemampuan, seperti berjalan santai, senam lansia, peregangan, latihan pernapasan, berkebun ringan, atau pekerjaan rumah sederhana. Aktivitas sebaiknya tidak terlalu berat dan tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur apabila membuat tubuh terlalu terjaga. Aktivitas yang dilakukan secara teratur dapat membantu mengurangi keluhan lelah kronis dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemeriksaan kesehatan sangat penting apabila kelelahan berlangsung lama. Kelelahan yang menetap tidak boleh langsung dianggap sebagai akibat usia tua.

Kelelahan dapat menjadi tanda anemia, diabetes tidak terkontrol, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan tiroid, infeksi, malnutrisi, efek obat, gangguan tidur, atau depresi. Perempuan lansia perlu diperiksa apabila kelelahan disertai penurunan berat badan, pucat, sesak napas, nyeri dada, pusing, demam, bengkak pada kaki, gangguan tidur berat, penurunan nafsu makan, atau perubahan perilaku. Pemeriksaan yang tepat membantu menemukan penyebab dan menentukan penanganan yang sesuai.

Keluarga memiliki peran penting dalam membantu perempuan lansia mengatasi gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan energi. Keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan tidur yang aman, mendampingi pemeriksaan kesehatan, menyediakan makanan bergizi, mengingatkan obat sesuai anjuran, mengajak lansia bergerak ringan, serta memberikan dukungan emosional. Keluarga juga perlu memperhatikan perubahan kecil, seperti lansia menjadi lebih sering tidur siang, terlihat lemah, tidak berminat beraktivitas, sering terbangun malam, atau tampak tidak segar. Perubahan tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Tenaga kesehatan berperan dalam melakukan pengkajian menyeluruh terhadap keluhan tidur dan kelelahan. Pengkajian perlu mencakup pola tidur, durasi tidur, frekuensi terbangun, kebiasaan sebelum tidur, keluhan nyeri, frekuensi buang air kecil, obat yang digunakan, penyakit kronis, status gizi, kondisi psikologis, dan aktivitas harian. Dengan pengkajian yang menyeluruh, intervensi dapat diberikan sesuai penyebab. Jika gangguan tidur disebabkan oleh nyeri, maka nyeri perlu dikelola. Jika disebabkan oleh kecemasan, maka dukungan psikologis diperlukan. Jika disebabkan oleh efek obat, maka evaluasi obat perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

Maka dari pembahasan diatas, gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan energi merupakan masalah yang sering dialami perempuan lansia dan dapat berdampak luas terhadap kesehatan. Perubahan pola tidur pada lansia dapat dipengaruhi oleh proses penuaan, menopause, nyeri, sering buang air kecil, kecemasan, efek obat, dan penyakit kronis. Kurang tidur dapat memengaruhi emosi, konsentrasi, daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko jatuh. Kelelahan kronis dapat berkaitan dengan anemia, malnutrisi, penyakit kronis, kurang aktivitas fisik, dan gangguan psikologis. Upaya memperbaiki kualitas tidur perlu dilakukan melalui rutinitas tidur yang baik, lingkungan tidur yang nyaman, pengelolaan nyeri, pengaturan cairan, aktivitas fisik aman, dukungan emosional, dan pemeriksaan kesehatan bila keluhan berlangsung lama. Dengan penanganan yang tepat, perempuan lansia dapat memiliki energi yang lebih baik, tidur lebih berkualitas, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman serta bermartabat.

I. Inkontinensia Urine dan Gangguan Urogenital Pascamenopause

Inkontinensia urine dan gangguan urogenital pascamenopause merupakan masalah kesehatan yang cukup sering dialami perempuan lansia, tetapi sering kali tidak disampaikan secara terbuka karena dianggap memalukan, tabu, atau bagian wajar dari proses penuaan. Padahal, keluhan ini dapat memengaruhi kenyamanan, kebersihan diri, rasa percaya diri, aktivitas sosial, hubungan dengan pasangan, dan kualitas hidup perempuan lansia secara menyeluruh. Sistem urogenital mencakup organ-organ yang berhubungan dengan saluran kemih dan organ reproduksi. Pada masa pascamenopause, sistem ini mengalami berbagai perubahan akibat penurunan hormon estrogen, proses penuaan jaringan, melemahnya otot dasar panggul, serta adanya penyakit penyerta yang sering dialami pada usia lanjut.

Inkontinensia urine adalah kondisi ketika seseorang mengalami keluarnya urine secara tidak sengaja atau sulit mengontrol buang air kecil. Pada perempuan lansia, kondisi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada lansia yang urine keluar saat batuk, bersin, tertawa, atau mengangkat sesuatu. Ada pula yang tiba-tiba merasa sangat ingin buang air kecil dan tidak sempat mencapai toilet. Sebagian perempuan lansia mengalami kebocoran urine dalam jumlah sedikit, tetapi ada juga yang mengalami keluarnya urine cukup banyak sehingga pakaian menjadi basah. Meskipun inkontinensia urine bukan kondisi yang selalu mengancam nyawa, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dapat sangat besar karena berkaitan dengan rasa malu, bau tidak sedap, iritasi kulit, gangguan tidur, dan pembatasan aktivitas.

Penyebab inkontinensia urine pada perempuan lansia cukup beragam. Salah satu penyebab utama adalah melemahnya otot dasar panggul. Otot dasar panggul berfungsi menopang kandung kemih, rahim, dan organ panggul lainnya, serta membantu mengontrol keluarnya urine. Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot ini dapat menurun. Ketika otot dasar panggul melemah, kemampuan menahan urine juga berkurang. Akibatnya, urine dapat keluar saat terjadi peningkatan tekanan dalam perut, misalnya ketika batuk, tertawa, bersin, atau bergerak tiba-tiba. Kondisi ini sering disebut sebagai inkontinensia stres, yaitu keluarnya urine karena tekanan fisik pada kandung kemih, bukan karena stres emosional.

Riwayat persalinan juga berperan dalam terjadinya inkontinensia urine pada perempuan lansia. Perempuan yang pernah melahirkan, terutama melalui persalinan pervaginam, dapat mengalami peregangan atau cedera pada otot dasar panggul dan jaringan penyangga organ panggul. Semakin banyak jumlah persalinan, semakin besar kemungkinan terjadi kelemahan otot panggul, meskipun tidak semua perempuan mengalami keluhan yang sama. Proses persalinan yang

sulit, bayi besar, penggunaan alat bantu persalinan, atau robekan jalan lahir juga dapat berkontribusi terhadap perubahan struktur panggul. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa pada usia muda, tetapi dapat menjadi lebih jelas ketika perempuan memasuki masa menopause dan usia lanjut.

Obesitas juga menjadi faktor yang dapat memperberat inkontinensia urine. Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan pada kandung kemih dan struktur dasar panggul. Tekanan yang terus-menerus dapat memperlemah otot dan jaringan penyangga, sehingga kontrol berkemih menjadi lebih sulit. Pada perempuan lansia dengan obesitas, inkontinensia urine dapat terjadi lebih sering dan lebih mengganggu aktivitas sehari-hari. Obesitas juga sering berkaitan dengan penyakit lain seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan nyeri sendi, yang semuanya dapat memengaruhi mobilitas dan kemampuan lansia mencapai toilet tepat waktu. Oleh karena itu, pengelolaan berat badan yang sehat dan aman dapat membantu mengurangi keluhan inkontinensia pada sebagian perempuan lansia.

Perubahan hormon setelah menopause juga sangat memengaruhi sistem urogenital. Penurunan hormon estrogen menyebabkan jaringan di sekitar vagina, uretra, dan saluran kemih menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, mudah iritasi, dan meningkatnya risiko infeksi saluran kemih. Uretra yang menjadi lebih tipis dan jaringan penyangga yang melemah dapat membuat kontrol urine berkurang. Selain itu, kandung kemih juga dapat menjadi lebih sensitif sehingga perempuan lansia lebih sering merasa ingin buang air kecil. Perubahan hormonal ini menjelaskan mengapa keluhan urogenital sering meningkat setelah menopause dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan perempuan lansia.

Dampak inkontinensia urine terhadap rasa percaya diri sangat besar. Banyak perempuan lansia merasa malu karena takut pakaian basah, takut tercium bau urine, atau takut orang lain mengetahui bahwa ia tidak mampu mengontrol buang air kecil. Perasaan malu ini dapat membuat lansia menjadi tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia mungkin merasa dirinya tidak bersih, tidak menarik, atau menjadi beban bagi keluarga. Pada sebagian lansia, inkontinensia urine dapat menimbulkan kecemasan berlebihan sebelum keluar rumah karena khawatir tidak menemukan toilet atau mengalami kebocoran urine di tempat umum. Kondisi ini dapat menurunkan rasa aman dan kebebasan lansia dalam menjalani aktivitas.

Inkontinensia juga berdampak pada kebersihan diri. Urine yang sering keluar dan mengenai kulit dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal, bau tidak sedap, dan meningkatkan risiko infeksi kulit. Jika kebersihan area genital tidak dijaga

dengan baik, risiko infeksi saluran kemih juga dapat meningkat. Perempuan lansia yang mengalami kelemahan fisik, gangguan penglihatan, obesitas, atau keterbatasan mobilitas mungkin mengalami kesulitan membersihkan diri setelah terjadi kebocoran urine. Dalam kondisi ini, bantuan keluarga atau caregiver dapat diperlukan, tetapi bantuan harus diberikan dengan tetap menjaga privasi, rasa hormat, dan martabat lansia. Cara keluarga memberikan bantuan sangat menentukan apakah lansia merasa didukung atau justru merasa malu dan tidak berdaya.

Aktivitas sosial perempuan lansia dapat sangat terganggu akibat inkontinensia urine. Lansia yang sebelumnya aktif mengikuti pengajian, arisan, posyandu lansia, senam, kegiatan keluarga, atau kunjungan ke rumah tetangga dapat mulai mengurangi kegiatan tersebut karena takut mengompol. Ia mungkin menolak bepergian jauh, enggan naik kendaraan umum, atau selalu mencari lokasi toilet saat berada di luar rumah. Jika kondisi ini berlangsung lama, perempuan lansia dapat mengalami isolasi sosial. Berkurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan kesepian, penurunan semangat hidup, dan bahkan meningkatkan risiko depresi. Dengan demikian, inkontinensia urine bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikososial yang dapat menurunkan kualitas hidup.

Kualitas hidup perempuan lansia dapat menurun apabila inkontinensia urine tidak ditangani. Lansia dapat mengalami gangguan tidur karena sering terbangun untuk buang air kecil atau mengganti pakaian. Kurang tidur menyebabkan tubuh lelah pada siang hari, emosi lebih sensitif, konsentrasi menurun, dan risiko jatuh meningkat. Lansia juga dapat mengurangi konsumsi cairan karena takut sering buang air kecil, padahal kurang minum dapat menyebabkan dehidrasi, konstipasi, dan memperburuk infeksi saluran kemih. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan inkontinensia harus dilakukan secara tepat, bukan dengan membatasi cairan secara berlebihan atau membiarkan lansia menarik diri dari aktivitas.

Selain inkontinensia urine, perempuan lansia juga sering mengalami gangguan urogenital pascamenopause. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah kekeringan vagina. Setelah menopause, penurunan estrogen menyebabkan dinding vagina menjadi lebih tipis, kurang lembap, dan kurang elastis. Kekeringan vagina dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal, perih, atau nyeri, terutama saat bergerak, duduk lama, atau berhubungan seksual. Karena area genital merupakan bagian tubuh yang dianggap sensitif dan pribadi, banyak perempuan lansia merasa malu membicarakan keluhan ini. Akibatnya, keluhan dibiarkan berlarut-larut dan mengganggu kenyamanan.

Iritasi pada area urogenital juga dapat terjadi akibat perubahan jaringan pascamenopause. Kulit dan mukosa yang lebih tipis menjadi lebih mudah

mengalami gesekan, gatal, kemerahan, dan rasa perih. Penggunaan sabun yang terlalu keras, kebersihan yang kurang tepat, kelembapan berlebih akibat kebocoran urine, atau penggunaan pembalut/pelindung yang terlalu lama dapat memperburuk iritasi. Iritasi yang tidak ditangani dapat menimbulkan rasa tidak nyaman berkepanjangan dan meningkatkan risiko infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan area genital dengan cara yang benar sangat penting bagi perempuan lansia, terutama yang mengalami inkontinensia atau kekeringan vagina.

Infeksi saluran kemih merupakan gangguan urogenital yang juga sering dialami perempuan lansia. Penurunan estrogen dapat mengubah kondisi jaringan saluran kemih dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Selain itu, inkontinensia urine, kebersihan yang kurang baik, kurang minum, diabetes melitus, dan kesulitan mengosongkan kandung kemih secara tuntas dapat meningkatkan risiko infeksi. Gejala infeksi saluran kemih dapat berupa nyeri atau panas saat buang air kecil, sering ingin berkemih, urine keruh atau berbau menyengat, nyeri perut bawah, demam, atau tubuh terasa lemah. Pada lansia, gejala infeksi kadang tidak khas dan dapat muncul sebagai kebingungan, penurunan nafsu makan, atau lemas. Oleh karena itu, keluarga dan tenaga kesehatan perlu peka terhadap perubahan kondisi perempuan lansia.

Nyeri pada area urogenital juga dapat dialami perempuan lansia. Nyeri dapat disebabkan oleh kekeringan vagina, iritasi, infeksi, luka kecil, atau gangguan lain pada organ panggul. Nyeri ini dapat membuat lansia tidak nyaman saat berjalan, duduk, membersihkan diri, atau berhubungan seksual. Jika tidak dikaji, lansia mungkin hanya menunjukkan perubahan perilaku seperti enggan mandi, mudah marah, menolak beraktivitas, atau tampak gelisah. Tenaga kesehatan perlu menyediakan suasana komunikasi yang aman agar lansia berani menyampaikan keluhan yang bersifat pribadi. Pendekatan yang sopan, sensitif, dan tidak menghakimi sangat diperlukan dalam membahas masalah urogenital.

Perubahan fungsi seksual pada perempuan lansia juga merupakan bagian penting dari kesehatan urogenital. Penuaan dan menopause dapat menyebabkan perubahan pada hasrat seksual, kenyamanan saat berhubungan, respons tubuh, dan kedekatan emosional dengan pasangan. Kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, penyakit kronis, kelelahan, penggunaan obat, perubahan citra tubuh, atau kehilangan pasangan dapat memengaruhi kehidupan seksual perempuan lansia. Namun, penting dipahami bahwa lanjut usia tidak berarti seseorang kehilangan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, sentuhan, dan hubungan emosional. Kesehatan seksual pada lansia perlu dipahami secara luas, tidak hanya sebagai aktivitas seksual, tetapi juga sebagai bagian dari kenyamanan, harga diri, kedekatan pasangan, dan kualitas hidup.

Banyak perempuan lansia merasa malu membicarakan perubahan fungsi seksual karena norma budaya, rasa sungkan, atau anggapan bahwa seksualitas bukan lagi hal yang pantas dibahas pada usia lanjut. Akibatnya, keluhan seperti nyeri, kekeringan, atau hilangnya kenyamanan dalam hubungan intim sering tidak tersampaikan. Tenaga kesehatan perlu memahami bahwa masalah ini nyata dan dapat memengaruhi kesejahteraan lansia. Edukasi yang diberikan harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak vulgar, dan menghormati nilai budaya pasien. Jika lansia memiliki pasangan, komunikasi yang baik dengan pasangan juga penting agar hubungan tetap harmonis dan tidak menimbulkan tekanan emosional.

Hambatan perempuan lansia dalam menyampaikan keluhan urogenital sangat sering terjadi. Rasa malu menjadi hambatan utama karena keluhan berkemih, area genital, dan fungsi seksual dianggap sebagai hal pribadi. Lansia mungkin takut dianggap jorok, tua, merepotkan, atau tidak pantas membicarakan masalah tersebut. Stigma juga dapat muncul dari keluarga atau masyarakat yang menganggap inkontinensia sebagai hal yang wajar dan tidak perlu ditangani. Padahal, meskipun sering terjadi, inkontinensia dan keluhan urogenital bukan berarti harus dibiarkan. Keluhan tersebut dapat dikaji, dikurangi, dan dikelola agar perempuan lansia tetap nyaman dan percaya diri.

Sebagian perempuan lansia juga tidak menyampaikan keluhan karena merasa takut diperiksa, takut biaya pengobatan, atau tidak tahu bahwa keluhannya dapat dibantu. Ada juga yang sudah mencoba mengatasi sendiri dengan mengurangi minum, menggunakan kain seadanya, atau membatasi aktivitas keluar rumah. Cara-cara tersebut kadang justru memperburuk kondisi. Mengurangi minum secara berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan infeksi saluran kemih. Menggunakan pelindung yang tidak diganti dengan cukup sering dapat menyebabkan iritasi kulit. Membatasi aktivitas sosial dapat memperburuk kesepian. Oleh karena itu, edukasi sangat penting agar perempuan lansia memahami bahwa keluhan urogenital perlu dibicarakan dan dapat ditangani secara bermartabat.

Salah satu upaya penanganan inkontinensia urine adalah latihan otot dasar panggul. Latihan ini bertujuan memperkuat otot yang membantu menahan urine. Jika dilakukan secara benar dan teratur, latihan otot dasar panggul dapat membantu mengurangi kebocoran urine, terutama pada jenis inkontinensia yang berkaitan dengan kelemahan otot. Perempuan lansia perlu diajarkan cara mengenali otot yang tepat dan melakukan latihan secara bertahap. Latihan sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan, tidak menimbulkan nyeri, dan dapat

dikombinasikan dengan aktivitas harian. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi dan memastikan lansia memahami cara latihan yang benar.

Menjaga kebersihan diri merupakan upaya penting dalam menangani inkontinensia dan gangguan urogenital. Area genital perlu dibersihkan dengan lembut dan dikeringkan dengan baik untuk mencegah iritasi. Pelindung atau popok dewasa, jika digunakan, perlu diganti secara teratur agar kulit tidak terlalu lama kontak dengan urine. Pakaian dalam sebaiknya bersih, nyaman, dan menyerap keringat. Penggunaan sabun yang terlalu keras atau pewangi berlebihan sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi. Keluarga yang membantu perawatan diri perlu menjaga privasi lansia, berbicara dengan sopan, dan tidak menunjukkan rasa jijik atau menyalahkan. Sikap yang menghargai akan membantu lansia merasa tetap bermartabat.

Pengaturan cairan juga perlu dilakukan dengan tepat. Perempuan lansia tidak dianjurkan mengurangi minum secara berlebihan hanya karena takut mengompol. Cairan tetap dibutuhkan untuk menjaga fungsi ginjal, mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan kulit, dan mencegah konstipasi. Namun, pola minum dapat diatur, misalnya memenuhi kebutuhan cairan lebih banyak pada pagi hingga sore hari dan mengurangi minum berlebihan menjelang tidur jika sering buang air kecil malam hari. Minuman yang dapat merangsang kandung kemih, seperti kafein, mungkin perlu dibatasi pada sebagian lansia. Pengaturan cairan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan, terutama bila lansia memiliki penyakit jantung atau ginjal yang membutuhkan pembatasan cairan tertentu.

Pemeriksaan kesehatan sangat penting apabila inkontinensia atau keluhan urogenital mengganggu kehidupan sehari-hari. Perempuan lansia perlu diperiksa bila mengalami kebocoran urine yang semakin sering, nyeri saat buang air kecil, urine berdarah, demam, nyeri perut bawah, gatal berat, keputihan tidak biasa, nyeri area genital, atau luka/iritasi yang tidak membaik. Pemeriksaan membantu menentukan penyebab keluhan, apakah berkaitan dengan infeksi, kelemahan otot, perubahan hormonal, diabetes, efek obat, atau gangguan lain. Dengan mengetahui penyebabnya, penanganan dapat dilakukan lebih tepat. Pemeriksaan juga membantu mencegah komplikasi seperti infeksi berulang, iritasi kulit berat, atau penurunan kualitas hidup.

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung perempuan lansia yang mengalami inkontinensia urine atau gangguan urogenital. Keluarga perlu memahami bahwa kondisi ini bukan alasan untuk mempermalukan atau menyalahkan lansia. Dukungan keluarga dapat berupa membantu menyediakan pakaian bersih, pelindung yang sesuai, akses ke toilet yang aman, pencahayaan malam hari, serta pendampingan ke fasilitas kesehatan. Keluarga juga perlu

menjaga komunikasi yang baik agar lansia berani menyampaikan keluhan. Jika keluarga merespons dengan marah, jijik, atau mengejek, lansia akan semakin menutup diri dan masalah menjadi lebih sulit ditangani.

Lingkungan rumah juga perlu disesuaikan untuk membantu perempuan lansia. Toilet sebaiknya mudah dijangkau, tidak licin, memiliki pencahayaan cukup, dan bila memungkinkan dilengkapi pegangan. Jalur dari tempat tidur ke kamar mandi perlu bebas dari barang yang dapat membuat tersandung. Hal ini penting karena perempuan lansia yang sering terburu-buru ke toilet berisiko jatuh, terutama pada malam hari. Jika mobilitas lansia terbatas, keluarga dapat mempertimbangkan penggunaan alat bantu yang sesuai. Lingkungan yang aman dapat mengurangi kecemasan lansia dan membantu menjaga kemandirian.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pengkajian, dan penanganan yang sensitif terhadap masalah urogenital perempuan lansia. Edukasi perlu menekankan bahwa inkontinensia dan gangguan urogenital sering terjadi, tetapi bukan sesuatu yang harus ditanggung sendiri. Tenaga kesehatan harus menggunakan komunikasi yang sopan, menjaga kerahasiaan, dan memberi kesempatan kepada lansia untuk berbicara tanpa rasa malu. Pengkajian perlu mencakup frekuensi berkemih, waktu kebocoran urine, jumlah urine yang keluar, faktor pemicu, keluhan nyeri, riwayat persalinan, penggunaan obat, penyakit kronis, pola minum, kebersihan diri, dan dampak terhadap aktivitas.

Dengan demikian, inkontinensia urine dan gangguan urogenital pascamenopause merupakan masalah penting pada perempuan lansia yang dapat berdampak luas terhadap rasa percaya diri, kebersihan, aktivitas sosial, hubungan intim, dan kualitas hidup. Inkontinensia urine dapat terjadi akibat melemahnya otot dasar panggul, riwayat persalinan, obesitas, perubahan hormon, penyakit kronis, atau gangguan mobilitas. Gangguan urogenital pascamenopause dapat berupa kekeringan vagina, iritasi, infeksi saluran kemih, dan nyeri akibat penurunan estrogen. Hambatan seperti rasa malu dan stigma sering membuat lansia enggan menyampaikan keluhan. Oleh karena itu, penanganan perlu dilakukan secara holistik melalui latihan otot dasar panggul, menjaga kebersihan, pengaturan cairan, pemeriksaan kesehatan, dukungan keluarga, lingkungan rumah yang aman, serta komunikasi tenaga kesehatan yang empatik dan menghargai martabat perempuan lansia.

J. Gangguan Sensorik, Mobilitas, dan Risiko Jatuh

Gangguan sensorik, mobilitas, dan risiko jatuh merupakan masalah kesehatan yang sangat penting pada perempuan lansia karena berhubungan langsung

dengan keselamatan, kemandirian, dan kualitas hidup. Pada masa lanjut usia, berbagai fungsi tubuh mengalami penurunan secara bertahap, termasuk fungsi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, keseimbangan, kekuatan otot, dan koordinasi gerak. Perubahan-perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan perempuan lansia dalam bergerak, berinteraksi, melakukan aktivitas sehari-hari, serta menjaga keamanan diri. Gangguan sensorik yang tampak sederhana, seperti penglihatan kabur atau pendengaran menurun, dapat berdampak luas apabila tidak dikenali dan ditangani dengan baik. Lansia dapat menjadi lebih mudah tersandung, salah memahami informasi, kehilangan selera makan, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan mengalami jatuh yang berakibat serius.

Penurunan penglihatan merupakan salah satu gangguan sensorik yang sering dialami perempuan lansia. Seiring bertambahnya usia, struktur mata mengalami perubahan. Lensa mata dapat menjadi kurang elastis, kemampuan fokus menurun, dan sensitivitas terhadap cahaya berubah. Perempuan lansia dapat mengalami kesulitan membaca tulisan kecil, melihat benda dari jarak dekat, membedakan warna tertentu, atau melihat dengan jelas pada ruangan yang pencahayaannya kurang. Keluhan seperti penglihatan kabur, mata mudah lelah, silau, sulit melihat pada malam hari, atau sering tersandung benda kecil dapat menjadi tanda adanya gangguan penglihatan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh proses penuaan normal, tetapi juga dapat berkaitan dengan penyakit mata seperti katarak, glaukoma, retinopati diabetik, atau degenerasi makula.

Penurunan penglihatan sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari perempuan lansia. Aktivitas seperti membaca, memasak, menjahit, berjalan di luar rumah, mengenali wajah orang, memilih obat, atau membaca label makanan dapat menjadi lebih sulit. Jika penglihatan terganggu, perempuan lansia juga lebih rentan salah minum obat karena tidak dapat membaca aturan pakai dengan jelas. Selain itu, gangguan penglihatan meningkatkan risiko jatuh karena lansia mungkin tidak melihat permukaan lantai yang tidak rata, anak tangga, benda kecil di jalan, atau genangan air. Pada malam hari, risiko ini semakin tinggi apabila pencahayaan rumah kurang memadai. Oleh karena itu, pemeriksaan mata secara berkala, penggunaan kacamata yang sesuai, pencahayaan rumah yang cukup, serta penataan lingkungan yang aman sangat penting untuk menjaga keselamatan perempuan lansia.

Gangguan pendengaran juga sering terjadi pada perempuan lansia dan dapat memengaruhi komunikasi serta hubungan sosial. Penurunan pendengaran pada lansia dapat terjadi secara perlahan sehingga sering tidak langsung disadari. Perempuan lansia mungkin mulai sulit mendengar suara pelan, meminta orang lain

mengulang perkataan, meningkatkan volume televisi, atau sulit memahami percakapan di tempat ramai. Gangguan pendengaran dapat membuat lansia salah menangkap pesan, tidak merespons ketika dipanggil, atau tampak tidak memperhatikan pembicaraan. Kondisi ini kadang disalahartikan oleh keluarga sebagai sikap tidak peduli, lambat merespons, atau tidak mau mendengar, padahal penyebabnya adalah penurunan fungsi pendengaran.

Dampak penurunan pendengaran terhadap komunikasi cukup besar. Komunikasi yang terganggu dapat menyebabkan kesalahpahaman antara perempuan lansia dan keluarga. Lansia dapat merasa malu karena sering meminta orang lain mengulang pembicaraan. Ia juga dapat merasa lelah mengikuti percakapan karena harus berusaha keras memahami suara. Dalam jangka panjang, perempuan lansia dengan gangguan pendengaran dapat memilih menarik diri dari percakapan keluarga, kegiatan sosial, atau pertemuan masyarakat. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesepian, isolasi sosial, dan penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, keluarga perlu berbicara dengan jelas, menghadap ke arah lansia saat berbicara, tidak berteriak, mengurangi kebisingan saat berkomunikasi, dan memastikan lansia memahami pesan yang disampaikan.

Penurunan penciuman dan pengecapan juga dapat terjadi pada perempuan lansia. Fungsi penciuman yang menurun membuat lansia kurang peka terhadap bau makanan, bau asap, bau gas, bau benda terbakar, atau bau tidak sedap yang dapat menjadi tanda bahaya. Penurunan pengecapan membuat makanan terasa hambar, sehingga lansia dapat kehilangan selera makan. Kondisi ini dapat berdampak pada asupan nutrisi. Perempuan lansia yang merasa makanan tidak lagi enak dapat makan lebih sedikit, memilih makanan tertentu saja, atau menambahkan garam dan gula secara berlebihan agar rasa makanan lebih kuat. Kebiasaan menambahkan garam berlebihan dapat memperburuk hipertensi, sedangkan penambahan gula berlebihan dapat memperburuk diabetes melitus atau meningkatkan risiko gangguan metabolik.

Penurunan penciuman juga dapat memengaruhi keamanan. Perempuan lansia yang tidak dapat mencium bau gas, asap, atau makanan basi berisiko mengalami kecelakaan rumah tangga atau gangguan kesehatan. Misalnya, lansia mungkin tidak menyadari kebocoran gas di dapur atau tidak mengetahui bahwa makanan sudah tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, keluarga perlu memperhatikan keamanan rumah, terutama area dapur. Kompor harus dipastikan dalam keadaan mati setelah digunakan, ventilasi rumah harus baik, dan makanan perlu disimpan dengan cara yang aman. Untuk membantu meningkatkan nafsu makan, makanan dapat disajikan dengan tampilan menarik, tekstur yang sesuai,

aroma alami yang menyenangkan, serta variasi menu yang tetap memperhatikan kondisi kesehatan lansia.

Gangguan mobilitas merupakan masalah yang sering dialami perempuan lansia akibat penurunan kekuatan otot, nyeri sendi, osteoporosis, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, penyakit kronis, atau rasa takut jatuh. Mobilitas adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan aman, seperti berjalan, berdiri, berpindah tempat, naik turun tangga, atau melakukan aktivitas rumah tangga. Ketika mobilitas menurun, perempuan lansia menjadi lebih sulit melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Ia mungkin membutuhkan bantuan untuk berjalan, mandi, menggunakan toilet, memasak, atau berbelanja. Penurunan mobilitas tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada psikologis karena lansia dapat merasa tidak berdaya, bergantung, atau menjadi beban keluarga.

Gangguan keseimbangan merupakan salah satu penyebab utama keterbatasan mobilitas dan risiko jatuh. Keseimbangan tubuh dipengaruhi oleh kerja sama antara mata, telinga bagian dalam, otot, sendi, saraf, dan otak. Pada masa lanjut usia, fungsi-fungsi tersebut dapat mengalami penurunan. Perempuan lansia mungkin merasa tubuhnya goyah saat berdiri, sulit berjalan lurus, perlu berpegangan pada dinding, atau merasa tidak stabil ketika berubah posisi dari duduk ke berdiri. Gangguan keseimbangan juga dapat diperburuk oleh tekanan darah yang turun mendadak saat berdiri, efek obat, gangguan penglihatan, kelemahan otot, atau penyakit saraf. Jika tidak ditangani, gangguan keseimbangan dapat membuat lansia takut bergerak dan semakin membatasi aktivitasnya.

Perubahan cara berjalan juga sering terlihat pada perempuan lansia. Langkah dapat menjadi lebih pendek, kecepatan berjalan melambat, tubuh lebih membungkuk, ayunan tangan berkurang, dan kaki tampak kurang terangkat saat melangkah. Perubahan ini dapat terjadi karena nyeri sendi, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, penglihatan menurun, atau rasa takut jatuh. Cara berjalan yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko tersandung, terutama di permukaan lantai yang tidak rata. Perempuan lansia yang mengalami perubahan cara berjalan membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar penyebabnya dapat diketahui. Bila diperlukan, alat bantu seperti tongkat atau walker dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dan diajarkan dengan benar.

Risiko jatuh pada perempuan lansia dapat muncul akibat kombinasi berbagai faktor. Kelemahan otot merupakan salah satu faktor utama karena otot yang lemah membuat tubuh sulit mempertahankan posisi stabil. Gangguan penglihatan membuat lansia tidak mampu melihat hambatan di sekitarnya dengan baik. Lantai

licin, karpet yang terlipat, kabel berserakan, pencahayaan kurang, tangga tanpa pegangan, kamar mandi basah, dan alas kaki yang tidak sesuai dapat memperbesar risiko jatuh. Obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan pusing, mengantuk, tekanan darah turun, atau gangguan keseimbangan. Lansia yang menggunakan obat tidur, obat penenang, obat tekanan darah, atau beberapa jenis obat sekaligus perlu dipantau karena efek obat dapat memengaruhi kewaspadaan dan stabilitas tubuh.

Lingkungan yang tidak aman menjadi faktor penting dalam kejadian jatuh. Banyak kejadian jatuh terjadi di rumah, terutama di kamar mandi, dapur, tangga, atau area yang pencahayaannya kurang. Kamar mandi merupakan tempat berisiko karena lantainya sering basah dan licin. Perempuan lansia yang terburu-buru ke kamar mandi, terutama pada malam hari, lebih mudah terpeleset atau kehilangan keseimbangan. Risiko semakin meningkat bila lansia mengalami inkontinensia urine atau sering buang air kecil pada malam hari. Oleh karena itu, penataan rumah yang aman menjadi bagian penting dalam pencegahan jatuh. Keamanan rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab lansia, tetapi juga keluarga yang tinggal bersama atau merawatnya.

Dampak jatuh pada perempuan lansia dapat sangat serius. Jatuh dapat menyebabkan luka ringan seperti memar atau lecet, tetapi juga dapat menimbulkan cedera berat seperti fraktur, cedera kepala, atau perdarahan. Pada perempuan lansia yang mengalami osteoporosis, jatuh ringan pun dapat menyebabkan patah tulang, terutama pada tulang panggul, pergelangan tangan, atau tulang belakang. Fraktur panggul merupakan salah satu dampak jatuh yang paling serius karena dapat menyebabkan lansia tidak mampu berjalan, membutuhkan perawatan lama, dan mengalami ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Cedera kepala juga perlu diwaspadai karena pada lansia dampaknya dapat lebih berat, terutama jika menggunakan obat pengencer darah atau memiliki penyakit tertentu.

Selain dampak fisik, jatuh juga dapat menimbulkan dampak psikologis. Perempuan lansia yang pernah jatuh dapat mengalami ketakutan bergerak. Rasa takut ini dapat membuat lansia membatasi aktivitas, menolak berjalan sendiri, atau lebih banyak duduk dan berbaring. Pembatasan aktivitas yang berlebihan dapat menyebabkan otot semakin lemah, sendi semakin kaku, keseimbangan menurun, dan risiko jatuh berikutnya semakin besar. Dengan demikian, jatuh dapat menciptakan lingkaran masalah: jatuh menyebabkan takut bergerak, takut bergerak menyebabkan kurang aktivitas, kurang aktivitas menyebabkan tubuh melemah, dan kelemahan meningkatkan risiko jatuh kembali. Oleh karena itu,

setelah kejadian jatuh, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian berulang.

Jatuh juga dapat menurunkan kemandirian perempuan lansia. Setelah mengalami cedera, lansia mungkin membutuhkan bantuan untuk mandi, berpakaian, berjalan, menggunakan toilet, atau berpindah tempat. Ketergantungan ini dapat menimbulkan perasaan sedih, malu, tidak berguna, atau menjadi beban bagi keluarga. Perempuan lansia yang sebelumnya aktif dalam kegiatan keluarga atau masyarakat dapat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Penurunan kemandirian juga dapat memengaruhi hubungan sosial dan kualitas hidup. Oleh sebab itu, pencegahan jatuh bukan hanya bertujuan mencegah cedera fisik, tetapi juga mempertahankan martabat, rasa percaya diri, dan peran sosial perempuan lansia.

Pencegahan jatuh harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Penataan rumah merupakan langkah yang sangat penting. Lantai rumah sebaiknya tidak licin, bebas dari barang yang berserakan, dan tidak memiliki karpet yang mudah terlipat. Pencahayaan harus cukup, terutama di kamar tidur, lorong, tangga, dan kamar mandi. Kamar mandi sebaiknya dilengkapi pegangan bila memungkinkan, serta menggunakan alas antiselip. Barang yang sering digunakan sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau agar lansia tidak perlu memanjat atau membungkuk terlalu jauh. Tangga perlu memiliki pegangan yang kuat, dan lantai yang rusak atau tidak rata perlu diperbaiki. Penataan rumah yang aman dapat mengurangi risiko jatuh secara bermakna.

Penggunaan alat bantu juga dapat membantu mencegah jatuh. Tongkat, walker, atau pegangan tambahan dapat memberikan dukungan saat berjalan, terutama bagi perempuan lansia yang mengalami kelemahan otot, gangguan keseimbangan, atau nyeri sendi. Namun, alat bantu harus dipilih sesuai kebutuhan dan digunakan dengan cara yang benar. Tongkat yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu postur dan justru meningkatkan risiko jatuh. Walker yang tidak sesuai juga dapat membuat lansia sulit bergerak. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lansia dan mendapat arahan dari tenaga kesehatan. Keluarga juga perlu memastikan alat bantu dalam keadaan baik dan tidak licin.

Latihan keseimbangan dan kekuatan otot sangat penting untuk mencegah jatuh. Perempuan lansia perlu tetap aktif sesuai kemampuan agar otot tidak semakin lemah. Latihan sederhana seperti berdiri dari kursi secara perlahan, berjalan santai, senam lansia, latihan peregangan, latihan mengangkat kaki ringan, atau latihan keseimbangan dengan pendampingan dapat membantu meningkatkan stabilitas tubuh. Latihan harus dilakukan secara aman dan bertahap.

Lansia yang memiliki riwayat jatuh, penyakit jantung, nyeri sendi berat, atau gangguan keseimbangan perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan latihan tertentu. Tujuan latihan bukan memaksakan tubuh, tetapi mempertahankan fungsi gerak dan rasa percaya diri.

Pemeriksaan kesehatan juga merupakan bagian penting dalam pencegahan jatuh. Perempuan lansia perlu memeriksakan penglihatan, pendengaran, tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan tulang, serta obat-obatan yang digunakan. Penglihatan yang buruk perlu dikoreksi dengan kacamata yang sesuai. Tekanan darah yang mudah turun saat berdiri perlu dipantau karena dapat menyebabkan pusing. Kadar gula darah yang tidak stabil dapat menyebabkan lemas atau gangguan saraf. Obat-obatan yang menyebabkan kantuk, pusing, atau gangguan keseimbangan perlu dievaluasi oleh tenaga kesehatan. Dengan pemeriksaan rutin, faktor risiko jatuh dapat dikenali lebih awal dan ditangani secara tepat.

Pendampingan keluarga sangat penting dalam mencegah jatuh dan menjaga mobilitas perempuan lansia. Keluarga dapat membantu menata rumah, mendampingi lansia berjalan, memastikan alas kaki aman, mengingatkan penggunaan alat bantu, serta memberikan dukungan emosional agar lansia tidak takut bergerak. Namun, keluarga perlu menjaga keseimbangan antara melindungi dan mempertahankan kemandirian. Jika keluarga terlalu melarang lansia bergerak, otot lansia dapat semakin lemah dan rasa percaya diri menurun. Sebaliknya, jika lansia dibiarkan melakukan aktivitas berisiko tanpa pendampingan, kemungkinan jatuh meningkat. Dukungan yang tepat adalah membantu saat diperlukan, tetapi tetap memberi kesempatan kepada lansia melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan.

Komunikasi yang baik juga diperlukan dalam pencegahan jatuh. Perempuan lansia perlu diberi pemahaman bahwa menggunakan alat bantu, memperlambat gerakan, meminta bantuan, atau menata rumah bukan tanda kelemahan, melainkan cara menjaga keselamatan. Keluarga perlu menyampaikan hal ini dengan bahasa yang menghargai agar lansia tidak merasa diremehkan. Lansia yang merasa dihormati akan lebih mudah menerima saran keselamatan. Tenaga kesehatan juga perlu memberikan edukasi dengan cara yang sederhana dan praktis, misalnya menjelaskan cara bangun dari tempat tidur secara perlahan, cara menggunakan tongkat, pentingnya memakai alas kaki yang tidak licin, dan pentingnya menyalakan lampu saat berjalan malam hari.

Dengan demikian, gangguan sensorik, mobilitas, dan risiko jatuh merupakan masalah yang saling berkaitan pada perempuan lansia. Penurunan penglihatan dapat mengganggu aktivitas dan meningkatkan risiko tersandung. Penurunan pendengaran dapat menghambat komunikasi dan menyebabkan isolasi sosial.

Penurunan penciuman dan pengecapan dapat memengaruhi nafsu makan serta keamanan. Gangguan keseimbangan dan perubahan cara berjalan dapat menurunkan mobilitas serta meningkatkan risiko jatuh. Jatuh dapat menimbulkan luka, fraktur, cedera kepala, ketakutan bergerak, dan penurunan kemandirian. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui penataan rumah yang aman, penggunaan alat bantu yang tepat, latihan keseimbangan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pendampingan keluarga. Dengan upaya yang tepat, perempuan lansia dapat mempertahankan mobilitas, rasa aman, kemandirian, dan kualitas hidup secara lebih optimal.

K. Gangguan Psikologis dan Sosial pada Perempuan Lansia

Gangguan psikologis dan sosial pada perempuan lansia merupakan masalah penting yang perlu dipahami secara menyeluruh karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, kemandirian, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional. Pada masa lanjut usia, perempuan tidak hanya mengalami perubahan fisik akibat proses penuaan, tetapi juga menghadapi berbagai perubahan dalam peran, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, status sosial, serta cara memandang diri sendiri. Perubahan tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak disertai kemampuan adaptasi yang baik dan dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan lansia dapat mengalami kecemasan, kesepian, depresi, penurunan daya ingat, perubahan konsep diri, isolasi sosial, serta berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.

Kecemasan merupakan salah satu gangguan psikologis yang sering dialami perempuan lansia. Kecemasan pada masa lanjut usia dapat muncul karena berbagai hal, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan, kemandirian, ekonomi, dan masa depan. Perempuan lansia yang mulai mengalami penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, osteoporosis, atau gangguan penglihatan, dapat merasa khawatir terhadap perkembangan penyakitnya. Mereka mungkin takut penyakit semakin berat, takut mengalami komplikasi, takut jatuh, takut tidak dapat berjalan, atau takut harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Kekhawatiran tersebut dapat menjadi lebih kuat apabila lansia pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan, seperti jatuh, dirawat di rumah sakit, kehilangan pasangan, atau melihat teman sebaya mengalami kondisi kesehatan yang berat.

Kecemasan terkait kemandirian juga sering muncul pada perempuan lansia. Banyak perempuan sepanjang hidupnya terbiasa mengurus keluarga, bekerja, mengelola rumah tangga, merawat anak, atau membantu orang lain. Ketika usia bertambah dan kemampuan tubuh mulai menurun, mereka dapat merasa tidak

nyaman karena harus menerima bantuan dari keluarga. Perempuan lansia mungkin merasa takut menjadi beban, takut tidak lagi dihargai, atau takut kehilangan kontrol terhadap hidupnya. Aktivitas sederhana seperti mandi, berpakaian, berjalan, mengelola obat, atau pergi ke fasilitas kesehatan dapat menjadi sumber kecemasan apabila lansia mulai merasa tidak mampu melakukannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecemasan pada lansia tidak hanya berhubungan dengan penyakit, tetapi juga dengan rasa kehilangan kemandirian dan harga diri.

Masalah ekonomi juga dapat menjadi sumber kecemasan bagi perempuan lansia. Sebagian perempuan lansia tidak memiliki penghasilan tetap, pensiun, tabungan, atau jaminan sosial yang cukup. Ada pula perempuan yang sepanjang hidupnya lebih banyak bekerja di ranah domestik sehingga tidak memiliki penghasilan pribadi pada masa tua. Ketergantungan ekonomi pada anak, pasangan, atau keluarga besar dapat menimbulkan rasa tidak enak, malu, atau takut merepotkan. Perempuan lansia mungkin menunda berobat, mengurangi kebutuhan makan, atau tidak membeli alat bantu kesehatan karena khawatir biaya. Kecemasan ekonomi dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental karena lansia merasa tidak aman menghadapi masa depan.

Kecemasan terhadap masa depan juga sering dialami perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, seseorang mulai lebih sering memikirkan kematian, kehilangan orang terdekat, kemungkinan sakit berat, serta siapa yang akan merawatnya jika kondisi memburuk. Perempuan lansia yang tinggal sendiri atau jauh dari anak-anak dapat merasa lebih cemas karena khawatir tidak ada yang membantu saat terjadi keadaan darurat. Kecemasan ini dapat menyebabkan sulit tidur, mudah lelah, jantung berdebar, sering mengeluh, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, atau menarik diri dari aktivitas. Jika tidak dikenali, kecemasan dapat memperburuk kondisi fisik, menurunkan nafsu makan, dan mengurangi motivasi lansia untuk menjaga kesehatan.

Selain kecemasan, kesepian merupakan masalah psikologis dan sosial yang sangat sering dialami perempuan lansia. Kesepian dapat terjadi akibat kehilangan pasangan, anak-anak yang tinggal terpisah, berkurangnya teman sebaya, atau menurunnya keterlibatan dalam kegiatan sosial. Kehilangan pasangan merupakan salah satu pengalaman emosional yang berat bagi perempuan lansia karena pasangan sering menjadi teman hidup, tempat berbagi cerita, sumber dukungan emosional, dan pendamping dalam aktivitas sehari-hari. Setelah pasangan meninggal, perempuan lansia dapat merasa rumah menjadi sepi, kehilangan teman berbicara, serta merasa hidupnya berubah secara drastis. Proses berduka membutuhkan waktu dan dukungan, karena kehilangan pasangan bukan hanya

kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan bagian penting dari rutinitas dan identitas hidup.

Anak-anak yang tinggal terpisah juga dapat memperkuat rasa kesepian. Pada masa sebelumnya, perempuan lansia mungkin terbiasa hidup dalam keluarga besar dan memiliki banyak aktivitas bersama anak-anak. Ketika anak sudah dewasa, menikah, bekerja, atau tinggal di kota lain, interaksi sehari-hari menjadi berkurang. Meskipun anak tetap memberikan dukungan secara ekonomi atau sesekali berkunjung, perempuan lansia tetap dapat merasa kesepian apabila tidak memiliki komunikasi yang hangat dan rutin. Kesepian tidak selalu berarti lansia hidup sendiri. Lansia yang tinggal bersama keluarga pun dapat merasa kesepian jika tidak diajak berbicara, tidak didengarkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan keluarga, atau merasa keberadaannya hanya dianggap sebagai tanggung jawab.

Berkurangnya teman sebaya juga berpengaruh terhadap kesepian perempuan lansia. Teman sebaya memiliki peran penting karena mereka biasanya memiliki pengalaman hidup yang mirip, seperti pengalaman menjadi tua, menghadapi penyakit, kehilangan pasangan, atau perubahan peran dalam keluarga. Ketika teman sebaya meninggal, sakit, pindah rumah, atau tidak lagi aktif dalam kegiatan sosial, lingkaran pertemanan lansia semakin menyempit. Perempuan lansia dapat kehilangan tempat untuk berbagi cerita dan merasa tidak ada orang yang benar-benar memahami pengalaman hidupnya. Jika kondisi ini berlangsung lama, kesepian dapat berkembang menjadi isolasi sosial dan meningkatkan risiko depresi.

Risiko depresi pada perempuan lansia perlu mendapat perhatian serius. Depresi bukan sekadar rasa sedih biasa, melainkan kondisi psikologis yang dapat memengaruhi pikiran, emosi, perilaku, tidur, nafsu makan, energi, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari. Pada perempuan lansia, depresi dapat dipicu oleh banyak faktor, seperti penyakit kronis, nyeri berkepanjangan, kehilangan pasangan, hidup sendiri, keterbatasan ekonomi, penurunan kemandirian, kesepian, konflik keluarga, atau merasa tidak lagi memiliki peran. Depresi sering tidak terdeteksi karena gejalanya dapat tampak seperti keluhan fisik biasa, misalnya mudah lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun, nyeri tubuh, atau kurang semangat.

Perempuan lansia yang mengalami depresi dapat menunjukkan tanda-tanda seperti perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, menarik diri dari keluarga atau masyarakat, mudah menangis, merasa tidak berguna, merasa menjadi beban, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, perubahan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya kemampuan merawat diri. Pada beberapa lansia, depresi tidak selalu tampak sebagai kesedihan yang jelas. Mereka mungkin lebih sering mengeluh sakit, mudah marah, menolak

makan, atau enggan berbicara. Karena itu, keluarga dan tenaga kesehatan perlu peka terhadap perubahan perilaku lansia, terutama jika perubahan tersebut berlangsung lebih dari beberapa waktu dan memengaruhi aktivitas harian.

Depresi pada perempuan lansia tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari penuaan. Proses penuaan memang membawa banyak perubahan, tetapi lansia tetap berhak memiliki kesejahteraan emosional dan hidup yang bermakna. Jika depresi dibiarkan, dampaknya dapat sangat luas. Lansia dapat kehilangan motivasi untuk makan, minum obat, beraktivitas, menjaga kebersihan diri, atau mengikuti kontrol kesehatan. Depresi juga dapat memperburuk penyakit kronis karena lansia menjadi kurang peduli terhadap perawatan dirinya. Dalam kondisi berat, depresi dapat menimbulkan pikiran bahwa hidup tidak lagi bermakna. Oleh karena itu, dukungan emosional, kegiatan bermakna, komunikasi keluarga yang hangat, dukungan spiritual, dan bantuan tenaga kesehatan sangat penting.

Penurunan daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif juga sering menjadi perhatian pada perempuan lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak dalam memproses informasi dapat mengalami perubahan. Lansia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi baru, lebih sering lupa meletakkan barang, lupa nama seseorang, atau sulit mengikuti percakapan panjang. Penurunan ringan dalam daya ingat dapat menjadi bagian dari penuaan normal, tetapi jika gangguan memori semakin berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Misalnya, lansia yang sering lupa minum obat, lupa mematikan kompor, tersesat saat keluar rumah, tidak mampu mengelola uang, atau tidak mengenali orang dekat membutuhkan perhatian khusus.

Fungsi kognitif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, kesehatan otak, penyakit kronis, kualitas tidur, nutrisi, aktivitas mental, penggunaan obat, gangguan pendengaran atau penglihatan, serta kondisi psikologis. Perempuan lansia yang mengalami depresi atau kecemasan dapat tampak mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, meskipun penyebab utamanya adalah gangguan suasana hati. Kurang tidur, anemia, malnutrisi, diabetes yang tidak terkontrol, atau efek obat juga dapat memengaruhi daya ingat dan konsentrasi. Oleh karena itu, penurunan fungsi kognitif perlu dipahami secara menyeluruh, tidak langsung dianggap sebagai kepikunan biasa. Pengkajian yang baik membantu menentukan apakah masalah kognitif berkaitan dengan penuaan normal, kondisi medis, gangguan psikologis, atau penyakit neurodegeneratif.

Stimulasi kognitif penting untuk membantu mempertahankan fungsi otak perempuan lansia. Aktivitas seperti membaca, menulis, berdiskusi, menghafal doa atau lagu, bermain permainan sederhana, mengikuti kegiatan keagamaan,

bercerita dengan cucu, atau belajar keterampilan ringan dapat membantu otak tetap aktif. Interaksi sosial juga berperan penting karena percakapan dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat memberi rangsangan mental yang bermanfaat. Lansia yang jarang berinteraksi, kurang aktivitas, dan lebih banyak menyendiri dapat mengalami penurunan motivasi serta stimulasi mental yang lebih rendah. Oleh sebab itu, menjaga keterlibatan sosial bukan hanya penting bagi emosi, tetapi juga bagi fungsi kognitif.

Perubahan konsep diri merupakan aspek psikologis penting pada perempuan lansia. Konsep diri adalah cara seseorang memandang, menilai, dan menerima dirinya sendiri. Pada masa lanjut usia, konsep diri dapat berubah akibat proses penuaan, penyakit kronis, perubahan penampilan, penurunan kemampuan fisik, dan perubahan peran dalam keluarga. Kulit keriput, rambut memutih, tubuh melemah, berat badan berubah, atau munculnya keterbatasan aktivitas dapat membuat sebagian perempuan lansia merasa kurang percaya diri. Perempuan yang sebelumnya aktif, produktif, dan menjadi pusat pengasuhan keluarga dapat merasa kehilangan identitas ketika tidak lagi mampu menjalankan peran seperti dulu.

Penyakit kronis juga dapat memengaruhi konsep diri perempuan lansia. Lansia yang mengalami diabetes, penyakit jantung, nyeri sendi, osteoporosis, atau inkontinensia urine dapat merasa tubuhnya tidak lagi kuat dan tidak dapat diandalkan. Jika penyakit menyebabkan ketergantungan pada keluarga, lansia dapat merasa menjadi beban. Perubahan ini dapat menurunkan harga diri, terutama jika keluarga memperlakukan lansia dengan cara yang merendahkan atau tidak melibatkan lansia dalam keputusan. Sebaliknya, konsep diri dapat tetap terjaga apabila lansia merasa dihargai, diberi kesempatan untuk mandiri sesuai kemampuan, dan tetap memiliki peran dalam keluarga maupun masyarakat.

Perubahan peran keluarga juga sangat berpengaruh terhadap konsep diri. Banyak perempuan sepanjang hidupnya menjalankan peran sebagai ibu, istri, pengasuh, pengatur rumah tangga, pekerja, atau tokoh keluarga. Ketika anak-anak sudah mandiri, pasangan meninggal, atau kemampuan fisik menurun, peran tersebut dapat berubah. Perempuan lansia mungkin merasa tidak lagi dibutuhkan atau merasa kehilangan posisi penting dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga perlu tetap memberikan ruang bagi lansia untuk berperan sesuai kemampuan, misalnya memberi nasihat, membantu pekerjaan ringan, berbagi pengalaman, mendampingi cucu, atau terlibat dalam kegiatan keluarga. Peran sederhana dapat memberi rasa bermakna dan memperkuat harga diri lansia.

Isolasi sosial merupakan kondisi ketika seseorang memiliki interaksi sosial yang terbatas atau kurang terlibat dalam kehidupan sosial. Pada perempuan lansia,

isolasi sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kehilangan pasangan, anak tinggal jauh, teman sebaya berkurang, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, keterbatasan mobilitas, inkontinensia urine, penyakit kronis, atau rasa malu terhadap kondisi fisik. Lansia yang mengalami isolasi sosial cenderung lebih banyak berada di rumah, jarang berbicara dengan orang lain, tidak mengikuti kegiatan masyarakat, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh dukungan emosional. Isolasi sosial dapat memperburuk kesepian, depresi, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan kualitas hidup.

Penurunan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat juga dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan lansia. Kegiatan masyarakat, keagamaan, posyandu lansia, senam lansia, arisan, pengajian, kelompok keterampilan, atau kegiatan komunitas dapat menjadi sarana penting bagi lansia untuk tetap aktif dan merasa terhubung. Ketika perempuan lansia tidak lagi mengikuti kegiatan tersebut, ia dapat kehilangan rutinitas, teman berbicara, dan rasa menjadi bagian dari lingkungan. Namun, berkurangnya keterlibatan tidak selalu karena lansia tidak berminat. Sering kali penyebabnya adalah keterbatasan fisik, tidak ada transportasi, takut jatuh, tidak ada yang mendampingi, atau merasa malu karena keluhan kesehatan tertentu. Karena itu, masyarakat perlu menciptakan kegiatan yang ramah lansia dan mudah diakses.

Dukungan keluarga sangat penting dalam menjaga kesehatan mental perempuan lansia. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional melalui perhatian, kasih sayang, komunikasi yang hangat, dan kesediaan mendengarkan. Lansia perempuan membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, dan pengalamannya. Keluarga juga dapat memberikan dukungan praktis, seperti mendampingi kontrol kesehatan, membantu aktivitas yang sulit, menyediakan makanan bergizi, mengingatkan obat, dan memastikan lingkungan rumah aman. Namun, dukungan harus diberikan dengan tetap menghargai martabat dan kemandirian lansia. Bantuan yang terlalu mengatur dapat membuat lansia merasa tidak berdaya, sedangkan kurang perhatian dapat membuat lansia merasa diabaikan.

Dukungan spiritual juga berperan besar dalam menjaga kesehatan mental perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual sering meningkat karena lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, kematian, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, membaca kitab suci, berzikir, mengikuti kegiatan keagamaan, atau berbagi pengalaman rohani dapat memberikan ketenangan batin. Spiritualitas membantu lansia menerima perubahan, mengelola kecemasan, menghadapi kehilangan, dan menemukan makna dalam masa tua. Keluarga dan masyarakat perlu mendukung

kebutuhan spiritual lansia sesuai keyakinannya, tanpa memaksakan atau mengabaikan nilai-nilai yang dianut lansia.

Komunitas juga dapat menjadi sumber dukungan yang sangat berarti. Kegiatan komunitas memberikan kesempatan bagi perempuan lansia untuk bertemu orang lain, berbagi cerita, merasa dihargai, dan tetap aktif. Komunitas dapat berbentuk kelompok lansia, kelompok keagamaan, posyandu lansia, kelompok senam, kelompok keterampilan, atau kelompok sosial lainnya. Keterlibatan dalam komunitas membantu mengurangi kesepian dan mempertahankan rasa bermakna. Selain itu, komunitas dapat menjadi tempat lansia memperoleh informasi kesehatan, dukungan emosional, dan bantuan ketika mengalami kesulitan. Masyarakat yang ramah lansia akan membantu perempuan lansia merasa tetap menjadi bagian penting dari lingkungan sosial.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental perempuan lansia. Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan perlu mengkaji tidak hanya keluhan fisik, tetapi juga kondisi emosional, daya ingat, kualitas tidur, nafsu makan, dukungan keluarga, aktivitas sosial, dan kemungkinan depresi atau kecemasan. Lansia yang sering mengeluh lelah, sulit tidur, nyeri, atau tidak nafsu makan perlu dikaji secara menyeluruh karena keluhan tersebut dapat berkaitan dengan masalah psikologis. Tenaga kesehatan perlu menggunakan komunikasi yang sabar, empatik, dan tidak menghakimi. Perempuan lansia harus diberi kesempatan untuk menceritakan keluhan dan perasaannya dengan aman.

gangguan psikologis dan sosial pada perempuan lansia mencakup kecemasan, kesepian, risiko depresi, penurunan daya ingat, gangguan konsentrasi, perubahan konsep diri, isolasi sosial, dan penurunan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Gangguan tersebut dapat dipengaruhi oleh kesehatan fisik, penyakit kronis, menopause, kehilangan pasangan, perubahan peran keluarga, masalah ekonomi, keterbatasan mobilitas, dan kurangnya dukungan sosial. Kesehatan mental perempuan lansia tidak dapat dipisahkan dari dukungan keluarga, spiritualitas, komunitas, dan pelayanan kesehatan. Dengan dukungan yang tepat, perempuan lansia dapat mempertahankan harga diri, mengurangi kesepian, mengelola kecemasan, mencegah depresi, tetap aktif dalam kehidupan sosial, dan menjalani masa tua dengan lebih sehat, bermartabat, serta bermakna.

L. Simpulan

Masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia merupakan kondisi yang kompleks dan saling berkaitan antara proses penuaan, menopause, perubahan hormonal, penyakit kronis, gaya hidup, status gizi, kondisi psikologis, serta dukungan sosial. Perempuan lansia menjadi kelompok yang rentan karena

mengalami penurunan fungsi tubuh secara bertahap, seperti melemahnya otot, berkurangnya kepadatan tulang, menurunnya fungsi penglihatan dan pendengaran, perubahan metabolisme, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Kondisi seperti osteoporosis, nyeri sendi, hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, gangguan sirkulasi, gangguan tidur, kelelahan, malnutrisi, anemia, inkontinensia urine, gangguan urogenital, gangguan sensorik, dan risiko jatuh dapat memengaruhi kemandirian, kenyamanan, mobilitas, serta kemampuan perempuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain masalah fisik, perempuan lansia juga rentan mengalami gangguan psikologis dan sosial. Kecemasan, kesepian, depresi, penurunan daya ingat, perubahan konsep diri, isolasi sosial, serta berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat dapat muncul akibat penyakit kronis, kehilangan pasangan, anak yang tinggal terpisah, perubahan peran keluarga, masalah ekonomi, maupun keterbatasan fisik. Gangguan psikologis dan sosial tersebut dapat memperburuk kondisi kesehatan apabila tidak dikenali dan ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kesehatan perempuan lansia tidak hanya dapat dinilai dari keadaan fisik, tetapi juga perlu dilihat dari aspek emosional, sosial, spiritual, dan kualitas hidup secara menyeluruh.

Upaya menjaga kesehatan perempuan lansia perlu dilakukan melalui deteksi dini, pencegahan, pemantauan kesehatan secara berkala, pengendalian penyakit kronis, pemenuhan gizi seimbang, aktivitas fisik yang aman, pengaturan pola tidur, pencegahan jatuh, serta perawatan diri yang sesuai dengan kondisi lansia. Peran keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan emosional, sosial, spiritual, dan praktis. Keluarga perlu mendampingi lansia dengan tetap menghargai kemandirian dan martabatnya, tenaga kesehatan berperan dalam edukasi serta pemantauan kondisi, sedangkan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan bebas dari stigma. Dengan pendekatan holistik, perempuan lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, mandiri, nyaman, bermartabat, dan bermakna.

M. Referensi

-
- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. Diabetes Care, 47(Suppl. 1), S1–S321.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk lanjut usia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bandiyah, S. (2009). *Lanjut usia dan keperawatan gerontik*. Nuha Medika.
- Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper,

- C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinkova, E., Vandewoude, M., Visser, M., & Zamboni, M. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31. doi: 10.1093/ageing/afy169
- Darmojo, R. B., & Martono, H. H. (2015). *Buku ajar geriatri: Ilmu kesehatan usia lanjut* (Edisi 5). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Eliopoulos, C. (2018). *Gerontological nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Halter, J. B., Ouslander, J. G., Studenski, S., High, K. P., Asthana, S., Supiano, M. A., & Ritchie, C. (Eds.). (2017). *Hazzard's geriatric medicine and gerontology* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2019). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. *Osteoporosis International*, 30(1), 3–44. doi: 10.1007/s00198-018-4704-5
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2016–2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mauk, K. L. (2018). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Meiner, S. E., & Yeager, J. J. (2019). *Gerontologic nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Miller, C. A. (2019). *Nursing for wellness in older adults* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., ... Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: A global initiative. *Age and Ageing*, 51(9), afac205. doi: 10.1093/ageing/afac205
- National Institute for Health and Care Excellence. (2019). *Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: Management* (NICE Guideline No. 123). National Institute for Health and Care Excellence.
- Nugroho, W. (2008). *Keperawatan gerontik dan geriatrik* (Edisi 3). EGC.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.

- Santini, Z. I., Jose, P. E., Cornwell, E. Y., Koyanagi, A., Nielsen, L., Hinrichsen, C., Meilstrup, C., Madsen, K. R., & Koushede, V. (2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans. *The Lancet Public Health*, 5(1), e62–e70. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30230-0
- Stanley, M., & Beare, P. G. (2007). *Buku ajar keperawatan gerontik* (Edisi 2). EGC.
- Steptoe, A., Shankar, A., Demakakos, P., & Wardle, J. (2013). Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(15), 5797–5801. doi: 10.1073/pnas.1219686110
- Tamher, S., & Noorkasiani. (2009). *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. Salemba Medika.
- The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society Advisory Panel. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 29(7), 767–794. doi: 10.1097/GME.0000000000002028
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2020). *Ebersole & Hess' gerontological nursing & healthy aging* (5th ed.). Elsevier.
- Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., Ramirez, A., Schlaich, M., Stergiou, G. S., Tomaszewski, M., Wainford, R. D., Williams, B., & Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Hypertension*, 75(6), 1334–1357. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026
- Valtorta, N. K., Kanaan, M., Gilbody, S., Ronzi, S., & Hanratty, B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: Systematic review and meta-analysis. *Heart*, 102(13), 1009–1016. doi: 10.1136/heartjnl-2015-308790
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021a). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021b). *Global report on ageism*. World Health Organization.

N. Glosarium

- **Perempuan Lansia**

Perempuan yang telah memasuki tahap lanjut usia dan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta fungsional akibat proses penuaan.

- **Penuaan**

Proses alami yang terjadi secara bertahap sepanjang kehidupan dan ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, daya tahan, metabolisme, serta kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap perubahan.

- **Menopause**

Masa berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dan produksi hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron.

- **Pascamenopause**

Masa setelah menopause yang ditandai dengan penyesuaian tubuh terhadap kadar estrogen yang rendah dan dapat memengaruhi kesehatan tulang, kulit, pembuluh darah, sistem urogenital, serta suasana hati.

- **Estrogen**

Hormon utama pada perempuan yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, elastisitas pembuluh darah, kelembapan jaringan urogenital, kesehatan kulit, dan kestabilan suasana hati.

- **Osteoporosis**

Kondisi menurunnya kepadatan dan kekuatan tulang sehingga tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah mengalami patah tulang, terutama pada perempuan lansia setelah menopause.

- **Fraktur**

Patah tulang yang dapat terjadi akibat benturan, jatuh, atau tekanan ringan pada tulang yang rapuh, terutama pada lansia dengan osteoporosis.

- **Osteoarthritis**

Penyakit sendi degeneratif yang terjadi akibat kerusakan tulang rawan sendi secara perlahan sehingga menimbulkan nyeri, kaku, bengkak, dan keterbatasan gerak.

- **Hipertensi**

Kondisi tekanan darah yang berada di atas batas normal secara menetap dan dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, serta gangguan pembuluh darah.

- **Diabetes Melitus**

Penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau kombinasi keduanya.

- **Penyakit Degeneratif**

Penyakit yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ tubuh, proses penuaan, perubahan metabolisme, dan gaya hidup, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, dan osteoarthritis.

- **Malnutrisi**

Kondisi ketika tubuh tidak memperoleh zat gizi yang cukup atau tidak mendapatkan zat gizi secara seimbang, sehingga dapat menyebabkan kelemahan, penurunan daya tahan tubuh, anemia, dan penurunan kualitas hidup.

- **Anemia**

Kondisi ketika kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah berada di bawah normal sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun dan menyebabkan lemah, pucat, pusing, serta cepat lelah.

- **Inkontinensia Urine**

Kondisi keluarnya urine secara tidak sengaja atau sulit dikontrol, yang sering terjadi pada perempuan lansia akibat melemahnya otot dasar panggul, perubahan hormon, riwayat persalinan, atau penyakit tertentu.

- **Pendekatan Holistik**

Pendekatan pelayanan kesehatan yang memandang perempuan lansia sebagai individu utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan.

CHAPTER 4

PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM MENDUKUNG PEREMPUAN LANSIA

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Perempuan lansia merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan pendampingan secara menyeluruh. Memasuki masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, spiritual, dan kualitas hidup. Pada fase ini, perempuan lansia dapat menghadapi penurunan fungsi tubuh, perubahan peran dalam keluarga, berkurangnya aktivitas sosial, penyakit kronis, serta kebutuhan emosional yang semakin besar. Oleh karena itu, dukungan keluarga dan komunitas menjadi sangat penting agar perempuan lansia tetap dapat menjalani kehidupan secara sehat, aman, nyaman, mandiri sesuai kemampuan, dan bermartabat.

Dukungan keluarga memiliki peranan utama karena keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi perempuan lansia. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi pihak yang paling sering berinteraksi dengan lansia, memahami kebiasaan lansia, mengetahui perubahan kondisi lansia, serta memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan secara langsung. Dukungan keluarga tidak hanya berbentuk bantuan fisik, seperti menyediakan makanan, membantu aktivitas harian, atau mendampingi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga mencakup dukungan emosional, sosial, spiritual, dan penghargaan terhadap martabat lansia. Perempuan lansia yang merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai oleh keluarganya cenderung memiliki semangat hidup yang lebih baik serta lebih mampu menerima perubahan yang terjadi pada dirinya.

Selain keluarga, komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung perempuan lansia. Komunitas merupakan lingkungan sosial yang dapat membantu lansia tetap merasa terhubung dengan masyarakat. Kegiatan komunitas, seperti posyandu lansia, senam lansia, kelompok keagamaan, kegiatan sosial, pengajian, arisan, kelompok keterampilan, atau kegiatan masyarakat lainnya, dapat menjadi ruang bagi perempuan lansia untuk tetap aktif, berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memperoleh informasi kesehatan. Keterlibatan dalam komunitas dapat

mencegah lansia merasa terasing, mengurangi kesepian, serta meningkatkan rasa bermakna dalam kehidupan. Dengan demikian, dukungan komunitas menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan psikologis perempuan lansia.

Pentingnya dukungan keluarga dan komunitas semakin terlihat karena perempuan lansia merupakan kelompok yang mengalami perubahan fisik secara bertahap. Proses penuaan dapat menyebabkan kekuatan otot menurun, tulang menjadi lebih rapuh, sendi mudah nyeri, daya tahan tubuh berkurang, penglihatan dan pendengaran menurun, serta keseimbangan tubuh tidak sebaik sebelumnya. Perubahan fisik ini dapat membuat perempuan lansia lebih sulit melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan jauh, naik turun tangga, memasak, membersihkan rumah, mandi, berpakaian, atau pergi ke fasilitas kesehatan. Jika tidak didukung dengan baik, penurunan fungsi fisik dapat menyebabkan lansia semakin bergantung pada orang lain dan kehilangan rasa percaya diri.

Perubahan fisik pada perempuan lansia juga sering berkaitan dengan masalah kesehatan kronis. Hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, nyeri sendi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan tidur, dan inkontinensia urine merupakan beberapa masalah yang sering dialami pada masa lanjut usia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan, mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup. Dalam situasi ini, keluarga berperan membantu memantau kondisi kesehatan lansia, mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi kontrol kesehatan, memperhatikan pola makan, serta membantu menciptakan lingkungan rumah yang aman. Komunitas dan tenaga kesehatan juga dapat berperan melalui kegiatan pemeriksaan rutin, edukasi kesehatan, dan pemantauan lansia di lingkungan masyarakat.

Selain perubahan fisik, perempuan lansia juga mengalami perubahan psikologis. Perubahan tubuh, munculnya penyakit kronis, berkurangnya kemampuan beraktivitas, kehilangan pasangan, anak yang tinggal terpisah, serta perubahan peran dalam keluarga dapat memengaruhi emosi dan konsep diri lansia. Perempuan lansia dapat merasa cemas, sedih, mudah tersinggung, kesepian, atau merasa tidak lagi dibutuhkan. Sebagian lansia mungkin merasa menjadi beban keluarga ketika mulai membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Perasaan seperti ini perlu dipahami dengan empati, karena jika dibiarkan dapat menurunkan motivasi lansia dalam merawat diri dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Dukungan emosional dari keluarga sangat penting untuk membantu perempuan lansia menghadapi perubahan psikologis tersebut. Keluarga perlu menyediakan waktu untuk berbicara dengan lansia, mendengarkan keluhannya,

menghargai pendapatnya, dan memberikan rasa aman. Komunikasi yang sabar, hangat, dan tidak menghakimi dapat membantu lansia merasa tetap dihargai sebagai bagian penting dari keluarga. Lansia tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak mampu berpikir atau tidak memiliki hak untuk menyampaikan keinginan. Sebaliknya, perempuan lansia perlu tetap dilibatkan dalam percakapan keluarga, pengambilan keputusan sederhana, dan kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Perubahan sosial juga menjadi tantangan besar bagi perempuan lansia. Pada masa dewasa, banyak perempuan memiliki peran yang luas, seperti menjadi ibu, istri, pengasuh anak, pengelola rumah tangga, pekerja, atau anggota masyarakat yang aktif. Ketika memasuki usia lanjut, peran tersebut dapat berubah. Anak-anak mungkin sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, pasangan mungkin telah meninggal, aktivitas sosial berkurang, dan kemampuan fisik mulai terbatas. Perubahan ini dapat menimbulkan rasa kehilangan peran. Perempuan lansia yang sebelumnya terbiasa aktif dan dibutuhkan dapat merasa hidupnya menjadi sepi atau kurang bermakna ketika tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan keluarga dan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, keluarga dan komunitas perlu membantu perempuan lansia tetap memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan. Peran tersebut tidak harus berat atau formal. Lansia dapat tetap berperan sebagai pemberi nasihat, penjaga nilai keluarga, pendamping cucu, peserta kegiatan keagamaan, anggota kelompok lansia, atau sumber pengalaman bagi generasi muda. Ketika lansia masih diberi kesempatan untuk berkontribusi, ia akan merasa hidupnya tetap bermakna. Perasaan bermakna sangat penting bagi kesehatan mental perempuan lansia karena dapat meningkatkan harga diri, semangat hidup, dan penerimaan terhadap proses penuaan.

Aspek spiritual juga menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual sering meningkat karena lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, pengalaman masa lalu, rasa syukur, kematian, dan hubungan dengan Tuhan. Dukungan spiritual dari keluarga dan komunitas dapat membantu lansia merasa lebih tenang, kuat, dan mampu menerima perubahan hidup. Keluarga dapat memfasilitasi lansia untuk beribadah, membaca kitab suci, berdoa, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Komunitas keagamaan juga dapat menjadi sumber dukungan sosial dan emosional yang sangat berarti, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau kehilangan pasangan.

Proses penuaan dan menopause merupakan dua hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perempuan lansia. Penuaan menyebabkan penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap, sedangkan menopause

menyebabkan perubahan hormonal, terutama penurunan hormon estrogen. Penurunan estrogen dapat meningkatkan risiko osteoporosis, gangguan urogenital, perubahan kulit, perubahan suasana hati, serta peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Dampak perubahan ini dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas hidup perempuan lansia. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami bahwa keluhan lansia, seperti nyeri sendi, sulit tidur, mudah lelah, sering buang air kecil, atau perubahan emosi, tidak boleh selalu dianggap sebagai keluhan biasa yang tidak perlu diperhatikan.

Penyakit kronis juga menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas hidup perempuan lansia. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoarthritis, dan osteoporosis membutuhkan pengelolaan jangka panjang. Apabila tidak dikendalikan, penyakit kronis dapat menyebabkan komplikasi, keterbatasan aktivitas, ketergantungan, dan penurunan rasa percaya diri. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu lansia menjalani pengobatan secara teratur, menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik ringan, serta memantau tanda-tanda bahaya. Komunitas juga dapat membantu dengan menyediakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi penyakit kronis, serta dukungan sosial bagi lansia yang membutuhkan pendampingan.

Kesepian merupakan masalah yang sering dialami perempuan lansia dan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental. Kesepian dapat terjadi karena kehilangan pasangan, anak-anak tinggal jauh, berkurangnya teman sebaya, keterbatasan mobilitas, gangguan pendengaran, atau kurangnya keterlibatan sosial. Lansia yang merasa kesepian dapat kehilangan minat untuk beraktivitas, mengalami gangguan tidur, menurunkan nafsu makan, mudah sedih, atau menarik diri dari lingkungan. Kesepian yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko depresi. Oleh karena itu, keluarga perlu menjaga komunikasi yang rutin dan bermakna dengan perempuan lansia, sedangkan komunitas perlu menyediakan ruang interaksi sosial yang ramah dan mudah diakses.

Perubahan peran dalam keluarga juga dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan lansia. Jika sebelumnya lansia memiliki peran besar dalam mengurus keluarga, maka pada usia lanjut ia mungkin merasa tidak lagi memiliki fungsi yang sama. Perasaan tidak dibutuhkan dapat muncul apabila keluarga tidak melibatkan lansia dalam kegiatan rumah tangga atau keputusan sederhana. Padahal, keterlibatan lansia dalam keluarga sangat penting untuk menjaga harga diri dan rasa bermakna. Keluarga sebaiknya tidak hanya melihat perempuan lansia sebagai orang yang perlu dirawat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pengalaman, nilai, kebijaksanaan, dan hak untuk tetap berperan.

Kualitas hidup perempuan lansia sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Lansia yang memiliki penyakit kronis tetap dapat memiliki kualitas hidup yang baik apabila penyakitnya terkontrol, mendapat dukungan keluarga, memiliki lingkungan yang aman, dan tetap dapat berinteraksi dengan komunitas. Sebaliknya, lansia yang secara fisik tidak memiliki keluhan berat dapat mengalami kualitas hidup yang rendah apabila merasa kesepian, tidak dihargai, tidak memiliki kegiatan, atau kehilangan makna hidup. Oleh sebab itu, dukungan terhadap perempuan lansia tidak boleh hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, spiritual, dan lingkungan.

Lingkungan keluarga yang aman, suportif, dan ramah lansia sangat dibutuhkan untuk mencegah cedera dan meningkatkan kenyamanan hidup. Rumah perlu ditata agar mengurangi risiko jatuh, misalnya dengan memastikan lantai tidak licin, pencahayaan cukup, barang tidak berserakan, kamar mandi aman, dan alat bantu tersedia bila diperlukan. Keluarga juga perlu memperhatikan kebutuhan dasar lansia, seperti makanan bergizi, obat-obatan, kebersihan diri, istirahat, dan kesempatan bergerak. Namun, bantuan yang diberikan harus tetap menghormati kemandirian lansia. Lansia sebaiknya tetap diberi kesempatan melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan agar tidak kehilangan rasa percaya diri.

Komunitas yang ramah lansia juga memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan perempuan lansia. Komunitas yang ramah lansia adalah komunitas yang menghargai keberadaan lansia, menyediakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan lansia, serta tidak memberikan stigma atau diskriminasi. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kegiatan spiritual, dan kelompok sosial dapat membantu perempuan lansia tetap aktif. Selain itu, komunitas dapat membantu mengidentifikasi lansia yang hidup sendiri, mengalami penelantaran, memiliki keterbatasan fisik, atau membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan.

Dukungan komunitas juga dapat membantu keluarga dalam merawat perempuan lansia. Tidak semua keluarga memiliki pengetahuan, waktu, atau kemampuan yang cukup untuk memberikan pendampingan optimal. Kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tetangga, dan relawan dapat membantu memberikan perhatian, informasi, serta dukungan sosial. Kolaborasi antara keluarga dan komunitas dapat menciptakan sistem pendukung yang lebih kuat. Dengan adanya dukungan bersama, perempuan lansia tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memperoleh perhatian dari lingkungan yang lebih luas.

Tujuan pembahasan bab ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan perempuan lansia. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami bahwa perempuan lansia memiliki kebutuhan yang kompleks dan saling berkaitan. Mereka membutuhkan dukungan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan lingkungan yang aman. Dengan pemahaman tersebut, keluarga diharapkan mampu memberikan pendampingan yang lebih sabar, empatik, dan menghargai martabat lansia. Komunitas juga diharapkan mampu menyediakan lingkungan sosial yang inklusif, peduli, dan ramah lansia.

dukungan keluarga dan komunitas merupakan faktor penting dalam membantu perempuan lansia menjalani masa tua secara sehat, aman, mandiri, bermartabat, dan bermakna. Keluarga berperan sebagai sumber dukungan terdekat, sedangkan komunitas berperan sebagai ruang sosial yang membantu lansia tetap terhubung dengan lingkungan. Proses penuaan, menopause, penyakit kronis, kesepian, dan perubahan peran dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan lansia, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui dukungan yang tepat. Lingkungan yang aman, suportif, dan ramah lansia akan membantu perempuan lansia mempertahankan kesehatan, harga diri, kemandirian, serta rasa bermakna dalam kehidupan.

B. Konsep Dasar Perempuan Lansia dalam Keluarga dan Komunitas

Perempuan lansia merupakan perempuan yang telah memasuki tahap lanjut usia dan mengalami berbagai perubahan sebagai bagian dari proses penuaan. Secara umum, lansia sering dipahami sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Namun, pengertian perempuan lansia tidak hanya dapat dilihat dari angka usia saja, karena kondisi setiap individu pada masa lanjut usia sangat beragam. Ada perempuan lansia yang masih mampu beraktivitas secara mandiri, mengikuti kegiatan sosial, mengambil keputusan sendiri, dan menjalankan perannya dalam keluarga. Sebaliknya, ada pula perempuan lansia yang mulai mengalami keterbatasan fisik, penyakit kronis, gangguan penglihatan, penurunan pendengaran, gangguan mobilitas, kesepian, atau ketergantungan terhadap keluarga. Oleh karena itu, perempuan lansia perlu dipahami tidak hanya berdasarkan usia kronologis, tetapi juga berdasarkan kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kemampuan fungsionalnya.

Berdasarkan tahapan usia lanjut, perempuan lansia dapat berada pada tahap lansia awal, lansia madya, atau lansia tua. Pada tahap lansia awal, sebagian perempuan masih memiliki kemampuan fisik yang cukup baik, masih aktif dalam kegiatan keluarga, pekerjaan ringan, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan

masyarakat. Pada tahap ini, dukungan keluarga dan komunitas lebih diarahkan untuk mempertahankan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjaga agar perempuan lansia tetap aktif. Pada tahap usia yang lebih lanjut, kemampuan tubuh biasanya semakin menurun sehingga kebutuhan bantuan dan pendampingan menjadi lebih besar. Perempuan lansia mungkin mulai membutuhkan bantuan untuk berjalan, mengelola obat, melakukan pemeriksaan kesehatan, memenuhi kebutuhan nutrisi, atau menjaga keamanan di rumah. Dengan memahami tahapan usia lanjut ini, keluarga dan komunitas dapat memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perempuan lansia.

Karakteristik perempuan lansia dapat dilihat dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara fisik, perempuan lansia mengalami penurunan fungsi tubuh secara bertahap akibat proses penuaan. Kekuatan otot dapat berkurang, tulang menjadi lebih rapuh, sendi mudah nyeri, kulit menjadi lebih kering, rambut memutih atau menipis, serta penglihatan dan pendengaran dapat menurun. Pada perempuan, perubahan fisik ini juga dipengaruhi oleh menopause dan penurunan hormon estrogen. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko osteoporosis, gangguan urogenital, perubahan kulit, gangguan tidur, serta penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung. Perubahan fisik ini dapat memengaruhi kemampuan perempuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga keluarga dan komunitas perlu memahami bahwa lansia membutuhkan dukungan tanpa menghilangkan kemandiriannya.

Secara psikologis, perempuan lansia dapat mengalami perubahan dalam cara memandang diri, menerima proses penuaan, dan menghadapi perubahan hidup. Perubahan penampilan, penurunan kemampuan fisik, penyakit kronis, kehilangan pasangan, anak-anak yang telah mandiri, atau berkurangnya peran dalam keluarga dapat memengaruhi konsep diri perempuan lansia. Sebagian perempuan lansia dapat menerima masa tua sebagai bagian alami dari kehidupan dan tetap merasa dirinya bermakna. Namun, sebagian lainnya dapat merasa cemas, sedih, kesepian, mudah tersinggung, kurang percaya diri, atau merasa tidak lagi dibutuhkan. Kondisi psikologis ini perlu dipahami oleh keluarga dan komunitas agar perempuan lansia tidak hanya dibantu secara fisik, tetapi juga didukung secara emosional. Dukungan berupa perhatian, komunikasi yang hangat, penghargaan, dan kesempatan untuk bercerita dapat membantu perempuan lansia merasa aman dan dihargai.

Secara sosial, perempuan lansia memiliki hubungan yang erat dengan keluarga dan komunitas. Sepanjang hidupnya, banyak perempuan memiliki peran penting sebagai ibu, istri, nenek, pengasuh, pengelola rumah tangga, pekerja, anggota organisasi, atau bagian aktif dari masyarakat. Ketika memasuki masa

lanjut usia, peran-peran tersebut dapat berubah. Anak-anak mungkin telah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, pasangan mungkin telah meninggal, aktivitas fisik mulai terbatas, dan keterlibatan dalam masyarakat dapat berkurang. Perubahan sosial ini dapat menimbulkan rasa kehilangan apabila perempuan lansia merasa tidak lagi dilibatkan dalam keluarga atau lingkungan. Oleh karena itu, keluarga dan komunitas perlu tetap memberikan ruang bagi perempuan lansia untuk berpartisipasi sesuai kemampuan, misalnya dalam percakapan keluarga, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, atau kegiatan ringan yang membuat lansia merasa tetap memiliki peran.

Secara spiritual, perempuan lansia umumnya memiliki kebutuhan yang semakin kuat untuk memperoleh ketenangan batin, makna hidup, dan kedekatan dengan Tuhan. Pada masa lanjut usia, perempuan sering lebih banyak merenungkan perjalanan hidup, pengalaman masa lalu, rasa syukur, kematian, serta hubungan dengan keluarga dan Sang Pencipta. Kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, membaca kitab suci, mengikuti pengajian, kebaktian, atau kegiatan keagamaan lainnya dapat memberikan ketenangan dan kekuatan bagi perempuan lansia. Dukungan keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan spiritual sangat penting karena spiritualitas dapat membantu lansia menerima perubahan, mengurangi kecemasan, menghadapi kehilangan, serta mempertahankan harapan dan makna hidup.

Perubahan peran perempuan lansia dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada masa dewasa, perempuan sering menjadi pusat pengasuhan dan pengelolaan keluarga. Ia berperan sebagai ibu yang membesarkan anak, istri yang mendampingi pasangan, pengasuh yang menjaga anggota keluarga, dan pengelola rumah tangga yang memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Ketika memasuki usia lanjut, sebagian peran tersebut dapat berkurang atau berubah. Anak-anak yang dahulu diasuh kini telah mandiri, pasangan mungkin membutuhkan perawatan atau telah meninggal, dan kemampuan fisik perempuan lansia mungkin tidak lagi sekuat sebelumnya. Perubahan ini dapat menimbulkan perasaan kehilangan, terutama bila keluarga tidak lagi melibatkan perempuan lansia dalam kegiatan atau keputusan keluarga.

Sebagai ibu, perempuan lansia tetap memiliki nilai penting dalam keluarga meskipun anak-anaknya telah dewasa. Ia dapat menjadi sumber nasihat, pengalaman, nilai moral, dan dukungan emosional bagi anak-anaknya. Sebagai nenek, perempuan lansia dapat memiliki hubungan yang hangat dengan cucu dan berperan dalam menanamkan nilai keluarga, memberi kasih sayang, serta menjadi figur yang dihormati. Namun, peran sebagai nenek juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan lansia. Perempuan lansia dapat membantu mengasuh cucu

sesuai kemampuan, tetapi tidak seharusnya dibebani tanggung jawab yang terlalu berat hingga mengganggu kesehatannya. Keluarga perlu memahami batas kemampuan lansia agar peran yang diberikan tetap menjadi sumber kebahagiaan, bukan beban.

Sebagai pasangan, perempuan lansia juga mengalami perubahan peran. Bila masih memiliki pasangan, hubungan pada masa lanjut usia sering berfokus pada saling menemani, saling merawat, dan memberi dukungan emosional. Namun, jika pasangan mengalami sakit kronis, perempuan lansia dapat berperan sebagai caregiver meskipun dirinya juga mengalami proses penuaan. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional. Sebaliknya, jika pasangan telah meninggal, perempuan lansia dapat mengalami kesepian dan kehilangan sumber dukungan utama. Oleh karena itu, keluarga dan komunitas perlu memberi perhatian kepada perempuan lansia yang hidup sendiri atau kehilangan pasangan agar mereka tidak merasa terabaikan.

Dalam beberapa keluarga, perempuan lansia juga menjadi anggota keluarga yang membutuhkan pendampingan. Pendampingan ini dapat berupa bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, mandi, berpakaian, berjalan, menggunakan toilet, minum obat, atau pergi ke fasilitas kesehatan. Namun, pendampingan harus dilakukan dengan tetap menghargai kemandirian dan martabat lansia. Perempuan lansia tidak boleh diperlakukan seolah-olah tidak mampu melakukan apa pun. Selama masih memungkinkan, ia perlu diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang masih dapat dilakukan sendiri. Pendampingan yang baik adalah pendampingan yang membantu ketika diperlukan, tetapi tetap memberi ruang bagi lansia untuk mempertahankan rasa percaya diri dan harga dirinya.

Kedudukan perempuan lansia dalam komunitas dan masyarakat juga sangat penting. Dalam banyak budaya, perempuan lansia dipandang sebagai sosok yang memiliki pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Mereka dapat menjadi tokoh informal dalam keluarga dan masyarakat, menjadi penasihat, penggerak kegiatan keagamaan, anggota kelompok sosial, atau panutan bagi perempuan yang lebih muda. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perempuan lansia mendapatkan penghargaan yang layak. Sebagian lansia dapat mengalami stigma karena dianggap tidak produktif, lambat, lemah, merepotkan, atau tidak lagi memiliki kontribusi. Pandangan seperti ini dapat menurunkan harga diri dan menyebabkan perempuan lansia menarik diri dari kehidupan sosial.

Komunitas yang baik adalah komunitas yang memberikan ruang bagi perempuan lansia untuk tetap terlibat. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam

lansia, pengajian, arisan, kelompok keterampilan, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan dapat membantu perempuan lansia tetap aktif dan merasa menjadi bagian dari masyarakat. Keterlibatan dalam komunitas dapat mengurangi kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, memperluas hubungan sosial, dan membantu lansia memperoleh informasi kesehatan. Komunitas juga dapat menjadi tempat untuk mendeteksi lebih awal lansia yang mengalami masalah, seperti hidup sendiri, mengalami penelantaran, mengalami kesulitan ekonomi, atau membutuhkan bantuan kesehatan.

Perempuan lansia memiliki kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Kebutuhan fisik mencakup makanan bergizi, istirahat cukup, aktivitas fisik yang aman, kebersihan diri, pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta lingkungan rumah yang aman. Kebutuhan psikologis mencakup rasa aman, rasa dicintai, dihargai, didengarkan, dan tidak merasa menjadi beban. Kebutuhan sosial mencakup kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, tetangga, dan komunitas. Kebutuhan spiritual mencakup kesempatan untuk beribadah dan memperoleh ketenangan batin. Selain itu, perempuan lansia juga membutuhkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan.

Pemenuhan kebutuhan dasar perempuan lansia tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak. Keluarga memiliki peran utama karena menjadi lingkungan terdekat, tetapi komunitas juga memiliki peran besar dalam mendukung lansia tetap aktif, terhubung, dan memperoleh perhatian. Tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan dapat membantu keluarga dalam memberikan edukasi, pemantauan kesehatan, kegiatan sosial, serta dukungan emosional. Kolaborasi antara keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat dan ramah lansia. Dengan adanya dukungan tersebut, perempuan lansia tidak hanya mendapatkan bantuan ketika sakit, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk hidup lebih bermakna.

Penghormatan terhadap martabat perempuan lansia merupakan prinsip dasar dalam memberikan dukungan. Martabat berarti perempuan lansia tetap dipandang sebagai manusia yang bernilai, memiliki hak, pengalaman, pendapat, dan pilihan hidup. Usia lanjut tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan, mengabaikan, atau mengambil alih seluruh keputusan lansia. Perempuan lansia perlu tetap diajak berbicara, didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut dirinya, dan diperlakukan dengan sopan. Bantuan yang diberikan keluarga atau komunitas harus dilakukan dengan cara yang menghargai, bukan dengan memaksa, membentak, mempermalukan, atau menganggap lansia tidak mampu memahami keadaan.

Pengalaman hidup perempuan lansia juga perlu dihargai. Banyak perempuan lansia telah melalui perjalanan hidup panjang, menghadapi berbagai tantangan, membesarkan keluarga, bekerja, merawat orang lain, dan berkontribusi dalam masyarakat. Pengalaman tersebut merupakan sumber pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan yang berharga. Keluarga dan komunitas dapat menunjukkan penghargaan dengan memberi ruang bagi lansia untuk bercerita, berbagi pengalaman, memberikan nasihat, atau terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Ketika pengalaman lansia dihargai, mereka akan merasa hidupnya tetap bermakna dan tidak tersisih dari keluarga maupun masyarakat.

Hak perempuan lansia juga harus diperhatikan. Perempuan lansia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan, rasa aman, dukungan sosial, kesempatan berpartisipasi, informasi yang mudah dipahami, serta perlakuan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga memiliki hak untuk menentukan pilihan yang berkaitan dengan dirinya selama masih mampu mengambil keputusan. Dalam keluarga, hak ini dapat diwujudkan dengan melibatkan lansia dalam keputusan mengenai perawatan, makanan, aktivitas, tempat tinggal, atau pengobatan. Dalam komunitas, hak ini dapat diwujudkan melalui akses terhadap kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang ramah lansia.

konsep dasar perempuan lansia dalam keluarga dan komunitas mencakup pemahaman mengenai tahapan usia lanjut, karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, perubahan peran dalam keluarga, kedudukan dalam masyarakat, kebutuhan dasar, serta pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak lansia. Perempuan lansia tidak hanya perlu dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pengalaman, nilai, potensi, dan peran penting. Keluarga dan komunitas memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, menghargai, dan ramah lansia agar perempuan lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, bermartabat, dan bermakna.

C. Kebutuhan Perempuan Lansia yang Perlu Didukung Keluarga dan Komunitas

Perempuan lansia memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipahami dan dipenuhi secara menyeluruh oleh keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan psikologis, sosial, spiritual, keamanan, serta informasi kesehatan. Pada masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan akibat proses penuaan, menopause, penyakit kronis, perubahan peran dalam keluarga, serta berkurangnya kemampuan tubuh dalam beradaptasi. Kondisi

tersebut membuat perempuan lansia membutuhkan dukungan yang lebih terarah, sabar, dan berkesinambungan. Dukungan keluarga dan komunitas menjadi sangat penting agar perempuan lansia tetap dapat menjalani kehidupan dengan sehat, aman, nyaman, mandiri sesuai kemampuan, serta merasa dihargai sebagai individu yang bermartabat.

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi perempuan lansia. Kebutuhan ini mencakup pemenuhan nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, kebersihan diri, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan. Pada masa lanjut usia, tubuh mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Otot menjadi lebih lemah, tulang lebih rapuh, daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, dan risiko penyakit degeneratif meningkat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan fisik harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Perempuan lansia tidak dapat disamakan satu sama lain, karena ada yang masih aktif dan mandiri, tetapi ada pula yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pemenuhan nutrisi menjadi salah satu kebutuhan fisik utama. Perempuan lansia membutuhkan makanan yang bergizi seimbang agar tubuh tetap memiliki energi, daya tahan tubuh terjaga, massa otot tidak cepat menurun, tulang tetap kuat, dan penyakit kronis dapat lebih terkontrol. Asupan protein diperlukan untuk menjaga kekuatan otot dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium dan vitamin D penting untuk kesehatan tulang, terutama karena perempuan lansia setelah menopause memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi. Serat dibutuhkan untuk mencegah konstipasi, sedangkan cairan diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga fungsi organ tubuh. Keluarga dapat mendukung kebutuhan nutrisi dengan menyediakan makanan yang sesuai kondisi kesehatan lansia, memperhatikan tekstur makanan bila lansia mengalami gangguan gigi atau kesulitan mengunyah, serta menciptakan suasana makan yang nyaman dan tidak memaksa.

Kebutuhan istirahat juga harus diperhatikan. Perempuan lansia sering mengalami perubahan pola tidur, seperti sulit tidur, mudah terbangun pada malam hari, bangun terlalu pagi, atau merasa tidur tidak nyenyak. Gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh nyeri sendi, sering buang air kecil, kecemasan, penyakit kronis, efek obat, atau suasana lingkungan yang tidak nyaman. Kurang tidur dapat menyebabkan lansia mudah lelah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan berisiko jatuh. Keluarga dapat membantu dengan menciptakan lingkungan tidur yang tenang, bersih, pencahayaan cukup, suhu nyaman, dan aman bila lansia perlu berjalan ke kamar mandi pada malam hari. Rutinitas tidur yang teratur, aktivitas

ringan pada siang hari, serta dukungan emosional juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur perempuan lansia.

Aktivitas fisik merupakan kebutuhan penting yang sering kali kurang diperhatikan. Sebagian keluarga terlalu khawatir terhadap kondisi lansia sehingga membatasi aktivitasnya secara berlebihan. Padahal, kurang bergerak dapat mempercepat penurunan massa otot, membuat sendi semakin kaku, menurunkan keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh. Perempuan lansia tetap membutuhkan aktivitas fisik yang aman dan sesuai kemampuan, seperti berjalan santai, senam lansia, peregangan, latihan napas, berkebun ringan, atau aktivitas rumah tangga sederhana. Aktivitas fisik membantu menjaga kekuatan otot, memperlancar sirkulasi darah, mengontrol berat badan, meningkatkan suasana hati, serta mempertahankan kemandirian. Komunitas dapat mendukung kebutuhan ini melalui kegiatan senam lansia, jalan sehat, atau kelompok aktivitas fisik yang ramah lansia.

Kebersihan diri juga menjadi kebutuhan fisik yang sangat penting. Perempuan lansia perlu menjaga kebersihan tubuh, rambut, kulit, kuku, gigi dan mulut, serta area urogenital. Pada usia lanjut, kulit menjadi lebih tipis dan kering sehingga lebih mudah mengalami iritasi, luka, atau infeksi. Perempuan lansia yang mengalami inkontinensia urine membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kebersihan area genital agar tidak terjadi iritasi kulit atau infeksi saluran kemih. Keluarga dapat membantu bila lansia mengalami keterbatasan fisik, tetapi bantuan harus diberikan dengan tetap menjaga privasi dan martabat lansia. Bantuan dalam mandi, berpakaian, atau membersihkan diri tidak boleh dilakukan dengan sikap merendahkan, tergesa-gesa, atau membuat lansia merasa malu.

Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan fisik yang perlu didukung keluarga dan komunitas. Banyak perempuan lansia memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, atau nyeri sendi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Keluarga dapat membantu mengingatkan jadwal minum obat, memastikan obat diminum sesuai anjuran, mencatat keluhan setelah minum obat, serta mendampingi lansia kontrol ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan kesehatan rutin seperti tekanan darah, gula darah, berat badan, kesehatan mata, pendengaran, kesehatan tulang, dan fungsi ginjal penting dilakukan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Komunitas dapat membantu melalui posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi kesehatan, dan rujukan bila ditemukan masalah.

Selain kebutuhan fisik, perempuan lansia juga memiliki kebutuhan psikologis yang sangat penting. Perempuan lansia membutuhkan rasa aman, dihargai,

didengarkan, dicintai, dan tidak merasa menjadi beban. Pada masa lanjut usia, banyak perubahan yang dapat memengaruhi kondisi emosional, seperti penurunan kemampuan tubuh, penyakit kronis, kehilangan pasangan, anak-anak yang tinggal terpisah, perubahan peran dalam keluarga, atau berkurangnya aktivitas sosial. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemasan, kesepian, kesedihan, mudah tersinggung, atau perasaan tidak berguna. Oleh karena itu, keluarga perlu memberikan dukungan emosional yang hangat dan konsisten.

Rasa aman merupakan kebutuhan psikologis yang mendasar. Perempuan lansia perlu merasa bahwa dirinya tidak ditinggalkan, tidak diabaikan, dan tidak diperlakukan sebagai beban. Rasa aman dapat dibangun melalui kehadiran keluarga, komunikasi yang baik, perhatian terhadap kebutuhan sehari-hari, serta kepastian bahwa ada orang yang dapat membantu ketika dibutuhkan. Lansia yang merasa aman biasanya lebih tenang, lebih terbuka menyampaikan keluhan, dan lebih mudah menerima bantuan. Sebaliknya, lansia yang merasa tidak aman dapat menjadi cemas, menarik diri, atau menolak perawatan karena takut kehilangan kendali atas hidupnya.

Kebutuhan untuk dihargai dan didengarkan juga sangat penting. Perempuan lansia memiliki pengalaman hidup yang panjang, nilai, kebiasaan, dan pendapat yang tetap perlu dihormati. Keluarga tidak seharusnya mengambil semua keputusan tanpa melibatkan lansia, terutama keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Misalnya, keputusan tentang makanan, aktivitas, pengobatan, tempat tinggal, atau kegiatan sosial sebaiknya tetap melibatkan perempuan lansia selama ia masih mampu menyampaikan pendapat. Mendengarkan lansia bukan hanya berarti mendengar keluhannya, tetapi juga menghargai perasaan, pengalaman, dan keinginannya. Ketika lansia merasa didengarkan, harga diri dan rasa percaya dirinya akan lebih terjaga.

Perempuan lansia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa dicintai. Kasih sayang dapat ditunjukkan melalui perhatian sederhana, seperti menyapa, menanyakan kabar, menemani makan, mengajak berbicara, mendampingi berobat, atau melibatkan lansia dalam kegiatan keluarga. Banyak perempuan lansia tidak selalu membutuhkan bantuan yang besar, tetapi sangat membutuhkan perhatian yang tulus. Keluarga yang sibuk sering kali tidak menyadari bahwa kurangnya percakapan dan kebersamaan dapat membuat lansia merasa kesepian. Oleh karena itu, dukungan psikologis perlu diberikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika lansia sakit.

Kebutuhan sosial juga menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan lansia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, termasuk pada masa lanjut usia. Perempuan lansia membutuhkan

hubungan dengan keluarga, teman sebaya, tetangga, dan komunitas agar tetap merasa terhubung dengan lingkungan. Interaksi sosial membantu mencegah kesepian, mempertahankan fungsi kognitif, meningkatkan semangat hidup, dan memperkuat rasa bermakna. Perempuan lansia yang masih memiliki hubungan sosial yang baik biasanya lebih mampu menghadapi perubahan hidup dan lebih termotivasi menjaga kesehatan.

Interaksi dengan keluarga merupakan bentuk dukungan sosial yang paling dekat. Keluarga dapat mengajak lansia berbicara, makan bersama, menghadiri acara keluarga, atau melakukan aktivitas sederhana di rumah. Lansia sebaiknya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi tetap dilibatkan sebagai anggota keluarga yang memiliki peran. Interaksi dengan cucu, misalnya, dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi perempuan lansia. Namun, keluarga juga perlu memperhatikan agar lansia tidak dibebani tanggung jawab pengasuhan yang terlalu berat. Peran sosial dalam keluarga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan lansia.

Interaksi dengan teman sebaya dan tetangga juga penting. Teman sebaya sering kali memiliki pengalaman yang serupa, sehingga perempuan lansia dapat merasa lebih dipahami. Mereka dapat berbagi cerita tentang kesehatan, keluarga, kehilangan pasangan, atau pengalaman masa lalu. Tetangga juga dapat menjadi sumber dukungan, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau jauh dari anak. Lingkungan tetangga yang peduli dapat membantu mengenali jika lansia mengalami masalah, seperti sakit mendadak, jatuh, atau membutuhkan pertolongan. Komunitas yang aktif dan peduli dapat menjadi jembatan antara lansia, keluarga, dan pelayanan kesehatan.

Kebutuhan spiritual pada perempuan lansia juga perlu didukung. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual sering meningkat karena lansia mulai lebih banyak merenungkan makna hidup, kematian, rasa syukur, dan hubungan dengan Tuhan. Perempuan lansia membutuhkan kesempatan untuk beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan, membaca kitab suci, berdoa, atau menjalankan praktik spiritual sesuai keyakinannya. Kegiatan spiritual dapat memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, membantu menerima perubahan, serta memberi kekuatan dalam menghadapi penyakit atau kehilangan. Keluarga dan komunitas perlu memfasilitasi kebutuhan spiritual ini tanpa memaksakan keyakinan atau mengabaikan pilihan lansia.

Kegiatan keagamaan di komunitas dapat menjadi sumber dukungan spiritual sekaligus sosial. Pengajian, kebaktian, doa bersama, kelompok rohani, atau kegiatan keagamaan lainnya dapat membantu perempuan lansia tetap terhubung dengan lingkungan dan memperoleh ketenangan. Bagi lansia yang memiliki

keterbatasan mobilitas, keluarga dapat membantu menyediakan sarana ibadah di rumah, mendampingi kegiatan spiritual, atau membantu menghubungkan lansia dengan tokoh agama. Dukungan spiritual bukan hanya berkaitan dengan ibadah formal, tetapi juga dengan membantu lansia merasa damai, diterima, dan memiliki makna dalam menjalani masa tua.

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, risiko jatuh, cedera, kekerasan, penelantaran, dan ketidakamanan lingkungan dapat meningkat. Penurunan penglihatan, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, nyeri sendi, sering buang air kecil pada malam hari, serta penggunaan obat tertentu dapat meningkatkan risiko jatuh. Oleh karena itu, lingkungan rumah perlu ditata agar aman. Lantai sebaiknya tidak licin, pencahayaan cukup, barang tidak berserakan, kamar mandi dilengkapi pegangan bila memungkinkan, dan jalur menuju toilet mudah dijangkau. Alas kaki harus nyaman dan tidak mudah tergelincir. Jika diperlukan, alat bantu seperti tongkat atau walker dapat digunakan dengan arahan tenaga kesehatan.

Pencegahan jatuh tidak hanya dilakukan melalui penataan rumah, tetapi juga melalui pemeliharaan kondisi tubuh lansia. Perempuan lansia perlu didukung untuk tetap bergerak, melakukan latihan keseimbangan, memeriksakan mata dan pendengaran, serta mengelola penyakit kronis. Keluarga perlu mendampingi lansia ketika melakukan aktivitas yang berisiko, tetapi tidak boleh terlalu membatasi aktivitas hingga lansia menjadi semakin lemah. Komunitas juga dapat berperan dengan memberikan edukasi pencegahan jatuh, pemeriksaan risiko jatuh, dan kegiatan latihan fisik yang aman. Pencegahan jatuh penting karena jatuh dapat menyebabkan luka, fraktur, cedera kepala, ketakutan bergerak, dan penurunan kemandirian.

Perempuan lansia juga membutuhkan perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Kekerasan terhadap lansia dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, emosional, ekonomi, maupun penelantaran. Perempuan lansia yang mengalami ketergantungan fisik atau ekonomi dapat menjadi lebih rentan mengalami perlakuan tidak pantas. Kekerasan verbal seperti membentak, menghina, menyalahkan, atau mempermalukan lansia dapat melukai kondisi psikologisnya. Penelantaran dapat terjadi ketika kebutuhan makan, obat, kebersihan, keamanan, atau perhatian emosional lansia diabaikan. Keluarga dan komunitas perlu membangun kesadaran bahwa perempuan lansia memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, aman, dan bebas dari kekerasan.

Kebutuhan informasi kesehatan juga sangat penting bagi perempuan lansia. Informasi kesehatan yang mudah dipahami membantu lansia dan keluarga

mengenali perubahan tubuh, memahami penyakit, mengetahui cara minum obat, mengenali tanda bahaya, menerapkan pola hidup sehat, dan mencari pertolongan ketika diperlukan. Informasi yang diberikan kepada perempuan lansia harus menggunakan bahasa sederhana, jelas, tidak menakut-nakuti, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, serta kemampuan kognitifnya. Tenaga kesehatan, kader, dan komunitas dapat berperan dalam menyampaikan informasi melalui penyuluhan, posyandu lansia, kunjungan rumah, atau percakapan langsung.

Informasi kesehatan harus relevan dengan kondisi perempuan lansia. Misalnya, perempuan lansia dengan hipertensi perlu memahami pentingnya membatasi garam, memantau tekanan darah, minum obat teratur, dan mengenali tanda bahaya seperti nyeri dada atau sesak napas. Lansia dengan diabetes perlu memahami pengaturan makan, pemeriksaan gula darah, perawatan kaki, dan tanda luka yang perlu segera diperiksa. Lansia dengan risiko osteoporosis perlu memahami pentingnya kalsium, vitamin D, aktivitas fisik, dan pencegahan jatuh. Lansia dengan inkontinensia urine perlu diberi informasi bahwa keluhan tersebut dapat dibantu dan bukan sesuatu yang harus ditanggung sendiri.

Pemberian informasi kesehatan juga harus memperhatikan cara komunikasi. Perempuan lansia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi atau mengingat instruksi. Oleh karena itu, penjelasan perlu diberikan perlahan, dapat diulang, dan sebaiknya disertai contoh yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga dapat membantu mencatat informasi penting dari tenaga kesehatan, seperti jadwal obat, jadwal kontrol, makanan yang perlu dibatasi, atau tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Komunitas juga dapat membantu menyediakan media edukasi sederhana dan kegiatan penyuluhan yang ramah lansia.

kebutuhan perempuan lansia yang perlu didukung keluarga dan komunitas mencakup kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, keamanan, dan informasi kesehatan. Kebutuhan fisik meliputi nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, kebersihan diri, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan. Kebutuhan psikologis mencakup rasa aman, dihargai, didengarkan, dicintai, dan tidak merasa menjadi beban. Kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi bersama keluarga, teman sebaya, tetangga, dan komunitas. Kebutuhan spiritual membantu lansia memperoleh ketenangan batin dan makna hidup. Kebutuhan keamanan mencakup lingkungan yang aman, pencegahan jatuh, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Sementara itu, kebutuhan informasi kesehatan membantu perempuan lansia memahami kondisi dirinya dan menjalani perawatan secara lebih baik. Apabila keluarga dan komunitas mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara holistik, perempuan

lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aman, nyaman, bermartabat, dan bermakna.

D. Peran Keluarga dalam Memberikan Dukungan Emosional

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional kepada perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan yang dapat memengaruhi kondisi perasaan, rasa percaya diri, dan cara memandang dirinya sendiri. Perubahan fisik, munculnya penyakit kronis, penurunan kemampuan beraktivitas, kehilangan pasangan, anak-anak yang mulai hidup mandiri, serta berkurangnya peran dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai respons emosional. Perempuan lansia dapat merasa cemas, sedih, kesepian, mudah tersinggung, merasa tidak lagi dibutuhkan, atau takut menjadi beban keluarga. Dalam kondisi seperti ini, dukungan emosional dari keluarga menjadi sumber kekuatan utama agar lansia tetap merasa aman, dicintai, dihargai, dan memiliki makna dalam kehidupan.

Dukungan emosional keluarga dapat dimulai dari pemberian perhatian yang tulus. Perhatian tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk bantuan besar, tetapi dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Menanyakan kabar, menyapa dengan lembut, menemani makan, mengajak berbicara, mendengarkan cerita, atau sekadar duduk bersama dapat memberikan rasa nyaman bagi perempuan lansia. Banyak lansia tidak selalu mengungkapkan kebutuhannya secara langsung, tetapi mereka sangat merasakan ketika keluarga hadir dan peduli. Perhatian dari keluarga dapat membuat lansia merasa bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dalam keluarga dan tidak ditinggalkan.

Kasih sayang juga menjadi unsur penting dalam dukungan emosional. Perempuan lansia yang merasa dicintai oleh keluarganya cenderung lebih mudah menerima perubahan yang terjadi pada dirinya. Kasih sayang dapat ditunjukkan melalui ucapan yang lembut, sentuhan yang sopan, sikap sabar, serta kesediaan membantu tanpa membuat lansia merasa rendah diri. Pada usia lanjut, sebagian perempuan mungkin menjadi lebih sensitif karena merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu atau merasa perannya mulai berkurang. Oleh karena itu, sikap penuh kasih dari keluarga dapat membantu mengurangi rasa tidak aman dan memperkuat harga diri lansia.

Rasa aman merupakan kebutuhan emosional yang sangat penting bagi perempuan lansia. Rasa aman tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, seperti rumah yang tidak licin atau bebas dari risiko jatuh, tetapi juga berkaitan dengan keamanan emosional. Perempuan lansia perlu merasa bahwa keluarga akan tetap mendampingi, memperhatikan, dan tidak mengabaikannya ketika ia

membutuhkan bantuan. Lansia yang merasa aman biasanya lebih tenang dalam menjalani hari-hari, lebih terbuka menyampaikan keluhan, dan lebih mudah menerima dukungan. Sebaliknya, lansia yang merasa tidak aman dapat menjadi cemas, mudah curiga, menarik diri, atau menolak bantuan karena takut kehilangan kendali atas dirinya.

Salah satu bentuk dukungan emosional yang sangat penting adalah kemampuan keluarga untuk mendengarkan. Perempuan lansia sering memiliki banyak cerita, pengalaman, keluhan, dan kekhawatiran yang ingin disampaikan. Mereka mungkin ingin menceritakan masa lalu, mengulang cerita yang sama, menyampaikan keluhan fisik, atau mengungkapkan rasa takut terhadap penyakit dan masa depan. Keluarga perlu mendengarkan dengan sabar, tanpa terburu-buru memotong pembicaraan atau menganggap cerita lansia tidak penting. Bagi lansia, didengarkan berarti diakui keberadaannya. Ketika keluarga memberikan perhatian saat lansia berbicara, lansia akan merasa dihargai dan tidak merasa sendirian.

Mendengarkan keluhan perempuan lansia juga membutuhkan empati. Keluhan yang disampaikan lansia mungkin tampak sederhana bagi anggota keluarga yang lebih muda, tetapi bagi lansia keluhan tersebut dapat terasa berat. Misalnya, keluhan nyeri sendi, sulit tidur, sering buang air kecil, kehilangan nafsu makan, atau mudah lelah dapat memengaruhi kenyamanan hidupnya secara nyata. Keluarga sebaiknya tidak langsung mengatakan bahwa keluhan tersebut hanya akibat usia tua. Sikap seperti itu dapat membuat lansia merasa diabaikan. Sebaliknya, keluarga perlu menunjukkan bahwa keluhan tersebut dipahami dan akan dibantu untuk dicari penyebab maupun cara penanganannya.

Selain keluhan fisik, keluarga juga perlu mendengarkan perasaan dan kekhawatiran lansia. Perempuan lansia dapat merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan, biaya pengobatan, hubungan dengan anak-anak, kehilangan pasangan, atau kemungkinan menjadi beban keluarga. Kekhawatiran tersebut perlu diterima dengan penuh pengertian. Keluarga tidak harus selalu langsung memberikan solusi, karena sering kali yang dibutuhkan lansia adalah tempat untuk mencurahkan perasaan. Dengan mendengarkan secara sabar, keluarga membantu lansia melepaskan beban emosional yang mungkin selama ini dipendam.

Keluarga juga perlu menghargai pengalaman hidup perempuan lansia. Lansia memiliki perjalanan hidup yang panjang, penuh pengalaman, perjuangan, dan nilai-nilai yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Ketika lansia bercerita tentang masa lalu, keluarga sebaiknya tidak menganggapnya sebagai pengulangan yang membosankan. Cerita masa lalu dapat menjadi cara lansia mempertahankan identitas diri, mengingat peran yang pernah dijalani, dan merasa bahwa hidupnya memiliki arti. Memberi kesempatan kepada lansia untuk bercerita

dapat memperkuat rasa bermakna dan membantu menjaga kesehatan psikologisnya.

Dalam memberikan dukungan emosional, keluarga perlu menghindari sikap menyalahkan. Perempuan lansia yang mengalami keterbatasan fisik, lupa minum obat, sulit berjalan, atau membutuhkan bantuan dalam aktivitas tertentu tidak seharusnya disalahkan. Sikap menyalahkan dapat membuat lansia merasa bersalah, malu, dan semakin tidak percaya diri. Misalnya, ketika lansia terjatuh karena lantai licin, keluarga sebaiknya tidak langsung memarahi, tetapi perlu menenangkan, memeriksa kondisi lansia, dan mengevaluasi keamanan lingkungan rumah. Sikap yang menyalahkan hanya akan meningkatkan rasa takut dan membuat lansia enggan menyampaikan masalah yang dialami.

Keluarga juga perlu menghindari sikap meremehkan. Keluhan perempuan lansia sering kali dianggap biasa karena usia tua, padahal keluhan tersebut dapat menjadi tanda masalah kesehatan yang perlu ditangani. Ucapan seperti “itu biasa karena sudah tua” atau “jangan terlalu banyak mengeluh” dapat melukai perasaan lansia. Sikap meremehkan membuat lansia merasa tidak dipahami dan tidak dihargai. Dalam jangka panjang, lansia dapat memilih diam dan tidak lagi menyampaikan keluhan, sehingga masalah kesehatan atau psikologis yang dialami menjadi terlambat diketahui.

Membentak atau mempermalukan lansia juga harus dihindari. Perempuan lansia yang mulai lambat bergerak, sering lupa, sulit memahami instruksi, atau membutuhkan bantuan tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Bentakan dapat menimbulkan rasa takut, sedih, malu, dan menurunkan harga diri. Mempermalukan lansia di depan anggota keluarga lain atau orang luar juga dapat berdampak buruk terhadap kondisi emosionalnya. Lansia tetap memiliki martabat yang harus dihormati. Keluarga perlu menggunakan cara komunikasi yang lembut, jelas, dan sabar, terutama ketika memberikan arahan atau bantuan.

Perempuan lansia sering menghadapi kecemasan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan masa depan. Mereka mungkin takut penyakitnya memburuk, takut jatuh, takut tidak mampu berjalan, takut mengalami ketergantungan, atau takut tidak ada yang merawat ketika sakit. Keluarga dapat membantu menghadapi kecemasan tersebut dengan memberikan rasa tenang, menjelaskan bahwa lansia tidak sendirian, dan mendampingi dalam pemeriksaan kesehatan. Keluarga juga dapat membantu membuat rutinitas yang teratur, memastikan obat tersedia, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman. Kepastian dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi kecemasan lansia.

Kesepian juga menjadi masalah emosional yang sering dialami perempuan lansia. Kesepian dapat terjadi ketika pasangan telah meninggal, anak-anak tinggal terpisah, teman sebaya berkurang, atau lansia jarang diajak berinteraksi. Perempuan lansia yang tinggal bersama keluarga pun tetap dapat merasa kesepian apabila tidak ada komunikasi yang hangat. Keluarga dapat membantu mengurangi kesepian dengan meluangkan waktu untuk berbicara, mengajak lansia mengikuti kegiatan keluarga, mendampingi kegiatan keagamaan, atau menghubungkan lansia dengan teman sebaya dan komunitas. Kehadiran keluarga yang konsisten dapat membuat lansia merasa lebih terhubung dan tidak terasing.

Kehilangan pasangan merupakan pengalaman berat bagi perempuan lansia. Pasangan sering menjadi teman hidup, tempat berbagi cerita, sumber dukungan emosional, dan pendamping dalam aktivitas sehari-hari. Ketika pasangan meninggal, perempuan lansia dapat mengalami kesedihan mendalam, rasa hampa, dan kehilangan arah dalam rutinitas hidup. Keluarga perlu memberikan dukungan dengan cara yang sabar, tidak memaksa lansia segera melupakan kehilangan, dan memberi ruang bagi lansia untuk berduka. Mendengarkan cerita tentang pasangan yang telah tiada, menemani dalam masa-masa sulit, serta membantu lansia membangun rutinitas baru dapat menjadi bentuk dukungan emosional yang sangat berarti.

Perubahan peran juga dapat memengaruhi kondisi emosional perempuan lansia. Pada masa sebelumnya, perempuan mungkin memiliki peran besar sebagai ibu, istri, pengasuh, pengelola rumah tangga, pekerja, atau tokoh keluarga. Ketika memasuki masa lanjut usia, sebagian peran tersebut berkurang karena anak sudah mandiri, kemampuan fisik menurun, atau keluarga mengambil alih tanggung jawab tertentu. Perubahan ini dapat membuat lansia merasa tidak lagi dibutuhkan. Keluarga perlu membantu lansia menemukan peran baru yang sesuai dengan kemampuan, seperti memberi nasihat, mendampingi cucu, membantu pekerjaan ringan, atau terlibat dalam kegiatan keluarga. Peran yang sederhana tetap dapat memberi rasa bermakna.

Rasa tidak berdaya juga dapat muncul ketika perempuan lansia mulai mengalami keterbatasan fisik atau ketergantungan. Lansia yang dahulu mandiri mungkin merasa sedih ketika harus dibantu berjalan, mandi, berpakaian, atau minum obat. Keluarga perlu memberikan bantuan dengan cara yang tidak membuat lansia merasa lemah. Bantuan sebaiknya diberikan sesuai kebutuhan, sambil tetap memberi kesempatan kepada lansia untuk melakukan hal-hal yang masih mampu dilakukan. Dengan demikian, lansia tetap merasa memiliki kendali atas dirinya dan tidak kehilangan harga diri.

Motivasi dari keluarga sangat penting agar perempuan lansia tetap memiliki semangat hidup. Motivasi dapat diberikan melalui dukungan verbal, penghargaan terhadap usaha lansia, dan dorongan untuk tetap aktif sesuai kemampuan. Misalnya, keluarga dapat memuji lansia ketika ia bersedia berjalan pagi, mengikuti kegiatan posyandu lansia, menjaga pola makan, atau rutin minum obat. Pujian yang tulus dapat meningkatkan rasa percaya diri. Keluarga juga dapat mengajak lansia melakukan kegiatan bermakna, seperti merawat tanaman, memasak ringan, beribadah bersama, bercerita kepada cucu, atau mengikuti kegiatan komunitas. Kegiatan yang bermakna dapat membantu lansia merasa hidupnya tetap bernilai.

Rasa bermakna merupakan kebutuhan emosional yang sangat penting pada masa lanjut usia. Perempuan lansia perlu merasa bahwa keberadaannya masih memiliki arti bagi keluarga dan lingkungan. Jika lansia hanya dipandang sebagai orang yang harus dirawat, ia dapat merasa menjadi beban. Sebaliknya, jika keluarga tetap menghargai pengalaman, pendapat, dan perannya, lansia akan merasa lebih kuat secara emosional. Rasa bermakna dapat membantu lansia menghadapi penyakit, kehilangan, dan perubahan hidup dengan lebih tenang. Oleh karena itu, keluarga perlu menciptakan suasana yang membuat perempuan lansia merasa tetap dibutuhkan dan dihormati.

Komunikasi keluarga yang hangat merupakan dasar utama dukungan emosional. Komunikasi hangat ditandai dengan ucapan yang sopan, nada suara lembut, kesabaran, kontak mata yang baik, dan kesediaan mendengarkan. Keluarga perlu menghindari komunikasi yang kasar, tergesa-gesa, atau bernada memerintah. Perempuan lansia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi atau merespons pertanyaan. Oleh karena itu, keluarga perlu berbicara perlahan, menggunakan bahasa yang sederhana, dan memastikan lansia memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi yang baik akan membuat lansia merasa aman dan dihargai.

Komunikasi yang terbuka juga penting. Perempuan lansia perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keinginan, dan keluhannya tanpa takut dimarahi atau diabaikan. Keluarga dapat membangun komunikasi terbuka dengan bertanya secara lembut, misalnya tentang apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, atau kegiatan apa yang ingin dilakukan. Komunikasi terbuka membantu keluarga memahami kebutuhan lansia secara lebih tepat. Selain itu, komunikasi terbuka juga mencegah terjadinya kesalahpahaman antara lansia dan anggota keluarga lain.

Empati menjadi inti dalam komunikasi dengan perempuan lansia. Empati berarti keluarga berusaha memahami perasaan lansia dari sudut pandangnya. Lansia yang mudah tersinggung mungkin sebenarnya sedang merasa takut, nyeri, kesepian, atau tidak dihargai. Lansia yang sering mengulang cerita mungkin

sedang membutuhkan perhatian dan pengakuan. Lansia yang menolak bantuan mungkin sedang berusaha mempertahankan kemandiriannya. Dengan empati, keluarga tidak hanya melihat perilaku yang tampak, tetapi juga memahami perasaan di balik perilaku tersebut. Sikap empatik akan membantu keluarga memberikan respons yang lebih tepat dan tidak menyakiti lansia.

Menghargai martabat lansia harus menjadi prinsip utama dalam dukungan emosional. Perempuan lansia tetap memiliki hak, pengalaman, pilihan, dan harga diri. Usia lanjut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan lansia secara kasar, merendahkan, atau mengabaikan pendapatnya. Dalam setiap bentuk bantuan, keluarga perlu menjaga privasi dan menghormati pilihan lansia. Misalnya, saat membantu mandi atau berpakaian, keluarga perlu menjaga rasa malu lansia. Saat membicarakan pengobatan atau perawatan, lansia sebaiknya tetap dilibatkan dalam keputusan. Penghormatan terhadap martabat akan membuat perempuan lansia merasa tetap menjadi pribadi yang bernilai.

Dukungan emosional keluarga juga dapat mencegah gangguan psikologis yang lebih berat. Perempuan lansia yang merasa didukung cenderung lebih mampu menghadapi stres, lebih patuh terhadap pengobatan, lebih aktif secara sosial, dan lebih bersemangat menjaga kesehatan. Sebaliknya, kurangnya dukungan emosional dapat meningkatkan risiko kecemasan, kesepian, depresi, penurunan motivasi, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, dukungan emosional bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam menjaga kesehatan perempuan lansia secara menyeluruh.

peran keluarga dalam memberikan dukungan emosional kepada perempuan lansia mencakup pemberian perhatian, kasih sayang, rasa aman, kesediaan mendengarkan, komunikasi yang sabar, serta penghargaan terhadap martabat lansia. Keluarga perlu menghindari sikap menyalahkan, meremehkan, membentak, atau memperlakukan lansia karena hal tersebut dapat melukai perasaan dan menurunkan harga diri. Dukungan emosional juga diperlukan untuk membantu lansia menghadapi kecemasan, kesepian, kehilangan pasangan, perubahan peran, dan rasa tidak berdaya. Dengan motivasi, komunikasi hangat, empati, dan penghormatan, perempuan lansia dapat tetap memiliki semangat hidup, rasa bermakna, dan kualitas hidup yang lebih baik pada masa lanjut usia.

E. Peran Keluarga dalam Mendukung Kesehatan Fisik Perempuan Lansia

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan fisik perempuan lansia karena keluarga merupakan lingkungan terdekat yang paling sering berinteraksi dengan lansia dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan fisik akibat proses

penuaan, menopause, penyakit kronis, penurunan kekuatan otot, perubahan metabolisme, serta menurunnya daya tahan tubuh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan perempuan lansia dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, bergerak, menjaga kebersihan diri, mengonsumsi obat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, dukungan keluarga tidak hanya diperlukan saat lansia sakit, tetapi juga dalam upaya mempertahankan kesehatan, mencegah komplikasi, menjaga kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu bentuk dukungan keluarga yang paling mendasar adalah membantu pemenuhan nutrisi seimbang sesuai kondisi kesehatan lansia. Perempuan lansia membutuhkan asupan makanan yang cukup, bergizi, mudah dikonsumsi, dan sesuai dengan penyakit atau kondisi tubuh yang dimiliki. Pada usia lanjut, kebutuhan energi dapat menurun karena metabolisme tubuh melambat, tetapi kebutuhan zat gizi penting seperti protein, vitamin, mineral, serat, kalsium, vitamin D, dan cairan tetap harus diperhatikan. Protein diperlukan untuk mempertahankan massa otot agar lansia tidak mudah lemah. Kalsium dan vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang, terutama pada perempuan lansia yang berisiko mengalami osteoporosis setelah menopause. Serat membantu mencegah konstipasi, sedangkan cairan membantu menjaga fungsi ginjal, pencernaan, kulit, dan keseimbangan tubuh.

Keluarga perlu memahami bahwa pemenuhan nutrisi pada perempuan lansia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Lansia dengan hipertensi perlu dibantu membatasi konsumsi garam dan makanan tinggi natrium. Lansia dengan diabetes melitus membutuhkan pengaturan asupan gula dan karbohidrat agar kadar gula darah tetap stabil. Lansia dengan penyakit jantung perlu mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan memilih makanan yang lebih sehat bagi pembuluh darah. Lansia dengan gangguan ginjal mungkin membutuhkan pengaturan cairan, protein, atau mineral tertentu sesuai arahan tenaga kesehatan. Dengan demikian, keluarga berperan dalam menyesuaikan makanan harian lansia agar tetap bergizi, aman, dan tidak memperburuk penyakit yang sudah ada.

Dalam praktik sehari-hari, keluarga dapat membantu dengan menyediakan makanan dalam porsi kecil tetapi sering apabila nafsu makan lansia menurun. Makanan juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dikunyah dan ditelan, terutama jika lansia mengalami gangguan gigi, gigi tanggal, gigi palsu yang kurang nyaman, atau mulut kering. Penyajian makanan yang menarik, suasana makan yang tenang, serta kebiasaan makan bersama keluarga dapat meningkatkan selera makan perempuan lansia. Keluarga sebaiknya menghindari sikap memaksa, memarahi, atau menyalahkan lansia ketika ia tidak mau makan, karena hal tersebut

dapat membuat lansia semakin kehilangan minat terhadap makanan. Pendekatan yang sabar dan penuh perhatian lebih membantu dalam menjaga asupan nutrisi lansia.

Selain nutrisi, keluarga juga berperan penting dalam mengingatkan dan mendampingi perempuan lansia dalam minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Banyak perempuan lansia memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, nyeri sendi, osteoporosis, atau gangguan lain yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Penggunaan beberapa jenis obat dalam waktu bersamaan dapat membuat lansia bingung, lupa jadwal minum obat, salah dosis, atau menghentikan obat karena merasa sudah membaik. Kondisi ini dapat berbahaya karena penyakit kronis sering kali membutuhkan pengendalian yang konsisten meskipun gejala tidak selalu terasa.

Keluarga dapat membantu dengan membuat jadwal minum obat yang jelas, menyiapkan kotak obat harian atau mingguan, menuliskan aturan pakai dengan huruf besar, serta mengingatkan waktu minum obat secara teratur. Pendampingan ini sangat penting bagi perempuan lansia yang mengalami penurunan daya ingat, gangguan penglihatan, atau kesulitan memahami instruksi obat. Keluarga juga perlu memperhatikan apakah ada keluhan setelah minum obat, seperti pusing, mual, lemas, mengantuk berlebihan, bengkak, gatal, atau keluhan lain. Bila muncul efek samping atau perubahan kondisi, keluarga sebaiknya membantu lansia berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan tidak menghentikan obat secara sepihak.

Pendampingan minum obat perlu dilakukan dengan cara yang menghargai martabat lansia. Keluarga sebaiknya tidak membentak atau menyalahkan lansia ketika ia lupa minum obat. Lupa pada usia lanjut dapat terjadi karena penurunan daya ingat, jadwal obat yang rumit, atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat obat. Pendekatan yang lembut, pengulangan informasi, dan penataan obat yang rapi akan lebih efektif daripada sikap memarahi. Keluarga juga perlu menjelaskan bahwa minum obat secara teratur merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan agar lansia tetap dapat beraktivitas dan mempertahankan kemandirian.

Peran keluarga berikutnya adalah mendampingi perempuan lansia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan kesehatan sangat penting karena banyak penyakit pada lansia berkembang secara perlahan dan tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Hipertensi, diabetes melitus, gangguan kolesterol, osteoporosis, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, anemia, malnutrisi, dan gangguan ginjal dapat muncul atau memburuk tanpa disadari. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi masalah sejak

dini sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat.

Pemeriksaan tekanan darah perlu dilakukan secara berkala karena hipertensi merupakan masalah yang sering terjadi pada perempuan lansia dan sering tidak menimbulkan gejala. Tekanan darah yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan gangguan penglihatan. Pemeriksaan gula darah juga penting, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, obesitas, sering merasa haus, sering buang air kecil, mudah lelah, luka sulit sembuh, atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Keluarga dapat mendampingi lansia ke posyandu lansia, puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Kesehatan tulang juga perlu diperhatikan karena perempuan lansia, terutama setelah menopause, berisiko mengalami osteoporosis. Pemeriksaan atau pengkajian risiko osteoporosis dapat membantu mengetahui apakah lansia memiliki risiko tulang rapuh dan patah tulang. Keluarga juga perlu mendampingi pemeriksaan mata dan pendengaran karena penurunan penglihatan dan pendengaran dapat memengaruhi keselamatan, komunikasi, dan kemandirian lansia. Gangguan penglihatan dapat meningkatkan risiko jatuh dan kesalahan membaca aturan obat, sedangkan gangguan pendengaran dapat menyebabkan salah komunikasi, menarik diri, dan kesepian. Dengan pemeriksaan rutin, gangguan tersebut dapat dikenali dan ditangani lebih awal.

Keluarga juga memiliki peran dalam mendorong aktivitas fisik ringan yang aman. Aktivitas fisik merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan perempuan lansia. Banyak keluarga merasa khawatir apabila lansia bergerak terlalu banyak, terutama jika lansia pernah jatuh, mengalami nyeri sendi, atau memiliki penyakit kronis. Namun, membatasi aktivitas secara berlebihan justru dapat mempercepat penurunan kekuatan otot, membuat sendi semakin kaku, menurunkan keseimbangan, memperburuk sirkulasi darah, dan meningkatkan ketergantungan. Oleh karena itu, perempuan lansia tetap perlu didukung untuk bergerak sesuai kemampuan dan kondisi kesehatannya.

Aktivitas fisik ringan yang dapat dilakukan perempuan lansia antara lain berjalan kaki santai, senam lansia, peregangan, latihan pernapasan, latihan keseimbangan, berkebun ringan, atau melakukan aktivitas rumah tangga sederhana. Aktivitas tersebut dapat membantu menjaga kekuatan otot, kelenturan sendi, kesehatan jantung, kestabilan gula darah, kualitas tidur, serta suasana hati. Keluarga dapat mendampingi lansia saat berjalan pagi, memastikan alas kaki aman, memilih tempat berjalan yang tidak licin, serta menghindari aktivitas yang terlalu berat. Pada lansia dengan penyakit jantung, sesak napas, nyeri dada, gangguan

keseimbangan, atau riwayat jatuh, aktivitas fisik perlu disesuaikan dengan arahan tenaga kesehatan.

Dukungan keluarga dalam aktivitas fisik juga harus memperhatikan rasa percaya diri lansia. Perempuan lansia yang pernah jatuh atau sering merasa lemah mungkin takut bergerak. Keluarga dapat memberikan motivasi secara perlahan, bukan memaksa. Misalnya, keluarga dapat mengajak lansia berjalan beberapa menit terlebih dahulu, lalu meningkatkan durasi sesuai kemampuan. Pujian dan dukungan sederhana dapat membantu lansia merasa dihargai dan berani bergerak kembali. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan secara teratur, aman, dan menyenangkan agar lansia tidak merasa terbebani.

Selain aktivitas fisik, keluarga juga berperan dalam membantu menjaga kebersihan diri perempuan lansia. Kebersihan diri mencakup mandi, mencuci rambut, menyikat gigi, mengganti pakaian, merawat kulit, merawat kuku, menjaga kebersihan kaki, serta menjaga kebersihan area urogenital. Pada usia lanjut, lansia dapat mengalami kelemahan otot, nyeri sendi, gangguan penglihatan, atau gangguan keseimbangan yang membuat aktivitas merawat diri menjadi lebih sulit. Keluarga perlu membantu sesuai kebutuhan, tetapi tetap menjaga privasi dan martabat lansia. Bantuan dalam kebersihan diri harus dilakukan dengan sopan, sabar, dan tidak mempermalukan.

Perawatan kulit penting karena kulit perempuan lansia cenderung menjadi lebih tipis, kering, dan mudah iritasi akibat proses penuaan dan penurunan elastisitas kulit. Kulit yang kering dapat menimbulkan gatal, luka, atau lecet. Lansia yang banyak berbaring juga berisiko mengalami luka tekan. Keluarga dapat membantu dengan memastikan kulit tetap bersih, menggunakan pelembap bila diperlukan, mengganti pakaian yang basah atau kotor, serta memperhatikan area tubuh yang sering tertekan. Bila terdapat luka, kemerahan, bengkak, atau tanda infeksi, keluarga perlu segera membawa lansia untuk mendapatkan pemeriksaan.

Perawatan kaki juga sangat penting, terutama pada perempuan lansia dengan diabetes melitus, gangguan sirkulasi, atau penurunan sensasi pada kaki. Luka kecil pada kaki dapat berkembang menjadi luka yang sulit sembuh apabila tidak dirawat dengan baik. Keluarga dapat membantu memeriksa kaki secara rutin, menjaga kaki tetap bersih dan kering, memotong kuku dengan hati-hati, memastikan alas kaki nyaman, serta menghindari penggunaan sandal atau sepatu yang terlalu sempit. Lansia sebaiknya tidak berjalan tanpa alas kaki, terutama jika memiliki diabetes atau gangguan saraf, karena luka kecil mungkin tidak terasa dan terlambat diketahui.

Kebersihan area urogenital juga perlu mendapat perhatian, terutama pada perempuan lansia yang mengalami inkontinensia urine, sering buang air kecil,

kekeringan vagina, iritasi, atau infeksi saluran kemih. Area genital yang lembap karena kebocoran urine dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal, bau tidak sedap, dan meningkatkan risiko infeksi. Keluarga dapat membantu menyediakan pakaian dalam yang bersih, pelindung yang sesuai bila diperlukan, serta mengingatkan lansia untuk mengganti pelindung secara teratur. Saat membantu membersihkan area pribadi, keluarga harus menjaga privasi, berbicara dengan sopan, dan tidak menunjukkan sikap jijik atau menyalahkan. Sikap keluarga yang menghargai akan membantu lansia tetap merasa bermartabat.

Peran keluarga yang tidak kalah penting adalah mengenali tanda bahaya pada perempuan lansia. Tanda bahaya perlu dikenali sejak dini agar lansia segera mendapatkan pertolongan sebelum kondisi memburuk. Sesak napas merupakan salah satu tanda yang perlu diwaspadai, terutama jika muncul saat aktivitas ringan, saat berbaring, atau disertai dada terasa berat, batuk malam, bibir kebiruan, atau bengkak pada kaki. Sesak napas dapat berkaitan dengan gangguan jantung, paru, anemia, atau infeksi. Nyeri dada juga merupakan tanda penting, terutama jika terasa seperti ditekan, menjalar ke lengan, rahang, punggung, disertai keringat dingin, mual, pusing, atau lemas berat.

Pusing berat juga perlu diperhatikan, terutama jika disertai kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, bicara pelo, wajah mencong, penurunan kesadaran, atau gangguan penglihatan mendadak. Gejala tersebut dapat menjadi tanda gangguan serius seperti stroke atau masalah kardiovaskular. Luka sulit sembuh juga merupakan tanda bahaya, terutama pada lansia dengan diabetes melitus atau gangguan sirkulasi. Luka yang tidak membaik, bernanah, berbau, membengkak, atau disertai demam perlu segera diperiksa. Keluarga sebaiknya tidak menunda penanganan karena luka pada lansia dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih berat.

Jatuh juga harus dianggap sebagai tanda penting, meskipun tampak ringan. Pada perempuan lansia, jatuh dapat menyebabkan luka, memar, fraktur, cedera kepala, atau ketakutan bergerak. Lansia dengan osteoporosis sangat rentan mengalami patah tulang akibat jatuh ringan. Setelah lansia jatuh, keluarga perlu memeriksa adanya nyeri hebat, bengkak, perubahan bentuk anggota tubuh, kesulitan berjalan, pusing, muntah, kebingungan, atau penurunan kesadaran. Jika ada tanda-tanda tersebut, lansia perlu segera mendapat pemeriksaan medis. Keluarga juga perlu mengevaluasi penyebab jatuh, seperti lantai licin, pencahayaan kurang, alas kaki tidak aman, efek obat, atau gangguan keseimbangan.

Penurunan berat badan yang tidak direncanakan juga perlu diwaspadai. Bila perempuan lansia tampak semakin kurus, pakaian menjadi longgar, nafsu makan menurun, mudah lelah, atau tampak lemah, keluarga perlu mencari penyebabnya.

Penurunan berat badan dapat berkaitan dengan malnutrisi, depresi, penyakit kronis, gangguan pencernaan, infeksi, gangguan menelan, efek obat, atau masalah kesehatan yang lebih serius. Demikian pula perubahan perilaku seperti lansia menjadi lebih pendiam, bingung, mudah marah, tidak mau makan, tidak mau mandi, menarik diri, sulit tidur, atau tampak gelisah perlu diperhatikan. Perubahan perilaku dapat menjadi tanda gangguan fisik, infeksi, efek obat, gangguan kognitif, kecemasan, atau depresi.

Dalam menjalankan semua peran tersebut, keluarga perlu memiliki komunikasi yang baik dengan perempuan lansia dan tenaga kesehatan. Keluarga dapat mencatat keluhan lansia, jadwal obat, hasil pemeriksaan, perubahan berat badan, pola tidur, nafsu makan, serta kejadian seperti jatuh atau luka. Catatan sederhana ini dapat membantu tenaga kesehatan melakukan pengkajian dan menentukan penanganan yang lebih tepat. Keluarga juga perlu bertanya kepada tenaga kesehatan jika ada hal yang belum dipahami, misalnya aturan minum obat, makanan yang perlu dibatasi, aktivitas yang aman, atau tanda bahaya yang harus segera ditangani.

Dukungan keluarga dalam kesehatan fisik perempuan lansia harus diberikan dengan tetap menghargai kemandirian. Perempuan lansia tetap perlu diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang masih mampu dilakukan. Bantuan yang terlalu berlebihan dapat membuat lansia merasa tidak berguna dan kehilangan rasa percaya diri. Sebaliknya, kurangnya pendampingan dapat meningkatkan risiko cedera, ketidakpatuhan obat, atau keterlambatan penanganan. Oleh karena itu, keluarga perlu menyeimbangkan antara perlindungan dan pemberian kesempatan bagi lansia untuk tetap mandiri.

peran keluarga dalam mendukung kesehatan fisik perempuan lansia mencakup pemenuhan nutrisi seimbang, pendampingan minum obat, pemeriksaan kesehatan rutin, dorongan aktivitas fisik yang aman, bantuan menjaga kebersihan diri, serta kemampuan mengenali tanda bahaya. Dukungan ini sangat penting karena perempuan lansia menghadapi berbagai perubahan akibat penuaan, menopause, dan penyakit kronis. Apabila keluarga mampu memberikan dukungan secara sabar, tepat, dan menghargai martabat lansia, maka perempuan lansia dapat mempertahankan kesehatan fisik, mencegah komplikasi, menjaga kemandirian, dan menjalani masa tua dengan lebih aman, nyaman, dan bermakna.

F. Peran Komunitas dalam Mendukung Kesehatan Perempuan Lansia

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan perempuan lansia karena komunitas merupakan lingkungan sosial tempat lansia berinteraksi, memperoleh dukungan, dan mempertahankan rasa keterhubungan

dengan orang lain. Pada masa lanjut usia, perempuan dapat mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang memengaruhi kualitas hidupnya. Perubahan tersebut dapat berupa penurunan kekuatan tubuh, penyakit kronis, berkurangnya kemampuan mobilitas, kehilangan pasangan, anak yang tinggal terpisah, kesepian, serta perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, dukungan komunitas menjadi sangat diperlukan agar perempuan lansia tidak merasa terasing dan tetap memiliki ruang untuk beraktivitas, berkomunikasi, serta merasa dihargai sebagai bagian dari lingkungan sosial.

Salah satu bentuk peran komunitas adalah menyediakan kegiatan yang ramah lansia. Kegiatan komunitas yang ramah lansia adalah kegiatan yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan perempuan lansia. Kegiatan tersebut sebaiknya mudah dijangkau, tidak terlalu melelahkan, aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Posyandu lansia merupakan salah satu contoh kegiatan komunitas yang sangat penting karena dapat menjadi tempat pemantauan kesehatan secara berkala. Melalui posyandu lansia, perempuan lansia dapat memperoleh pemeriksaan tekanan darah, berat badan, gula darah, edukasi kesehatan, pemantauan status gizi, serta informasi mengenai pencegahan penyakit degeneratif. Kegiatan ini membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sehingga lansia dapat memperoleh penanganan lebih cepat sebelum terjadi komplikasi.

Selain posyandu lansia, senam lansia juga merupakan kegiatan komunitas yang bermanfaat. Senam lansia dapat membantu mempertahankan kekuatan otot, kelenturan sendi, keseimbangan, sirkulasi darah, dan kesehatan jantung. Aktivitas fisik yang dilakukan secara bersama-sama juga dapat meningkatkan semangat perempuan lansia karena mereka merasa tidak beraktivitas sendirian. Namun, senam lansia perlu dilakukan dengan gerakan yang aman, tidak terlalu berat, serta disesuaikan dengan kemampuan peserta. Perempuan lansia yang memiliki penyakit jantung, nyeri sendi berat, gangguan keseimbangan, atau riwayat jatuh perlu mendapat perhatian khusus agar aktivitas fisik tetap aman. Dengan adanya kegiatan fisik yang terarah, komunitas dapat membantu perempuan lansia tetap aktif dan mencegah penurunan fungsi tubuh yang lebih cepat.

Edukasi kesehatan juga menjadi bagian penting dari peran komunitas. Banyak perempuan lansia dan keluarganya membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai proses penuaan, menopause, nutrisi, penyakit kronis, pencegahan jatuh, penggunaan obat, kesehatan mental, kebersihan diri, dan tanda bahaya yang perlu segera diperiksakan. Edukasi yang diberikan di tingkat komunitas dapat membantu lansia memahami perubahan yang dialami tubuhnya

dan mengetahui cara menjaga kesehatan sehari-hari. Edukasi sebaiknya disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan lansia, serta tidak menggunakan istilah medis yang sulit dipahami. Dengan edukasi yang baik, perempuan lansia dapat lebih percaya diri dalam merawat dirinya dan keluarga dapat lebih siap memberikan dukungan.

Komunitas juga berperan dalam mendorong perempuan lansia agar tetap terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Keterlibatan sosial sangat penting karena manusia tetap membutuhkan hubungan dengan orang lain sepanjang hidupnya, termasuk pada masa lanjut usia. Ketika perempuan lansia masih terlibat dalam kegiatan masyarakat, ia akan merasa menjadi bagian dari lingkungan dan tidak merasa tersisih. Kegiatan sosial seperti arisan, pertemuan warga, kelompok keterampilan, kunjungan sosial, atau kegiatan gotong royong ringan dapat memberikan kesempatan bagi lansia untuk tetap berinteraksi. Kegiatan tersebut tidak harus berat, tetapi cukup memberikan ruang bagi lansia untuk hadir, berbicara, mendengar, dan merasa diterima.

Kegiatan keagamaan juga memiliki peran yang besar dalam mendukung perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, kebutuhan spiritual biasanya semakin meningkat. Perempuan lansia sering lebih banyak merenungkan makna hidup, rasa syukur, kematian, dan hubungan dengan Tuhan. Kegiatan seperti pengajian, kebaktian, doa bersama, majelis taklim, kelompok rohani, atau kegiatan keagamaan lainnya dapat memberikan ketenangan batin sekaligus memperkuat hubungan sosial. Melalui kegiatan keagamaan, perempuan lansia dapat memperoleh dukungan spiritual dan emosional. Mereka dapat bertemu teman sebaya, berbagi pengalaman, memperoleh nasihat, dan merasa memiliki tempat yang menerima keberadaannya.

Komunitas yang baik juga memberikan ruang bagi perempuan lansia untuk berbagi pengalaman. Perempuan lansia memiliki perjalanan hidup yang panjang dan pengalaman yang berharga. Mereka pernah menjalani peran sebagai anak, istri, ibu, nenek, pekerja, pengasuh, atau anggota masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi yang lebih muda. Ketika komunitas memberi ruang bagi lansia untuk bercerita, memberi nasihat, atau berbagi pengalaman hidup, lansia akan merasa dihargai dan diakui. Hal ini sangat penting untuk menjaga harga diri dan rasa bermakna. Perempuan lansia tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kontribusi dan kebijaksanaan.

Interaksi dalam komunitas juga dapat membantu mengurangi risiko isolasi sosial dan kesepian. Isolasi sosial merupakan kondisi ketika seseorang memiliki keterbatasan hubungan sosial atau kurang terlibat dalam interaksi dengan orang

lain. Perempuan lansia berisiko mengalami isolasi sosial karena kehilangan pasangan, teman sebaya yang meninggal atau sakit, anak-anak yang tinggal jauh, keterbatasan fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau rasa malu akibat masalah kesehatan tertentu seperti inkontinensia urine. Jika perempuan lansia jarang keluar rumah dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, ia dapat merasa kesepian, sedih, tidak bersemangat, dan kehilangan makna hidup. Kegiatan kelompok di komunitas dapat menjadi sarana untuk mencegah keadaan tersebut.

Kesepian pada perempuan lansia tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Kesepian yang berlangsung lama dapat memengaruhi nafsu makan, kualitas tidur, kesehatan mental, motivasi beraktivitas, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Lansia yang kesepian dapat menjadi lebih pasif, menarik diri, dan kurang memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu, kegiatan komunitas yang melibatkan perempuan lansia secara rutin dapat menjadi bentuk pencegahan yang sangat penting. Ketika lansia memiliki jadwal kegiatan, teman berbicara, dan lingkungan yang memperhatikan kehadirannya, ia akan merasa lebih terhubung dan memiliki alasan untuk tetap aktif.

Dalam mendukung perempuan lansia, komunitas perlu melibatkan berbagai pihak, seperti kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan. Kader kesehatan memiliki peran penting karena biasanya dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi warga di lingkungannya. Kader dapat membantu memantau kondisi perempuan lansia, mengingatkan jadwal posyandu lansia, melakukan kunjungan rumah, memberikan edukasi sederhana, serta membantu menghubungkan lansia dengan fasilitas kesehatan apabila ditemukan masalah. Kader juga dapat membantu mengenali perempuan lansia yang tinggal sendiri, jarang keluar rumah, mengalami keterbatasan, atau berisiko mengalami penelantaran.

Tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam menciptakan lingkungan yang peduli terhadap lansia. Tokoh masyarakat dapat mendorong adanya kegiatan ramah lansia, mengajak warga untuk memperhatikan perempuan lansia di sekitar mereka, serta membantu membangun budaya saling peduli. Dalam masyarakat, keberadaan tokoh yang mendukung program lansia dapat meningkatkan partisipasi warga. Misalnya, ketua RT, ketua RW, perangkat desa, atau tokoh adat dapat membantu mengorganisasi kegiatan pemeriksaan kesehatan, kunjungan sosial, atau penggalangan dukungan bagi lansia yang membutuhkan bantuan. Dukungan tokoh masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap perempuan lansia.

Tokoh agama juga memiliki peran penting, terutama dalam memberikan dukungan spiritual dan moral. Banyak perempuan lansia merasa lebih tenang

ketika mendapatkan penguatan spiritual dari tokoh agama atau komunitas keagamaan. Tokoh agama dapat membantu memberikan nasihat, membangun harapan, menguatkan penerimaan diri, serta mendorong keluarga dan masyarakat untuk memperlakukan lansia dengan hormat. Kegiatan keagamaan juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesepian, memperluas hubungan sosial, dan memperkuat rasa bermakna pada perempuan lansia. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dalam pendampingan lansia dapat memberikan manfaat yang besar, terutama pada aspek psikologis dan spiritual.

Relawan juga dapat berperan dalam mendukung perempuan lansia, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri, memiliki keterbatasan mobilitas, atau kurang mendapat dukungan keluarga. Relawan dapat membantu melalui kunjungan rumah, pendampingan ke fasilitas kesehatan, bantuan dalam kegiatan sosial, atau sekadar menjadi teman berbicara. Kehadiran relawan dapat memberikan rasa diperhatikan bagi perempuan lansia yang mungkin jarang dikunjungi keluarga. Namun, pendampingan oleh relawan perlu dilakukan dengan tetap menjaga etika, privasi, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat lansia.

Komunitas juga perlu membangun lingkungan sosial yang peduli, inklusif, dan bebas stigma terhadap perempuan lansia. Lingkungan yang peduli adalah lingkungan yang memperhatikan kebutuhan lansia, tidak membiarkan lansia terisolasi, dan siap membantu ketika ada lansia yang mengalami kesulitan. Lingkungan yang inklusif adalah lingkungan yang memberi kesempatan kepada perempuan lansia untuk tetap terlibat dalam kegiatan sesuai kemampuan. Lansia tidak boleh dianggap tidak produktif, lambat, merepotkan, atau tidak memiliki peran. Pandangan negatif seperti itu dapat membuat perempuan lansia merasa rendah diri dan menarik diri dari masyarakat.

Stigma terhadap perempuan lansia perlu dicegah karena dapat merusak harga diri dan kualitas hidup. Stigma dapat muncul dalam bentuk ucapan merendahkan, sikap mengabaikan, tidak melibatkan lansia dalam kegiatan, atau menganggap keluhan lansia sebagai hal yang tidak penting. Misalnya, keluhan nyeri, sulit tidur, gangguan pendengaran, inkontinensia urine, atau kesepian sering dianggap sebagai hal biasa pada usia tua sehingga tidak ditangani. Padahal, setiap keluhan perlu didengarkan dan dikaji secara tepat. Komunitas yang bebas stigma akan mendorong perempuan lansia untuk lebih terbuka menyampaikan kebutuhan dan lebih berani mengikuti kegiatan sosial.

Lingkungan komunitas yang ramah lansia juga perlu memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan. Tempat kegiatan sebaiknya mudah dijangkau, memiliki tempat duduk yang nyaman, pencahayaan cukup, lantai tidak licin, dan tidak memerlukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Waktu kegiatan juga perlu

disesuaikan dengan kondisi lansia, misalnya tidak terlalu malam dan tidak terlalu lama. Jika memungkinkan, komunitas dapat membantu menyediakan pendampingan atau transportasi bagi lansia yang sulit datang sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perempuan lansia akan lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan komunitas.

Peran komunitas dalam mendukung kesehatan perempuan lansia juga perlu berjalan bersama keluarga dan tenaga kesehatan. Komunitas dapat menjadi jembatan antara keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya, jika kader menemukan perempuan lansia yang sering lemah, mengalami penurunan berat badan, tampak kesepian, atau memiliki luka sulit sembuh, maka kader dapat menyarankan keluarga untuk membawa lansia ke puskesmas. Sebaliknya, tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan komunitas untuk memberikan penyuluhan dan pemantauan kesehatan. Kolaborasi ini membuat dukungan terhadap perempuan lansia menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, komunitas memiliki peran besar dalam mendukung kesehatan perempuan lansia melalui penyediaan kegiatan yang ramah lansia, seperti posyandu lansia, senam lansia, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan rutin. Komunitas juga berperan mendorong keterlibatan perempuan lansia dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta memberi ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan merasa dihargai. Melalui kegiatan kelompok, risiko isolasi sosial dan kesepian dapat dikurangi. Keterlibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan sangat penting dalam pendampingan lansia. Dengan membangun lingkungan sosial yang peduli, inklusif, dan bebas stigma, komunitas dapat membantu perempuan lansia menjalani masa tua dengan lebih sehat, aktif, aman, bermartabat, dan bermakna.

G. Peran Komunitas dalam Pencegahan Masalah Kesehatan Lansia

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan masalah kesehatan pada perempuan lansia. Pada masa lanjut usia, perempuan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit serta menurunkan kualitas hidup apabila tidak mendapat dukungan yang memadai. Pencegahan masalah kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga membutuhkan keterlibatan komunitas sebagai lingkungan sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari lansia. Komunitas dapat menjadi tempat perempuan lansia memperoleh informasi kesehatan, melakukan pemeriksaan sederhana, mengikuti kegiatan fisik, berinteraksi sosial, mendapatkan dukungan emosional, serta

terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan apabila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Salah satu peran utama komunitas dalam pencegahan masalah kesehatan lansia adalah melakukan edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan sangat penting karena banyak perempuan lansia dan keluarganya belum sepenuhnya memahami perubahan yang terjadi pada masa lanjut usia. Sebagian keluhan sering dianggap sebagai hal biasa akibat usia tua, seperti nyeri sendi, sulit tidur, mudah lelah, sering lupa, penurunan penglihatan, sering buang air kecil, atau rasa kesepian. Padahal, keluhan tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu dikaji dan ditangani. Melalui edukasi yang tepat, komunitas dapat membantu perempuan lansia dan keluarga mengenali perubahan normal akibat penuaan, membedakannya dengan tanda penyakit, serta mengetahui langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini.

Edukasi mengenai penyakit degeneratif menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan komunitas. Penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, osteoporosis, osteoarthritis, dan gangguan ginjal sering dialami perempuan lansia. Penyakit-penyakit tersebut berkembang secara perlahan dan kadang tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Hipertensi, misalnya, dapat terjadi tanpa keluhan tetapi berisiko menyebabkan stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal apabila tidak dikontrol. Diabetes melitus juga dapat berkembang diam-diam dan menimbulkan komplikasi seperti gangguan saraf, luka sulit sembuh, gangguan penglihatan, dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, komunitas perlu memberikan edukasi tentang faktor risiko, tanda yang perlu diwaspadai, pentingnya pemeriksaan rutin, kepatuhan minum obat, serta pola hidup sehat untuk mencegah komplikasi penyakit degeneratif.

Edukasi mengenai menopause juga penting diberikan kepada perempuan lansia. Menopause merupakan bagian alami dari siklus kehidupan perempuan, tetapi perubahan hormonal setelah menopause dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan. Penurunan hormon estrogen dapat meningkatkan risiko osteoporosis, gangguan urogenital, perubahan kulit, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Banyak perempuan merasa malu membicarakan keluhan pascamenopause, seperti kekeringan vagina, nyeri saat berkemih, inkontinensia urine, atau gangguan fungsi seksual. Komunitas dapat membantu mengurangi rasa tabu dengan menyediakan edukasi yang sopan, mudah dipahami, dan menghargai nilai budaya. Dengan edukasi yang baik, perempuan lansia dapat memahami bahwa keluhan tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung sendiri, melainkan dapat dikonsultasikan dan ditangani secara tepat.

Nutrisi juga menjadi topik penting dalam edukasi komunitas. Perempuan lansia membutuhkan pola makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan perubahan metabolisme tubuh. Pada masa lanjut usia, kebutuhan energi dapat menurun, tetapi kebutuhan zat gizi penting seperti protein, kalsium, vitamin D, serat, cairan, vitamin, dan mineral tetap harus terpenuhi. Komunitas dapat memberikan penyuluhan mengenai makanan yang baik untuk menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, daya tahan tubuh, dan pengendalian penyakit kronis. Edukasi juga perlu mencakup pembatasan garam bagi lansia dengan hipertensi, pengaturan gula bagi lansia dengan diabetes, pembatasan lemak jenuh bagi lansia dengan penyakit jantung, serta pentingnya cairan dan serat untuk mencegah konstipasi. Edukasi nutrisi sebaiknya disampaikan dengan contoh makanan sehari-hari yang mudah diperoleh dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Aktivitas fisik juga perlu menjadi bagian dari edukasi dan program komunitas. Banyak perempuan lansia mengurangi aktivitas karena takut jatuh, nyeri sendi, mudah lelah, atau merasa tubuhnya tidak lagi kuat. Namun, kurang bergerak justru dapat mempercepat kelemahan otot, menurunkan keseimbangan, memperburuk nyeri sendi, meningkatkan risiko obesitas, serta memperbesar risiko jatuh. Komunitas dapat memberikan pemahaman bahwa aktivitas fisik tidak harus berat. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, peregangan, latihan keseimbangan, atau aktivitas rumah tangga sederhana dapat membantu menjaga kesehatan. Edukasi ini penting agar perempuan lansia dan keluarga tidak terlalu membatasi gerak lansia secara berlebihan, tetapi tetap memperhatikan keamanan dan kemampuan masing-masing individu.

Pencegahan jatuh merupakan materi edukasi yang sangat penting karena jatuh dapat berdampak serius pada perempuan lansia. Jatuh dapat menyebabkan luka, fraktur, cedera kepala, ketakutan bergerak, penurunan kemandirian, bahkan ketergantungan jangka panjang. Risiko jatuh dapat meningkat karena kelemahan otot, gangguan keseimbangan, penurunan penglihatan, penggunaan obat tertentu, lantai licin, pencahayaan kurang, kamar mandi tidak aman, atau alas kaki yang tidak sesuai. Komunitas dapat memberikan edukasi kepada lansia dan keluarga tentang cara menata rumah agar lebih aman, pentingnya menggunakan alas kaki yang tidak licin, perlunya pencahayaan yang cukup, penggunaan pegangan di kamar mandi, serta pentingnya latihan keseimbangan. Dengan edukasi tersebut, keluarga dapat lebih aktif menciptakan lingkungan rumah yang ramah lansia.

Kesehatan mental juga perlu mendapat perhatian dalam edukasi komunitas. Perempuan lansia rentan mengalami kecemasan, kesepian, depresi, penurunan konsep diri, dan isolasi sosial. Kondisi tersebut dapat muncul akibat kehilangan

pasangan, anak yang tinggal terpisah, penyakit kronis, keterbatasan fisik, masalah ekonomi, atau berkurangnya peran dalam keluarga. Komunitas perlu memberikan pemahaman bahwa kesehatan mental lansia sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Lansia yang tampak sering sedih, menarik diri, sulit tidur, tidak nafsu makan, kehilangan minat, atau merasa tidak berguna perlu mendapatkan perhatian. Edukasi kesehatan mental dapat membantu keluarga dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku lansia serta mendorong lansia untuk tetap terlibat dalam kegiatan sosial dan spiritual.

Selain edukasi, komunitas juga berperan dalam mendukung deteksi dini masalah kesehatan. Deteksi dini sangat penting karena banyak masalah kesehatan pada perempuan lansia berkembang secara perlahan dan tidak langsung menimbulkan gejala. Pemeriksaan sederhana di tingkat komunitas, seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, penimbangan berat badan, pengukuran lingkaran lengan atau status gizi, serta pengkajian risiko jatuh dapat membantu menemukan masalah lebih awal. Melalui kegiatan seperti posyandu lansia, pemeriksaan berkala, atau kunjungan kader, perempuan lansia dapat memperoleh pemantauan kesehatan secara rutin tanpa harus selalu menunggu kondisi menjadi berat.

Pemeriksaan tekanan darah di komunitas sangat bermanfaat untuk mendeteksi hipertensi atau memantau tekanan darah lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi. Karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, banyak lansia baru mengetahui tekanan darahnya tinggi ketika sudah terjadi keluhan berat. Dengan adanya pemeriksaan rutin, tekanan darah dapat dipantau lebih teratur dan lansia dapat segera dianjurkan untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila hasil pemeriksaan tidak normal. Pemeriksaan gula darah juga penting, terutama bagi perempuan lansia yang memiliki faktor risiko diabetes melitus, seperti obesitas, riwayat keluarga diabetes, pola makan tinggi gula, kurang aktivitas fisik, atau sering mengalami luka sulit sembuh. Deteksi dini kadar gula darah dapat membantu mencegah komplikasi diabetes yang lebih berat.

Pemantauan berat badan dan status gizi juga penting dilakukan di komunitas. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan dapat menjadi tanda malnutrisi, penyakit kronis, depresi, gangguan pencernaan, atau masalah kesehatan lain. Sebaliknya, peningkatan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan nyeri sendi. Komunitas dapat membantu memantau perubahan berat badan perempuan lansia secara berkala dan memberikan edukasi apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Kader kesehatan dapat menanyakan pola makan, nafsu makan, kemampuan mengunyah,

kondisi gigi, serta dukungan keluarga dalam pemenuhan nutrisi. Dengan demikian, masalah gizi dapat dikenali lebih cepat.

Pengkajian risiko jatuh juga dapat dilakukan di tingkat komunitas. Kader atau petugas kesehatan dapat menanyakan riwayat jatuh, keluhan pusing, gangguan penglihatan, penggunaan alat bantu, kesulitan berjalan, atau rasa takut bergerak. Selain itu, komunitas dapat mendorong keluarga untuk menilai keamanan rumah, seperti kondisi lantai, pencahayaan, kamar mandi, tangga, dan alas kaki. Jika ditemukan perempuan lansia yang berisiko tinggi jatuh, komunitas dapat menyarankan keluarga untuk melakukan penataan rumah, mendampingi aktivitas lansia, serta membawa lansia ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Deteksi dini risiko jatuh sangat penting karena pencegahan jauh lebih baik daripada menangani dampak jatuh yang dapat menyebabkan fraktur dan ketergantungan.

Komunitas juga dapat mengadakan kegiatan fisik yang aman dan terarah sesuai kemampuan perempuan lansia. Kegiatan fisik bersama, seperti senam lansia, jalan santai, latihan peregangan, latihan keseimbangan, atau gerakan ringan di posyandu lansia, dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kegiatan tersebut sebaiknya dipandu oleh orang yang memahami kondisi lansia atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Gerakan yang diberikan harus aman, tidak terlalu cepat, tidak terlalu berat, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta. Perempuan lansia yang memiliki keluhan tertentu, seperti nyeri sendi berat, sesak napas, riwayat jatuh, atau penyakit jantung, perlu diberi perhatian khusus agar tidak memaksakan diri.

Kegiatan fisik di komunitas tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga bermanfaat bagi psikologis dan sosial perempuan lansia. Ketika lansia berolahraga bersama, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu teman sebaya, bercakap-cakap, tertawa, dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Hal ini dapat mengurangi kesepian dan meningkatkan semangat hidup. Aktivitas fisik kelompok juga lebih menyenangkan dibandingkan dilakukan sendiri, sehingga perempuan lansia lebih termotivasi untuk hadir secara rutin. Dengan demikian, kegiatan fisik komunitas dapat menjadi sarana pencegahan masalah kesehatan fisik sekaligus pencegahan isolasi sosial.

Komunitas juga berperan dalam mendorong kebiasaan hidup sehat di lingkungan masyarakat. Kebiasaan hidup sehat tidak hanya dibentuk oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jika lingkungan masyarakat mendukung pola makan sehat, aktivitas fisik, pemeriksaan rutin, dan kepedulian terhadap lansia, maka perempuan lansia akan lebih mudah menjalani gaya hidup sehat. Komunitas dapat mengadakan penyuluhan, menyediakan kegiatan bersama,

mengajak keluarga mendampingi lansia, serta menciptakan budaya saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan. Misalnya, warga dapat didorong untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dalam acara bersama, menyediakan pilihan makanan yang lebih sehat, atau mengajak lansia hadir dalam kegiatan fisik dan pemeriksaan rutin.

Kebiasaan hidup sehat juga mencakup pengelolaan stres, tidur cukup, menjaga kebersihan diri, tidak merokok, dan minum obat sesuai anjuran. Komunitas dapat membantu dengan menciptakan suasana sosial yang mendukung, tidak menstigma lansia, dan memberi ruang bagi perempuan lansia untuk tetap berperan. Lingkungan yang menghargai lansia dapat membantu menjaga kesehatan mental dan mencegah kesepian. Selain itu, komunitas dapat memberikan contoh bahwa masa lanjut usia tetap dapat dijalani secara aktif dan bermakna apabila didukung dengan kebiasaan hidup sehat serta hubungan sosial yang baik.

Peran komunitas berikutnya adalah membantu mengidentifikasi perempuan lansia yang hidup sendiri, mengalami keterbatasan, atau berisiko mengalami penelantaran. Tidak semua perempuan lansia memiliki keluarga yang tinggal serumah atau mampu memberikan pendampingan secara optimal. Ada lansia yang hidup sendiri karena pasangan telah meninggal, anak-anak tinggal jauh, atau tidak memiliki keluarga dekat. Ada pula perempuan lansia yang tinggal bersama keluarga tetapi kurang mendapatkan perhatian karena keluarga sibuk, mengalami masalah ekonomi, atau kurang memahami kebutuhan lansia. Dalam situasi seperti ini, komunitas dapat menjadi pihak yang membantu mengenali lansia yang membutuhkan perhatian lebih.

Kader kesehatan, tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan dapat berperan dalam memperhatikan kondisi perempuan lansia di lingkungannya. Mereka dapat mengenali tanda-tanda seperti lansia jarang keluar rumah, tampak semakin kurus, rumah tampak tidak terawat, lansia sering terlihat sedih, mengalami luka yang tidak diobati, sering jatuh, tidak hadir dalam kegiatan rutin, atau tampak kebingungan. Tanda-tanda tersebut dapat menunjukkan adanya masalah kesehatan, kesepian, keterbatasan fisik, atau penelantaran. Identifikasi dini oleh komunitas sangat penting agar perempuan lansia tidak mengalami masalah yang semakin berat tanpa diketahui.

Penelantaran pada lansia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kebutuhan makan yang tidak terpenuhi, obat tidak diberikan sesuai anjuran, kebersihan diri diabaikan, lansia tidak dibawa berobat saat sakit, atau lansia dibiarkan hidup dalam lingkungan yang tidak aman. Penelantaran tidak selalu terjadi karena keluarga tidak peduli, tetapi dapat juga terjadi karena keluarga

kurang pengetahuan, kelelahan merawat, keterbatasan ekonomi, atau tidak menyadari kebutuhan lansia. Komunitas dapat membantu dengan memberikan edukasi, dukungan sosial, dan menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan atau bantuan sosial apabila diperlukan. Pendekatan yang digunakan sebaiknya tidak menyalahkan, tetapi membantu mencari solusi agar lansia tetap terlindungi.

Komunitas juga berperan menghubungkan perempuan lansia dan keluarga dengan fasilitas pelayanan kesehatan bila ditemukan masalah kesehatan. Kegiatan komunitas seperti posyandu lansia atau kunjungan kader dapat menjadi pintu awal untuk menemukan masalah. Namun, ketika masalah yang ditemukan membutuhkan penanganan lebih lanjut, komunitas perlu mendorong lansia dan keluarga untuk mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, atau layanan rujukan lainnya. Misalnya, perempuan lansia dengan tekanan darah sangat tinggi, gula darah tidak terkontrol, luka sulit sembuh, penurunan berat badan drastis, sesak napas, nyeri dada, jatuh, gangguan penglihatan berat, atau tanda depresi perlu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Menghubungkan lansia dengan fasilitas kesehatan tidak hanya berarti memberi tahu agar lansia berobat. Dalam beberapa situasi, komunitas perlu membantu mengatasi hambatan akses. Perempuan lansia mungkin tidak memiliki transportasi, takut pergi sendiri, tidak memahami prosedur pelayanan, tidak memiliki biaya, atau merasa malu menyampaikan keluhan. Kader atau relawan dapat membantu memberikan informasi, mendampingi ke layanan kesehatan, membantu keluarga memahami pentingnya pemeriksaan, atau menghubungkan dengan program bantuan yang tersedia. Dengan dukungan ini, perempuan lansia memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Kolaborasi antara komunitas dan fasilitas kesehatan sangat penting agar pencegahan masalah kesehatan lansia berjalan berkelanjutan. Puskesmas dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelatihan kepada kader mengenai pemeriksaan sederhana, edukasi kesehatan, pengenalan tanda bahaya, pencegahan jatuh, dan pendampingan lansia. Kader kemudian dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan masyarakat. Sebaliknya, kader dapat menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan mengenai kondisi lansia di wilayahnya yang membutuhkan perhatian. Hubungan dua arah ini akan memperkuat sistem dukungan bagi perempuan lansia.

Peran komunitas dalam pencegahan masalah kesehatan lansia juga harus didasarkan pada penghargaan terhadap martabat perempuan lansia. Dalam memberikan edukasi, pemeriksaan, atau pendampingan, komunitas perlu menjaga

privasi, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari sikap menghakimi. Perempuan lansia tidak boleh dipermalukan karena penyakit, keterbatasan, inkontinensia, gangguan pendengaran, atau kondisi ekonominya. Komunitas yang menghargai lansia akan membuat mereka lebih percaya untuk mengikuti kegiatan dan menyampaikan keluhan. Sebaliknya, komunitas yang penuh stigma dapat membuat lansia menarik diri dan menolak bantuan.

peran komunitas dalam pencegahan masalah kesehatan perempuan lansia sangat luas dan penting. Komunitas dapat melakukan edukasi kesehatan tentang penyakit degeneratif, menopause, nutrisi, aktivitas fisik, pencegahan jatuh, dan kesehatan mental. Komunitas juga dapat mendukung deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, status gizi, dan risiko jatuh. Kegiatan fisik yang aman dan terarah dapat membantu menjaga fungsi tubuh serta mengurangi kesepian. Selain itu, komunitas dapat mendorong kebiasaan hidup sehat, mengidentifikasi lansia yang hidup sendiri atau berisiko penelantaran, serta menghubungkan perempuan lansia dan keluarga dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan komunitas yang peduli, terorganisasi, dan ramah lansia, perempuan lansia dapat lebih terlindungi, lebih aktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

H. Kolaborasi Keluarga, Komunitas, dan Tenaga Kesehatan

Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan merupakan unsur penting dalam mendukung perempuan lansia agar dapat menjalani masa tua dengan sehat, aman, mandiri, bermartabat, dan bermakna. Perempuan lansia mengalami berbagai perubahan yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Perubahan tersebut sering kali tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Keluarga memang menjadi lingkungan terdekat bagi lansia, tetapi keluarga juga membutuhkan dukungan dari komunitas dan tenaga kesehatan agar pendampingan yang diberikan lebih tepat. Komunitas dapat menyediakan ruang sosial dan kegiatan ramah lansia, sedangkan tenaga kesehatan memiliki peran profesional dalam edukasi, pengkajian, pemantauan, deteksi dini, dan rujukan. Ketika ketiga unsur ini bekerja sama, kebutuhan perempuan lansia dapat dipenuhi secara lebih menyeluruh.

Pentingnya kerja sama antara keluarga, komunitas, kader, dan tenaga kesehatan didasarkan pada kenyataan bahwa masalah kesehatan perempuan lansia sering kali saling berkaitan. Misalnya, perempuan lansia yang mengalami nyeri sendi dapat menjadi jarang bergerak. Karena jarang bergerak, otot semakin lemah, keseimbangan menurun, dan risiko jatuh meningkat. Jika lansia pernah jatuh, ia dapat menjadi takut bergerak, kemudian lebih banyak berdiam diri di

rumah. Kondisi ini dapat menyebabkan kesepian, penurunan semangat hidup, dan berkurangnya keterlibatan sosial. Dalam keadaan seperti ini, keluarga perlu mendampingi lansia di rumah, komunitas perlu menyediakan kegiatan yang aman dan mendukung, sedangkan tenaga kesehatan perlu menilai kondisi fisik, memberikan edukasi, dan menentukan latihan atau perawatan yang sesuai.

Kolaborasi juga penting karena perempuan lansia sering memiliki lebih dari satu masalah kesehatan. Seorang lansia dapat mengalami hipertensi, diabetes melitus, nyeri sendi, gangguan tidur, inkontinensia urine, penurunan penglihatan, dan kesepian secara bersamaan. Jika penanganan hanya berfokus pada satu masalah, kebutuhan lansia tidak akan terpenuhi secara optimal. Tenaga kesehatan mungkin dapat memberikan obat dan anjuran medis, tetapi keberhasilan perawatan sangat bergantung pada keluarga yang membantu menerapkan anjuran tersebut di rumah. Komunitas juga dapat membantu menjaga keterlibatan sosial lansia agar ia tidak merasa sendirian. Dengan demikian, kolaborasi menjadi jembatan yang menghubungkan perawatan medis, dukungan keluarga, dan dukungan sosial dalam kehidupan sehari-hari perempuan lansia.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada perempuan lansia, keluarga, dan komunitas. Edukasi kesehatan diperlukan agar lansia dan keluarga memahami perubahan yang terjadi pada masa lanjut usia, faktor risiko penyakit, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta cara menjaga kesehatan. Edukasi dapat mencakup pengaturan pola makan, aktivitas fisik yang aman, kepatuhan minum obat, pencegahan jatuh, perawatan kaki pada lansia dengan diabetes, pengelolaan tekanan darah, kesehatan tulang, kesehatan urogenital, serta kesehatan mental. Edukasi yang baik harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, tidak menakut-nakuti, dan sesuai dengan kemampuan pemahaman lansia maupun keluarganya.

Selain memberikan edukasi, tenaga kesehatan juga berperan dalam melakukan pengkajian. Pengkajian pada perempuan lansia perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menanyakan keluhan fisik, tetapi juga menilai kondisi psikologis, sosial, spiritual, kemampuan aktivitas sehari-hari, pola makan, pola tidur, penggunaan obat, risiko jatuh, dukungan keluarga, serta keterlibatan sosial. Misalnya, ketika perempuan lansia mengeluh sulit tidur, tenaga kesehatan perlu mengkaji apakah keluhan tersebut disebabkan oleh nyeri, sering buang air kecil, kecemasan, efek obat, penyakit kronis, atau kesepian. Pengkajian yang menyeluruh akan membantu tenaga kesehatan memberikan intervensi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan lansia.

Deteksi dini juga menjadi bagian penting dari peran tenaga kesehatan. Banyak masalah kesehatan pada perempuan lansia berkembang secara perlahan

dan tidak langsung menimbulkan gejala yang jelas. Hipertensi dapat terjadi tanpa keluhan, diabetes melitus dapat tidak disadari hingga muncul komplikasi, osteoporosis dapat baru diketahui setelah terjadi patah tulang, dan depresi dapat tampak sebagai keluhan fisik seperti lemah, sulit tidur, atau tidak nafsu makan. Melalui pemeriksaan berkala, tenaga kesehatan dapat membantu menemukan masalah sejak dini. Deteksi dini dapat dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, status gizi, kesehatan mata, pendengaran, kesehatan tulang, fungsi kognitif, dan risiko jatuh.

Pemantauan kondisi perempuan lansia perlu dilakukan secara berkelanjutan. Lansia dengan penyakit kronis membutuhkan pemantauan rutin agar penyakit tetap terkendali dan komplikasi dapat dicegah. Tenaga kesehatan dapat memantau tekanan darah pada lansia hipertensi, kadar gula darah pada lansia diabetes, keluhan nyeri pada lansia dengan osteoarthritis, risiko fraktur pada lansia osteoporosis, serta perubahan perilaku pada lansia yang berisiko mengalami gangguan psikologis. Pemantauan ini tidak selalu harus dilakukan di rumah sakit, tetapi dapat dilakukan melalui puskesmas, posyandu lansia, kunjungan rumah, atau kerja sama dengan kader kesehatan. Dengan pemantauan yang teratur, perubahan kondisi lansia dapat segera dikenali dan ditindaklanjuti.

Tenaga kesehatan juga berperan dalam melakukan rujukan apabila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya, perempuan lansia yang mengalami nyeri dada, sesak napas berat, tekanan darah sangat tinggi, gula darah tidak terkontrol, luka kaki yang sulit sembuh, penurunan berat badan drastis, jatuh dengan nyeri hebat, gangguan penglihatan berat, atau tanda depresi berat perlu segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih sesuai. Rujukan yang tepat membantu mencegah keterlambatan penanganan. Dalam proses rujukan, keluarga perlu diberi penjelasan mengenai alasan rujukan, tanda bahaya, dan langkah yang harus dilakukan agar mereka memahami pentingnya tindakan tersebut.

Keluarga memiliki peran utama dalam menerapkan anjuran kesehatan di rumah. Setelah tenaga kesehatan memberikan edukasi atau terapi, keluarga menjadi pihak yang membantu memastikan anjuran tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika tenaga kesehatan menyarankan pembatasan garam pada lansia hipertensi, keluarga perlu membantu menyediakan makanan yang rendah garam. Jika lansia dengan diabetes perlu mengatur pola makan, keluarga dapat membantu menyiapkan menu yang sesuai dan mengingatkan jadwal makan. Jika lansia perlu minum obat secara teratur, keluarga dapat membuat jadwal obat dan mendampingi lansia agar tidak lupa. Dengan demikian,

keluarga menjadi pelaksana penting dari rencana perawatan yang diberikan tenaga kesehatan.

Keluarga juga berperan dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung kesehatan perempuan lansia. Rumah perlu ditata agar aman dan nyaman, terutama bagi lansia yang mengalami gangguan keseimbangan, penurunan penglihatan, nyeri sendi, atau sering buang air kecil pada malam hari. Lantai sebaiknya tidak licin, pencahayaan cukup, barang-barang tidak berserakan, kamar mandi aman digunakan, dan jalur menuju toilet mudah dijangkau. Jika diperlukan, keluarga dapat menyediakan alat bantu seperti tongkat, walker, kacamata, atau alat bantu dengar. Penataan rumah yang aman merupakan bagian penting dari pencegahan jatuh dan cedera pada perempuan lansia.

Selain menerapkan anjuran kesehatan secara fisik, keluarga juga perlu mendukung aspek emosional perempuan lansia. Perempuan lansia membutuhkan perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan penghargaan terhadap martabatnya. Dalam menjalankan anjuran kesehatan, keluarga sebaiknya tidak bersikap memaksa, menyalahkan, atau memarahi lansia. Misalnya, ketika lansia sulit mengubah pola makan atau lupa minum obat, keluarga perlu memberikan penjelasan dengan sabar. Perubahan kebiasaan pada usia lanjut membutuhkan waktu dan dukungan. Sikap keluarga yang hangat akan membantu lansia lebih mudah menerima anjuran kesehatan dan mempertahankan motivasi untuk merawat diri.

Komunitas berperan dalam menyediakan dukungan sosial dan kegiatan yang ramah lansia. Dukungan komunitas sangat penting karena perempuan lansia membutuhkan ruang untuk tetap berinteraksi, merasa dihargai, dan menjadi bagian dari masyarakat. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, penyuluhan kesehatan, pengajian, arisan, kelompok keterampilan, kegiatan sosial, atau kunjungan rumah dapat membantu lansia tetap aktif dan terhubung. Kegiatan komunitas juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesepian dan isolasi sosial. Perempuan lansia yang masih terlibat dalam kegiatan kelompok biasanya memiliki semangat hidup yang lebih baik dan merasa lebih bermakna.

Komunitas juga dapat membantu keluarga dalam merawat perempuan lansia. Tidak semua keluarga memiliki pengetahuan, waktu, atau kemampuan yang cukup untuk mendampingi lansia secara optimal. Kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan dapat membantu memberikan informasi, memantau kondisi lansia, mengajak lansia mengikuti kegiatan, atau menghubungkan lansia dengan pelayanan kesehatan. Misalnya, kader posyandu lansia dapat mengingatkan jadwal pemeriksaan, mencatat tekanan darah, menimbang berat

badan, atau memberi edukasi sederhana kepada lansia dan keluarga. Dukungan seperti ini dapat memperkuat perawatan lansia di rumah.

Kegiatan ramah lansia di komunitas perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan perempuan lansia. Tempat kegiatan sebaiknya mudah diakses, memiliki pencahayaan cukup, lantai tidak licin, tersedia tempat duduk, dan tidak terlalu jauh dari rumah lansia. Kegiatan juga sebaiknya tidak terlalu melelahkan dan disesuaikan dengan kemampuan fisik lansia. Perempuan lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau penyakit kronis tetap perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dengan penyesuaian yang sesuai. Dengan cara ini, komunitas dapat menjadi lingkungan yang inklusif dan tidak meninggalkan lansia yang memiliki keterbatasan.

Komunikasi dan koordinasi antara keluarga, kader kesehatan, posyandu lansia, puskesmas, dan masyarakat sangat penting agar dukungan terhadap perempuan lansia berjalan efektif. Tanpa komunikasi yang baik, masalah kesehatan lansia dapat tidak terpantau atau terlambat ditangani. Misalnya, keluarga mungkin mengetahui bahwa lansia sering jatuh, tetapi tidak menyampaikan kepada kader atau tenaga kesehatan. Sebaliknya, kader mungkin menemukan tekanan darah lansia tinggi saat posyandu, tetapi keluarga tidak mengetahui pentingnya kontrol lanjutan. Oleh karena itu, informasi perlu mengalir dengan baik antara semua pihak yang terlibat dalam pendampingan lansia.

Koordinasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Keluarga dapat mencatat keluhan lansia, jadwal obat, hasil pemeriksaan tekanan darah atau gula darah, serta kejadian penting seperti jatuh, luka, atau perubahan perilaku. Catatan tersebut dapat dibawa saat kontrol ke puskesmas atau disampaikan kepada kader kesehatan. Kader dapat membantu memantau kondisi lansia di komunitas dan menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan apabila ditemukan masalah. Posyandu lansia dapat menjadi tempat berkumpulnya data sederhana mengenai kondisi lansia, sedangkan puskesmas dapat memberikan arahan lebih lanjut, edukasi, dan rujukan bila diperlukan. Koordinasi yang baik membuat perawatan lansia menjadi lebih terarah.

Komunikasi yang baik juga diperlukan agar keluarga memahami anjuran tenaga kesehatan dan mampu menerapkannya di rumah. Tenaga kesehatan perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sedangkan keluarga perlu berani bertanya apabila ada informasi yang belum jelas. Misalnya, keluarga perlu memahami kapan obat diminum, makanan apa yang perlu dibatasi, aktivitas apa yang aman, tanda bahaya apa yang harus diwaspadai, dan kapan lansia harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Apabila komunikasi kurang jelas, keluarga dapat salah memahami anjuran, sehingga perawatan di rumah menjadi kurang tepat.

Oleh karena itu, komunikasi yang sederhana, terbuka, dan berulang sangat diperlukan dalam perawatan perempuan lansia.

Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan lansia. Kualitas hidup tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan lansia merasa nyaman, aman, dihargai, mandiri sesuai kemampuan, memiliki hubungan sosial, dan tetap merasa hidupnya bermakna. Tenaga kesehatan dapat membantu mengendalikan penyakit dan memberikan edukasi. Keluarga dapat memberikan pendampingan sehari-hari. Komunitas dapat menyediakan ruang sosial dan kegiatan ramah lansia. Ketika ketiganya berjalan bersama, perempuan lansia memiliki peluang lebih besar untuk menjalani masa tua dengan baik.

Kolaborasi juga dapat membantu mempertahankan kemandirian perempuan lansia. Kemandirian lansia tidak berarti harus melakukan semua hal sendiri, tetapi kemampuan untuk tetap terlibat dalam aktivitas sesuai kapasitasnya. Keluarga dapat memberi kesempatan lansia melakukan hal-hal yang masih mampu dilakukan. Tenaga kesehatan dapat menilai kemampuan fungsional dan memberikan anjuran aktivitas yang aman. Komunitas dapat menyediakan kegiatan yang memungkinkan lansia tetap aktif. Dengan dukungan bersama, perempuan lansia tidak hanya dirawat, tetapi juga diberdayakan agar tetap memiliki peran dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Keselamatan perempuan lansia juga dapat meningkat melalui kolaborasi. Risiko jatuh, salah minum obat, luka sulit sembuh, tekanan darah tidak terkontrol, gula darah tinggi, atau keterlambatan penanganan dapat dikurangi jika keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan saling bekerja sama. Keluarga dapat memantau kondisi sehari-hari, kader dapat membantu mengenali masalah di lingkungan, dan tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan profesional. Misalnya, jika kader mengetahui seorang lansia sering tidak hadir di posyandu dan tampak semakin lemah, kader dapat menghubungi keluarga atau menyarankan pemeriksaan ke puskesmas. Langkah sederhana seperti ini dapat mencegah masalah menjadi lebih berat.

Kesejahteraan perempuan lansia juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan emosional. Kolaborasi yang baik dapat mencegah lansia merasa sendirian. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian, komunitas memberi ruang interaksi, sedangkan tenaga kesehatan memberi rasa aman melalui pemantauan kesehatan. Perempuan lansia yang merasa didukung cenderung lebih bersemangat, lebih patuh terhadap pengobatan, lebih bersedia mengikuti kegiatan, dan lebih mampu menerima perubahan akibat penuaan. Sebaliknya,

kurangnya dukungan dapat meningkatkan risiko kesepian, kecemasan, depresi, dan penurunan kualitas hidup.

Dalam pelaksanaannya, kolaborasi perlu didasarkan pada penghormatan terhadap martabat perempuan lansia. Lansia bukan hanya objek perawatan, tetapi individu yang memiliki hak, pengalaman, pendapat, dan pilihan. Keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan perlu melibatkan lansia dalam keputusan yang berkaitan dengan dirinya selama lansia masih mampu mengambil keputusan. Misalnya, lansia dapat diajak berdiskusi tentang makanan, aktivitas, jadwal kontrol, penggunaan alat bantu, atau keikutsertaan dalam kegiatan komunitas. Dengan melibatkan lansia, rasa percaya diri dan harga dirinya tetap terjaga.

Kolaborasi juga perlu memperhatikan keberlanjutan. Dukungan terhadap perempuan lansia tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi perlu berlangsung terus-menerus sesuai perubahan kondisi lansia. Kondisi lansia dapat berubah dari waktu ke waktu. Lansia yang saat ini masih mandiri mungkin suatu saat membutuhkan bantuan lebih banyak. Lansia yang memiliki penyakit kronis membutuhkan pemantauan jangka panjang. Lansia yang kehilangan pasangan membutuhkan dukungan emosional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan perlu membangun sistem dukungan yang konsisten agar perempuan lansia tidak hanya mendapat perhatian saat sakit, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

kolaborasi keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan merupakan dasar penting dalam mendukung perempuan lansia. Tenaga kesehatan berperan dalam edukasi, pengkajian, deteksi dini, pemantauan, dan rujukan. Keluarga berperan menerapkan anjuran kesehatan di rumah, mendampingi aktivitas harian, menjaga lingkungan aman, dan memberikan dukungan emosional. Komunitas berperan menyediakan kegiatan ramah lansia, dukungan sosial, dan ruang interaksi yang mencegah isolasi sosial. Komunikasi dan koordinasi antara keluarga, kader kesehatan, posyandu lansia, puskesmas, dan masyarakat sangat diperlukan agar perawatan lansia berjalan efektif. Melalui kolaborasi yang baik, perempuan lansia dapat memperoleh dukungan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, menjaga keselamatan, dan mencapai kesejahteraan pada masa lanjut usia.

I. Hambatan dan Strategi Penguatan Dukungan bagi Perempuan Lansia

Dukungan terhadap perempuan lansia merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan, kemandirian, keselamatan, dan kualitas hidup pada masa lanjut usia. Namun, dalam praktiknya, pemberian dukungan kepada perempuan lansia tidak selalu berjalan mudah. Terdapat berbagai hambatan yang dapat

berasal dari keluarga, perempuan lansia itu sendiri, komunitas, kondisi sosial ekonomi, budaya, stigma, maupun keterbatasan pelayanan. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan kebutuhan perempuan lansia tidak terpenuhi secara optimal. Akibatnya, lansia dapat mengalami penurunan kesehatan fisik, gangguan psikologis, kesepian, penurunan kemandirian, bahkan risiko penelantaran. Oleh karena itu, hambatan dalam pemberian dukungan perlu dikenali agar dapat disusun strategi penguatan dukungan yang tepat, manusiawi, dan berkelanjutan.

Salah satu hambatan yang sering muncul berasal dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi perempuan lansia, tetapi tidak semua keluarga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebutuhan lansia. Kurangnya pengetahuan dapat membuat keluarga menganggap keluhan lansia sebagai hal biasa yang tidak perlu diperhatikan. Misalnya, nyeri sendi, sulit tidur, sering lupa, penurunan nafsu makan, sering buang air kecil, atau rasa kesepian sering dianggap sebagai bagian normal dari usia tua. Padahal, keluhan tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu dikaji dan ditangani. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan keluarga tidak memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, kepatuhan minum obat, pemenuhan gizi, aktivitas fisik yang aman, serta pencegahan jatuh di rumah.

Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan penting dalam keluarga. Pada masa sekarang, banyak anggota keluarga memiliki kesibukan bekerja, mengurus rumah tangga, merawat anak, atau menjalankan tanggung jawab sosial lainnya. Akibatnya, waktu untuk mendampingi perempuan lansia menjadi terbatas. Lansia mungkin tinggal satu rumah dengan keluarga, tetapi tetap merasa kesepian karena jarang diajak berbicara atau dilibatkan dalam kegiatan keluarga. Keterbatasan waktu juga dapat membuat keluarga sulit mendampingi lansia kontrol ke fasilitas kesehatan, mengawasi jadwal obat, menyiapkan makanan sesuai kebutuhan, atau menemani aktivitas fisik. Jika kondisi ini berlangsung lama, perempuan lansia dapat merasa diabaikan meskipun secara fisik tinggal bersama keluarga.

Beban ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi dukungan terhadap perempuan lansia. Perawatan lansia sering membutuhkan biaya untuk pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, transportasi, makanan bergizi, alat bantu, popok dewasa, kacamata, alat bantu dengar, atau perbaikan lingkungan rumah agar lebih aman. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam beberapa keadaan, lansia mungkin menunda berobat, mengurangi konsumsi makanan bergizi, atau tidak menggunakan alat bantu yang sebenarnya diperlukan karena khawatir membebani keluarga. Masalah ekonomi juga dapat menimbulkan stres pada anggota keluarga,

yang kemudian memengaruhi kualitas komunikasi dan kesabaran dalam merawat lansia.

Konflik keluarga juga dapat menjadi hambatan serius. Konflik dapat terjadi antara anak-anak mengenai siapa yang bertanggung jawab merawat lansia, pembagian biaya, tempat tinggal lansia, atau keputusan pengobatan. Konflik juga dapat muncul karena perbedaan pandangan antara lansia dan anggota keluarga, misalnya lansia ingin tetap mandiri, sedangkan keluarga terlalu membatasi aktivitasnya. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, perempuan lansia dapat merasa menjadi sumber masalah atau beban keluarga. Perasaan ini dapat menurunkan harga diri, menimbulkan kecemasan, dan membuat lansia menarik diri. Oleh karena itu, hubungan keluarga yang harmonis dan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam mendukung perempuan lansia.

Kelelahan caregiver juga sering menjadi hambatan dalam pemberian dukungan. Caregiver adalah orang yang memberikan perawatan atau pendampingan kepada lansia, baik anggota keluarga maupun orang lain. Merawat perempuan lansia yang memiliki penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, gangguan kognitif, atau ketergantungan tinggi dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional. Caregiver mungkin harus membantu mandi, makan, berpakaian, minum obat, kontrol kesehatan, menjaga kebersihan, dan mendampingi aktivitas sehari-hari. Jika caregiver tidak mendapatkan dukungan, istirahat, atau pembagian tugas yang baik, ia dapat mengalami stres, mudah marah, kehilangan kesabaran, bahkan tanpa sadar memperlakukan lansia secara kurang tepat. Karena itu, kesehatan dan kesejahteraan caregiver juga perlu diperhatikan.

Selain hambatan dari keluarga, hambatan juga dapat berasal dari perempuan lansia itu sendiri. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah rasa malu. Perempuan lansia mungkin merasa malu menyampaikan keluhan tertentu, terutama keluhan yang berkaitan dengan inkontinensia urine, gangguan urogenital, perubahan fungsi seksual, depresi, kesepian, atau ketergantungan dalam perawatan diri. Rasa malu dapat membuat lansia menyembunyikan masalahnya hingga kondisi menjadi lebih berat. Misalnya, lansia yang mengalami kebocoran urine mungkin tidak mau memberitahu keluarga karena takut dianggap merepotkan atau tidak bersih. Akibatnya, ia membatasi aktivitas sosial, kurang minum, atau menggunakan pelindung yang tidak sesuai, sehingga risiko iritasi dan infeksi meningkat.

Perempuan lansia juga dapat menolak bantuan. Penolakan ini tidak selalu berarti lansia tidak membutuhkan dukungan, tetapi dapat menjadi cara untuk mempertahankan harga diri dan kemandirian. Banyak perempuan lansia sepanjang hidupnya terbiasa merawat keluarga, mengurus rumah, dan mengambil keputusan

sendiri. Ketika memasuki masa lanjut usia dan mulai membutuhkan bantuan, mereka dapat merasa tidak nyaman karena posisi yang dahulu mandiri berubah menjadi bergantung pada orang lain. Penolakan bantuan dapat muncul dalam bentuk tidak mau diperiksa, tidak mau menggunakan alat bantu, tidak mau dibantu mandi, tidak mau mengikuti anjuran diet, atau menolak ikut kegiatan lansia. Dalam menghadapi kondisi ini, keluarga perlu menggunakan pendekatan yang sabar dan menghargai, bukan memaksa secara kasar.

Takut menjadi beban juga merupakan hambatan psikologis yang banyak dialami perempuan lansia. Lansia mungkin menyadari bahwa keluarga memiliki kesibukan dan beban masing-masing, sehingga ia memilih diam meskipun merasa sakit, kesepian, atau membutuhkan bantuan. Perempuan lansia dapat menahan keluhan, menunda meminta pertolongan, atau berusaha melakukan aktivitas yang sebenarnya berisiko karena tidak ingin merepotkan. Sikap ini dapat membahayakan, misalnya lansia memaksakan berjalan sendiri lalu jatuh, tidak menyampaikan luka yang sulit sembuh, atau tidak memberi tahu jika obat habis. Oleh karena itu, keluarga perlu meyakinkan lansia bahwa meminta bantuan bukan berarti menjadi beban, melainkan bagian dari hubungan saling peduli dalam keluarga.

Kesulitan menerima perubahan juga menjadi hambatan bagi perempuan lansia. Proses penuaan membawa banyak perubahan, seperti tubuh menjadi lebih lemah, kulit berubah, penglihatan menurun, pendengaran berkurang, peran keluarga berubah, dan aktivitas tidak lagi sebebaskan sebelumnya. Sebagian lansia dapat menerima perubahan tersebut secara bertahap, tetapi sebagian lainnya merasa sedih, marah, kecewa, atau menyangkal kondisi yang terjadi. Lansia yang sulit menerima perubahan mungkin tetap memaksakan aktivitas berat, menolak alat bantu, atau tidak mau mengikuti pemeriksaan kesehatan. Sebaliknya, ada pula yang menjadi sangat pasif karena merasa dirinya tidak lagi mampu melakukan apa pun. Kedua keadaan ini membutuhkan pendampingan emosional dan edukasi yang tepat.

Hambatan berikutnya berasal dari komunitas. Tidak semua komunitas memiliki program yang memadai untuk lansia. Di beberapa lingkungan, kegiatan untuk lansia mungkin belum berjalan rutin, belum terorganisasi, atau hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan sederhana tanpa memperhatikan aspek sosial dan psikologis. Kurangnya program lansia dapat membuat perempuan lansia kehilangan kesempatan untuk berinteraksi, memperoleh edukasi kesehatan, melakukan aktivitas fisik, atau mendapatkan pemantauan kondisi secara berkala. Padahal, komunitas memiliki potensi besar untuk mencegah isolasi sosial, mendukung deteksi dini, dan membantu keluarga dalam pendampingan lansia.

Keterbatasan akses juga menjadi hambatan komunitas. Perempuan lansia yang tinggal di daerah jauh dari fasilitas kesehatan, memiliki keterbatasan mobilitas, atau tidak memiliki pendamping dapat kesulitan mengikuti kegiatan komunitas maupun mendapatkan pelayanan kesehatan. Jalan yang tidak ramah lansia, tempat kegiatan yang jauh, tangga yang sulit dilalui, atau lokasi yang tidak memiliki fasilitas duduk dan toilet aman dapat mengurangi partisipasi lansia. Kegiatan yang sebenarnya bermanfaat menjadi tidak dapat diakses oleh perempuan lansia yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, aksesibilitas perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program komunitas.

Kurangnya transportasi juga dapat menghambat perempuan lansia mengikuti kegiatan kesehatan dan sosial. Sebagian lansia tidak lagi mampu mengendarai kendaraan sendiri, takut bepergian sendirian, atau bergantung pada keluarga untuk diantar. Jika keluarga sibuk, lansia mungkin tidak dapat menghadiri posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan, kegiatan keagamaan, atau pertemuan komunitas. Kondisi ini dapat menyebabkan lansia semakin terisolasi. Komunitas perlu memikirkan solusi, seperti kegiatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal lansia, pendampingan oleh kader, jadwal kegiatan yang sesuai, atau kerja sama warga untuk membantu transportasi lansia yang membutuhkan.

Rendahnya partisipasi sosial juga menjadi hambatan. Sebagian perempuan lansia enggan mengikuti kegiatan karena merasa malu, tidak percaya diri, takut merepotkan, merasa tidak mengenal peserta lain, atau memiliki pengalaman kurang menyenangkan. Ada juga lansia yang menarik diri karena gangguan pendengaran, inkontinensia urine, nyeri sendi, atau ketakutan jatuh. Rendahnya partisipasi sosial dapat memperburuk kesepian dan menurunkan kesehatan mental. Komunitas perlu menciptakan kegiatan yang hangat, inklusif, tidak menghakimi, dan memberi rasa aman agar perempuan lansia merasa nyaman untuk hadir.

Hambatan budaya, stigma, dan diskriminasi juga dapat memengaruhi dukungan bagi perempuan lansia. Dalam beberapa lingkungan, lansia dipandang sebagai kelompok yang tidak produktif, lemah, lambat, atau merepotkan. Pandangan seperti ini dapat membuat lansia tidak dilibatkan dalam kegiatan keluarga maupun masyarakat. Stigma juga dapat muncul terhadap keluhan tertentu, seperti inkontinensia urine, gangguan mental, depresi, atau penurunan daya ingat. Perempuan lansia yang mengalami masalah tersebut mungkin dianggap memalukan atau menjadi bahan pembicaraan. Akibatnya, lansia dan keluarga memilih menyembunyikan kondisi tersebut, padahal seharusnya mendapatkan dukungan dan penanganan.

Diskriminasi terhadap perempuan lansia dapat terjadi secara halus maupun nyata. Secara halus, lansia mungkin tidak diajak berdiskusi, pendapatnya diabaikan, atau dianggap tidak mampu memahami keputusan. Secara nyata, lansia dapat mengalami penelantaran, kekerasan verbal, pembatasan aktivitas tanpa alasan yang jelas, atau tidak diberi akses terhadap pelayanan kesehatan. Perempuan lansia juga dapat mengalami beban ganda karena faktor usia dan gender. Sepanjang hidupnya, perempuan sering berperan sebagai pengasuh, tetapi ketika ia menjadi lansia dan membutuhkan bantuan, kebutuhannya kadang tidak diprioritaskan. Oleh karena itu, budaya yang menghargai lansia dan kesetaraan dalam perawatan perlu diperkuat.

Strategi penguatan dukungan bagi perempuan lansia perlu dimulai dari edukasi keluarga. Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang proses penuaan, perubahan fisik dan psikologis, penyakit kronis, kebutuhan nutrisi, pentingnya aktivitas fisik, pencegahan jatuh, penggunaan obat, serta cara berkomunikasi dengan lansia. Edukasi keluarga dapat dilakukan melalui posyandu lansia, puskesmas, kunjungan rumah, penyuluhan komunitas, atau konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, keluarga akan lebih mampu mengenali kebutuhan lansia, mencegah komplikasi, dan memberikan dukungan yang tepat tanpa merendahkan martabat lansia.

Pemberdayaan caregiver juga sangat penting. Caregiver perlu mendapat pengetahuan, keterampilan, dan dukungan emosional agar mampu merawat lansia dengan baik. Pemberdayaan dapat mencakup pelatihan sederhana tentang membantu mobilitas lansia, mencegah jatuh, menyiapkan makanan sesuai penyakit, mengatur obat, menjaga kebersihan diri, mengenali tanda bahaya, serta mengelola stres caregiver. Selain itu, caregiver juga perlu memiliki waktu istirahat dan dukungan dari anggota keluarga lain. Pembagian tugas dalam keluarga sangat penting agar perawatan lansia tidak hanya dibebankan kepada satu orang. Caregiver yang sehat dan didukung akan lebih mampu memberikan perawatan yang sabar dan berkualitas.

Peningkatan kegiatan komunitas juga menjadi strategi penting. Komunitas perlu menyediakan kegiatan yang ramah lansia, seperti posyandu lansia, senam lansia, edukasi kesehatan, pemeriksaan rutin, kegiatan keagamaan, kelompok dukungan, dan kegiatan sosial yang sesuai kemampuan lansia. Kegiatan tersebut perlu dirancang agar aman, mudah dijangkau, tidak terlalu melelahkan, dan menyenangkan. Kegiatan komunitas juga perlu memperhatikan lansia yang memiliki keterbatasan, misalnya menyediakan tempat duduk, memperjelas suara saat penyuluhan, menggunakan bahasa sederhana, dan memberi kesempatan

lansia untuk berpartisipasi tanpa tekanan. Dengan kegiatan yang teratur, perempuan lansia dapat tetap aktif dan merasa menjadi bagian dari masyarakat.

Kunjungan rumah merupakan strategi yang sangat bermanfaat, terutama bagi perempuan lansia yang hidup sendiri, mengalami keterbatasan mobilitas, jarang hadir di kegiatan komunitas, atau berisiko mengalami penelantaran. Melalui kunjungan rumah, kader kesehatan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, atau relawan dapat melihat kondisi lansia secara langsung. Mereka dapat menilai apakah rumah aman, apakah lansia memiliki makanan yang cukup, apakah obat diminum dengan benar, apakah ada luka, apakah lansia tampak kesepian, atau apakah keluarga membutuhkan edukasi tambahan. Kunjungan rumah juga dapat menjadi bentuk perhatian yang membuat perempuan lansia merasa tidak dilupakan.

Strategi lain yang penting adalah membangun lingkungan yang ramah lansia. Lingkungan ramah lansia adalah lingkungan yang aman, mudah diakses, menghargai, dan mendukung partisipasi lansia. Di tingkat rumah, lingkungan ramah lansia dapat diwujudkan melalui lantai tidak licin, pencahayaan cukup, toilet aman, barang tidak berserakan, dan alat bantu yang sesuai. Di tingkat komunitas, lingkungan ramah lansia dapat diwujudkan melalui kegiatan yang mudah diakses, tempat kegiatan yang aman, transportasi yang memungkinkan, serta sikap masyarakat yang peduli. Lingkungan ramah lansia membantu perempuan lansia merasa lebih aman untuk bergerak, berinteraksi, dan mengikuti kegiatan.

Penghargaan terhadap martabat perempuan lansia harus menjadi dasar dalam setiap strategi dukungan. Perempuan lansia tidak boleh diperlakukan sebagai objek perawatan semata, melainkan sebagai individu yang memiliki hak, pengalaman, pilihan, dan peran. Dalam keluarga, lansia perlu dilibatkan dalam keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Dalam komunitas, lansia perlu diberi ruang untuk berbagi pengalaman dan tetap berpartisipasi. Dalam pelayanan kesehatan, lansia perlu didengarkan dan diperlakukan dengan sopan. Penghormatan terhadap martabat akan membantu lansia merasa dihargai dan lebih mudah menerima dukungan.

Mendukung perempuan lansia agar tetap aktif juga menjadi bagian penting dari penguatan dukungan. Aktif tidak selalu berarti melakukan aktivitas berat. Aktif dapat berarti tetap bergerak sesuai kemampuan, mengikuti kegiatan sosial, menjalankan ibadah, berbicara dengan keluarga, membantu pekerjaan ringan, merawat tanaman, atau berbagi pengalaman dengan generasi muda. Aktivitas yang sesuai dapat menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Keluarga dan komunitas perlu membantu menemukan aktivitas yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi perempuan lansia.

Maka dari itu, hambatan dalam mendukung perempuan lansia dapat berasal dari keluarga, lansia itu sendiri, komunitas, budaya, stigma, dan diskriminasi. Keluarga dapat mengalami hambatan berupa kurang pengetahuan, keterbatasan waktu, beban ekonomi, konflik, dan kelelahan caregiver. Perempuan lansia dapat mengalami hambatan berupa rasa malu, menolak bantuan, takut menjadi beban, atau sulit menerima perubahan. Komunitas dapat menghadapi hambatan berupa kurangnya program lansia, keterbatasan akses, kurang transportasi, dan rendahnya partisipasi sosial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi penguatan melalui edukasi keluarga, pemberdayaan caregiver, peningkatan kegiatan komunitas, kunjungan rumah, serta pembangunan lingkungan yang ramah lansia. Dengan dukungan yang kuat, penuh penghargaan, dan berkelanjutan, perempuan lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, aktif, aman, bermartabat, dan bermakna.

J. Simpulan

Perempuan lansia merupakan kelompok yang membutuhkan dukungan menyeluruh karena mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akibat proses penuaan, menopause, penyakit kronis, serta perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kemandirian, rasa percaya diri, kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup perempuan lansia. Oleh karena itu, dukungan keluarga dan komunitas menjadi sangat penting agar perempuan lansia tetap merasa aman, dihargai, dicintai, didengarkan, serta memiliki kesempatan untuk menjalani masa tua secara aktif dan bermakna.

Keluarga memiliki peran utama sebagai lingkungan terdekat yang memberikan dukungan emosional, fisik, sosial, spiritual, dan praktis bagi perempuan lansia. Dukungan keluarga dapat dilakukan melalui perhatian, kasih sayang, komunikasi yang sabar, pendampingan dalam pengobatan, pemenuhan nutrisi, pemeriksaan kesehatan, aktivitas fisik yang aman, menjaga kebersihan diri, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman dan ramah lansia. Di sisi lain, komunitas berperan dalam menyediakan kegiatan yang mendukung kesehatan dan keterlibatan sosial perempuan lansia, seperti posyandu lansia, senam lansia, edukasi kesehatan, kegiatan keagamaan, pemeriksaan rutin, serta ruang interaksi sosial yang dapat mencegah kesepian dan isolasi sosial.

Kolaborasi antara keluarga, komunitas, kader kesehatan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan diperlukan agar dukungan kepada perempuan lansia dapat berjalan secara berkelanjutan. Hambatan seperti kurangnya pengetahuan keluarga, keterbatasan waktu, beban ekonomi, kelelahan

caregiver, rasa malu lansia, penolakan bantuan, kurangnya program komunitas, keterbatasan akses, stigma, dan diskriminasi perlu diatasi melalui edukasi keluarga, pemberdayaan caregiver, peningkatan kegiatan komunitas, kunjungan rumah, serta pembangunan lingkungan yang ramah lansia. Dengan dukungan yang tepat, penuh penghargaan, dan berorientasi pada martabat, perempuan lansia dapat mempertahankan kesehatan, kemandirian, keselamatan, kesejahteraan, serta menjalani masa tua dengan lebih sehat, aktif, aman, dan bermakna.

K. Referensi

-
- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1–S321.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk lanjut usia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bandiyah, S. (2009). *Lanjut usia dan keperawatan gerontik*. Nuha Medika.
- Darmojo, R. B., & Martono, H. H. (2015). *Buku ajar geriatri: Ilmu kesehatan usia lanjut* (Edisi 5). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Eliopoulos, C. (2018). *Gerontological nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Halter, J. B., Ouslander, J. G., Studenski, S., High, K. P., Asthana, S., Supiano, M. A., & Ritchie, C. (Eds.). (2017). *Hazzard's geriatric medicine and gerontology* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2016–2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mauk, K. L. (2018). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Meiner, S. E., & Yeager, J. J. (2019). *Gerontologic nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Miller, C. A. (2019). *Nursing for wellness in older adults* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., ... Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: A global initiative. *Age and Ageing*, 51(9), afac205. doi:

10.1093/ageing/afac205

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Families caring for an aging America*. The National Academies Press.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2019). *Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: Management* (NICE Guideline No. 123). National Institute for Health and Care Excellence.
- Nugroho, W. (2008). *Keperawatan gerontik dan geriatrik* (Edisi 3). EGC.
- Pinquart, M., & Sörensen, S. (2003). Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: A meta-analysis. *Psychology and Aging, 18*(2), 250–267. doi: 10.1037/0882-7974.18.2.250
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Santini, Z. I., Jose, P. E., Cornwell, E. Y., Koyanagi, A., Nielsen, L., Hinrichsen, C., Meilstrup, C., Madsen, K. R., & Koushede, V. (2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans. *The Lancet Public Health, 5*(1), e62–e70. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30230-0
- Schulz, R., & Sherwood, P. R. (2008). Physical and mental health effects of family caregiving. *American Journal of Nursing, 108*(9 Suppl.), 23–27. doi: 10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c
- Stanley, M., & Beare, P. G. (2007). *Buku ajar keperawatan gerontik* (Edisi 2). EGC.
- Step toe, A., Shankar, A., Demakakos, P., & Wardle, J. (2013). Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 110*(15), 5797–5801. doi: 10.1073/pnas.1219686110
- Tamher, S., & Noorkasiani. (2009). *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. Salemba Medika.
- The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society Advisory Panel. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause, 29*(7), 767–794. doi: 10.1097/GME.0000000000002028
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2020). *Ebersole & Hess' gerontological nursing & healthy aging* (5th ed.). Elsevier.
- Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., Ramirez, A., Schlaich, M., Stergiou, G. S., Tomaszewski, M., Wainford, R. D., Williams, B., & Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Hypertension, 75*(6), 1334–1357. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026

- Valtorta, N. K., Kanaan, M., Gilbody, S., Ronzi, S., & Hanratty, B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: Systematic review and meta-analysis. *Heart*, 102(13), 1009–1016. doi: 10.1136/heartjnl-2015-308790
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021a). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021b). *Global report on ageism*. World Health Organization.

L. Glosarium

- **Perempuan Lansia**

Perempuan yang telah memasuki tahap lanjut usia dan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta fungsional akibat proses penuaan.

- **Dukungan Keluarga**

Bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada perempuan lansia, baik berupa perhatian, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan fisik, pendampingan kesehatan, dukungan emosional, maupun penghargaan terhadap martabat lansia.

- **Dukungan Komunitas**

Bantuan dan keterlibatan lingkungan masyarakat dalam mendukung perempuan lansia melalui kegiatan sosial, keagamaan, posyandu lansia, edukasi kesehatan, pemeriksaan rutin, dan pendampingan sosial.

- **Komunitas Ramah Lansia**

Lingkungan masyarakat yang aman, inklusif, peduli, mudah diakses, bebas stigma, serta memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap aktif dan berpartisipasi sesuai kemampuan.

- **Posyandu Lansia**

Kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan memantau kondisi kesehatan lansia melalui pemeriksaan sederhana, edukasi kesehatan, pemantauan status gizi, serta deteksi dini masalah kesehatan.

- **Caregiver**

Orang yang memberikan perawatan, pendampingan, dan bantuan kepada lansia dalam aktivitas sehari-hari, baik berasal dari anggota keluarga maupun pihak lain yang terlibat dalam perawatan lansia.

- **Dukungan Emosional**

Bentuk dukungan berupa perhatian, kasih sayang, rasa aman, kesediaan mendengarkan, empati, motivasi, dan komunikasi yang hangat agar perempuan lansia merasa dihargai dan tidak sendirian.

- **Dukungan Sosial**

Hubungan dan bantuan yang diperoleh lansia dari keluarga, teman sebaya, tetangga, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, dan komunitas untuk menjaga keterhubungan sosial serta mencegah kesepian.

- **Dukungan Spiritual**

Bantuan yang diberikan kepada perempuan lansia untuk memenuhi kebutuhan rohani, seperti kesempatan beribadah, berdoa, mengikuti kegiatan keagamaan, memperoleh ketenangan batin, dan menemukan makna hidup.

- **Kualitas Hidup**

Keadaan kesejahteraan perempuan lansia yang mencakup kesehatan fisik, kenyamanan, rasa aman, kemandirian, hubungan sosial, kesehatan mental, spiritualitas, dan rasa bermakna dalam kehidupan.

- **Kemandirian Lansia**

Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kapasitasnya, seperti makan, mandi, berpakaian, berjalan, minum obat, beribadah, dan berpartisipasi dalam keluarga atau komunitas.

- **Pencegahan Jatuh**

Upaya untuk mengurangi risiko jatuh pada perempuan lansia melalui penataan rumah yang aman, penggunaan alat bantu, latihan keseimbangan, pemeriksaan penglihatan, serta pendampingan saat beraktivitas.

- **Deteksi Dini**

Upaya menemukan masalah kesehatan lansia sejak awal melalui pemantauan dan pemeriksaan rutin, seperti tekanan darah, gula darah, berat badan, status gizi, risiko jatuh, serta perubahan perilaku.

- **Penelantaran Lansia**

Kondisi ketika kebutuhan dasar lansia, seperti makanan, obat, kebersihan, keamanan, perhatian emosional, dan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi secara layak.

- **Kolaborasi Keluarga, Komunitas, dan Tenaga Kesehatan**

Kerja sama antara keluarga, masyarakat, kader kesehatan, posyandu lansia, puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, dan tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan, keselamatan, kemandirian, serta kesejahteraan perempuan lansia.

PROFIL PENULIS



Titin Apriyani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb dilahirkan di Palembang pada tanggal 15 April 1996. Pada tahun 2016 Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang, Pendidikan Diploma IV Kebidanan telah berhasil dirampungkannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang pada tahun 2017. Penulis telah meraih gelar Magister Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung pada tahun 2020,

serta telah melanjutkan kembali pendidikannya yaitu Profesi Bidan di Stikes Abdi Nusantara Jakarta dan lulus pada tahun 2024. Penulis merupakan Dosen tetap pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang sejak tahun 2020 sampai sekarang, selain itu sebagai akademisi, penulis aktif di berbagai pelatihan, workshop serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemudian aktif publish di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Bagi yang ingin berkomunikasi dengan penulis, bisa melalui e-mail: titinapriyani65@gmail.com



Maria F. Nining Kosad, SST., M.Kes. Lahir di Kupang, 10 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan. Pendidik pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjadjaran Bandung. tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadj. Madah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali. pada tahun Pengalaman bekerja Sebagai Bidan PTT di Desa Seki Kec. Kupang. Timur Kab. Kupang Tahun

1995–1997, Bidan PTT merangkap Kepala Puskesmas. Pembantu di desa Kuanheum Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Propinsi NTT. Tahun 1997-1998. Tahun 2001-sekarang Sebagai Dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Gender dan PUG, Askeb Komunitas, Etikolegal dalam Praktik Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 10niningkosad11@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bd. Elwitri Silvia, S.ST., M.Keb Lahir di Padang, 26 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Universitas Sumatera Barat sebagai seorang dosen dengan mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL; Inovasi dan Teknologi dalam Kebidanan; Asuhan Kebidanan pada Kondisi Rentan; Fisiologi Kehamilan, Persalinan dan BBL; dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan berbagi informasi dan edukasi melalui Youtube tentang persiapan UKOM mahasiswa kebidanan dan materi perkuliahan kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: elwitri.silvia.91@gmail.com



Dr. Bdn. Subang Aini Nasution, SKM, S.Keb, M.Kes, Lahir di Sampilpil, 06 Januari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatra Utara dan lulus tahun pada tahun 2011. Dan melanjutkan Pendidikan Sarjana Kebidanan serta Pendidikan Profesi Bidan Universitas Prima Indonesia lulus tahun 2021. Lalu melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Kedokteran, Universitas Prima Indonesia dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia sampai tahun 2017. Mulai tahun 2018 sampai saat ini penulis bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Adiwangsa Jambi, mengampu mata kuliah di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta workshop. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: subang.aini@unaja.ac.id

Sinopsis

“Bunga Rampai Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Lansia melalui Pendekatan Kebidanan” merupakan buku yang membahas secara komprehensif tentang perempuan lansia sebagai bagian dari sasaran pelayanan kebidanan sepanjang daur kehidupan. Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar perempuan lansia dalam perspektif kebidanan, termasuk pemahaman mengenai lansia, karakteristik masa lanjut usia, serta pentingnya peran bidan dalam mengenali kebutuhan kesehatan perempuan pada fase ini. Perempuan lansia tidak hanya mengalami perubahan biologis akibat proses penuaan, tetapi juga menghadapi perubahan psikologis, sosial, spiritual, dan peran dalam keluarga maupun masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya.

Pembahasan dalam buku ini dilanjutkan dengan uraian mengenai perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan. Perubahan fisik meliputi penurunan fungsi tubuh, perubahan sistem organ, serta munculnya berbagai masalah kesehatan yang sering dialami pada masa lanjut usia. Perubahan psikologis dan sosial turut dibahas, seperti kecemasan, kesepian, perubahan konsep diri, penurunan peran sosial, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemandirian perempuan lansia. Buku ini juga menjelaskan upaya adaptasi lansia perempuan dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk pentingnya dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam membantu lansia tetap sehat, aktif, aman, dan bermartabat.

Selain membahas perubahan dan adaptasi, buku ini juga menguraikan berbagai masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia, seperti osteoporosis, nyeri sendi, risiko fraktur, hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, gangguan nutrisi, anemia, gangguan tidur, inkontinensia urine, gangguan urogenital pascamenopause, gangguan sensorik, mobilitas, risiko jatuh, serta gangguan psikologis dan sosial. Pada bagian akhir, buku ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung perempuan lansia melalui pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, spiritual, keamanan, edukasi kesehatan, kegiatan komunitas, deteksi dini, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Dengan pendekatan kebidanan yang holistik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, bidan, tenaga kesehatan, keluarga, kader, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan lansia agar dapat menjalani masa tua secara sehat, mandiri, bermakna, dan bermartabat.

"Bunga Rampai Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Lansia melalui Pendekatan Kebidanan" merupakan buku yang membahas secara komprehensif tentang perempuan lansia sebagai bagian dari sasaran pelayanan kebidanan sepanjang daur kehidupan. Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar perempuan lansia dalam perspektif kebidanan, termasuk pemahaman mengenai lansia, karakteristik masa lanjut usia, serta pentingnya peran bidan dalam mengenali kebutuhan kesehatan perempuan pada fase ini. Perempuan lansia tidak hanya mengalami perubahan biologis akibat proses penuaan, tetapi juga menghadapi perubahan psikologis, sosial, spiritual, dan peran dalam keluarga maupun masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya.

Pembahasan dalam buku ini dilanjutkan dengan uraian mengenai perubahan fisik, psikologis, dan sosial pada lansia perempuan. Perubahan fisik meliputi penurunan fungsi tubuh, perubahan sistem organ, serta munculnya berbagai masalah kesehatan yang sering dialami pada masa lanjut usia. Perubahan psikologis dan sosial turut dibahas, seperti kecemasan, kesepian, perubahan konsep diri, penurunan peran sosial, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemandirian perempuan lansia. Buku ini juga menjelaskan upaya adaptasi lansia perempuan dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk pentingnya dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam membantu lansia tetap sehat, aktif, aman, dan bermartabat.

Selain membahas perubahan dan adaptasi, buku ini juga menguraikan berbagai masalah kesehatan yang sering dialami perempuan lansia, seperti osteoporosis, nyeri sendi, risiko fraktur, hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, gangguan nutrisi, anemia, gangguan tidur, inkontinensia urine, gangguan urogenital pascamenopause, gangguan sensorik, mobilitas, risiko jatuh, serta gangguan psikologis dan sosial. Pada bagian akhir, buku ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung perempuan lansia melalui pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, spiritual, keamanan, edukasi kesehatan, kegiatan komunitas, deteksi dini, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Dengan pendekatan kebidanan yang holistik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, bidan, tenaga kesehatan, keluarga, kader, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan lansia agar dapat menjalani masa tua secara sehat, mandiri, bermakna, dan bermartabat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-31-2 (PDF)



9

786347

756312